sina 新浪育儿 · 权威推荐
baby.sina.com.cn

美国亚马逊最长销的睡眠圣经 哈佛医学院教授最行之有效的儿童睡眠安抚法

《父母世界Parents》执行主编朱正欧倾情推荐

睡眠仅次于喂养，让孩子的幸福从一夜好眠开始

Richard Ferber

法伯睡眠宝典

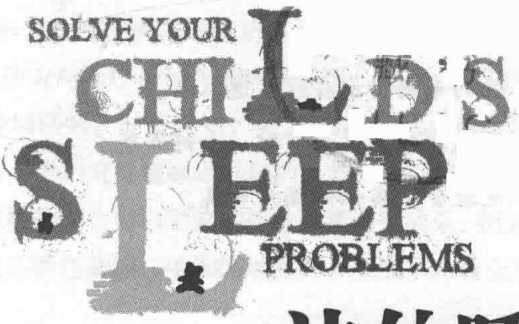
如何顺利解决孩子的睡眠问题

[美] 理查德·法伯◎著　戴莎◎译

畅销30年

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS

浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE



法伯睡眠宝典

如何顺利解决孩子的睡眠问题

Richard Ferber
[美] 理查德·法伯◎著　戴莎◎译

浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

法伯睡眠宝典：如何顺利解决孩子的睡眠问题 /（美）法伯著；戴莎译．
—杭州：浙江人民出版社，2013.1
ISBN 978-7-213-05238-5

Ⅰ.①法… Ⅱ.①法…②戴… Ⅲ.①儿童—睡眠—研究 Ⅳ.①R338.63

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第271214号

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字:11-2012-197号

版权所有，侵权必究

本书法律顾问　北京诚英律师事务所　吴京菁律师
北京市证信律师事务所　李云翔律师

法伯睡眠宝典：如何顺利解决孩子的睡眠问题

作　　者：［美］理查德·法伯　著
译　　者：戴莎　译
出版发行：浙江人民出版社（杭州体育场路347号　邮编　310006）
市场部电话：（0571）85061682　85176516
集团网址：浙江出版联合集团　http://www.zjcb.com
责任编辑：金　纪　王方玲
责任校对：鞠　朗　朱　妍
印　　刷：北京京北印刷有限公司
开　　本：720 mm × 965 mm　1/16　　**印　　张：**13.5
字　　数：22.8 万　　**插　　页：**2
版　　次：2013 年 1 月第 1 版　　**印　　次：**2014 年11月第 3 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-213-05238-5
定　　价：39.90 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与市场部联系调换。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS 中文版序

写给全世界父母的儿童睡眠宝典

《法伯睡眠宝典》能够在中国出版面世，我真是感激不尽。1985 年，该书第一版问世。而早在 1978 年，我就在美国马萨诸塞州波士顿建立了当时全球唯一一家儿童睡眠障碍中心，致力于研究与治疗各种儿童睡眠问题。当时，中心的研究处于世界领先水平，很少有其他机构能够匹敌。时光飞逝，到 2006 年《法伯睡眠宝典》第二版出版时，世界各地出现了许许多多研究儿童睡眠问题的机构——亚洲地区也出现了一些类似的研究中心。这些研究机构的医生与科学家们彼此分享研究成果，相关书籍与杂志也不断问世，世界性的学术会议不断在美国、中国等地召开，形成了席卷全球的浓厚学术氛围。

虽然风俗文化不同，世界各地人们的睡眠神经控制系统却是一样的。每个人的睡眠基本机制，比如所需的睡眠长度、睡眠发生时间、睡眠阶段（包括深度睡眠、浅眠及做梦）及各睡眠阶段之间的转换过程等，都是大同小异的。同样，从生理角度来说，睡眠节律的日常运行受体温、新陈代谢及激素释放等因素影响，而儿童的生理机能、自我控制及睡眠节律的运行也不会因文化差异而产生本质的变化。

但是，撇开生理因素，在不同文化背景下，家长抚养孩子的方式及亲子间的互动也差异巨大。即使在美国这一个国家里，也存在着许许多多不同的育儿方法。因为文化与取向不同，家长们教育孩子的方法也截然不同。在亲子互动、睡眠习惯养成及睡眠环境等方面，不同家庭间的差异非常大。我想，在中国这样一个幅员辽阔、人口众多的国家，

肯定也存在着许多不同的育儿方法。在地区间，甚至邻里间，家长对孩子的抚养与教育方法可能大不相同。在我看来，这些差异的存在是非常有益的。

我对这些因文化不同而产生的差异很感兴趣，在写作本书时，我时刻将这一点牢记在心，尽可能给出不同的案例与方案，以帮助家长们确认孩子的症状，并选择既有利于孩子又符合家庭情况的治疗方案。我不希望我的读者群仅仅局限在某一类人、某一个地区，相反，我希望本书能帮助世界各地各种各样的家庭。

每个人的睡眠习惯不尽相同，有的甚至截然不同，但是，隐藏在差异之后的深层原理是相同的。这些年来，我们研究发现：

- **大多数一般性的睡眠问题出现在健康的儿童身上，这些孩子也没有潜在的疾病或精神问题；**
- **儿童在夜间多次醒来是很正常的一种现象；**
- **“梦游”之所以让人头疼，不是因为“游”这一行为，而是孩子在经历梦游后很难在毫无外界帮助的情况下自行再次入睡；**
- **一般性的儿童睡眠问题都非常容易矫正。**

此外，我们还发现，导致睡眠问题的原因主要有两类：行为习惯与生理节律。行为习惯方面的原因包括睡眠习惯、夜间哺乳习惯、喂食习惯、设定限制及焦虑。生理节律方面的原因则主要考虑人体内部系统（即生物钟），它控制了人体内多个系统的日常运作，包括夜间准时入睡及白天保持清醒。本书给出的建议与方案都基于以上发现，家长们可以根据实际情况与自己的育儿理念进行微调，然后付诸实践。

理查德·法伯

2012 年 12 月写于美国华盛顿

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS 第二版序

让孩子的睡眠问题迎刃而解

本书第一版出版于1985年，当时在医学领域，研究儿童睡眠问题还是一个非常新的课题。如今，睡眠的基本知识已经非常普及了。我提出的这套用来应对儿童睡眠问题的方法，被波士顿睡眠问题研究中心及其他世界各地的专业机构反复使用，效果非常显著，很多家长按照书中所教导的方法加以尝试都收获良多，给我写来感谢信，因为困扰他们数月乃至数年的问题都迎刃而解了。我之所以修订本书，主要有以下三个原因。

- 纠正一些关于本书提供的方法及其应用的普遍性误解。我写作本书的目的是帮助家长了解睡眠的基本原理及儿童睡眠问题的基本知识，从而自己判断并解决孩子的睡眠问题。此外，我设计的很多方法都是为了避免孩子长时间地哭闹，而不是对孩子放任不管。
- 深入探讨一些第一版中没有详细介绍的问题。读者们的意见及建议促使我探讨了很多以前忽略的问题，比如家长与孩子同床睡的情形、日间睡眠问题、双胞胎的睡眠问题、跨越不同时区所产生的睡眠问题等。
- 我希望将这些年来所积累的新经验、取得的新成果、获得的新发现展现给读者。

睡眠问题非常复杂，为了更好地了解与应对儿童睡眠问题，家长需要了解一定的睡眠知识。我建议读者先认真阅读第1、2、9、11章，这些章节会告诉你很多有关睡眠的基本知识。

在阅读其他章节时，读者要试着找到与自己孩子的睡眠问题相关的章节。大多数儿童的睡眠问题不止一个，睡眠问题之间也会交叉混合。例如，幼儿失眠最常见的原因是睡眠环境问题，但是要解决这个问题，仅仅阅读睡眠环境这一章还远远不够，家长需要全面了解其他相关知识，诸如如何设定限制、黑夜恐惧、作息时间规律及非正常觉醒等。如果你家宝宝有夜惊问题，你就需要了解生活习惯与作息规律对孩子睡眠的影响，然后才能采取适当的应对措施。下面，我给出一些具体的建议。

如果孩子梦游或夜惊：

1. 请阅读第 3 章及第 10 章，了解睡眠环境问题及如何设定限制，阅读第 7~8 章了解作息不规律行为，阅读第 13~14 章了解非正常觉醒及做噩梦。
2. 如果宝宝需要夜间哺乳，可以阅读第 4 章。
3. 如果宝宝对黑夜感到恐惧，可以阅读第 5 章。
4. 如果宝宝有腹绞痛或其他病理性问题，可以阅读第 6 章。
5. 如果宝宝还保持着日间睡眠习惯，或理应有日间睡眠却不肯睡，可以阅读第 12 章。
6. 如果宝宝在夜间会摇晃身体或用头撞击物体，可以阅读第 16 章。
7. 如果宝宝睡觉时打鼾，可以阅读第 17 章。

如果孩子白天总是昏昏欲睡：

1. 白天困倦的原因很可能是缺乏睡眠或作息不合理，可以阅读第 8 章和第 11 章。
2. 此外，还可以阅读第 12 章和第 18 章。

如果孩子尿床：

可以重点阅读第 15 章。

如果效果不明显，应该停止矫正，仔细阅读全书，再制定新的方案。另外，我可以在此保证，本书中的所有案例都来源于真实的病例。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS

目 录

中文版序 Ⅰ
写给全世界父母的儿童睡眠宝典
第二版序 Ⅲ
让孩子的睡眠问题迎刃而解

第一部分
睡眠知识入门

003 第1章 解决孩子“天生”的睡眠问题
你家孩子天生就睡不好吗/005
如何判断儿童是否出现了睡眠问题/006

009 第2章 关于睡眠，我们知道什么
非快速眼动睡眠/009
快速眼动睡眠/011
儿童睡眠阶段的发展过程/012
儿童睡眠周期/013
睡眠与觉醒规律/015
生物节律的重要性/016

第二部分
睡眠问题类型及解决方法

021 第3章 睡眠环境问题——引发睡眠问题的关键所在
由睡眠环境改变引发的睡眠问题/022

劣质睡眠环境/023
循序渐进法/025
整体矫正法与分步矫正法/031
戒掉奶嘴/032
关于孩子与父母一起睡的建议/033
循序渐进法收效不佳怎么办/035

039 第4章 夜间哺乳——另一个引发睡眠问题的关键
你家宝宝的睡眠问题是由夜间哺乳导致的吗/040
由夜间哺乳导致的睡眠问题的解决方法/041
夜间哺乳的几个要点/045

047 第5章 黑夜恐惧症
睡眠恐惧/048
评估孩子的恐惧程度/049
如何处理孩子的黑夜恐惧症/053
帮助孩子减少恐惧、使其快速入睡的方法/054

059 第6章 腹绞痛及其他影响睡眠的疾病
腹绞痛/059
慢性病/061
夜间疼痛症状/061
药物导致的睡眠问题/063
大脑功能异常导致的睡眠问题/064

066 第7章 第一类作息紊乱问题——睡眠阶段问题
睡眠阶段/066
睡眠阶段的变化/069
青少年的睡眠阶段变化/074

081 第8章 第二类作息紊乱问题——其他常见作息问题
规律作息前提下的其他睡眠问题/081
作息不规律或不持续导致的其他睡眠问题/089
跨时区旅行导致的睡眠问题/093

第三部分
养成规律的睡眠习惯

097 第9章 帮助孩子养成良好的睡眠习惯

睡前相处/097
仰卧能降低婴儿患猝死综合征的风险/099
孩子应不应该跟父母同床睡/101
孩子和家长一起睡的小常识/102
双胞胎和多胞胎家庭怎么办/106
为孩子挑选他最喜欢的玩具/108
帮助孩子养成良好的作息习惯/108

112 第10章 如何给孩子设定限制

谁说了算/112
给孩子设定限制的困难何在/113
多种问题交织出现/115
给孩子设定限制的方法/116
给孩子设定限制的实例分析/125

127 第11章 作息规律与生理节律

日夜节律与睡眠禁区/128
设定生物钟：确定自身的时间系统/130
个人差异：你是云雀还是猫头鹰/131
社会化剥夺了我们的睡眠/133
不同的睡眠问题影响不同的睡眠阶段/134

137 第12章 日间睡眠

日间睡眠的长度及时间点/138
取消日间睡眠的困难所在：过渡阶段产生的问题/145
孩子在家或在托儿所小睡/146

第四部分
非正常睡眠

149 第13章 非正常觉醒——说梦话、梦游、觉醒障碍、夜惊
非正常觉醒现象/150
非正常觉醒发生的原因：睡眠与觉醒的平衡/153
评估非正常觉醒的状态：何时叫醒孩子比较恰当/157
如何解决孩子的非正常觉醒问题/158
非正常觉醒案例回顾/161

167 第14章 做噩梦
孩子做噩梦时，家长应该怎么办/169
做噩梦与非正常觉醒/171

173 第15章 尿床
尿床的原因/173
尿床的解决之道/175

179 第16章 怪异而有节律的动作
家长应该何时干预怪异而有节律的行为/180
怪异而有节律的行为出现的根源/181
怪异而有节律的行为的解决方法/182

185 第17章 打鼾与睡眠呼吸暂停综合征
睡眠呼吸暂停综合征是怎么回事/185
什么导致了阻塞/187
睡眠呼吸暂停的治疗方法/189
有关睡眠呼吸暂停的注意事项/191

193 第18章 嗜睡症
嗜睡症对孩子的影响及症状/194
嗜睡症产生的原因/197
嗜睡症的治疗方法/199

SOLVE
YOUR CHILD'S
SLEEP PROBLEMS

第一部分

睡眠知识入门

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS

第1章　解决孩子“天生”的睡眠问题

我在波士顿儿童医院的儿童睡眠障碍中心工作时，经常会接到家长们打来咨询儿童睡眠问题的电话。每当我接起电话，家长们就会纷纷诉苦，比如绝望地说“我已经束手无策了”或者“我们已经智穷计尽了”。这样的电话接得多了，我也就自然而然能猜出他们接下来要说什么了。

通常来说，这些家长都有一个 5 个月到 4 岁大的孩子（大部分是家里的第一胎），这个让父母头疼的孩子要么无法安稳地一觉睡到天亮，要么会在夜里反反复复醒来。家长们疲于应对，表现得沮丧、筋疲力尽甚至怒气冲冲，家庭关系因此变得紧张。家长们开始怀疑，到底是遗传方面出了问题，还是自己没有尽到做家长的责任。

在我遇到的绝大部分案例中，家长们在打电话求助之前就已经咨询过身边的亲朋好友甚至儿科医生了，而他们得到的建议无非是“你就随他哭闹去吧，哭完了就消停了，不能太宠着他”，或者“这是挺自然的一个阶段，等他慢慢长大，自然就好了”。尽管家长们不想放任不理，但是在绞尽脑汁尝试了各种各样的办法都不奏效之后，就开始考虑破罐子破摔了。家长们越是绞尽脑汁去尝试各种办法，这种消极的放任情绪就来得越猛烈。迟早有一天他们会受不了，他们会想：“在我自己崩溃之前，这孩子能不能消停啊？”

一开始，事情还处于可控阶段，但是，如果孩子晚上睡不好，或者有其他闹心的睡眠问题，比如夜惊、遗尿、做噩梦或打鼾，要不了多久，你就会束手无策。但事情也没有想象中那么糟糕。**通过努力，绝大多数儿童的睡眠障碍都可以得到缓解，部分可以完**

全治愈。在这本书里，你可以找到睡眠问题的分类方法，从而自己为孩子确认症状。同时，本书也提供了很多解决问题的实用方法供家长们参考。

我在儿童睡眠障碍中心工作时，通常会同时会见家长与孩子，和他们一起探讨如何解决孩子的睡眠问题。我会详细询问孩子的睡眠情况，搞清楚睡眠问题的发作频率与持续时间、发作时症状如何、在症状出现时家长采用的处理方法以及家族病史及其他可能影响睡眠的因素。了解以上信息之后，给孩子进行体检，个别案例再辅以实验室研究，一般情况下，我都能准确判断出睡眠障碍类型与起因，从而与家长一起解决问题。我们通常不采用药物治疗，而是与家长一起给孩子制定新的作息规律，探讨新的应对方法。

治疗中，需要矫正儿童的生物节律，至少需要重新制定作息规律，让儿童适应新的入睡时间，母亲们则要减少夜间喂食。在此过程中，家长们需要正确掌控孩子的行为，适当地激励孩子。

我通常会不厌其烦地与家长们讨论治疗方案的每一个细节，让他们赞同这个方案并且有自信从始至终贯彻它。因此，在讨论中，我尽量让家长来做选择。每个家庭的文化背景与社会层次都不同，最佳治疗方案也大相径庭。如果孩子年纪稍大一点，我们会征求他的意见。这样得出的方案才能恰如其分地符合每一例个案。

儿童睡眠障碍既不是家长失职导致的，也不是一个所谓的“自然阶段”可以等它自然度过，有睡眠障碍的儿童通常没有任何生理问题和精神障碍。在不同的家庭和社会环境中，儿童睡眠障碍是普遍存在的，而通过适当的治疗，绝大部分症状都能得到缓解。

我们对不同类型的睡眠障碍采取“分而治之”的方法。如针对睡眠中的呼吸暂停综合征，我们通常给予药物治疗，或者辅以外科手术。而在应对抑郁性嗜睡、做噩梦、夜惊或黑夜恐惧症等障碍时，我们则更多地考虑情绪因素。总之，准确判断病因非常重要，唯有如此才能对症下药。

儿童的睡眠状况不仅会影响其以后的行为习惯，更会影响家长对孩子的评价。我常常听到家长们说：“我的孩子真是个好孩子，不哭不闹，等我们摇他，他才醒来吃奶。”尽管家长们说的是婴儿睡眠状况良好，但这种评价不由自主地就有了道德评价的意味，

在他们看来，不哭不闹的孩子是“好”孩子。

这种评价很容易影响家长对待孩子的态度。如果孩子有睡眠问题，家长就会焦躁不安，会很自然地将这样的孩子称为“坏”孩子。如果夜夜都要照顾一个哭闹不休的孩子，反复起来安抚他，家长的睡眠就会完全被剥夺，如果情况严重，家长的负面情绪还会延续到第二天白天，他们会感觉心力交瘁。此时，家长与孩子间的关系就会变得紧张，甚至波及与配偶、朋友的关系。如果你正在遭受如上所述的痛苦生活，那我可以肯定地告诉你，你的孩子可以睡得更好，你也可以睡得更好，而解决之道就从准确判断孩子睡眠障碍的类型开始，循序渐进，找出治疗方案。

你家孩子天生就睡不好吗

如果孩子在睡眠中躁动不安，家长们通常会认为孩子天生就睡不好，或者天生就比同龄人睡得少。这种看法真是大错特错，只要不是患有严重的生理或心理疾病，所有的孩子都可以睡得很好。

事实上，家长们的错误看法在医院产房里就产生了。我听过产房护士跟孩子家长说：“你的孩子根本不睡觉，你可有得受了！”由于家长们深信自己的孩子天生就睡不好，所以他们对孩子的睡眠障碍不闻不问，任由他养成错误的睡眠习惯。其实，这些“天生”睡不好的孩子，只要稍加治疗，就能成为优质睡眠宝宝。

睡眠好坏因人而异。有的孩子天生就拥有优质睡眠习惯，他们在出生后几周内，夜里根本不哭不闹，喂奶时家长甚至要主动唤醒他们。随着年龄的增长，他们仍旧保持着婴儿时期的睡眠习惯，无论周围环境如何，他们都能自顾自地酣然大睡。而有的孩子就不一样，任何打乱他们睡眠作息的事都会让他们睡不安稳，家长通常觉得他们是“夜游神”。但是，如果对他们的作息时间与睡眠习惯做适当调整，他们也会睡得很好。

还有的孩子有很严重的睡眠障碍。对这些孩子来说，行为矫正的作用不大，他们通常需要药物治疗。患有极度严重的睡眠障碍的人少之又少，十有八九你家宝宝的睡眠问题是可以治愈的。即使你家宝宝表现出某些睡眠障碍，比如梦游或遗尿，也不用担心，这些症状通常出现在睡梦中或半梦半醒时，比起失眠当然是复杂多了，但是通过正确的治疗是可以缓解甚至痊愈的。

如何判断儿童是否出现了睡眠问题

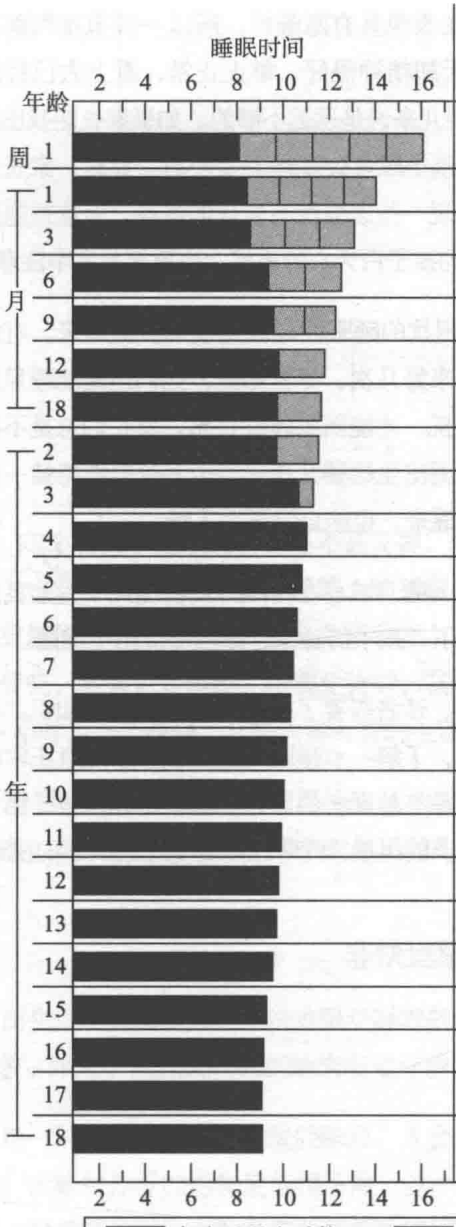
只要孩子的睡眠习惯让他自己或家长感到困扰，那就是有了睡眠问题。睡眠问题有的是显性的，很容易被家长察觉；有的却是隐性的，很容易被忽略。例如，如果孩子总是跟你抱怨他无法安然入睡，或者夜间你总是被他吵醒，那很明显你的孩子有睡眠问题。事实上，常见的睡眠问题是很容易被察觉的，如夜间入睡困难，睡眠中易醒、需要家长安抚才能继续入睡，早晨醒不过来或醒太早，日间昏昏欲睡。另外，夜惊、梦游、遗尿等症状也是非常明显、容易辨认的睡眠问题。

然而，有时候家长很难判断孩子是否有睡眠问题。如果孩子晚上睡得少，白天还是神采奕奕，家长们就吃不准实情了。同样，如果孩子双休日睡得很足，到了星期一却还是打不起精神来，家长们也会非常困惑。家长和老师可能会以为孩子在课堂上呼呼大睡是因为对学习提不起兴趣，事实上孩子很可能是没有休息好或者患有嗜睡症。

家长会觉得孩子变得懒散与易怒了，殊不知在他的行为背后隐藏着更深层次的原因——他有睡眠问题亟待解决。有的家长觉得孩子睡得很好，都打鼾了，却不知道打鼾可能正反映出他在睡眠中呼吸不顺畅，从而干扰他的睡眠，让他在白天变得疲劳与易怒。

在诸多睡眠问题中，最不被重视的恐怕就是“睡不够”了。每个孩子每天需要的睡眠时间并没有标准值，所以很难单单从时间长短来判断孩子到底有没有得到充足的休息。图 1—1 显示了各个阶段的未成年人每天所需的平均睡眠小时数，包括夜间睡眠与白天打盹。婴儿在出生几个月后，每天所需的睡眠时间就减少到 11 或 12 小时，并随着年龄的增长逐渐减少。同龄的未成年人在睡眠总时长上相差无几，但分配睡眠的方法大相径庭。比如，同样是 9 个月大的婴儿，有的习惯在夜间睡 9 个小时，在白天打两次盹，每次持续 90 分钟左右，而有的却习惯在夜里睡足 12 小时，白天根本不打盹。

一般来说，正常的孩子应该很容易入睡，睡眠质量非常高，在早晨能自行醒来，白天小睡的时间也应该与其年龄相符。如果你的孩子白天举止正常，作息规律，那他应该是睡眠充足的，相反，如果你的孩子早上叫不醒，或者周末会赖床一两个小时，那他很可能没有睡够。尤其是当孩子白天昏昏欲睡，或者到了下午明显表现出注意力不集中，行为举止异常，那十有八九他没有睡够。



年龄		睡眠时长	正常范围	夜间睡眠	白天睡眠	打盹次数（每次半小时至2小时）
周	1	16	14 ～18	不定	不定	不定
月	1	14	$12\frac{1}{2}$～$15\frac{1}{2}$	不定	不定	不定
	3	13	12 ～14	$8\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	3～4
	6	$12\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$～$13\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{4}$	2～4
	9	$12\frac{1}{4}$	$11\frac{1}{4}$～$13\frac{1}{4}$	$9\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	2
	12	$11\frac{3}{4}$	11 ～$18\frac{1}{2}$	$9\frac{1}{4}$ –$10\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$ –$2\frac{1}{2}$	1～2
	18	$11\frac{5}{8}$	11 ～$12\frac{1}{4}$	$9\frac{5}{8}$	2	1
年	2	$11\frac{1}{2}$	11 ～12	$9\frac{5}{8}$	$1\frac{7}{8}$	1
	3	$11\frac{1}{4}$	$10\frac{3}{4}$～$11\frac{3}{4}$	$9\frac{3}{4}$ –$11\frac{1}{4}$	0 –$1\frac{1}{2}$	0～1
	4	11	$10\frac{1}{2}$～$11\frac{1}{2}$	10 –11	0 –1	0～1
	5	$10\frac{3}{4}$	$10\frac{1}{4}$～$11\frac{1}{4}$	$10\frac{3}{4}$	0	0
	6	$10\frac{1}{2}$	10 ～18	$10\frac{1}{2}$	0	0
	7	$10\frac{3}{8}$	$9\frac{7}{8}$ ～$10\frac{7}{8}$	$10\frac{3}{8}$	0	0
	8	$10\frac{1}{4}$	$9\frac{3}{4}$ ～$10\frac{3}{4}$	$10\frac{1}{4}$	0	0
	9	$10\frac{1}{8}$	$9\frac{5}{8}$ ～$10\frac{5}{8}$	$10\frac{1}{8}$	0	0
	10	10	$9\frac{1}{2}$ ～$10\frac{1}{2}$	10	0	0
	11	$9\frac{7}{8}$	$9\frac{3}{8}$ ～$10\frac{3}{8}$	$9\frac{7}{8}$	0	0
	12	$9\frac{3}{4}$	$9\frac{1}{4}$ ～$10\frac{1}{4}$	$9\frac{3}{4}$	0	0
	13	$9\frac{5}{8}$	$9\frac{1}{8}$ ～$10\frac{1}{8}$	$9\frac{5}{8}$	0	0
	14	$9\frac{1}{2}$	9 ～10	$9\frac{1}{2}$	0	0
	15	$9\frac{1}{4}$	$8\frac{3}{4}$ ～$9\frac{3}{4}$	$9\frac{1}{4}$	0	0
	16	$9\frac{1}{8}$	$8\frac{5}{8}$ ～$9\frac{5}{8}$	$9\frac{1}{8}$	0	0
	17	9	$8\frac{1}{2}$ ～$9\frac{1}{2}$	9	0	0
	18	9	$8\frac{1}{2}$ ～$9\frac{1}{2}$	9	0	0

图 1—1　未成年人睡眠时间参考值

尽管我们可以通过仔细观察儿童白天的行为举止来判断其是否昏昏欲睡或举止异常，但是，由于儿童缺乏足够睡眠的外在表现具有隐蔽性，所以一般很难判断。例如，一个两岁的婴儿晚上只睡 8 小时，白天却精神很好，举止正常，看上去已经睡够了。可是，8 小时的睡眠时间对一个两岁的婴儿来说是远远不够的。如果家长能找出孩子只睡 8 小时的原因，并及时作出调整，那么孩子应该会多睡 1~2 小时。此时，家长会发现孩子的行为举止有了很大的改善，然后发现一些之前没有发现的征兆，而这些隐蔽的征兆正显示出孩子睡眠不够充足。睡眠充足的孩子白天心情更好，也更容易集中注意力。

除了“睡不够”，另一个常常让人感到困扰的睡眠问题就是夜间多次醒来。有的儿童（通常在 6 个月到 3 岁之间）会在夜里醒来好几次，尽管如此，他们还是能睡足所需的睡眠时间。他们每次醒来，都需要家长安抚，才能回到睡眠状态。家长们总是不能确定这样的状况是否正常。一般来说，一个足月出生的婴儿在三四个月时就能持续一整夜的睡眠状态了，也就是说，他们即使在夜间醒来，也能自己再次入睡。

五六个月的孩子在夜间醒来后无法自己入睡，或者在持续几周甚至几个月的良好睡眠后又开始在夜间频繁醒来，家长就要注意了，孩子的睡眠连续性可能出了问题。

在探讨具体的睡眠问题及解决方法之前，读者需要了解一些睡眠的基本知识。尽管不必对所有的睡眠研究成果烂熟于心，但是，了解一点睡眠的基本概念、儿童正常睡眠习惯的养成、错误睡眠习惯类型等知识，也是有益无害的。它们能帮助你在孩子错误睡眠习惯的萌芽阶段提高警惕，在其养成阶段予以纠正，同时预防其他睡眠问题的出现。

第2章　关于睡眠，我们知道什么

尽管对于睡眠的研究还不甚完善，但是，对睡眠期大脑活动的研究已经有了许多进展，比如对睡眠期大脑活跃与静止的区域的研究，以及对神经递质（在化学突触传递中担当信使的特定化学物质）被释放或阻断的情况的研究。尤其是对生物钟的研究，成果更是丰硕。所谓生物钟，其实就是控制人体作息的一种生理机制，通常以 24 小时为一个周期，几乎人体所有的生理系统都要受它左右。

20 世纪 50 年代之前，学界一直认为睡眠是与清醒迥异的单一状态。不过现在我们知道，睡眠的过程包含了两个截然不同的状态：非快速眼动睡眠与快速眼动睡眠。

非快速眼动睡眠

出生几个月后，人的非快速眼动睡眠就逐渐发展为 4 个明确的阶段，在实验室通过脑电波、眼动、肌张力检测就能清晰地分辨出每一个阶段。

第一阶段是开始进入睡眠的阶段，人会感到倦意袭来，眼球在眼睑下无意识地缓慢移动，大脑对外界的感知度慢慢下降。这一阶段是觉醒与非快速眼动睡眠的过渡阶段。在第二阶段开始时，大脑会产生短暂的睡眠梭形波和慢而长的 K- 复合波，这就是浅眠阶段。在这一阶段，人很容易醒来，而且会感觉自己并没有入睡。当然，每个人进入第二阶段的时间长短不同、睡眠深度不同，这种感觉会因人而异。

接下来是第三阶段，人体静止，大脑进入更深的睡眠中。最后是第四阶段，即深度睡眠阶段。由于这两个阶段非常类似，我们可以将其合在一起进行考察。在这两个阶段，浅眠终止，睡眠梭形波消失，取而代之的是缓慢而持久的 δ 波。此时，人体呼吸平稳，心跳规律，发汗功能增强，不易清醒。如果此时有人大声叫睡眠者的名字，睡眠者也不会像在第二阶段那样轻易醒来，相反，睡眠者对声音的敏感度在下降。图 2—1 显示了清醒与睡眠时的脑波情况。

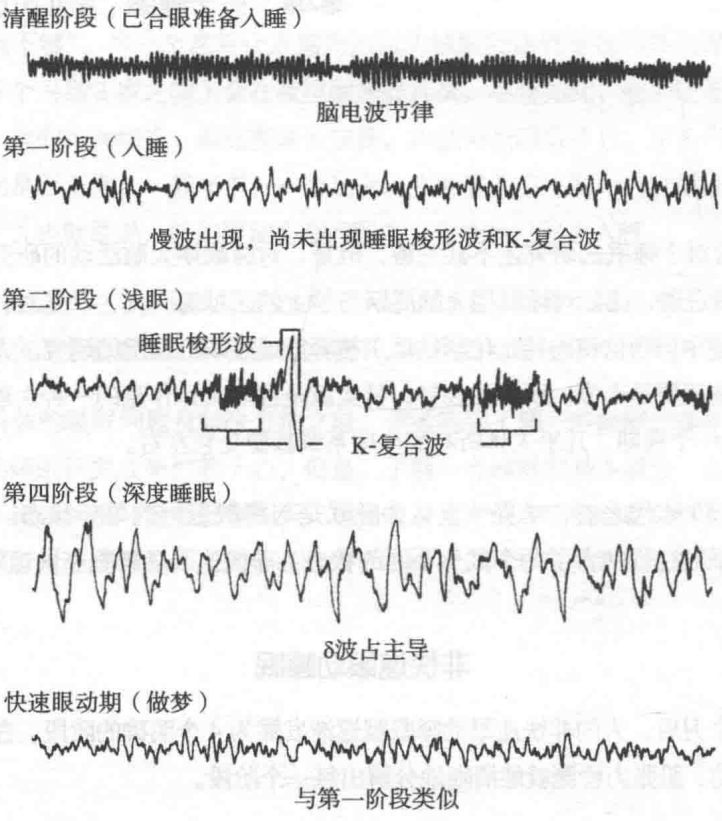


图 2—1　清醒与睡眠时脑波图形对比

当然，如果外界刺激足够强烈，即使是处于第四阶段也能被唤醒，大脑仍旧能处理外来信息。例如，在需要起来喂孩子的时候，家长可能会醒不过来，这时如果有人大喊“着火啦”，家长就会马上醒来。但是，此时即使能马上醒来，大脑也仍旧处于混沌状态。

在非快速眼动期，人体肌肉比清醒时放松得多。你可以移动身体，但是由于大脑不再向大多数肌肉传递移动身体的信号，所以在这一阶段，人始终躺在床上，而诸如梦游、睡眠中撞头等症状则属于不合常规的例外了。

当人类从非快速眼动期醒来时，会对身边环境中的异常因素特别敏感，例如房间中残留的烟味、楼梯上的脚印、隔壁房间传来的轻声抽泣。如果一切安全无虞，人就会自然而然地再次进入睡眠状态，而到了第二天早晨，根本不会记得头天晚上曾经醒来过。

快速眼动睡眠

在经历一两个非快速眼动期之后，人体进入快速眼动阶段，这是一个截然不同的新阶段。此时，呼吸与心跳变得不再规律，反射系统、肾功能与激素放射类型发生变化，体温调节系统削弱，人体不再出汗，也不会发抖。男性此时可能会出现勃起，女性则可能出现阴蒂变大、排经量增加等现象。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

快速眼动期是一个比较活跃的睡眠阶段。在这一阶段，人体的氧气消耗量大增，消耗更多的能量。大量血液涌向大脑，大脑温度上升，脑电波频率加快，显示出睡眠与清醒皆有的混合波形。在这一阶段，思绪逐渐“清醒”，但大脑只处理来自身体内部的信息，而无法处理外界信息，所以此时人会做奇奇怪怪的梦。

在这一阶段，人体肌肉，尤其是头部与颈部肌肉极度放松，原本应该在到达脊椎后继续传导至骨骼肌的神经冲动被阻滞在脊椎内，所以此时人体近乎“瘫痪”：大脑虽然仍旧向骨骼肌发出指令，但是这些指令却被阻滞，根本无法到达骨骼肌。由于这种阻滞是不完全阻滞，某些强烈的指令仍旧能到达指定肌肉，诸如控制眼球运动、呼吸、心跳的肌肉就能顺利获得指令，而这也是出现小幅度的手臂、双腿、脸部抽动的原因。

由于婴儿的神经系统尚未发育完全，他们会比成年人有更多的神经冲动传递到肌肉，因此，婴儿在快速眼动期可能会出现痉挛、狞笑、抽搐、踢蹬等现象，甚至还会发出声音。当然，即便如此，婴儿也无法站立起来四处走动。到 6～12 个月大时，随着身体机能的完善，原本能传递出去的神经冲动被阻滞在脊椎中，他们的睡眠就安稳多了。

快速眼动期最显著的特征就是快速眼球运动。在眼球快速运动时，心跳加速，血压上升，呼吸加快，大量血液涌向大脑，且都呈现出不规律状态。此时如果从睡眠中醒来，人会觉得自己刚刚做了一个梦，而梦的长度与快速眼动期持续的时间长度相当。

要把一个人从快速眼动期唤醒有时很容易，有时却很难，关键看给予的外界刺激是否足够强烈，以及睡眠者当时处于多深的梦境之中。因此，当处于美梦中时，闹钟可能无法将睡眠者唤醒，睡眠者甚至可能反过来将闹铃声添加到梦境中去。相反，如果此时防贼警报响了，睡眠者就可能从床上一跃而起，大脑立刻就处于完全清醒的状态，这与上文提到的从第四阶段醒来的“清醒”有着巨大的不同。

综上所述，人类从清醒到睡眠经历了三个截然不同的阶段。

- 在清醒阶段，人理性而又自主，能照料自己，满足生存所需。
- 在非快速眼动期，人体与大脑都处于休息状态，人体进入自我修复模式。
- 在快速眼动期，大脑重新进入活跃状态，但是思维并未恢复，肌肉无法获得大脑指令而处于静止状态，即使大脑给出指令，人体也无法动弹。

儿童睡眠阶段的发展过程

婴儿在出生前，其睡眠形态就已经在形成之中了。6~7 个月的胎儿就已经出现快速眼动睡眠了，此后再过一个多月，就会出现非快速眼动睡眠。对胎儿或婴儿来说，快速眼动睡眠意味着“活跃睡眠”，而非快速眼动睡眠则代表“静止睡眠”。到 8 个月左右，胎儿的这两个睡眠阶段就建立得非常完善了。在婴儿阶段，“活跃睡眠”是非常容易辨识的，处在这一睡眠阶段的婴儿通常会出现抽动，呼吸也不规律，眼球在眼睑下快速转动。而在“静止睡眠”中，婴儿的呼吸变得绵长，身体静止不动，偶尔会出现吮吸的动作或身体突然一动。

婴儿的“静止睡眠”与年龄稍大的儿童或成年人的非快速眼动睡眠有一定的差别。“静止睡眠”中的大脑会集中出现很多慢波，而不是连续出现。在婴儿出生后的第一个月里，非快速眼动期的脑电波就会变得连续；到一个月之后，睡眠梭形波就会出现；再过 1~2 个月，其非快速眼动睡眠就能分为深和浅两个阶段了。到婴儿 6 个月大时，就会出现 K-复合波，这标志着婴儿已经具备成熟的非快速眼动睡眠了。

相较于非快速眼动睡眠，快速眼动睡眠的形成要早得多。早产儿有 80% 的睡眠时间花在此阶段上，足月出生的婴儿则在此阶段花了 50% 的睡眠时间。胎儿在非快速眼动期是不做呼吸运动的，如果胎儿在成长中从来没有练习过如何呼吸，那他出生后很可能因为缺乏经验而不能调动呼吸所需的肌肉群，也就无法生存。然而，快速眼动期婴儿却可以获得这种练习，这是因为胎儿神经冲动的阻滞效果不如成年人，所以在这一阶段他们仍旧可以自由活动肌肉群。

也许对胎儿的成长与婴儿的早期发育来说，快速眼动睡眠至关重要，但是随着年龄的增长，这种重要性也在逐渐降低。事实上，尽管一个足月的婴儿在刚出生时将睡眠总时数的一半以上花在快速眼动期，到了三岁左右，这一比例就会下降到 1/3，等到进入儿童阶段或者青少年阶段，这一比例会下降到 1/4 左右。

儿童睡眠周期

儿童和成年人的睡眠周期通常是由交替出现的快速眼动期与非快速眼动期组成的。在儿童的成长发育过程中，一旦非快速眼动期发展出了明显不同的 4 个阶段，其夜间睡眠就成了一个完整的过程，这种规律出现的阶段交替会伴随他们一生。所以了解儿童睡眠周期的相关知识非常重要，有助于家长及时发现孩子潜在的睡眠问题。

从婴儿到青少年，人类睡眠周期的长度从 50 分钟逐渐增加到 90 分钟，同时，快速眼动睡眠总量与快速眼动睡眠量占全部睡眠量的比例都在不断降低。在这一阶段，随着睡眠总量的减少，非快速眼动期第四阶段的睡眠量也在减少，但是，其所占睡眠总量的比例仍旧维持在 25% 左右。成年人进入深度睡眠通常需要一个循序渐进的过程，儿童则不然，他们从睡意袭来那一刻或非快速眼动期的浅眠阶段进入非快速眼动期第四阶段只需要短短几分钟的时间（见图 2—2）。

对儿童来说，非快速眼动期第四阶段是极度深眠阶段，想要把孩子从这个阶段唤醒，简直是不可能完成的任务。儿童进入这一阶段后会持续一两个小时，之后进入一个短暂的半清醒期，短则数秒，长则几分钟。此时儿童的脑电波会发生显著变化，深眠、浅眠、昏昏欲睡、清醒等多种睡眠特征交替出现。此外，在这一阶段，儿童还会伴有一系列肢体动作，比如抓脸、咀嚼、翻身、啜泣、喃喃自语等，甚至可能短暂地睁开双眼或者突然坐起来。

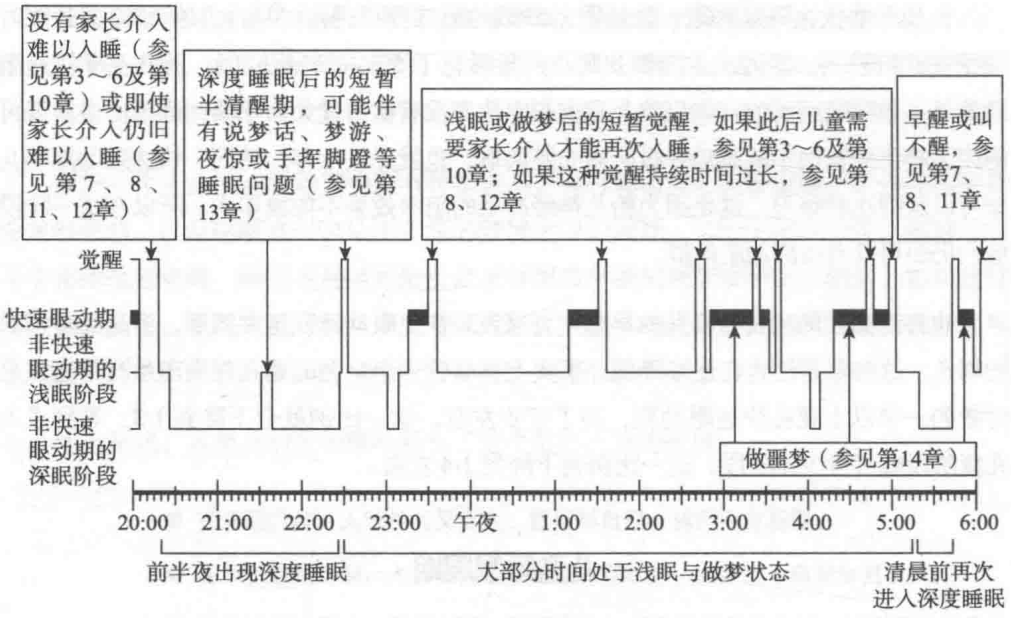


图 2—2　儿童睡眠阶段发展图

事实上，这个从非快速眼动期觉醒的半清醒状态会出现一系列状况，严重一点的会发展为梦游、夜惊、手挥脚踢等，此时儿童的脑电波同时具有清醒与睡眠两种特征。这些问题不是由做梦引起的，因为梦只产生于快速眼动期。

半清醒阶段后，会紧接着出现一个类似于入睡或快速眼动期开始时的阶段，儿童一般会跳过这个阶段。儿童的第一个快速眼动期无论何时出现都维持在 5～10 分钟，不会表现出频繁的眼球运动，心跳与呼吸也都保持平稳。

这个短暂的“类快速眼动期”过后，儿童就开始进入新一轮的非快速眼动期，再次进入深度睡眠。尽管不如第一个睡眠周期时那样迅速，儿童仍旧能在最短的时间内再次进入第四阶段。这一周期的深度睡眠维持在半小时至两小时之间，此后紧接着出现的觉醒阶段则标志着整个深度睡眠期的结束，通常这一整个深度睡眠期占据了整个夜间睡眠的前 1/3。因此，儿童入睡后的 3～4 小时是其深度睡眠期。

终止深度睡眠的觉醒阶段出现后，紧接而来的就是持续 5～20 分钟的快速眼动期，在这一阶段，儿童会多次醒来，并再次快速入睡。（婴儿的快速眼动期非常不稳定，总是会被短暂的身体移动造成的觉醒打断，到 6 个月大时，随着各项身体机能的发育，其快速眼动期就变得连续多了。）

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

婴儿的快速眼动期是非常不稳定的，总是会被短暂的身体移动造成的觉醒所打断，到了6个月大时，随着各项机能的发育，身体抑制神经冲动的能力逐渐增强，其快速眼动期就变得连续多了。

快速眼动期结束时，会出现新的短暂觉醒阶段，此时儿童会移动身体、调整睡姿、无意识地睁开眼看看周围一切是否如常，然后再次入睡。这个短暂的觉醒阶段非常有意义，调整睡姿有助于儿童皮肤、肌肉、关节的生长发育，也能让儿童观察到周围的环境是否和入睡时一样。

第一个快速眼动期结束后，进入睡眠的中间部分，由一个相对浅眠的非快速眼动期和一个紧随其后的更持久更强烈的快速眼动期组成，通常持续4小时左右。清晨到来前，儿童会再次进入有着深度睡眠的第四阶段，通常持续一两个小时。如果儿童直接从第四阶段醒来，就会表现得闷闷不乐或者哭闹不休。

睡眠与觉醒规律

刚出生的婴儿一天大概要睡16个小时，这16个小时并不是连续的，而是以数小时为一个阶段间隔出现。一般来说，婴儿在一天中会经历7个“睡眠—觉醒”阶段。这些阶段短则20分钟，长则5~6小时，以一个快速眼动期开始，分别表现出几个“快速眼动期—非快速眼动期”周期。出生后的几周内，婴儿的睡眠规律非常混乱，睡眠时间长短不一，何时入睡、何时醒来也没有固定模式，而且似乎一天一个样。

当婴儿三个月大时，日间睡眠固定为三个小睡阶段，第一个阶段出现在早饭与午饭之间，第二个阶段出现在午饭与晚饭之间，第三个阶段出现在晚饭与夜间入睡之间。3~4个月大的婴儿每天要睡13个小时，逐渐形成固定的睡眠规律，通常分为4~5个规律的睡眠阶段，而且2/3的睡眠发生在夜间。此时，白天睡眠与夜间睡眠已经能够清楚地分开，绝大部分夜间时间都花在睡眠上。

到6个月大时，几乎所有的婴儿都有了固定的睡眠规律，夜间持续睡眠时间也进一步延长。一个3~6个月大的婴儿每天需要睡12~13个小时，通常夜间睡眠量要达到9小时25分钟以上（如果日间睡眠不足，其夜间睡眠就会达到11个小时）。另外，这个年纪的婴儿每天需要补充两次日间睡眠，每次持续1~2小时，一次在早饭与午饭之间，

通常是上午 9:30～10:30，一次在下午吃点心时，通常是 14:00～15:00。

一岁左右时，绝大多数幼儿每天需要 12 个小时左右的睡眠，其中 9～10 小时发生在夜间。日间睡眠减少为一次，时间则变为 12:30 或 13:00，这个时间段刚好在以前两个小睡的中间。到了两岁，儿童每天需要的夜间睡眠为 9～10 小时，午后需要一个 1～2 小时的午睡，总睡眠时间达到 11 个半小时。

到了三四岁，绝大多数儿童都会逐渐停止睡午觉，转而在夜间睡得更久，其夜间睡眠时间可以达到 11 个小时。如果儿童过早停止日间小睡，将全部睡眠时间集中到夜间，其日间活动机能也许会受到限制。此时，若将夜间睡眠时间减少到 9～10 个小时，日间小睡就会自然而然地再次出现。有些儿童在特定环境下会恢复日间小睡的习惯，例如，在让人昏昏欲睡的环境下或待在托儿所、幼儿园，但是，一旦这些外界环境改变，孩子就会拒绝日间小睡。

从三岁开始直到成年为止，孩子的睡眠在逐渐减少。一旦过了蹒跚学步的时期，他就极少在日间小睡了，其夜间睡眠时间也在减少，学龄前保持在 11 个小时左右，到青少年时期就减少到 10 小时左右了。5～12 岁的儿童保持清醒的程度最高，他们拥有优质的夜间睡眠，白天神采奕奕，几乎都不需要日间睡眠的补充。

青春期青少年的睡眠规律会发生许多变化，但是其睡眠所需的基本时间仍保持不变。14～17 岁的青少年每天仍旧需要 9 个小时左右的睡眠来维持日间生理机能的正常运作，事实上，一般的青少年每天都要睡 9 小时以上，尤其是在周一到周五。

生物节律的重要性

为了更好地研究儿童睡眠问题，我们需要探究睡眠规律本身，这就不可避免地引导我们去研究控制睡眠规律的生物节律。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

“日夜节律”指生物以 24 小时为周期的生理规律，人体有很多这样的节律，包括睡眠与清醒、人体机能的活跃与抑制以及吃饭喝水、体温与激素水平。人的入睡与清醒都与这些节律有关。通常来说，人在入睡时体温会降到一天中的最低值，当体温上升到某一个峰值时，人就会醒来。

我们需要关注一个重点，那就是人的很多生命节律的周期都比 24 小时要长，大概会相差几分钟，就是这几分钟导致了很多差异。然而，日落之后的人造光源与日出之后人为制造的黑暗环境都会使人体的生命节律变缓慢，使其拉长到 25 个小时左右。

当然，如果我们作息规律，保持 24 小时的生物节律一点都不困难，只有当我们的作息规律被打乱，在不该睡的时候想要入睡，才会感觉不适应。需要轮班的职员、青少年、跨过时区需要倒时差的旅行者，由于其睡眠规律被打乱，会感到非常不适应，有些会出现睡眠问题，而那些跨时区旅行者则通常会患“时差综合征”。

生物节律控制着睡眠规律，作息不规律会影响这些规律的运行，由此导致睡眠问题的产生。维持良好的日夜节律有助于提高睡眠质量及日间生理机能的正常运作，对于很多与日夜节律有关的睡眠问题，应该首先考虑调整与校正节律，使之正常化。

SOLVE
YOUR CHILD'S
SLEEP PROBLEMS

第二部分

睡眠问题类型及解决方法

SOLVE
YOUR CHILD'S
SLEEP PROBLEMS

第二部分

睡眠问题和应对方法

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS

第3章　睡眠环境问题——引发睡眠问题的关键所在

绝大多数婴幼儿是无法独自入睡的，他们需要家长陪伴在旁，抱着他们，哄着他们，安抚他们。夜里他们可能会多次醒来，又哭又闹。如果跟家长一起睡，他们就会吵着要钻到父母怀里。每一次孩子醒来，家长都要跟着醒来，重新哄他们入睡。反复几次之后，家长就会感到筋疲力尽，甚至对孩子心生怒意。

这种情况是正常的。家长可以查明问题的症结所在，然后对症下药。如果孩子在三个月后还不能自己入睡，夜间频繁哭闹，家长就要注意了，因为一般情况下，这个年龄的孩子已经能够自己入睡了。如果到了 5 个月左右，孩子还是在夜间频繁醒来，家长就必须采取应对措施了。

问题通常出在睡眠环境上。所有的孩子都会把特定的外界环境与睡觉联系起来，也就是说，如果孩子身处卧室，躺在床上或摇篮里，身边放着入睡时抱着的玩具或小毯子，他就会意识到该睡觉了。到了半夜，绝大多数孩子会在睡眠周期转换的间隙醒来，如果发现环境有了变化，他们就无法再次安然入睡，因为周围的环境对他们来说已经处于不可控的状态了。此时就需要家长的介入，帮助他们再次入睡。

并不是所有的儿童都会因为睡眠环境而产生睡眠障碍。例如，有的家长每晚都抱着孩子，轻轻摇着他使其入睡，如果孩子一夜好眠，醒来后也能自己再次入睡，家长就不必担心了，继续这样摇着他入睡也没事。但是，如果孩子对家长摇着他入睡产生了依赖，不摇就不睡，或者入睡变得困难，夜间清醒的时间变长，家长就需要采取相应的措施。

由睡眠环境改变引发的睡眠问题

我曾经接触过一个名叫贝茨的小女孩。她在三个月左右就能自己一觉睡到天亮了，但是，在那之后，她的睡眠质量一落千丈，会在夜里反复醒来。我见到贝茨的时候，她已经10个月大了，夜里仍旧反复醒来。她无法独自入睡，需要家长轻轻摇着她、摸摸她的背哄她入睡，这个过程要持续20分钟。

她的父母告诉我，她有时候明明开始打瞌睡了，却会忽然睁开眼睛，四下张望，然后继续打瞌睡。父母将她放到婴儿床上之后，她顶多安安稳稳地睡15分钟，然后就会醒来，又哭又闹，家长只好再抱她起来哄她入睡。有时候，家长将她放在婴儿床上，轻轻摸着她的背哄她入睡，一旦停止，她就会立刻醒来。

贝茨只有在极度困倦的时候才会好好睡上几个小时，可是从半夜开始到凌晨4点的这段时间，她会数次醒来，哭闹不休。一旦醒来，就无法再次自己入睡。奇怪的是，在凌晨4点到6点这段时间她会睡得很好，但早晨往往是哭着醒来。贝茨有在白天小睡的习惯，早晨一次，下午一次，每次小睡都要家长哄着，跟晚上睡觉前一模一样。

贝茨的父母绞尽脑汁，试过了所有能想到的办法。有时候实在没办法了，他们就放任女儿哭闹15~20分钟，然后再过去哄她，但是这个方法也没有效果。有一次，他们带着贝茨去看医生，医生建议他们放任女儿哭闹，等她哭闹累了，自然就会睡了。这对可怜的父母就照做了，可是贝茨一直哭，不但丝毫没有停止的迹象，反而越哭越厉害。一个半小时后，这对父母再也忍不住了。他们冲进房间，安抚贝茨，像往常那样轻轻摇着她，哄她入睡。从那以后，他们再也不敢放任贝茨哭闹了。

试过所有方法之后，贝茨的父母只好求助医生，希望医生能给贝茨开一些药。医生给贝茨开了抗组胺剂，贝茨吃了一个礼拜，效果并不太好。虽然她晚上入睡得稍微比以前快了点儿，但是半夜频繁醒来与白天小睡需要人哄的问题都没有改善。

贝茨这样的情况是很普遍的，对家长的“杀伤力”很大。但是，只要明白症结所在，解决起来也不难。儿童的睡眠周期在运作过程中会出现阶段与阶段间的转换，在转换的间隙，就很容易醒来。事实上，家长在孩子醒来后去安抚他们，试图帮助他们再次入睡，

这本身就是对睡眠的一种干扰，或者说是在变相地巩固这种夜间的频繁清醒状态。

拿贝茨来说吧。贝茨在入睡时父母总是摇着她、哄着她、摸着她的背，可是当她在半夜醒来时，却发现自己独自躺在婴儿床上。她无法自己再次入睡，不是她不想，而是她不知道应该怎么做，所以她只好哭闹，而此时父母的介入刚好阻碍了她自己入睡的努力。如果家长一直哄她入睡，那她就永远学不会自己入睡。我认为，孩子在半夜醒来根本不是问题的关键所在，关键在于孩子在醒来后因为睡眠环境发生改变而无法自己再次入睡。

睡眠环境在成年人的睡眠中也扮演着举足轻重的角色，所以，我们可以通过分析成年人的睡眠环境问题来理解儿童的睡眠环境问题。成年人通常有一个固定的入睡模式：固定睡在床的某一边，用一个专用的枕头，盖特定的被子，睡前看电视、听收音机或者看看书。

在睡眠中，我们不时会醒来，尤其是在快速眼动期与非快速眼动期交替时。醒来后，我们通常会翻个身，调整下睡姿，拉一拉被子，观察一下身边的环境是否与入睡时一致。如果一切正常，我们会马上再次入睡，早晨醒来后甚至不记得这些清醒的过程。但是，如果半夜醒来后，发现身边有异常，比如听到异常的声音或闻到奇怪的味道，我们就会彻底醒来，去搞清楚发生了什么事。其实，根本用不着真的发生什么大事，只要有样东西放的地方跟入睡时不一样了，我们都会完全清醒过来，表现出高度的警惕。

很多孩子在入睡时身处客厅，被家长抱在怀里，放着电视，有微弱的灯光，但是半夜醒来时，却发现一切都变了，他独自一人睡在自己的房间里，周围一片漆黑，也没有声音。他立刻意识到在睡着的时候有人移动过他。他无法在这样的环境中入睡，也不能改变这种情况，所以只能哭闹，让家长进来帮助他。家长赶来后，重复孩子入睡时做的事，抱着他，哄他入睡，等孩子睡着后，就再次将他独自放在漆黑无声的环境里，直到他再次醒来，再次哭闹。整个晚上就反复上演这样的戏码，孩子与家长都睡不好。

劣质睡眠环境

我们回过头来检视贝茨的睡眠环境。对贝茨来说，如果有人能一直轻轻摇着她，她就能一觉睡到天亮，即使半夜醒来，也能自己再次入睡，不哭也不闹。在贝茨睡着后，要将她放到婴儿床上几乎是一件不可能完成的任务，因为她已经练就了一项适时醒来的“绝技”，时刻防止大人将她一个人放到婴儿床上去。贝茨在半夜醒来后，如果发现环境

发生了变化，就会觉得有什么东西“不对劲了”，她会表现得很绝望，然后大哭起来，直到父母赶来，轻轻摇着她，哄她入睡为止。

贝茨在进入睡眠状态之前，记住的最后一件事就是父母抱着她轻轻摇晃，而她半夜醒来后意识到的第一件事就是这种摇晃不见了。她不会记得在入睡后曾经被父母移动过，甚至不会记得自己刚刚睡着了。对她来说，这一切就好像是一眨眼父母就从身边消失了，而自己就从父母的房间到了婴儿床上，那种轻轻的摇晃眨眼之间就没有了。时间久了，她就会明白父母每晚都会移动她。所以她养成了一个习惯，每次半夜醒来都立刻清醒，仔细观察周围的环境是否变了。在这样的情况下，她睡得好才怪！

贝茨的问题其根源在于睡眠环境，入睡与醒来时环境的不同让她没有安全感。如果睡眠环境能保持不变，绝大多数孩子都能睡得很安稳，他们不必保持警惕去反复确认环境是否变了、家长在哪里。而且，父母不应该在孩子睡着后偷偷溜走，这会让孩子缺乏信任感，而良好的信任感恰恰是优质睡眠所必需的。

贝茨那样的睡眠问题多出现在婴幼儿身上，比起年龄稍大一点的孩子，这个年龄段的孩子根本不具备对外界环境的控制能力。当然，也有一些年龄稍大的儿童会有类似的问题，有些 5 岁左右的孩子在入睡时睡在家长的房内或客厅，睡着后家长就会偷偷地将他们移动到自己的床上去。有些孩子在入睡时会依赖特定的环境，比如只有在客厅里才睡得着，或者要开着音乐或电视等。对这些对睡眠环境有着特殊依赖的孩子来说，一旦醒来，就需要父母还原入睡时的环境才能继续入睡。

当然，并不是所有的儿童睡眠问题都与父母有关。我们来看另一个案例。

> 阿蕾克莎是一个 16 个月大的小女孩，跟父母一起睡。一开始，父母也乐意带着她一起睡，可是慢慢地就出问题了。阿蕾克莎的就寝时间是晚上 8 点，到了这个时间，她的妈妈就必须出现在床上，陪伴她入睡。一般在阿蕾克莎入睡后，她妈妈就会偷偷溜走，但是必须在她醒来之前赶回来。
>
> 到了后半夜，阿蕾克莎就会醒来，这可麻烦了，父母这时就只能把所有的精力都腾出来照顾她。而且阿蕾克莎的睡姿不好，她喜欢横躺在父母中间，头枕在妈妈身上，脚搁在爸爸身上。妈妈觉得这种姿势太别扭了，严重干扰到了她的睡眠。可是一旦她试图移动阿蕾克莎，或者让她的头枕到爸爸身上去，阿蕾克莎就会大哭。爸爸也觉得这种睡姿让他们很不舒服，还将他们夫妻分开了，可是阿蕾克莎毫不妥协，有时候他只好到隔壁房间去睡。

可就算这样，阿蕾克莎的父母也还是愿意跟她一起睡。所幸阿蕾克莎的情况还不算严重，只要逐渐矫正她的睡姿，让她把头枕到枕头上而不是妈妈身上，然后帮助她逐渐改掉需要妈妈陪伴入睡的习惯就可以了。

有的家长就没这么好运了，有些孩子的睡眠问题麻烦到让人头疼。我们再来看看萨姆的案例。

> 萨姆是一个两岁的小男孩，晚上父母在客厅看电视的时候，就让他睡在身边，看完电视后再将他抱到小床上。整个过程都很顺利，萨姆能自己入睡，父母搬动他的时候他也不会醒来。但是睡到床上几小时后，他就会醒来，指着客厅的方向大声呼唤父母。如果此时父母跟他睡在一起，或者他大叫后父母过来将他抱到自己的床上一起睡，他就会保持清醒，重复地念“电视，电视”。他这样的表现并不是因为受了惊吓，而是希望到客厅去。父母只好把他抱到客厅去，安顿到沙发上，然后打开电视。只要电视开着，不管父母是否陪在身边，他都能很快再次入睡，而且一觉睡到天亮。

萨姆的问题就出在入睡环境上，跟阿蕾克莎需要父母的陪伴才能入睡不同，萨姆依赖的是特定的入睡环境。对萨姆来说，只有在特定的地点、特定的灯光下，伴有特定的声音才能睡得安稳。所以，要矫正萨姆的睡眠习惯，就要让他习惯在黑暗、安静的环境里入睡。

当然，黑暗、安静的环境也并非万无一失，有的孩子在这样的环境里也会出现睡眠问题。

循序渐进法

要解决由睡眠环境不适宜引发的儿童睡眠问题，需要家长帮助孩子重新建立一个适宜的睡眠环境，让孩子在半夜醒来时感觉自己仍旧处于入睡时的环境里，周围的一切都处于可控状态。要达成这个目标，家长第一步就要仔细检视孩子现有的睡眠环境，找出不适宜之处。这个不适宜之处可以是任何的小细节，比如夜间哺乳、吮吸特定的物品、入睡时需要人摇着或哄着、睡眠时需要人轻抚后背，也可以是需要人轻拍着才能入睡、睡眠时需要大人抱着四处走动、喜欢在汽车后座上睡，还可以是需要听着特定的摇篮曲或者开着电视或音乐才能入睡，抑或是喜欢听电器发出的嗡嗡声。

家长帮助孩子重建睡眠环境的第一步，就是要充分认识到这是一个辛苦的过程，要抱着体谅的心态，耐心地坚持下去，直到孩子适应新的环境为止。改变旧的睡眠环境肯定是违背孩子的意愿的，孩子一开始肯定会产生抵制情绪，会大哭大闹，家长要学会对孩子说不，想办法纾缓这种抵制，绝对不能放弃。只要坚持，少则几天，多则几周，孩子的睡眠就会有所改善。

我们重新来探讨贝茨的案例，我处理这个案例的方法很值得借鉴。在我着手处理这个案例后，我就跟贝茨的父母一起找到了问题的症结：贝茨在入睡时与夜间醒来后都需要家长摇着她。然后我们一起规划了目标：大家一起努力，矫正贝茨的睡眠习惯，使她能够独自、安稳地睡在自己的婴儿床上。这就意味着我们需要改变贝茨现有的睡眠环境，建立一个新的睡眠环境，让她能够在夜间醒来时自己再次入睡。我用的方法就是“循序渐进法”，下面我详细介绍一下，家长也可以参考表 3—1 帮助理解。

表 3—1　　帮助孩子建立新的睡眠环境：循序渐进法

放任孩子哭闹的时间长度（分钟）				
		如果孩子在放任的时间里一直哭闹		
第几日	第一次放任时间	第二次放任时间	第三次放任时间	三次以后每次放任时间
1	3	5	10	10
2	5	10	12	12
3	10	12	15	15
4	12	15	17	17
5	15	17	20	20
6	17	20	25	25
7	20	25	30	30

以下建议是以孩子独自入睡为前提的。当然，我也为那些与家长同房同床或者与家长同房不同床的孩子提出了相关建议，家长可以根据实际情况变通使用。

1．矫正开始后的几周内可以适当推迟孩子的就寝时间，以 30~60 分钟为宜。同时应该确保孩子早晨起床的时间与平时一样，白天小睡的时间也不能随意增加。

2．就寝时家长要将孩子安顿在他自己的床上，不能抱着他或摇着他，要确保他入睡时的睡眠环境与半夜醒来时一致，这样就算他半夜醒来，看到一样的环境，也比较容易再次入睡。

3．如果孩子在就寝时或半夜醒来后哭闹不休，家长可以试试表 3—1 提供的等待时间，有意识地逐渐增加等待时间。如果家长觉得表 3—1 里的等待时间太长了，可以根据实际情

况进行调整。

4．如果夜里孩子哭闹的次数超过了表3—1给出的次数，家长也不应该放弃，而应该继续按照当夜等待时长的最大值重复执行，直到孩子在家长不在的情况下自己睡去为止。

5．到了第3天或第4天，孩子的睡眠状况应该有了很大的改善。如果到了第7天，情况虽然有了改善，但是仍未根除，那家长可以在第7天的基础上适当延长每次等待的时间。但是，如果到了第7天，情况一点都没有改善，甚至变得更糟，家长就应该对整个矫正过程进行反思了，请参考稍后的内容。

6．在每一次等待之后，家长都应该走进房间看看孩子，停留的时间不应该超过两分钟。

7．一旦孩子在清晨醒了，不管他醒来的时间比平时早还是比平时晚，都应该让他起床。整个夜间睡眠应该在一个房间内完成，不能这个房间睡一会儿，那个房间睡一会儿。

8．如果孩子不愿意待在自己的房间里，可以把孩子房间的门锁了，等他开始哭闹后，按照表3—1提供的时间走到门边去。如果锁门不管用，家长可以把自己房间的门也锁了。

9．如果孩子跟家长同房不同床，孩子不肯待在自己床上，而是跟着父母一起走出房间或者爬到父母的床上，家长就要在离开房间的时候果断地关上门，然后根据表3—1给出的时间间隔进入房间，重复这个步骤，直到孩子自己睡着为止。

10．如果孩子跟家长同睡一张床，当孩子哭闹时，家长要跟孩子保持距离，根据表3—1给出的时间间隔适时忽略孩子的任何要求。

11．表3—1不仅适用于夜间睡眠，还适用于白天小睡。如果孩子经过半小时还睡不着，或者睡了一会儿就醒来哭闹，家长应该终止这个小睡。另外，白天的小睡最好不要太迟，以免影响孩子夜间的睡眠。

12．家长可以参考图3—1中的睡眠情况记录表以及图3—2贝茨睡眠情况记录表，及时记录孩子的睡眠情况，以观测整个矫正过程。

在与贝茨的父母充分沟通后，我们达成了共识。从那以后，每天晚上贝茨入睡时以及半夜醒来后，家长都不能去贝茨的房间，我们希望能让她独自入睡。一开始贝茨会哭闹，家长就放任她哭闹一段时间，然后走进贝茨的房间，停留一小会儿，在她还清醒时就离开房间。如果家长离开后贝茨再次哭闹，就再放任她哭闹一会儿，然后再次进入房间，逗留一小会儿，仍旧在她清醒时离开。如此反复，直到贝茨凭自己的能力睡着为止。家长放任贝茨哭闹的时间逐渐延长，比如第一天放任她哭闹5分钟，第二天就变成10分钟，第三天就变成15分钟。

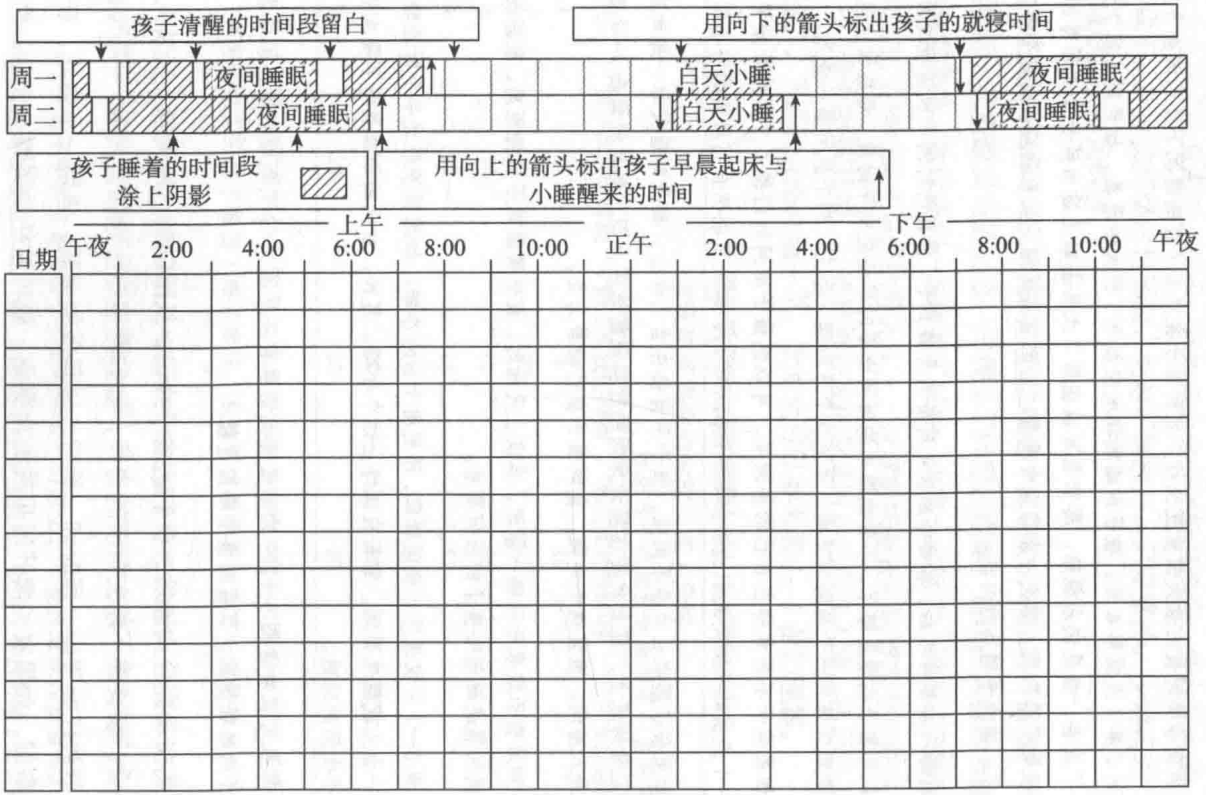

孩子清醒的时间段留白
用向下的箭头标出孩子的就寝时间
周一
周二
夜间睡眠
夜间睡眠
白天小睡
白天小睡
夜间睡眠
夜间睡眠
孩子睡着的时间段
涂上阴影
用向上的箭头标出孩子早晨起床与
小睡醒来的时间
上午
下午
日期
午夜
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
正午
2:00
4:00
6:00
8:00
10:00
午夜

图 3—1　睡眠情况记录表

在实施矫正方案前，我问过贝茨的父母对贝茨的哭闹能够忍受多久，他们觉得可以忍受15分钟左右，尽管如此，我还是坚持把第一个放任时间定为三分钟。根据我的经验，3~5分钟是家长比较能接受的第一个放任时间的长度，当然就如上文所说，如果家长还是觉得这个时间太长，完全可以根据实际情况进行调整。

第一天晚上，我们让贝茨晚半小时上床。就寝之后，父母要保持安静，绝对不哄她，也不去摇她。如果贝茨开始哭闹，家长可以在三分钟后回到房间，让她明白爸爸妈妈一直都在身边，同时也让家长知道贝茨很好，可以放心。家长可在房间内逗留一两分钟，这期间绝对不能抱起她，也不能像往常那样摇着她，可以跟她简短地聊聊天，帮她盖好被子，但是时间一到，不管贝茨是不是哭得更凶了，家长都要离开房间。

等贝茨哭够5分钟，父母就再次进入房间，重复第一次做的事。此后，如果她再哭，父母就等上10分钟再进入房间。我们给第一个晚上设定了一个最长的等待时间，就是10分钟，也就是说，从第三次进入房间开始，家长在门外等待的时间都是10分钟，如此反复，直到贝茨在父母离开的情况下自己睡着为止。当然，如果贝茨在这个过程中停止哭闹，或者哭闹声渐渐变小，家长就不再进入房间，因为家长此时介入可能干扰贝茨，她正在学习如何自己入睡呢。

如果贝茨夜间醒来，家长就重复上述步骤，第一次等待3分钟，第二次等待5分钟，以后每次都等待10分钟，直到贝茨再次入睡为止。但是，如果贝茨醒来的时间比她平时起床的时间早一个小时或不到一个小时，家长就无须再次重复上述步骤，而是应该让她起床。贝茨一般7点起床，这就意味着如果她在6点以后醒来，家长就应该让她起床。如果贝茨到了7点还没醒来，不管前一天夜里她有没有睡够，家长都要叫醒她。

白天小睡时，家长的应对方法跟夜间睡眠时一样。如果在半小时内贝茨既不哭闹也不入睡，那家长就应该终止这次小睡。如果稍后她在地板上或游戏室里睡着了，家长就让她睡。对贝茨来说，最重要的是能够独自入睡。只要贝茨每次都在自己的婴儿床上入睡，时间久了，她就自然会将睡觉与婴儿床联系起来了。

第二天，我们设定的第一次等待时间是5分钟，最长等待时间是12分钟。此后每一晚等待时间都逐渐增加，参见表3—1。

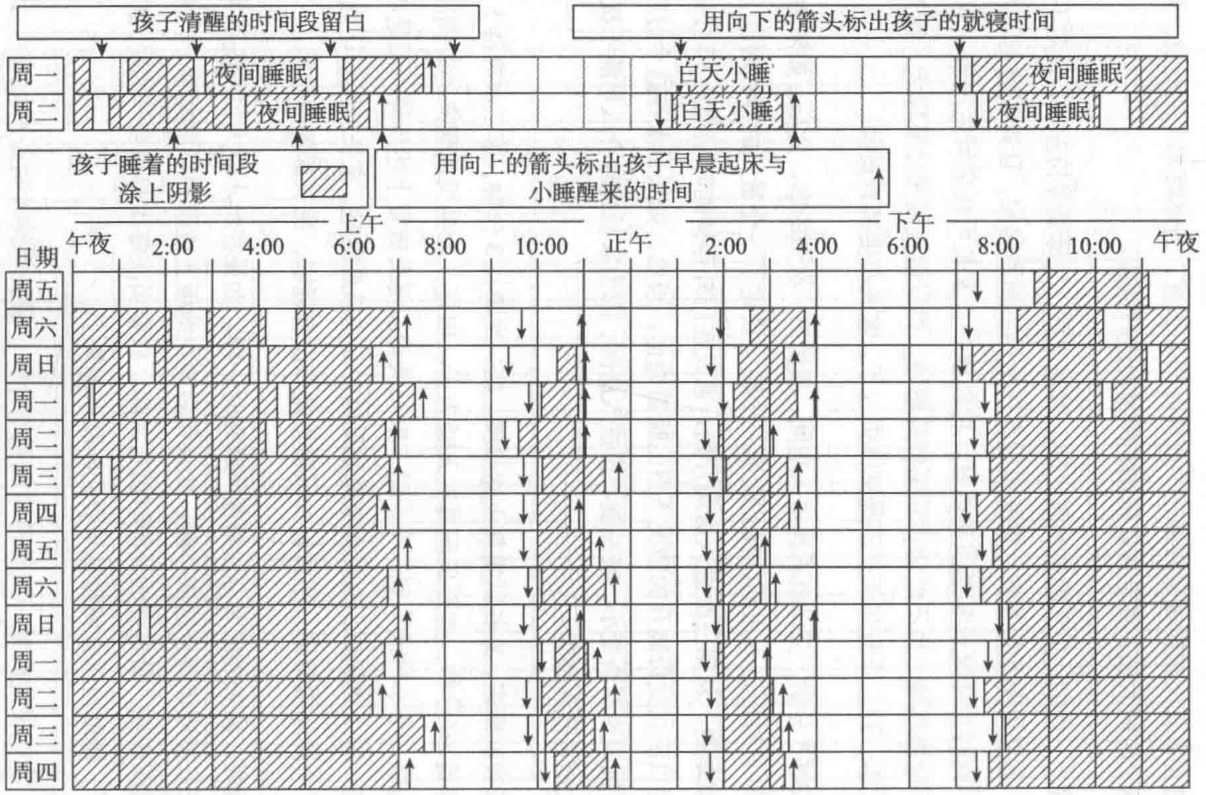


图 3—2　贝茨睡眠情况记录表

第一晚是最难熬的，但是当他们等到第三个 10 分钟时，贝茨就睡着了。那一晚她醒来了三次，每一次都比我们想象的更快入睡。第二晚父母只进入了房间一次，贝茨就自己睡着了，而且醒来后很快就自己再次入睡了。第三晚，父母根本用不着进入房间，贝茨就自己睡着了，半夜醒来也能自己入睡。到第一周结束，贝茨基本上不在半夜醒来了。一个月后，她的睡眠质量大大提高，白天小睡也有很大改善。具体情况请见图 3—2。

循序渐进法允许家长在孩子哭闹时进入房间，一方面可以让孩子知道父母的存在，另一方面也可以让父母看看孩子好不好。在使用循序渐进法时，有一点需要牢记，走进房间去看孩子的时间间隔可以是弹性的，家长如果不能长时间忍受孩子的哭闹，可以根据自己的实际情况制定出更和缓的方案。

整体矫正法与分步矫正法

睡眠习惯的矫正有两种方法，一种是整体矫正法（我就是用这个方法帮助贝茨的），另一种是分步矫正法。几个不同的睡眠习惯可以放在一起矫正，也可以逐个矫正；一个单独的睡眠习惯可以一次矫正，也可以分步矫正。比如有的孩子需要家长摇着才能入睡，这个习惯完全可以分解成几步加以矫正：

- **第一步，减少摇晃的频率；**
- **第二步，只是抱着孩子但不摇晃他；**
- **第三步，将孩子放在床上，只是看着他。**

绝大多数家长选择整体矫正法，我觉得这个可以因人而异，如果家长觉得分步矫正更有利于孩子与自己，那完全可以分步实行。**记住，在每一个步骤开始前都要巩固前一个步骤，整个过程的时间长短取决于分几个步骤来实行。**

孩子的适应能力非常强，花几天时间就可以让孩子改变固有的睡眠习惯，建立起新的睡眠习惯。这样强的适应能力有弊有利：弊端就是坏的睡眠习惯非常容易养成，有利的地方则在于矫正这种不良睡眠习惯也比较容易。举例来说，一个 9 个月大的孩子原本有非常好的睡眠习惯，但有一天他病了，家长为了照顾他不得不天天陪着他睡，等病好了，这个孩子就再也不肯自己睡了。从乐观的角度来看，一个过去天天要父母哄着入睡的孩子，也只需要几天时间就能学会自己入睡。

鉴于孩子这种超强的适应能力，我觉得完全可以采用整体矫正法，尽快帮助孩子完成矫正过程。当然，在某些特殊情况下，分步矫正法反而更有效。对于一离开父母就焦躁不安的孩子，或者第一次自己一个人睡的孩子，家长首先要找出根源，看看孩子是不是过分依赖奶嘴或家长的安抚，然后再考虑让孩子与自己分开睡。如果孩子对家长是否在身边不太关注，而是纠结于父母为什么不过去安抚他，那家长完全可以在一开始就将孩子放到他自己的房间里去。

分步矫正法与其说是为孩子设计的，不如说是考虑到了家长的实际需要，它将矫正过程拆分成几个步骤，家长可以逐一攻破。对聋哑儿、癌症患儿或者神经系统异常的孩子来说，分步矫正法是他们唯一的选择，只有通过长时间、多步骤的矫正，他们才能建立起新的睡眠习惯。甚至在某些个案中，整个矫正过程一无所获。

戒掉奶嘴

减少孩子夜间对父母的依赖可以与断奶分开进行。可以在减少对孩子的安抚的同时，保持夜间哺乳的习惯，即使孩子在哺乳过程中睡着了也不要紧。家长可以在给孩子喂完奶后就将他挪到自己的床上去，而不需要等到孩子完全睡着了才开始挪动。相反，在孩子还清醒时挪动他更好，这样他就会意识到自己不跟父母一起睡了，半夜醒来的时候也不会对周围的环境过于排斥。如果孩子在挪到小床上之后还醒着，家长可以按照表 3—1 给出的时间间隔来回应孩子。记住，一旦在睡前喂过孩子，整个晚上就都不需要再喂了。

如果孩子对睡前哺乳的依赖性比较强，每次都在吃奶时睡着，那家长就需要考虑将睡前哺乳与白天最后一次哺乳分开了。可以适当将睡前哺乳的时间提前，在哺乳过程中如果孩子开始犯困，家长可以及时将他叫醒，在他清醒时将他挪到自己的小床上去。白天小睡时也这样处理。

有些孩子晚上要喝很多水或奶，他们的睡眠质量肯定不好，因为他们会更容易感到饿，机体节律会随之改变，更容易尿床。但是，突然停止让孩子在夜间进食，对父母与孩子来说都不是一件容易的事，所以家长可以逐渐减少喂食的次数，降低喂食的频率。

有些孩子喜欢在晚上吸奶嘴，这可以帮助他们尽快入睡，如果家长能帮助孩子戒掉奶嘴，孩子对奶嘴的依赖性就会彻底消失。但是，有些孩子在白天都时刻含着奶嘴，那要戒掉就有点难了。

我建议家长们先减少孩子白天吸奶嘴的时间，可以在早晨和下午的某一个时间段内禁止孩子吸奶嘴，然后逐渐延长这个时间段。在禁止孩子吸奶嘴的时候，家长可以想办法转移孩子的注意力。一旦孩子只在夜间与休息的时候吸奶嘴了，家长就可以逐渐帮助孩子戒掉对奶嘴的依赖。

让孩子戒掉奶嘴要比想象中容易得多，尤其是4个月到一周岁的孩子。随着年龄的增加，戒奶嘴的难度也会增加，因为孩子的抵抗情绪会更强烈，保持清醒的时间也会更长。有的家长会限制孩子夜间吸奶嘴的时间，但是这个方案执行起来非常麻烦，也非常耗时。家长可以强硬一点。有的孩子虽然整夜含着奶嘴，但是真正吮吸却只有10分钟或者20分钟，而且通常是在入睡时或者醒来后再次入睡的间隙。只要让孩子过一两天没有奶嘴的日子，他就会习惯没有奶嘴。所以头两天，家长可以让孩子晚点睡，等他困得不行了，就不会在乎有没有奶嘴了。一旦孩子能够在没有奶嘴的情况下自己入睡，家长就再也不能将奶嘴递给他了。

关于孩子与父母一起睡的建议

支持孩子与父母一起睡的人总是说，一起睡好处多多，可以避免很多问题。由父母陪着入睡会让一些孩子感觉亲密，跟父母一起睡则让他感觉幸福，更容易睡着。但是，不良睡眠习惯与劣质睡眠环境可以发生在任何地点、任何情况下，即使和父母一起睡也无法彻底避免。

要是孩子跟父母同房不同床，那跟分两个房间睡没有本质差别。孩子和父母在一个房间的好处是孩子可以随时看到父母，会感到安心，可是这远远不能帮助孩子自己入睡。相反，让孩子时时刻刻都可以看到父母反而使他很难忽视父母的存在，而要让他自己入睡就更难了。孩子一哭闹就把他抱到父母的床上去睡，这虽然能让孩子很快安定下来，却不是根本解决之道，要彻底解决问题，还得改变策略。

如果家长在房间里时孩子无法安静下来，家长可以离开房间，然后有规律地进入房间探视。一旦孩子习惯自己入睡，家长就可以待在房间里了。有些父母在矫正的头几天会睡在另一间屋里，直到孩子养成新的睡眠习惯再搬回来。家长也可以在房间内

设置屏障，将房间分为相对隔绝的两部分，用毯子或帘子将婴儿床与大床隔开，只要让孩子看不见家长就行，这样家长就能在不起床、不出门的前提下实行矫正了。一般来说，可以将婴儿床隔离在房间内侧，大床在外侧。

如果父母跟孩子一起睡，最好父母双方都加入到矫正过程中来，尽管一个家长就足以完成矫正任务，但是两人一起会事半功倍。家长应该禁止孩子随便干扰自己的睡眠，也不需要哄他入睡，拒绝的时候应该果断明确，然后让孩子自己想办法入睡。

如果孩子对爸爸或妈妈特别依赖，被依赖的家长可以转过身去不理他，或者离开床，直到孩子睡着再回来。要是孩子大一点，会将转过身去的家长拉回来，或者跟着家长离开房间，那家长就必须离开房间，然后关上房门。离开房间后，家长可以采取循序渐进法进入房间探视，然后回到床上，若孩子开始哭闹或贴过来，就再次起床、出门。要让孩子知道，他只有两种选择：要么按照家长的方式，要么家长离开。时间一长，孩子就会习惯了。

上文提到过一个叫阿蕾克莎的小女孩，睡觉姿势不好，她的父母就采用了上面的方法，并取得了成功。每当阿蕾克莎想要枕到妈妈身上去的时候，妈妈就起来，离开房间，并逐渐增加再次进入房间的等待时间，与此同时，阿蕾克莎跟爸爸一起睡在床上。当阿蕾克莎挤到父母中间，想分开父母时，父母就把她放到地板上的毯子上去，并且每次待在地板上的时间逐渐延长。在地板上，她平时喜欢的那些睡觉姿势都使不出来了，渐渐地她也就放弃那些古怪的姿势了。

那些父母陪伴孩子直到孩子入睡再离开的家庭，虽然父母与孩子睡在不同的房间里，但是孩子入睡前与半夜醒来后都会需要父母的陪伴，这种情况也可以想办法矫正。孩子已经稍微懂事了，家长可以直接告诉他，以后不能再陪着他入睡了，同时确保孩子的作息规律正常。

在睡前，家长可以给孩子讲故事、跟他一起玩游戏、陪他聊聊天，但是一旦到了就寝时间，就应该停止这些活动，然后离开房间。注意，离开时不要关门。有些孩子不会跟着父母一起离开，仅仅是在床上哭闹，父母就可以采取循序渐进法，逐渐延长进入房间的时间间隔，直到孩子适应一个人睡为止。在进入房间后，父母可以跟孩子互动，但是绝对不要再躺到他床上去。孩子睡着后，父母一定要离开房间。

如果孩子在父母离开后会走出房间，那父母在离开时就要随手关门。如果孩子已经三岁了，那只是关门可能效果不佳，可以引入一个奖励机制。为孩子设计一个表格，然后每次孩子表现好就给他打一颗星或划一道杠，积累到一定数量之后，就给予孩子奖励。随着奖励机制带来的新鲜感逐渐减少，孩子会提出新的要求，此时家长要谨慎对待，不能随便妥协，否则之前的努力就白费了。等孩子真正养成独自入睡的习惯，家长就应该帮助孩子巩固这个习惯。

我们再来回顾一下上文提到的案例。萨姆，两岁，总是在客厅入睡，入睡时需要电视机一直开着。萨姆已经有能力自己离开床了，所以在矫正过程中家长需要在离开房间的时候随手关门。

矫正开始后，萨姆的父母就开始重视睡前相处的时间，他们会给萨姆讲一个他喜欢的睡前故事，通常是 15 分钟左右，然后告诉他要睡在自己的卧室里。一开始萨姆很排斥，在父母离开的时候，萨姆想跟着一起出去，但是父母关上门，将他留在了卧室里。萨姆一开始反弹得很厉害，到了第二周，他就乖乖地在自己房间里入睡了。

矫正贵在坚持。如果你家宝宝也有睡眠问题，并且跟本节提到的这些孩子类似，那么可以参考我给出的这些方案。年纪较小的孩子矫正起来比较容易，而且绝大多数三个月以上的孩子都能被矫正，只要家长持之以恒。

循序渐进法收效不佳怎么办

前面介绍的循序渐进法其实只适用于一种情况：孩子对某种睡眠环境有不正确的依赖感，从而无法自己入睡或无法在醒来后再次入睡。一般情况下，采用循序渐进法，只要坚持几天就会有明显的改善。如果一周以后情况非但没有好转，反而更严重了，家长就应该立刻停止矫正，仔细检查整个矫正过程。在采取下一步措施前，要多考虑几种可能性，有可能是对孩子哭闹的原因判断错误了，有可能判断对了但是这个原因仅仅是多个原因中的一个而已，也有可能判断没错也很全面但是矫正方法错了。

| 程序错误 |

家长在矫正过程中的行为表现会影响整个矫正的进程。有些家长在使用循序渐进法时执行得不够彻底，例如有些家长确实让孩子在自己的床上就寝，但还是会在孩子醒

来后去哄他入睡；有些家长在就寝时陪伴孩子直到他入睡，当孩子醒来后却对他不闻不问；有些家长确实让孩子独自入睡，但是当孩子在清晨醒来后却又将他挪到家长的床上去继续睡；有些家长在应对孩子的哭闹时毫无章法，一天一个样，或者觉得孩子再哭闹下去就会吵醒其他孩子，然后错误地满足孩子的要求；有些家庭只有一个家长投入到矫正中，另一个根本不管事。以上任何一种情况都足以消减矫正的效果。

掌握放任孩子哭闹的时间也很重要。有的家长确实按照表 3—1 给出的时间间隔进入孩子的房间，可是在进入房间后就一直陪着孩子，直到他睡着才出来，这样整个过程就被破坏了。有些家长没有按照表 3—1 的方案执行，一开始等待的时间就过短，每次等待的时间也不逐渐增加，这反而让孩子养成了等待家长进入房间的习惯，家长不进来，他就不睡。逐渐增加等待时间是为了让孩子独自待着的时间慢慢变长，直到长到他昏昏欲睡为止，增加几次之后，孩子在家长进房间前就能独自入睡。要让孩子明确地理解就寝与入睡的新习惯，然后坚持不懈。

也就是说，如果矫正方案不能被严格执行，缺乏明确的规则，矫正就会失败。**坚持与严格是成功的关键。**

| 无视作息规律 |

如果家长在制定矫正方案时没有充分考虑孩子的日常作息与生理节律，那效果肯定会大打折扣。循序渐进法应用的前提就是，在使用时孩子处于困倦状态，且有可能在矫正几次之后适应新的睡眠习惯。如果孩子一点都不想睡，那什么方案都没用。

假设孩子平时的就寝时间是晚上 9 点，家长在 7 点就开始实行矫正方案，那孩子就有两个小时的时间处于清醒状态，这两个小时足够折腾家长的了。这就是为什么我在一开始就建议家长将矫正开始的时间设定在就寝时间的原因，当然也可以比就寝时间晚一点。等矫正有点效果之后，可以逐渐提前开始的时间，直到与就寝时间一致。

如果孩子在半夜醒来后会清醒一两个小时，然后就要家长陪着一起玩，此时，家长应该让孩子继续躺在床上。在这种情况下，孩子在再次入睡前就会多出一两个小时的时间，家长要想办法在矫正过程开始前就缩短这个时间，详细做法参考本书第 8 章。

如果孩子在矫正开始后持续哭闹、彻夜不眠，家长也不要随意增加孩子的睡眠时间。按照平时的作息叫醒他，白天也不要增加午睡的次数或时间，同时，第二天的就寝时间

与起床时间也应该与平时一致。因为如果家长让孩子在白天补眠，那就失去了矫正的意义，这样做只是将部分夜间睡眠挪到白天来而已，第二天晚上孩子会哭闹得更厉害。如果在矫正的头几天，孩子很早就醒了，也没有关系，这样有利于第二天的矫正。

有的孩子作息很不规律，家长根本摸不准应该何时让孩子就寝，在这种情况下，家长要把重心放在帮助孩子建立规律的作息上。好的作息应该能让孩子在就寝时快速入睡，在夜间醒来后能够快速再次入睡，即使一开始入睡需要家长介入才能完成，也不要紧。等到建立起规律的作息，再着手实施方案也不迟。

忽视孩子的焦虑感

在矫正过程中，孩子可能会或多或少地感到害怕。如果孩子在白天就离不开大人，那他肯定也无法忍受在夜间独自一个人睡。对于这样的孩子，放任他哭闹的时间再长也无济于事，反而可能使情况变得更糟。如果家里有一个这样的孩子，就不能单纯使用循序渐进法了，而是应该综合考虑多种情况，家长应该先处理其他问题，然后再来攻克分房睡这个难题，具体可以参考本书第 5 章。即使家长整晚都陪着孩子睡，也可以坚持分床睡，在陪伴时也不要哄他、摇着他，不要让他吸奶嘴。如果孩子爬到家长的床上，家长可以离开房间，按照表 3—1 给出的方法反复进入房间。只要孩子不再爬到家长床上来，家长就可以留在房间内。

家长在辨别孩子睡眠问题的类型、寻找内在根源、试图矫正问题时，需要把握以下基本要点：

- 矫正并不仅仅是为了给自己减轻负担，更重要的是让孩子获得优质的睡眠。
- 理想的睡眠环境应该是安宁而又舒缓的，不能有刺激的声音或光源。
- 孩子在哪里入睡，就要在哪里醒来。
- 如果孩子半夜醒来后哭闹不休，一旦父母重建他入睡时的睡眠环境，他就立刻停止哭闹，快速入睡，父母就要警觉了，孩子根本没有明白自己的睡眠习惯需要矫正。
- 矫正不宜过早开始，等孩子满三个月之后再开始矫正比较适宜。
- 睡眠问题会因时而异、因地而异、因人而异。
- 尽管自始至终坚持矫正方案很重要，但是矫正的开始时间需要慎重考虑，千万

不要在有重大事情的前夜实行矫正方案。

- 一旦确定了开始时间，就要严格遵守，不要过多地提前。
- 双亲都应该参与孩子的矫正，避免让某一个家长过多地承担矫正任务。
- 如果家里有多个子女，家长要留心，在等待时间内一个孩子的哭闹可能会吵醒其他孩子。
- 矫正方案的制定必须考虑到邻居，没有人是住在无人岛上的。
- 一旦孩子养成了良好的睡眠习惯，他就会保持下去，但偶尔也可能出现反常。

第4章 夜间哺乳
——另一个引发睡眠问题的关键

在影响婴幼儿睡眠的诸多因素中，夜间哺乳很容易被忽视。一般来说，三个月左右的婴儿其夜间哺乳的次数应该控制在一次，作为对入睡前哺乳的一种补充。到了四五个月，就应该完全取消夜间哺乳。家长不应该无限制地满足孩子夜间进食的欲望。夜间进食的习惯一旦养成，就可能持续几年之久。

妈妈们都会觉得抱着孩子边哺乳边看着他睡着是一件很幸福的事，孩子似乎也很享受这样的入睡模式。在孩子一周岁之前，妈妈们大可以这样做，但是，如果孩子在喝奶后就不肯离开妈妈，一放到床上就开始哭闹，或者在半夜频繁醒来，醒来后非要再次哺乳才能继续入睡，就表明孩子已经出现了睡眠问题。

有这种睡眠问题的孩子通常会将哺乳与入睡联系起来。如果入睡时喝了太多的奶或果汁，尿布可能在半夜就已经湿透了，这会让他感觉很不舒服，频繁醒来。另外，入睡时摄入过多的营养物质会刺激孩子的消化系统，让原本应该相对抑制的消化系统变得活跃，影响身体其他系统的功能，激发或抑制某些激素的释放，从而导致体温偏高，最终导致身体很多与睡眠有关的生理节律出现异常或混乱。孩子的进食时间是可以人为控制的。

由夜间频繁哺乳引起的睡眠问题通常出现在两周岁以下的婴幼儿身上，因为这个年纪的孩子正处于哺乳期。我们来看看凯拉的案例。

凯拉是一个8岁大的小女孩，根据父母的描述，凯拉习惯在哺乳中入睡，一旦入睡，家长就可以很轻易地将她放到婴儿床上去。但是，她独自睡着的时间只能持续两个半小时，然后就会哭闹着醒来。此时，只有妈妈能哄她再次入睡，而爸爸只能干着急。妈妈将她抱起来后，凯拉能在10分钟之内再次入睡，可是通常只能持续两个小时左右，然后妈妈就要哄她入睡。如此反复，直到天亮为止。

一般来说，凯拉一晚上会醒来五六次，每次都需要喂食，而且尿布也没法维持到第二天天亮，半夜总要换一次。由于凯拉每次醒来都是妈妈在照顾，所以妈妈也心力交瘁。有时候，妈妈实在太累了，就想由着凯拉哭闹，可是凯拉爸爸却坚持让她及时起来去哄孩子。这让凯拉妈妈非常恼火，夫妻关系也由此变僵了。

看了以上描述，有的读者可能会得出凯拉将入睡与哺乳画上等号的结论，这个判断是正确的，但显然不是问题的全部症结。如果这么简单的话，凯拉不应该这么频繁地醒来，而且每次醒来都应该是完全清醒的，并且需要外力介入才能继续入睡，凯拉显然不是如此。她每次醒来时间都非常短暂，也不是每次都完全清醒。我认为，除了哺乳，还有其他因素导致她每夜频繁醒来。

你家宝宝的睡眠问题是由夜间哺乳导致的吗

三个月左右的婴儿可能会自动放弃频繁的夜间哺乳，但是想要寄希望于这么点大的孩子自己完全放弃夜间进食则是缘木求鱼。如果你家宝宝已经三个月大了，在入睡时还是需要家长哄或者需要含着奶瓶，夜间的进食频率多于一次，那家长就要注意了，这种额外的夜间进食很可能导致孩子在半夜频繁醒来。遇到上述情况，家长可以通过减少喂食的频率来改善孩子的睡眠。

有的孩子在夜间醒来后，家长只需要哄几分钟就能让他继续入睡；有的孩子在醒来后，仅仅从奶瓶里啜几口牛奶就能再次入睡。这些孩子其实都不是真的饿了，他们仅仅是对母亲的乳房或奶瓶产生了依赖，就像有的孩子依赖奶嘴一样。除此之外，需要频繁地换尿布也是夜间进食过度的信号。绝大多数三个月以上的孩子不需要在夜间换尿布，如果你家宝宝总是需要半夜换几次尿布，你就应该反思一下，是不是给孩子喝了太多的液体。

有的孩子一夜喝的奶加起来足足有4整瓶，而一个奶瓶的容量是250毫升，算一算，这个孩子在一夜间足足喝了一升的液体！即使对一个成年人来说，这个量也有点过分了，更何况是这样小的孩子呢？如果一个成年人一整夜喝一升水，他肯定要频繁地去厕所，根本没法踏踏实实地睡觉。所以家长如果发现孩子有类似的问题，就不难理解为什么孩子在夜间总是睡不好了吧？

由夜间哺乳导致的睡眠问题的解决方法

如果家长通过本章前一部分的内容判定出影响孩子睡眠的罪魁祸首是过度的夜间哺乳，那家长可以稍感欣慰了。因为这一原因虽然能引发婴幼儿严重的睡眠问题，但是从矫正的角度来看，确实比较容易。在矫正过程中，家长要一丝不苟地做好两件事：

- 减少或限制夜间哺乳的次数，这不仅能消除因哺乳而产生的睡眠问题，还能帮助孩子建立比较合理的进食规律；
- 帮助孩子建立新的睡眠环境，改掉睡前需要人哄、需要进食或含着奶嘴的坏习惯。

这两件事家长可以综合起来做，也可以一次只做一件事。首先，逐步减少喂食的次数，或逐渐减少进食的数量，也可以双管齐下，我称之为“减次减量法”。不要骤然停止喂食，否则孩子可能会不习惯，也可能会在夜里感到饿。家长可以制定一个循序渐进的方案，逐渐减少喂食的次数和数量，这对孩子和家长来说都比较容易操作。

矫正的目标是，逐步将孩子夜间进食的时间点挪到白天，从而完全杜绝夜间进食。如果孩子年龄太小，矫正的目标可以适当放宽，逐步将孩子夜间进食的部分时间点挪到白天，减少夜间的进食次数。有时候并不需要完全舍弃夜间喂食，事实上，对年龄较小的婴儿来说，完全没有夜间进食是不适宜的。两三个月大的孩子，一般夜间进食次数应控制在两次；到了三四个月大，就可以减少为一次；到5个月左右，则可以完全舍弃。

如果家长愿意，可以在孩子出生5个月之后保留一次夜间喂食，但是需要说明的是，这种喂食并不是基于孩子的生理需要，而仅仅是家长的一个选择而已。有的家长并不介意晚上频繁起来给孩子喂食，但这种喂食对孩子来说是有弊无利的。因为夜间喂食会打扰孩子连续稳定的睡眠，导致孩子频繁醒来。久而久之，孩子到了某一些时间点就会呼喊家长，或者等着家长起来给他喂食。即使孩子并不感觉饥饿，他也会在这几个时间点醒来，非要吃了东西才肯继续入睡。

而且，如果孩子对母亲的乳房或奶瓶有依赖，情况会更糟：他可能在距上一次进食醒来后不久又再次醒来，或者在喝了奶之后仍旧保持清醒。如果碰到这些情况，要怎么办？他习惯了醒来后被人哄，喝奶，但是由于两次醒来的时间间隔太短，或者保持清醒的时间太长，他不需要再次喝奶，也不需要人哄，只是干醒着而已。这种情况无论是对家长还是孩子来说，都是很痛苦的。

家长可以参考表 4—1。**哺乳也好，使用奶瓶也好，无论采用何种方法进行夜间喂食，最关键的都是要逐渐增加两次喂食之间的时间间隔。**家长可以记录下最近一段时间孩子夜间进食的时间间隔，然后以此入手，调整间隔长度。（如果间隔是一个时间区间，例如 1~3 小时，那就可以从最短的间隔一小时入手。）例如，第一天晚上家长采用每隔两小时喂食一次的频率，那就要精确执行，等到确实过了两小时再给孩子喂食一次。如果孩子在间隔周期之内就已经醒来，吵嚷着要吃东西，家长也应该等到时间到了才允许他进食。如果孩子在两小时之后醒来，则可以马上吃到东西。在此基础上，每晚增加 30 分钟的时间间隔，以此类推。

要是家长采取使用奶瓶的方法来喂食，最好的办法是逐渐减少每次喂食的数量，并记录下每次喂食的数量（如果每次喂食的数量是一个范围，就从最大值入手），然后每晚减少 30 毫升。如果家长想要帮助孩子彻底戒掉夜间进食的习惯，那就可以一直采用这个方法，直到孩子每次进食 30 毫升为止。等孩子的夜间进食控制在一两次，进食总量控制在 30~60 毫升，家长就可以彻底停止夜间喂食了。

很多家长发现，通过矫正，即使没有使孩子完全戒掉夜间进食，孩子在夜间醒来的频率也会大大降低。到了后来，即使孩子每晚只进食 30~90 毫升，他也只会因睡眠被打断而感到烦躁，此时，家长可以比预定计划早几天彻底终止夜间喂食。

表 4—1　　取消不必要的夜间喂食

第几日	两次喂食间最小时间间隔（小时）	每次进食的数量（奶瓶，单位：毫升）
1	2.0	210
2	2.5	180
3	3.0	150
4	3.5	120
5	4.0	90
6	4.5	60
7	5.0	30
8	完全戒除夜间喂食	

表格中的数量与次数都是一个大概值，仅供参考。家长可以根据自己的意愿和孩子的实际情况适当调整。

1．如果你家宝宝每次进食少于250毫升，则可以把他日常进食的大概值作为基准值，每次减少30毫升。

2．如果你家宝宝两次进食的时间间隔一开始就大于两小时，那就将他平时进食的时间间隔作为基准值，每次增加半小时。

3．如果采取哺乳的方式，可以在表4—1前两栏给出的数值的基础上逐渐增加哺乳的时间间隔，不要担心每次喂奶孩子到底喝了多少。

4．到了第7天，很可能只需要在孩子入睡后5个小时左右喂一次就够了，如果孩子还很小，家长希望保持一夜一次的哺乳习惯，那矫正过程就到此结束了。

5．如果家长愿意，可以隔天拉长喂食的时间间隔、减少喂食数量，而不是每天如此。这样做没什么坏处，只是所需的时间长一点罢了。

如果家长的目标不是彻底戒除夜间喂食，而是保留每晚1~2次的喂食，那么除非每次喂食的数量超过了240毫升，否则不需要减少喂食的数量。（绝大多数的夜间喂食应该控制在120~240毫升的范围内。）家长要把大力气花在增加两次进食之间的时间间隔上，直到将次数减少到家长希望的范围内。这个时间间隔可以从3小时到6小时不等，具体要看孩子的年龄大小与家长希望达到的效果。其次，解决睡眠环境问题。如果哺乳结束后，家长还允许孩子赖在身边，哄他入睡，那孩子会对母亲产生依赖，要立刻把他们放到小床上。

如果家长不是采取哺乳的方法，而是将奶瓶递给孩子，孩子自己进食，家长就不需要花大力气去解决睡眠环境问题了。因为在这种情况下，孩子通常是独自在房间内入睡的，不存在睡眠环境改变的问题。随着喂食次数的减少，孩子对奶瓶的依赖程度也会逐渐降低。（在此过程中千万不能用奶嘴代替奶瓶。）

在使用奶瓶的情况下，如果家长希望保留一两次夜间喂食，那就需要着重将夜间进食与入睡分离开来。夜间喂食的目的是给孩子充饥，而不是帮助孩子入睡。如果孩子在家长怀中边吮奶瓶边入睡，或者自己捧着奶瓶边喝边入睡，那所有的矫正都是徒劳。

有的家庭是孩子与父母同床睡的，在这种情况下，孩子很可能会在夜里找奶喝，家

长要坚决杜绝，不到进食的时间点，不能喂食。妈妈们可以在孩子哭着要喝奶的时候，暂时从床上起来，坐在床边，或者直接离开房间（前提是爸爸陪在孩子身边，以确保安全），直到孩子再次入睡或下一个进食时间点到来再进入房间。

以上介绍的都是将夜间进食与其他睡眠问题一起解决的方法，有些家长也许希望先解决夜间进食问题，再解决其他睡眠问题，这就要求家长在矫正的前半段维持孩子的睡眠习惯。孩子在半夜醒来后，家长可以顺着孩子的要求去安抚他，比如抱着他、轻抚他、轻轻摇晃他甚至跟他说说话。有时候，什么都不做会比积极干预好很多，特别是当孩子一个人睡在自己的房间内，如果家长进入他的房间却不喂他，反而会让他更加烦躁不安，此时家长不进入房间更有助于孩子冷静下来。

哺乳的妈妈会觉得抱着孩子看着他哭闹却不给他喂奶是很残忍的一件事。在双亲家庭中，非进食时间由爸爸来安顿孩子上床睡觉是比较恰当的。

一旦家长成功地减少或完全戒除夜间喂食，就意味着已经解决了夜间进食问题；而一旦孩子能够将入睡与进食分离开来，不再依赖奶瓶或母亲的乳房入睡，就代表着已经解决了睡眠环境问题。但是现实没有这样完美，有些家长在解决孩子的夜间进食问题后发现孩子仍旧需要家长安抚才能入睡，那么接下来就要着重解决睡眠环境问题了，具体做法可以参考本书第 3 章。通常情况下，只要解决好夜间进食问题，其他睡眠问题解决起来就会容易很多。

有的家长会放任孩子的其他睡眠问题，让孩子半夜醒来后，不进食自己再次入睡。只要适应良好，这样的模式也不失为一种可行的模式。但是如果孩子适应不良，如半夜醒来后家长要费九牛二虎之力才能将孩子挪到自己的房间里去，或者夜里无论何时醒来孩子都需要家长安抚，那么家长就要认真对待了。特别是当孩子昏昏欲睡时，要用心处理，选好时间点停止哺乳，将孩子抱到小床上去。如有必要，可以稍稍唤醒孩子，以确保在挪动的过程中孩子是有意识的。也可以将最后一次哺乳提前，在孩子还完全清醒的状态下停止哺乳，然后将孩子抱到床上去。

最后，在实践中，我还听过一个稍微复杂一点、但非常有效的方法，我称为“稀释法”，即逐渐降低奶瓶里牛奶（奶粉或果汁）的浓度，而不是减少喂食液体的体积或喂食的次数。稀释的过程是循序渐进的，最终的目标就是用水代替奶。

具体来说，第一个晚上可以用 3/4 的牛奶兑上 1/4 的水，然后每隔一两个晚上再稀释一点，逐渐变成一半水一半奶、1/4 的奶 3/4 的水，甚至 1/8 的奶 7/8 的水。以此类推，直到完全用水代替奶为止。

在这个过程中，孩子喝到的液体总量没有变，可是其中奶的浓度却发生了变化。等到整个奶瓶里都是水，那就意味着此时的奶瓶其实扮演着奶嘴的角色，而不提供任何营养物质了。家长可以在次日晚上不再提供奶瓶给孩子，一次性戒除孩子半夜要奶瓶的习惯。接下来就回到睡眠环境问题上来了，家长要做的就是帮助孩子戒掉睡觉时吮吸奶嘴的习惯，具体可以参考本书第 3 章。

采用“稀释法”时，家长要严格遵守稀释的比例，不能因为孩子的哭闹而轻易妥协，从而增加喂食的次数或数量。有的孩子对稀释过程的适应比较良好，有的则反应强烈。如果孩子在此过程中拒绝进食，那就意味着他不是很饿，这反而会加快戒除的进程。当然，家长可以在夜间多起来查看几次，孩子要奶瓶了，就立刻给他。但如果孩子没要，也不用主动给他。这样既不会饿着孩子，又可以帮助他逐渐戒除对奶瓶的依赖。如果家长发现孩子对“稀释法”完全不能接受，或成效不明显，我建议家长放弃这个方法，而改用之前介绍的“减次减量法”。

我采用本节介绍的方法对凯拉进行了矫正，效果很好，她很快就戒除了坏习惯，睡眠质量有了很大提高。凯拉接受矫正后，妈妈仍旧在白天哄她两次，但晚上则完全由她自己入睡。有时，妈妈也会哄她午睡，因为她发现这不会影响凯拉夜里的睡眠习惯，而与凯拉的亲子互动也让妈妈觉得非常幸福。凯拉的爸爸也明白了孩子一哭闹就要求妻子去照顾的行为不妥，由此，一家人原本紧张的气氛大大缓解。

夜间哺乳的几个要点

减少夜间喂食并不必然导致断奶。如果孩子只在入睡、午睡、夜间这几个时间段里依赖奶瓶或哺乳，那么不连贯地减少夜间喂食也许会导致孩子断奶。如果孩子没有到断奶的年龄或家长不希望这么早给孩子断奶，那么家长应该在减少夜间喂食的同时在其他时间段继续保持哺乳。

减少夜间哺乳总体上不会必然影响孩子白天的进食，除非孩子全部或大部分的进食都集中在晚上进行。在这种例外情况下，家长要密切关注孩子白天的进食是否有所增加，产生饥饿感的时间是否有所变化，进食后是否过饱。

在白天有规律地间隔一段时间哺乳一次并不会影响孩子白天或夜间的睡眠状况。但是，在孩子出生两个月之后，孩子的夜间睡眠就会受到夜间哺乳的影响。很多时候，这种进食并不是为了缓解孩子的饥饿感，而仅仅是为了缓解他们的焦躁感，满足他们的心理需要。对婴儿来说，将进食的满足感与哺乳或奶瓶联系起来是有利于其生存的。但是，如果将所有的事都与这种满足感联系起来就不妥了。如果奶瓶的作用仅仅是满足孩子吮吸的习惯，家长就应该考虑帮助孩子戒掉夜间进食的习惯了。

矫正的目的是帮助孩子找到其他能够让他冷静下来入睡的东西，从而仅仅将奶瓶或哺乳与进食联系起来。一旦家长发现孩子的焦虑感减少了，白天更怡然自得了，矫正也会容易一点，家长也会更有信心。

白天小睡过程中的哺乳问题可以有很多种应对方法，不必一刀切。如果孩子在哺乳时很容易睡着，睡着后家长可以很轻易地将他放到床上去，在整个睡眠过程中不再要求第二次喂食，那家长完全可以放任孩子在小睡前的那次哺乳。如果家长想将进食与入睡分开，可以像处理夜间进食那样处理白天小睡的进食问题。需要注意的是，如果在哺乳后，家长将孩子放到床上，孩子在 30 分钟后还不能入睡，那就应该终止这次午睡。可能在此之后，孩子会不依赖进食自己睡着。家长也可以先解决夜间进食问题，一旦孩子戒除了夜间进食，不再将进食与入睡联系在一起，家长就可以要求孩子在白天也这样做。

如果孩子独自躺在小床上或摇篮里，家长最好不要进行喂食，这不仅因为喂食可能打断孩子正常的睡眠过程，还关系到孩子的生理健康。将奶瓶递给一个仰卧着的婴儿可能导致婴儿的耳朵和牙齿出现问题。婴儿的耳咽管（中耳腔的鼓室前壁通向鼻咽侧壁的一个软性管道）非常短，处于水平状态，婴儿仰躺着进食很容易让液体或细菌通过耳咽管从喉咙进入中耳腔，从而引发中耳炎。而且，如果婴儿处于出牙期，夜间进食牛奶、果汁等液体很容易导致龋齿。

绝大多数儿童在夜里都会感到害怕，这种恐惧感会导致某些睡眠问题，因为受到惊吓的儿童通常无法独自入睡。我会给出一些方法，供家长们评估宝宝的黑夜恐惧程度，继而解决孩子的黑夜恐惧问题。

随着年龄的增长，孩子所面临的挑战越来越多。他要学会在白天与家长短暂分离，和保姆一起待在家里或去上幼儿园、托儿所，当晚上睡觉时，又要与家长分开睡。他要逐渐学会约束自己的行为、定点进食，养成良好的如厕习惯，同时，他又要学会控制愤怒、嫉妒等负面情绪，收起攻击性，处理好自己与家人、朋友的关系。再长大一点，他就会开始好奇死亡是怎么回事，然后产生忧虑，他会想知道上帝、天堂与地狱到底是什么意思。他会从自慰中获得性快感，却羞于这样做。我会给出一些方法，供家长们评估孩子的黑夜恐惧程度，继而解决孩子的黑夜恐惧问题。在不同的成长阶段，孩子会出现不同的焦虑感：

- 上幼儿园的孩子会对白天要离开家长耿耿于怀，他可以勉强忍受白天的分离，却不想在夜晚也与家长分开睡。
- 家长生病时，孩子也很容易感到焦虑，他会认为是自己赌气的话或幼稚的想法让家长生病的，从而担心家长不再像以前那样喜欢他了。
- 如厕训练也会让孩子感到焦虑，他会担心自己是否有足够的自制力来完成训练。很多婴幼儿在夜间会为了控制住自己不尿床而纠结。

- 五六岁的儿童看到电影中绑架或孩子攻击家长的情节时会表现得很不安，因为他会将这些情节当作真人真事。所有的孩子都具有潜在的攻击性并为此感到内疚，看到自己内心深处的潜在特性被搬上大荧幕会让他们感到非常焦虑。
- 6~12 岁的儿童要面临来自学校、体育竞技场、音乐课、宗教、家庭内部甚至他们自身的诸多压力。在这个年龄段，以前未被发现的心理问题与学习能力问题会逐渐显现出来。
- 青少年在经历青春期剧烈的生理与心理变化时也会面临诸多压力，他们开始思考未来，会考虑以后读大学、找工作、赚钱之类的事，性意识也开始慢慢觉醒。

睡眠恐惧

焦虑是导致入睡困难与夜间频繁醒来的最普遍、最重要的原因。在白天，焦虑能被人为控制住，毕竟，比起坐下来深思一番，孩子们有太多其他事可以做，有太多其他问题需要考虑了。但是，即使是白天非常自信的孩子，到了晚上也可能没有安全感。在等待入睡的过程中，焦虑感会逐渐产生。在这段时间里，他一个人睡在安静而黑暗的卧室里，周围没有其他事物能阻止他的思绪狂奔，他的思维与想象力都在此时自由驰骋。当他半夜醒来时，发现除了自己之外，其他人都处于睡眠中，他的焦虑感会更深。

这是因为在睡眠状态下，人对思维与想象力的控制能力逐渐减弱，孩子在晚上的思维模式与行为模式都会显得更加孩子气。也就是说，一个 5 岁的孩子在夜间所需要的关怀与一个 3 岁的孩子在白天所需要的关怀是一样的。家长不必因此而责怪他，也没必要跟他讲道理，只要试着去理解他就好了。

适当的焦虑是正常的，是在正常的成长过程中孩子内心世界的一种反应，过多的焦虑则有可能来自于外部环境。只要外界压力超过了孩子能承受的上限，比如生大病、家庭不和睦、与父母分离或父母离异等，任何年龄段的孩子都会出现担忧、焦虑、内疚及恐惧的情绪。到了晚上，除了睁大眼睛对卧室外的世界保持清醒之外，孩子对超过其承受能力范围的事无能为力，想象力就会开始肆虐，让他充满恐惧。由此就导致了入睡困难与夜间频繁醒来。

> 泰勒是一个 4 岁的小男孩，他的睡眠状况一直很好，直到我见到他的 4 个月前，他在半夜被一场雷暴吓醒了。从那以后，泰勒就没法独自入睡了。每晚 8 点，爸爸或妈妈就要跟他一起上床睡觉，陪在他身边，直到一小时

后他睡着为止。入睡前，他会反复询问家长是否会打雷，家长要反复向他保证不会。而且，如果家长要短暂离开他的卧室去办点其他的事，他会在家长离开后一直大声呼唤。如果家长不给予回应，他就会从卧室里跑出去，看看家长是否已经走远。一旦走远，他就会跑去把家长找回来。

他还要求在他的卧室里开两盏灯，彻夜不关。等他入睡后，家长就可以离开了。但是他一般会在半夜醒来，发现家长不在身边就大声尖叫。通常听到尖叫声后，爸爸或妈妈就会重新回到他的卧室里，再次陪他入睡。在他再次入睡前，他会一直紧紧地抓住家长，不让他（她）离开。所以他的父母会一直留在他的卧室里，以防他醒来后再次尖叫。如果父母对他的呼唤没有及时反应，他就会跑到父母的卧室里去，父母会让他跟他们一起睡。在父母身边，他会安稳地睡到天亮。

在白天，尽管泰勒不愿意再一个人待在房间里玩了，但是夜间的那种恐惧感似乎消失不见了。他对去托儿所也没有产生抵抗情绪。要是父母有事不在家，他就跟保姆待在一起。（保姆在他入睡前要一直陪着他，否则他就会一直撑到父母回家再去睡。）

泰勒告诉我，晚上他实在是太害怕了，不敢一个人入睡。当我问他是什么让他这么害怕时，他说是打雷。我相信对泰勒来说，打雷确实是可怕的事。但是，我认为泰勒不是一个焦虑症患者，他的症状与其说是由害怕导致的，不如说是习惯使然。他对打雷的恐惧只能算是第二位的影响因素，关键的症结还是在睡眠习惯上。对泰勒来说，那个晚上的雷暴让他惊醒之后，他就开始习惯性地认为每个晚上都有可能出现雷暴了。

父母会不会在他入睡前离开呢？他会在醒来后发现自己独自待在卧室中吗？他是否能让父母在离开后及时回到他身边呢？还是他要离开卧室去找他们回来？他会不会在半夜醒来后发现卧室里的灯都灭了，整间卧室漆黑一片呢？父母会不会不愿意缩在他的小床上陪他睡呢？父母愿意和他一起睡吗？这些问题困扰着泰勒，让他无法独自入睡。

评估孩子的恐惧程度

孩子们的“害怕”并不是指同一个意思。有的孩子会在没有任何焦虑感的情况下说这个词，有的则确实感到恐惧才这样说。有的孩子只对某些东西感到害怕，比如昆虫，

有的孩子则好像事事都害怕。有的仅仅在夜间感到害怕，有的则一整天都会感到恐惧。因此，面对孩子的具体情况，家长应该区别对待。为了确定矫正的具体方法，首先要搞清楚孩子的恐惧程度如何，可以参考以下问题进行判断。

| 孩子确实感到害怕吗 |

1. 孩子何时说出“害怕”这个词？说这个词时表现出害怕的情绪了吗？

一般来说，孩子在夜里唤醒父母的理由都是“我害怕”或者“我做了个噩梦”。但是对孩子来说，不管是否真的出现了恐惧感，他都会使用“害怕”这个词。如果孩子在说出这个词时非常平静，丝毫没有表现出恐惧，那很有可能他根本没有感到害怕。在判断时，孩子的表现比言辞更加可靠。也许孩子是想喝水，想让家长给他一些安抚，但是，他发现这些理由都不好用，只有当他说他害怕、房间里有怪物时，家长才会重视。而家长积极回应这些臆造的焦虑只会鼓励孩子继续这样说。

2. 孩子是否真的做了噩梦？

儿童做噩梦是很正常的，但是如果每晚都做噩梦就不正常了。那些抱怨每晚都做梦的孩子通常无法描述梦境的具体内容，而真的做了噩梦的儿童会表现得非常害怕，也能描述出梦境的内容（而不仅仅是含糊地说梦到了“怪物”、“蜜蜂”或者“强盗”）。如果孩子确实从噩梦中醒来，显得非常惊恐，家长最好不要让他独自待在卧室里，但是让家长每晚都陪着孩子睡也不现实。家长应该帮助孩子认识到他仅仅是做了个梦而已，现实生活中并不存在这样的危险。家长也可以在第二天找个时间与孩子就事论事地谈谈噩梦的内容（在夜里跟孩子聊天会让他养成不好的习惯）。

3. 孩子这样做是在测试家长的忍耐底线吗？

分清孩子是真的感到害怕，还是借此来测试家长的底线是很重要的，因为对于两者的处理方法非常不同，但是要分辨清楚却不是一件容易的事。无论孩子是真的感到害怕，还是仅仅为了测试家长的底线，他们都会表现出对入睡的抗拒。在这两种情况下，孩子都会抱怨说自己感到害怕。在有些情况下，区别是很明显的：充满恐惧的孩子会表现得非常惊恐，而企图测试家长底线的孩子则有可能笑场。而且，家长对真正惊恐的孩子越严厉，其恐惧感反而会更深，而测试底线的孩子则会变得愤怒。

4. 孩子是否还不困？

如果孩子的焦虑是由害怕引起的，那么，一旦家长允许孩子跟自己一起睡，他就会

很快入睡。要是在家长的陪同下，孩子还是无法快速入睡，那很可能是上床时间太早了。在入睡前的一两小时，人会经历一个异常清醒的阶段。有些非常乖的孩子，如果就寝时间过早，他们既不会想要看书，也不会想要看电视，而是安安静静地躺在床上，任想象力自由发挥，最终被不受控制的幻想吓到。在这种情况下，即使是没有焦虑感的儿童也会变得焦虑起来。只要调整作息时间，他们的问题就会迎刃而解。

| 焦虑程度 |

1. 孩子在夜间的恐惧程度如何？

孩子真正感到害怕是很容易看出来的。随着就寝时间的临近，他会感到惊恐，甚至手足无措。他会拉住父母不让他们离开，哭着求家长不要让他一个人待着。只要不让他独自入睡，他可以接受任何惩罚。半夜醒来后，他会躲在被子里尖叫、害怕离开自己的被窝，也可能跑到父母的卧室里去。相反，要是孩子在进入父母的卧室前还能自己拿起心爱的玩具，然后待在父母床前，安静地等着父母醒来，那他只是看上去有点紧张而已，并没有达到害怕的程度。要是孩子跟保姆在一起能很快入睡，那么他的害怕程度也不深。

2. 孩子的焦虑是仅仅出现在夜晚，还是一整天都会存在？

持续一整天的恐惧比仅仅在夜晚出现的恐惧更难处理。家长要搞清楚，孩子在白天是否行为正常，与其他人的相处是否融洽，是否会无缘无故地出现惊恐无措的情况。如果孩子的焦虑一整天都持续存在，对很多事物都有恐惧感，在参加各项活动时都表现出焦虑，那他夜间的焦虑不可能撇开白天的情况而单独处理，相反，这样的孩子需要更多的心理治疗。

3. 家长白天跟孩子短暂分开时，孩子的表现如何？

与家长的短暂分离会让儿童产生焦虑，这在幼儿身上很常见。这一问题最早出现在8~9个月的婴儿身上，焦虑感会在几个月内持续增长，然后慢慢降下来。有这一问题的孩子无法在保姆的陪同下入睡；每天去幼儿园或托儿所的时候，他们都会哭闹不止；他们不愿意外宿在朋友家，也不愿意朋友来家里留宿。如果孩子在家里很黏人，但是可以在保姆的陪伴下入睡，去上幼儿园时也不会哭闹，与其他孩子的相处也很融洽，对新的活动也不排斥，那他就不算是对离开父母有焦虑。

4. 焦虑持续的时间长吗？

看了恐怖片、从学校里听到了可怕的故事或者做了个噩梦，都有可能让孩子产生暂

时的焦虑。这种暂时的焦虑在每个孩子身上都会产生，无须进行特别的矫正。长时间存在的恐惧会持续几个月甚至几年，需要家长的特殊关注。这种恐惧会干涉孩子白天的表现，左右他们做决定。如果情况非常严重，甚至会影响孩子参与社会活动的能力。

孩子恐惧的对象是什么

1. 有什么事让孩子特别担心？

单一的刺激源，比如恐怖片，会引发孩子长期的焦虑与恐惧。孩子的恐惧肯定有个具体的原因，有可能是前一晚看到的电视节目、患重病的家人或者是家长出差了，也有可能是在学校里受欺负了、担心即将到来的考试或者害怕过于严苛的老师，还有可能是为家里的矛盾烦心，比如父母吵架、家长酗酒或者家人患有抑郁症等。根据孩子担忧的内容，家长可以提供适当的关心与帮助，也可以带孩子去进行心理咨询。

2. 孩子是对很多事都感到恐惧，还是仅仅对特定的事物感到恐惧？

有的孩子并不是对任何事物都感到害怕，他们会害怕某种特定的东西，比如昆虫、蜘蛛、蛇、着火等。如果孩子对特定的事物感到恐惧，那他的恐惧感只会在那种事物出现时才会产生。此时，家长就应该陪着孩子。如果在这些情况下，家长对孩子的要求置之不理，那么就有可能让恐惧蔓延到每一个晚上。要是孩子害怕的并不是特定的事物，且无论在白天还是黑夜都会产生焦虑感，那么除非这些恐惧感非常轻且出现频率非常低，否则下文介绍的那些行为矫正法收效都不会太大，家长需要向专业人士寻求帮助。

3. 孩子是否会害怕“怪物”或“强盗”这类他们并不熟悉的事物？

要是孩子对某些事物不理解，就有可能用自己的想象力来填补认识上的空白，从而产生焦虑。他会从那些外在的、具有威胁性的事物中寻找一个让自己害怕的特质，然后不受控制地陷入恐慌。记住，尽管孩子害怕的所谓怪物或强盗并不存在，孩子的恐惧却是真真切切的。这种恐惧感来自于真实的感觉与欲望。与其在房间内四处搜索“怪物”然后告诉孩子怪物根本不存在，不如用坚定、平静、充满关爱的语气告诉孩子，家长会好好地保护他，不让他受伤害。

4. 孩子是否怕黑？

很少有孩子能接受在彻底的黑暗中入睡。卧室里最好有一盏夜灯，或者能透进路灯的光，当孩子半夜醒来，尤其是从梦中醒来后，就能马上看清楚周围的环境，重新对睡眠环境进行定位，从而安定下来。

神经紧张的孩子会需要更多的亮光：首先要有一盏台灯，其次要有一盏顶灯。整个房间里的灯加起来会达到 60~200 瓦，让整个卧室变得非常明亮。也有的孩子宁愿睡在一片黑暗中，不愿意开着夜灯。如果这种选择出自孩子的本意，且孩子能在这样的环境中安睡，那家长不妨尊重孩子的选择。

5. 孩子是否害怕关门睡?

很多孩子希望在晚上睡觉时，房门不关上，至少得是虚掩着的。尽管那些害怕强盗的孩子会觉得关上门睡更安全，但是易受惊吓的孩子宁愿开着门。一般来说，开着门睡让孩子与外界环境保持连通，让他们对外界发生的事保持警惕，对自己所处的环境有正确的认知。听到家长走动或看电视的声音，会让孩子感到安心，因为这些声音意味着家长就在附近。一旦门关上，他就无法听到房间外的动静了，想象力就开始肆虐。家长不用担心房间外的动静会打扰孩子的睡眠。如果孩子仅仅是害怕关上门睡，那解决起来就很容易，虚掩着门就行了。

如何处理孩子的黑夜恐惧症

绝大多数家长都能分辨出孩子是真的害怕还是装出来的。如果家长认为孩子的害怕是装出来的，那就应该严格按照作息规律，跟孩子道晚安后就让他自己入睡。孩子就寝后，家长不要反复回到房间去查看情况。家长应该对自己的判断非常确定。如果孩子确实感到害怕，那严格执行作息规律不仅不能帮助孩子克服恐惧，还有可能加深这种恐惧。

如果孩子对就寝表现得忧心忡忡或者有一点害怕，家长可以在白天与孩子好好谈一谈。在夜晚，家长要表现得富有同情心、可靠而又非常支持孩子。只要孩子的忧虑能够减轻，家长就不必调整作息。入睡前，家长可以在孩子的床上坐久一点，但是要尽量遵守既定的作息时间。家长可以用平静坚定的语气告诉孩子他处于家长的保护之下，一切都很安全，然后跟孩子聊几句或者给他讲一个睡前故事。只要家长每晚坚持这样做，孩子就会逐渐感到安心。

如果孩子在夜间表现出焦虑，那家长的首要目标就是竭尽所能地消除这种焦虑。以下介绍的方法都基于一个准则：竭尽所能地让孩子感到安全，让他能够独自度过晚上的时间。当然这里的竭尽所能是以必要性为前提的。等状况稳定下来，家长就可以逐渐减少干涉，慢慢增强孩子的自信心与应对能力。

对焦虑程度不深的孩子来说，家长小小的帮助就能起到很大的作用。记住，恐惧感是呈螺旋式下降的，前一晚过得越平稳，后一晚的焦虑就会越少。尽量保持原有的作息规律，尤其是在恐惧感出现时间不长的情况下。睡前的亲子互动应该是愉快的、有条不紊的：家长的理解与支持非常重要。家长要试着确定孩子需要怎样的安抚，然后尽量满足。要让孩子知道，只要他需要帮助，家长就会伸出援手，既不会生气，也不会恼怒。家长的这种态度会减少孩子的焦虑。

每个孩子都是不同的，但是下面介绍的几种方法对绝大多数孩子都是非常有效的。所列方法是按情况的严重程度排列的，排在前面的适用于情况轻微的孩子，而排在后面的则适用于情况较为严重的孩子。

帮助孩子减少恐惧、使其快速入睡的方法

1. 让孩子待在卧室里的时间充满欢乐。如果孩子晚上是独自睡在卧室里或者和兄弟姐妹分享同一间卧室，可是他只会在晚上待在卧室里，那他很可能将卧室与夜间不愉快的事情联系了起来。家长可以在白天安排孩子多待在卧室里，让他做一些感觉愉快的事情，比如讲故事或者玩小游戏等。晚上就寝前的亲子互动也应该安排在卧室里进行。如果孩子对换睡衣或刷牙有排斥情绪，家长可以提前让孩子做好这些就寝准备，然后再开始亲子互动环节。

2. 延迟入睡时间。入睡时间越迟，孩子越困，入睡速度就越快，越能减少孩子的恐惧，从而让他接下来几天的睡眠进入良性循环。延迟应该以孩子出现倦意、不再精神奕奕为限。家长可以记下孩子真正入睡的时间，然后以此为参考，将入睡时间安排在这一时间之后。最好将入睡时间设定为比真正入睡时间迟 30 分钟至一小时，以确保孩子能在最短的时间内入睡。

3. 建立激励机制。为了帮助孩子缓解恐惧，家长要允许孩子提出自己的要求，具体如何执行要视孩子当前的行为、需求及能力而定。如果孩子在半夜醒来后无法自行入睡，家长可以这样设计积分表：能自己入睡积 1 分，这一分孩子肯定能得到；一夜安眠可以积 2 分。也可以这样设计：一觉睡到天亮积 3 分，半夜醒来后需要家长安抚积 2 分，半夜醒来后跑到家长房间需要家长陪着回到卧室积 1 分，需要更多帮助就不给分。

4. 教孩子独自应对焦虑，让他学会在半夜醒来后自己再次入睡。有些孩子养成了

呼唤父母的习惯，在没有真正感到害怕甚至还没有完全清醒时，就已经开始呼唤父母了。让孩子改掉这种习惯对帮助孩子克服恐惧是非常有用的，家长可以采用激励机制来达成这一目的。让孩子在呼唤父母前先好好想一想，到底有没有感到恐惧，如果没有，就不要随便呼唤父母。即使有恐惧或者有点紧张，也应该尽量撑一会儿。如果实在是太恐惧了，可以向父母寻求帮助。不呼唤父母的夜晚，孩子可以获得积分或奖励。

5. 与孩子谈谈，搞清楚孩子到底想要什么。儿童对自己的需求具有准确的判断力，如果你家宝宝告诉你，他希望你能在晚上隔一段时间就去他房间里看看他，其他时间你可以自由支配，那你大可以用这些时间去做自己的事。即使孩子一开始提出的要求有点超出家长的预期，家长也可以暂时接受它。只要孩子能快速入睡，且睡眠过程比较安稳，那就已经在进步了。关于家长对孩子提供的帮助及奖励，可以每周与孩子商量一次。一段时间之后，原本需要家长每隔 5 分钟就去看一次的孩子，可能只需要家长在入睡前去查看一次就够了；而一开始只能拿少量积分的孩子，可能会变成拿分高手。

6. 设定合理的限制。我们在上文说过，对有焦虑的孩子设定限制，比如让他在感到害怕时独自待在卧室里，可能会适得其反：孩子可能会更焦虑，从而走向另一个极端。只有一种情况例外，即造成焦虑的根本原因就是缺乏合理而固定的限制。换句话说，并不是对每一个有焦虑感的孩子都不能设定限制，某些有弹性的限制还是可以设定的。例如，家长可以答应孩子在他恐惧时陪他一会儿，同时可以拒绝孩子的其他要求，比如讲故事、拿水喝或玩家长的头发等。只要可能，家长就应该拒绝更多不必要的要求。

7. 晚上开着灯和房门。在孩子睡觉过程中，夜灯对缓解恐惧非常有用，但是一般的照明灯应该在孩子接受的前提下，逐渐放弃使用。应该更多地使用台灯而不是顶灯，可以将 60 瓦的灯泡换成 30 瓦的，然后换成 15 瓦的，最后换成夜灯用的 7 瓦灯泡。必要时，台灯或顶灯都可以换成磨砂效果。如果孩子抱怨夜灯产生的阴影让他害怕，家长可以适当进行调整，但是一旦采用了非常合理的模式，就应该坚持下去。不要有时开着灯有时关着灯，也不要三天两头更换灯的位置，这对减少孩子的恐惧没有一点好处。最后，在孩子睡觉时，开着他卧室的房门，除非孩子要求将房门关起来。

8. 每隔一段时间去查看一次孩子的情况。很多时候，孩子之所以反复呼唤父母是为了确认父母没有走远。家长可以答应孩子每隔一段时间去看他一次。开始时，查看的时间间隔可以设定得短一点，比如 5 分钟甚至 1 分钟查看一次，这样孩子在产生恐惧感之前就能看到父母了。一旦孩子适应查看的频率了，家长就可以延长两次查看之间的时

间间隔了，比如延长到10~15分钟。但是，最关键的是要在亲子间建立起信任感：家长要让孩子相信自己会在答应的时间内去看他，不要因为孩子没有发出声音就随便拖延查看的时间。

9. 陪孩子入睡后再离开。孩子肯定不喜欢在他入睡时整个楼层只有他一个人，家长可以答应孩子，当他入睡时，与他待在同一个楼层，直到他睡着为止，或者到孩子自己认为家长可以离开为止。一旦答应，就要遵守承诺。这种方法可以让孩子省去反复确认家长没有走远的时间，从而放松地进入睡眠。

10. 答应孩子晚点去睡。有些孩子，尤其是那些父母睡得比较早的孩子，害怕自己是家里最后一个入睡的人，到了半夜，全家就只有他一个人还醒着。这些孩子会在父母入睡前强迫自己入睡，可总会睡不着。在这种情况下，安排几次查看是非常有用的。家长不必每隔一段时间去查看一次，只需要在自己入睡前去看看孩子是否已经入睡即可。

11. 待在孩子的卧室里。如果隔一段时间去查看孩子无法让他平静下来，家长可能就需要花点时间待在孩子的卧室里了。可以陪着孩子睡，也可以坐在房间里等他睡着。待在孩子的卧室中时，家长可以采取逐渐远离法，一开始坐在孩子床边，逐渐将椅子挪得离床边远一点，然后挪到卧室外去。也可以在此过程中短暂离开，通过增加查看次数来减少集中待在孩子卧室里的时间；还可以引进激励机制。什么方法管用，家长就可以采用什么方法。

12. 睡在孩子的卧室里。如果你家宝宝的恐惧感非常严重，那么唯一让他感觉安全的方法就是陪他一起睡。家长可以在孩子的卧室里放两张床，与孩子分开睡；也可以在地板上铺上铺盖，睡在地板上。也可以让孩子睡在家长的卧室里，但是最终目的应该是让孩子到自己的卧室里去睡。

绝大多数孩子的恐惧会在父母的陪伴下减少，孩子会渐渐地睡得很好，家长也会因此而睡得很好。这种方法的原理就是让孩子逐渐平静下来，减少惊恐，恢复到正常状态，从而减轻症状。如果孩子的焦虑只是众多问题中的一部分，即使他在晚上睡得很好，在白天也仍旧会出现焦虑的症状，在这种情况下，家长就应该继续睡在孩子的卧室里，直到孩子的焦虑感有所减少为止。如果孩子的焦虑感很严重，持续时间很长，家长可以寻求专业帮助。

等孩子的情况有了一定程度的改善，家长就可以根据上文介绍的几种方法来进一步

改善孩子的症状。一旦孩子连续一两周都没有表现出惊恐了，家长就不需要再睡在孩子的卧室里了，只要与孩子待在同一层楼或在他害怕的时候适当进行安抚就可以了。

随着矫正的深入，孩子的睡眠状况开始好转，不会再在半夜反复醒来确认父母是否在身边了。如果孩子此时能学会在父母不在身边的时候自己入睡，问题就算是解决了。家长在矫正过程中加入激励机制或与孩子进行适当的沟通，问题解决起来就会容易得多。如果孩子还没准备好独自入睡，家长可以帮助孩子准备。在孩子入睡前，家长可以短暂离开孩子的卧室，借口去“拿点东西”。家长离开的时间取决于孩子对家长离开的承受能力，有可能是 10 秒钟，也有可能是 10 分钟。如果孩子在家长离开又返回后无法快速入睡，家长可以再次借故离开。在一两周之内，家长可以逐渐延长离开的时间，缩短返回后待在房内的时间，直到孩子习惯家长离开为止。

| 不要让兄弟姐妹或宠物代替父母 |

在很多家庭里，兄弟姐妹常常分享同一个房间。孩子在夜里出现惊恐感后，应该是父母而不是哥哥或姐姐去安抚他。家长不应该让惊恐的孩子在醒来后爬到其他孩子床上去，也不要让其他的孩子去安抚受惊的那个孩子，更不要为了安抚受惊的孩子而将原本不在一间房的孩子们安排到一个房间去住。孩子们不应该代替父母给彼此创造安全感，两个孩子睡在同一间房里确实可以相互照顾，但是不要让年龄稍大的孩子来照顾年龄较小的那一个。

让宠物代替家长陪伴受惊的孩子对宠物来说很不公平，而对孩子来说可能根本就没用。当房间里有宠物时，防止宠物从房间内跑出去，房间门一般是关上的，而关上房门有可能加重孩子的焦虑。即使房间内有宠物，当孩子受惊时，也很难及时找到它们，而宠物发出的声音还可能会打扰到孩子的正常睡眠。总之，宠物并不能缓解儿童的焦虑感，即使能缓解，孩子也只会对宠物产生强烈的依赖感，深层次的问题还是得不到解决。

| 泰勒的变化 |

上文我们提及过泰勒的症状，在对他的矫正过程中，我们使用了好几种上文介绍过的方法。我建议他的父母多花点时间在入睡前的亲子互动环节上，给他讲一个故事或者跟他一起玩游戏。由于泰勒到 9 点之后才会入睡，所以我们延迟他的入睡时间。父母先给他讲一个睡前故事，然后在 9 点半左右跟他道晚安。此时泰勒已经很困了，第二天早

晨父母仍旧在 7 点就唤醒他。泰勒要求父母在他入睡时跟他待在同一层楼，并隔一段时间就去看他一次，直到他睡着为止。他的父母也这样做了，即使泰勒没有发出任何声音，他们也按照约定去看他。泰勒同意关掉房间内的一盏灯，过了两个星期，他同意父母换上功率较低的灯泡。

在跟泰勒商量之后，我们制定了一个激励机制：如果晚上睡得很安稳就可以积分，如果能独自安睡或减少查看次数就可以积更多分。积分积累到一定程度就可以兑换奖品。这样一来，泰勒在半夜醒来之后开始试着自己再次入睡。如果他确实需要帮助，父母会及时伸出援手，必要时，父母会隔一段时间去看他一次，直到他再次入睡为止。泰勒不再跑到父母的床上去睡了，如果他非常惊恐，爸爸或妈妈就会陪着他睡在他自己的卧室里，但是在这样的情况下，他就不能积分了。当打雷时，爸爸或妈妈会去他房间里陪他，而他仍旧可以获得积分。

泰勒每晚都睡在自己的房间里。原本由入睡太早导致的长时间清醒不再出现，在延迟入睡时间后，他的入睡变得更容易了。他逐渐习惯独自入睡，在半夜醒来后，也不会觉得周围环境发生了改变。他也不再时刻担心父母是否已经走远了，因为他的父母每隔一段时间就会按照约定进来看他，如果他需要，父母会非常乐于帮助他。同时，房间内的光线也昏暗了很多，他也不再担心打雷了，因为一旦打雷，他的父母就会陪着他。而且，只要他表现良好，就能获得积分与奖品。

泰勒的矫正进行得很顺利。第一晚他就不再像以前那样频繁呼唤父母了，他明白父母就在附近，就像他们承诺的那样，会隔一段时间进来看他一次，所以他的忧虑少了，入睡也更快了。开始时，他确实需要家长时常去看他，但是一旦他发现父母确实严格遵守了承诺，他就表现得不再需要这些查看了。每晚他都独自一人入睡，而且睡眠质量不断提高。他对自己获得的积分与奖品深感自豪。后来，我们将他的入睡时间挪到 8 点半，将台灯换成了夜灯。渐渐的，他会在白天待在卧室里玩玩具，这样一来，卧室带给他的就不再仅仅是夜晚不愉快的时光了。

本章介绍的所有方法都应该根据孩子的具体情况选用，家长可以根据孩子的需求、家长自身的能力及居住环境设计一个矫正方案。经过一段时间的摸索，家长就会明白什么方法比较有效。首先要假设孩子的恐惧都是真实的，然后在对孩子提出要求之前给予孩子支持。如果经过一段时间的矫正，效果不明显或者没有效果，家长就应该去寻求专业帮助。

第6章　腹绞痛及其他影响睡眠的疾病

很多疾病都可能影响儿童的睡眠。发烧会让孩子睡不好，长牙时的疼痛也会干扰孩子的睡眠。在影响孩子睡眠的疾病中，最典型的就要数腹绞痛了，这种疾病的发作往往很突然。但即使是腹绞痛也不会长期干扰孩子的睡眠，不会持续数月或数年之久。如果你家宝宝长期睡不好，排除各种常见原因之后仍然找不出其根源，家长就要考虑孩子是否患有某种导致其无法安睡的疾病了。

腹绞痛

婴儿出生后头几个月，导致其严重睡眠障碍的通常是腹绞痛，婴儿会时常激烈地哭喊，而且很难被安抚。腹绞痛通常在下午或傍晚发作，最长可以持续几小时之久。如果孩子出现了腹绞痛，家长能做的无非就是抱着他四处走动，或者让他躺在自己腿上，给他摸摸背。一般来说，对于这种情况，家长无法提供实质性的帮助。

患有腹绞痛的婴儿通常会出现胀气，双腿缩在胸前，只有当腹中气体排出或肠道蠕动时，才会感觉好受一点。因此，腹绞痛通常被认为是由肠痛引起的。这种说法是否正确不得而知，但是在非常严重的腹绞痛病例中，儿科医生确实会给患儿开放松肠子的药物。还有一种说法，即胀气与某些不适其实是由长时间剧烈的哭泣而吸入的空气所导致的。而导致孩子大哭不止的原因则是另一回事了，需要单独考虑。

另一个可能引发腹绞痛的原因是孩子对外界环境过于敏感。患有腹绞痛的婴儿通常

对周围环境非常敏感，对外界的刺激会反应过度。很多专家都认为，腹绞痛患儿所看到、听到、感觉到的外部世界是令人不快与混乱无序的。他们接收到的感官刺激对他们来说很难处理，孩子会因此感到不安，充满紧张感，其处理机能严重超出负荷。当一天结束时，他就想要释放这些紧张感，由此导致了腹绞痛。无论这种说法是否正确，腹绞痛患儿确实表现得更需要借由大哭来释放压力，而且一哭起来就很难抑制住。

儿童出现腹绞痛时，家长首先要对其进行安抚，可以抱着他轻轻摇晃，喂他吃点东西，或者给他一个奶嘴。如果这些都不奏效，家长可以让孩子独自在婴儿床上哭 15 分钟，也可以安安静静地抱着他让他哭。若 15 分钟到了孩子还是大哭不止，家长可以重新进行安抚。安抚时，语气要镇定而柔和，不要慌乱，也不要做出激烈的举动，比如抱着他上下颠或者跟孩子一起在屋里疯跑。如果安抚没起作用，家长可以每隔 15 分钟安抚一次。

记住，由于腹绞痛患儿希望借由大哭来让自己好过一点，所以家长可以让他们适当哭一段时间。如果任由孩子大哭，两三次之后，孩子的症状就会减轻。在一两天内，孩子的哭闹会变得更短暂、更和缓，他也会睡得更好。有些因为严重腹绞痛而住院的孩子，似乎一住院就被神奇地“治愈”了，可能是因为护士会放任孩子大哭，而不是像家长那样硬性阻止孩子哭泣。

绝大多数腹绞痛症状会在婴儿满三个月后消失，当腹绞痛消失后，孩子的睡眠问题就转化成了习惯问题。腹绞痛出现时养成的习惯在腹绞痛消失后保留了下来，继续影响孩子的睡眠。当腹绞痛出现时，家长要花大量的时间抱着孩子轻轻摇晃、四处走动、进行安抚，以帮助其入睡。当腹绞痛消失后，孩子仍旧需要父母这样做，并不是因为他们难受，而仅仅是养成了习惯。因此，家长应该帮助孩子在腹绞痛消失后养成新的、更合理的入睡习惯，具体可以参考本书第 3 章。

最困难的环节在于判断腹绞痛症状是否消失了。通常，腹绞痛是逐渐消失的，所以家长不太容易发现。**记住，腹绞痛通常在孩子长到三个月时消失，不仅在晚上睡觉时不会再出现，而且在白天也一样。**腹绞痛在傍晚时最为严重，我们至今不知道到底是何种激素或何种身体机能导致了这一现象，但这似乎与人体潜在的日夜节律有关。

腹绞痛患儿看上去愁容满面，当他处于疼痛中时，很少会感觉到饥饿、沮丧或生气，想要通过外界刺激来转移他的注意力非常难。如果除了大哭之外孩子没有表现出有疼痛感，那他在晚上入睡时的哭闹就不大可能是由腹绞痛引起的。如果家长轻轻拍拍孩子的背、摇晃他、给他奶嘴或者喂食之后，孩子的哭闹就减轻了，那就可以判断哭闹不是由腹绞痛引起的。同样，如果孩子醒来后，家长可以通过安抚使其快速入睡，那么这样的清醒也不是由腹绞痛引起的。一旦分清这些情况，家长就可以判断孩子的睡眠问题是否是由腹绞痛引起的，从而对症下药。

慢性病

儿童慢性病可能会导致多种持续性睡眠障碍。慢性病本身会导致疼痛或不适：皮肤过敏会导致瘙痒，偏头痛会导致夜间头痛与恶心，哮喘会导致呼吸困难。儿童的睡眠可能被某种特定的病症或不适干扰：因为糖尿病而精神紧张、总想上厕所，因为癫痫频繁发作而无法安睡。同时，某些疾病的间接结果也会引发睡眠问题。例如，某些药物具有干扰睡眠的作用，矫形支架会让孩子感到不适从而影响其活动能力，而焦虑可能让孩子一直保持清醒而无法入睡。

如果你家宝宝正被某种慢性病所困扰，那你就要格外注意了。最难的是搞清楚到底是疾病中的什么因素干扰了睡眠。有时几种因素会集中到一起，共同引发睡眠问题。由慢性病导致的睡眠问题有可能非常复杂，其复杂程度甚至会超出家长的能力范围，必要时可以向医生求助。下面我们来讨论几种典型情况。

夜间疼痛症状

当夜间睡眠被疼痛干扰时，需要处理的不是睡眠本身，而是导致睡眠问题的疼痛症状。举例来说，当孩子受伤或长牙时，出现疼痛的原因非常清楚，所以处理方法也很简单直接，绝大多数影响儿童睡眠的夜间疼痛症状都是如此。然而，有两种病症会长期影响孩子的夜间睡眠却常常被家长忽视：中耳疾病与胃食管反流。

| 中耳疾病 |

一旦确诊，慢性中耳疾病是很容易治愈的。中耳疾病通常是由液体积聚在中耳腔中

无法排除导致的。这些液体会导致中耳感染，即使没有感染，也会导致暂时性失聪。如果液体长时间积聚在中耳腔内，最终会导致中耳骨骼的损坏。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

当儿童的中耳被感染后，中耳腔内的压力会增大，耳鼓会膨胀，从而产生疼痛感。如果液体没有引发感染，就不会导致疼痛，但是仍旧可能干扰睡眠。有可能是儿童躺平后，中耳排出液体的能力降低，更多的液体在中耳腔积聚，导致压力增大，到了某一程度，孩子就会感到不适。

不管具体原因是什么，那些耳鼓后长时间积聚液体的儿童确实会有严重的睡眠问题，并且除了这一因素之外，似乎也找不到其他影响睡眠的因素了。当这些儿童的病症得到正确的治疗之后，必要时插入引流管导出液体，不仅可以使中耳疾病得到有效的控制，而且可以极大改善孩子的睡眠。

> 卡洛琳是一个8个月大的小女孩，她有着长期的睡眠问题。虽然入睡非常快，晚上却总是频繁醒来。每次醒来后，她都大哭不止。有时父母抱起她，她就会停止哭闹，但是要再次入睡就非常困难了。即使父母抱着她轻轻摇晃或四处走动，也需要10~15分钟才能再次入睡。从卡洛琳的病史来看，似乎没有什么重大的疾病会影响其睡眠，不过她的父母告诉我，在过去一年里，她得过三四次中耳炎。

很多像卡洛琳这样的孩子都会在夜里频繁醒来，醒来后哭闹不止，重新入睡又非常困难，父母通常为此尝试了所有的方法都没有效果。每当看到这样的孩子，我都会仔细检查他们的耳鼓，然后再下诊断、开药。当我检查卡洛琳时，我发现她的耳鼓后面仍旧积聚着液体，所以我插入引流管将液体导出。术后不仅她的中耳炎得到了治愈，其睡眠问题也随之解决，这样就避免了一连串不必要的行为矫正。

胃食管反流

另一个导致夜间疼痛的原因是胃食管反流，又称“胃灼热”。通常，食物从口腔进入食道，顺食道而下，通过一个瓣膜进入胃中，这个瓣膜能让食物留在胃中，阻止其反向逆流。在婴儿期，这一瓣膜还无法完全发挥作用（这也是婴儿经常吐奶的原因）。同时，食物从胃进入肠道时也可能出现异常，从而引发新的问题。

偶尔出现的吐奶确实烦人，但却构不成困扰，因为反流上来的物质都被婴儿通过吞咽动作顺着食道重新咽下了。如果胃也出现类似现象，就会出现反复的反流，从而导致食物停留过久，造成灼热感，甚至疼痛。有时候，有些酸性物质甚至会进入气管，再进入肺中，从而引起咳嗽、窒息，甚至引发肺炎。

当婴幼儿在夜间频繁醒来并哭闹不止时，家长应该考虑原因是否就是胃肠道反流引发的疼痛。其实，孩子清醒时比在睡眠中更容易出现反流。夜间出现的反流绝大多数是由身体的挪动及哭闹引发的。夜间出现反流的儿童在白天也会表现出某些症状：他们会频繁吐奶，可能出现窒息或呛住的情况。如果你家宝宝在白天没有这些症状，那么很可能他在夜晚也不会出现反流。

如果孩子表现出反流迹象，就需要进一步诊断，可以做一个 X 光检查，也可以直接测试食道的酸性。我们偶尔会在实验室里整夜检测孩子的睡眠与反流情况，从而判断到底是否是反流导致了不适与频繁醒来。开具的药物通常包括抗酸剂与抗反流类药物。有时也会为了进行诊断而做一些基本测试，手术是最不常用的治疗方式。

药物导致的睡眠问题

帮助睡眠的药物总是被滥用。近年来医生发现，服用安眠类药物的成年人会出现更多的睡眠问题，儿童也一样。经常服用安眠类药物的儿童会对药物产生依赖，不服用就睡不着，而且即使借助药物睡着了，睡眠质量也很差。当孩子的睡眠问题久治不愈时，家长会感到绝望，转而向医生求助。通常医生会开一些帮助睡眠的药物，最常用的就是抗组胺剂，比如苯海拉明。这些药物都有副作用。催眠类药物水合氯醛及镇静剂类药物安定片等也时常出现在医生的药方里。

对一个健康的正常儿童来说，这些都无法解决其睡眠问题。这些药物可能对孩子产生反作用，让他们无法安静下来，也无法入睡。在某些情况下，比如睡眠性呼吸暂停，这些药物对孩子可能会有危险性。即使孩子在药物的帮助下睡得很好，只要家长能找出干扰睡眠的真正原因，并帮助他学着在不借助药物的情况下入睡，孩子就可以获得更高质量的睡眠。药物也许只能暂时改善孩子的睡眠，持续几天或几周，然后老问题又会出现。此外，药效较浅的药物通常会干扰孩子白天的情绪与行为：孩子可能会表现得亢奋、黏人、疯狂或者过度孩子气。

如果家长能在不借助药物的前提下，通过行为矫正改善孩子的睡眠，就不用担心孩子因为服用药物而存在潜在的生理或神经系统问题了。我接触过很多不需要服药而通过其他方法改善睡眠的案例。在很多案例中，服药反而会适得其反，孩子白天的行为能力、集中注意力的能力及学习能力都会受到影响。约书亚就是这样一个例子。

> 约书亚是一个4岁的小男孩，他的父母认为他既易怒又紧张。他在夜晚入睡有很大困难，在白天又表现得闷闷不乐，因此父母带他去看了医生。医生给约书亚开了药：早晨服药一次，用以保持一天的旺盛精力；晚上入睡前服用安眠类药物，如果半夜醒来后迟迟无法入睡，就再服用一次更强效的安眠类药物。在我看到他之前，他已经吃了10个月的药了。

我发现约书亚很不快乐，很容易为一点小事发怒。他与同龄人或大人的交往很不顺利，我觉得他应该进行一次心理评估。首先，我让他的父母停止给他吃药，以便彻底掌握他的症状，为进一步诊断打下基础。然后，我们一起商量改变他的作息时间，调整设定限制的方法。约书亚答应配合治疗，条件是表现好的时候要给予积分与奖励。

几周后，他的父母看上去放心多了。开始时确实比较艰难，但是过了这段时间，约书亚就能快速入睡，并且不再频繁醒来了。另外，他在白天也表现得更快乐了，亲子关系也得到了改善。当我再次见到约书亚时，他脸上挂着微笑，看上去很开心，在我们的对话中也表现得非常好。总而言之，他变成了一个阳光小孩。

对入睡困难的孩子，我向来不推荐药物治疗，当我着手矫正一个长期服用药物的孩子时，我都会让他先停药观察一段时间。如果是药物的副作用导致了孩子的睡眠问题，家长就应该与医生交流一下，找出行之有效的方法。可以改变孩子服药的剂量或次数，也可以更换药物。治疗哮喘可以用吸入器代替药物，副作用更小。抗生素本身不太可能导致睡眠问题，但是药水中的添加剂可能会影响睡眠，可以改用胶囊。

大脑功能异常导致的睡眠问题

在少数案例中，儿童脑部受损，导致控制睡眠的大脑机制遭到破坏，从而引发劣质睡眠。绝大多数脑部受损的儿童都有明显的外部特征，通常他们会有弱智现象，可能伴有癫痫或痉挛，还有可能是聋哑人。

在对脑部受损的儿童进行矫正时，可以放慢速度。例如，对于普通孩子，家长可以在孩子入睡后就离开房间，但是，对脑部受损的孩子，家长可以先让他习惯分床不分房睡，第二步才是离开房间。矫正不合理的作息是比较容易的，对视力受损的儿童来说尤其重要，因为这些儿童缺乏对光线的敏感性，无法根据光线来控制身体的节律。就像我们上面说的，药物也会对脑部受损的儿童的睡眠产生影响。最后，脑部受损可能会直接导致孩子的睡眠障碍，也就是说，大脑控制睡眠的区域无法像正常人那样运作。

当我遇到这样的患儿时，我通常先着手解决与脑部损伤无关的因素，比如药物的副作用、不合理的睡眠习惯或作息问题等。等所有其他因素都被排除之后，我才会断定孩子的睡眠问题是由脑部损伤引起的。

> 莎拉是一个6岁的小女孩，患有肌肉萎缩症，这让她深受其害。她的生活几乎被困在床上，每天只有小部分时间是坐在轮椅上的。她每天要吃一次药，以帮助肌肉放松。尽管不能说话，但是她对周围发生的事都很清楚。她的父母全心全意地照顾她，但对她每天只睡5个小时很不满意。她通常在半夜入睡，到凌晨5点就醒来了。如果就寝时间过早，她会试着发出声音，让父母过来陪她，或者将她抱到其他房间去，跟他们待在一起。对于莎拉这种情况，无论是调整习惯还是服药都不管用。有人告诉她的父母，问题出在莎拉的肌肉萎缩症上，而他们对此束手无策。

当我看到莎拉时，我发现她尽管晚上睡得很少，但会在白天小睡，每次都在4小时左右。白天她大部分时间都待在床上，当她一个人待着时，她就会睡觉。这与其说是由她的肌肉萎缩症导致的，还不如说是习惯使然。（停药后，她的睡眠没有发生改变。）

虽然这个问题困扰莎拉很多年了，矫正起来却很容易。我建议她的父母让她白天保持清醒，多让她离开床，安排一个人时刻陪着她以防止她打瞌睡。此外，我也对她服药的剂量与时间做了调整。一旦莎拉白天不再小睡了，她的夜间睡眠就得到了改善。两周之后，她的睡眠时间调整为晚上9点到第二天早晨6点，白天小睡不超过一小时。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS

第7章 第一类作息紊乱问题——睡眠阶段问题

本章我们将探讨由作息引发的睡眠问题及其应对方法。其实，很多由不合理的作息引发的睡眠问题非常相似，可以用类似的方法加以解决。

睡眠阶段

孩子入睡或保持清醒的能力在一天中的不同时段是不同的。在孩子处于清醒阶段时让他上床就寝，他会很抗拒。同样，在孩子还处于睡眠阶段时就叫醒他，他会表现得很不情愿或者起不来，因为他的身体机能还停留在睡眠状态中。

我们每个人都受到睡眠阶段的影响。假设某人每晚都在 11 点半入睡，一夜好眠，第二天早晨 7 点半起床，那这个人的睡眠阶段就从前一天晚上的 11 点半一直持续到第二天的 7 点半。如果改变这个作息，会发生什么呢？我们来看以下 4 个假设：

- 假设这个人提前上床，在睡眠阶段开始前就准备入睡，比如 8 点就躺床上了，结果很可能是怎么也睡不着。即使身体很疲倦，也无法立刻入睡。
- 假设提前起床，比如 4 点就起来，那起床就会变成一件艰难的事。即使起来了，人也会非常困倦，无精打采，这样的状态要持续到 7 点半。
- 假设延迟就寝时间，比如凌晨两点才上床，那头一碰到枕头就能马上入睡，可是早晨醒来的时间会保持不变。相较于平时，这一天的睡眠时间更少，会让人一整天都打不起精神。

- **假设第二天睡懒觉，一直拖到 10 点才起床，那 7 点半到 10 点这段时间，睡眠质量并不高，总是半睡半醒的。**

儿童也是这样，如果入睡和起床时间与他的睡眠阶段不吻合，他就会感到非常困倦。要是孩子不肯在家长安排的入睡时间入睡，或者在他困倦时熬夜不睡，他的睡眠阶段就有可能被人为地延迟或提前。

尽管儿童所需的睡眠时间与其年龄有关，但是，这个时间深受个人意愿与社会环境这两大因素的影响，因此，一个孩子实际所需的睡眠时间是一个非常有弹性的区间值。有的家庭习惯早睡，有的家庭习惯晚睡，这都没有关系，家长只要确定好孩子入睡的环境，然后采取合适的步骤调整其入睡时间即可。但是，就像你无法在短时间内跨越多个时区而不需倒时差一样，调整睡眠阶段也不可能在短时间内完成。你不可能在工作日执行一个作息，在双休日执行另一个作息，却不受任何影响。

要是家长对孩子入睡或起床的时间不满意，那这一章介绍的方法可能就不适用了。例如，孩子晚上的入睡时间是符合家长的期望的，但是早晨醒得太早，有的家长会将整个睡眠阶段延迟，以防止孩子早醒，可是这种方法往往适得其反，不仅解决不了问题，还会导致孩子晚上熬夜。对这类问题的具体探讨可以参考第 8 章。

| 睡眠阶段的判定 |

在搞清楚孩子睡眠阶段的起止时间前，千万不要盲目地做出任何决定。不知道孩子的准确入睡时间，就无法采取有效措施来进行矫正。一般来说，睡眠阶段的起始时间就是绝大多数晚上入睡的时间。注意，这里的入睡时间指的是真正入睡的时间，而不是家长期望孩子入睡的时间，也不是孩子躺上床的时间。对绝大多数孩子来说，这个入睡时间应该是相对固定的。

举例来说，如果你家宝宝在晚上 8 点就爬上床了，但是在接下来的两个小时里，他一直处于清醒状态，直到 10 点才逐渐睡去，那么 10 点才是真正的入睡时间，也就是睡眠阶段的起始时间。相反，如果你家宝宝每晚 7 点半就在沙发上睡着了，比你定下的 8 点早半小时，或者你需要费尽心思才能让他在 7 点半到 8 点这半个小时里保持清醒，那么 7 点半才是他真正的入睡时间。

正如我们在前文中提到的那样，儿童的睡眠时间是有弹性的。只要孩子愿意，他可以为了某种原因、某件事而延迟入睡时间。假设孩子的入睡时间是 10 点，这也是家长的入睡时间。但是家长扪心自问一下，10 点真的是孩子睡眠阶段开始的最早时间吗？还能提前吗？孩子在 10 点入睡到底是因为他真的要在这个时候入睡，还是他因为要等父母入睡而刻意撑到这个时间点？要找出答案也是很容易的。

家长可以在 8 点就上床睡觉，然后把孩子放在自己床上，如果孩子在 8 点半就能入睡，那就说明他真正的入睡时间是 8 点半。如果孩子在家长上床睡觉后，还能一个人自娱自乐到 10 点才入睡，那就说明 10 点确实是孩子的入睡时间。

即使孩子每晚入睡的时间都不一样，家长也应该能找出一个大概的入睡时间，然后将这个时间作为基准。确定好了起始时间，就可以着手确定睡眠阶段的终止时间了。一般来说，终止时间就是绝大多数早晨孩子自然醒来的时间。如果孩子总是在早晨 7 点自然醒来，那 7 点就是睡眠阶段的终止时间。可是，如果每天早晨 7 点孩子都是被家长唤醒的，尤其是当家长唤醒孩子时，孩子表现得不情不愿还要赖床，那 7 点就不是真正的终止时间。

与起始时间一样，终止时间也有很多蛛丝马迹可循。假设孩子每天早晨 7 点就醒来，跑到父母床边，然后爬上床再和父母一起睡一个小时，直到 8 点才再次醒来，那孩子的睡眠终止时间就应该是 8 点。如果这种情况只是偶尔出现，那孩子的起床时间不应该早于 7 点。确切的终止时间会随着矫正的深入而逐渐显现，并固定下来。

| 双休日、节假日的日间睡眠 |

节假日作息与日间睡眠情况能帮助家长确定孩子的睡眠阶段，更好地满足孩子的睡眠需求。家长确定了孩子在哪些时间点能够真正醒来与睡着，就能知道孩子的睡眠时间大概是多少。根据这些信息，家长可以找出影响孩子睡眠质量的深层次原因，从而进行有效矫正。

家长在着手记录孩子在节假日和双休日的起床时间时，务必要分辨清楚这个时间是孩子自然醒来的时间，还是被家长、兄弟姐妹或闹钟吵醒的时间。在长假期，孩子不会

像在双休日那样补眠，如果他在一定时期内都固定在某个时间点自然醒来，那家长就可以根据这个时间推算孩子所需的睡眠时间长度。

对那些还保留着白天小睡习惯的孩子们，家长要记录好入睡时间、持续睡眠的时间，同样要注意分辨到底是自然醒来还是受外界干扰而醒来。所谓的日间睡眠应该包括发生在日间的所有睡眠，包括在车上、在婴儿推车上、在电视机前睡着的情况，而不仅仅是那些正儿八经的午睡。有些家长会跟我说他们的孩子从来不在白天睡觉，但实际上孩子早就在车上打了好几次盹了。

日间睡眠可以是非常规律的，也可以是杂乱无章的。三岁的孩子在托儿所里可能会乖乖午睡，但是放假在家时就不肯午睡了。又或者他在托儿所里会固定在下午 1 点午睡，在家里就会延迟到 4 点才睡。如果你家宝宝的日间睡眠无论在时间长度上还是在入睡时间上都毫无规律可言，那你可以用图表记录下来，以便更直观地进行分析。

最后，将夜间睡眠时间与日间睡眠时间相加，以 24 小时为一个计算周期，算出孩子的睡眠时间长度。注意，如果孩子在上学时与周末、节假日所呈现出来的睡眠时间不一致，家长应该分别统计。

利用直观的图表来记录孩子的睡眠时间是非常明智的一件事，可以参考图 3—1。采用图表记录法之后，家长会发现很多先前未曾发现的小细节。例如，如果孩子起床比较晚，比如在周末早晨，那他当天晚上入睡的时间就会相应延迟；如果孩子在下午 4 点之后午睡，晚上就很难准时入睡。采用图表法还能避免家长只专注于那些孩子哭闹得比较厉害的晚上，而将好坏皆有的整个过程反映出来，从而避免家长片面地看待问题。在整个矫正过程中，家长都应该坚持记录，这样才能时时回顾过去采取的措施并思考其是否有效，从而不断改进直至矫正成功。

睡眠阶段的变化

在本节开始前，需要明确一个概念，我们所说的睡得“太早”或“太晚”，并不是指睡眠习惯不良，也不是指作息不健康，而是指这种睡眠阶段的提前或延迟已经导致了人体的不适，让人感觉到睡眠时间被剥夺了，因为人所需要的睡眠时间并不是由个人意志决定的，也不是由所谓的作息决定的，而是由人的生理需求决定的。

| 睡眠阶段提前 |

如果你家宝宝睡得比你早，起得比你早，那他的睡眠阶段就提前了，这样的孩子一般都是“云雀型”宝宝，具体可以参考图 7—1。

> 维多利亚是一个 9 岁的小女孩，她有睡眠阶段提前的问题。父母希望她能睡满 10 个小时，从晚上 8 点半睡到第二天早晨 6 点半。维多利亚每晚确实是睡够了 10 个小时，但是她的睡眠阶段是从晚上 7 点开始，到第二天早晨 5 点结束，她的父母对此感到心力交瘁。有几次，维多利亚的父母好不容易让她撑到了 8 点半才上床睡觉，但是维多利亚对这么晚睡很不满，她在凌晨 5 点就开始哭闹了。父母对她束手无策。

维多利亚就属于典型的睡眠阶段提前，她的父母企图通过只改变她的入睡时间来矫正整个睡眠阶段问题，这显然是徒劳的。要解决维多利亚的问题，就需要全面考虑。维多利亚每天早晨 5 点就醒了，她的父母也习惯在那个时间点给她喂食，然后午饭定在 11 点，晚饭定在下午 4 点半。早晨 8 点她会睡个回笼觉，午饭后会睡个午觉。从整体上来看，她的整个作息时间都被提前了。如果她的作息能往后延迟 1~2 小时，那早醒的问题就迎刃而解了。我们的矫正方案就是以此为准则展开的。

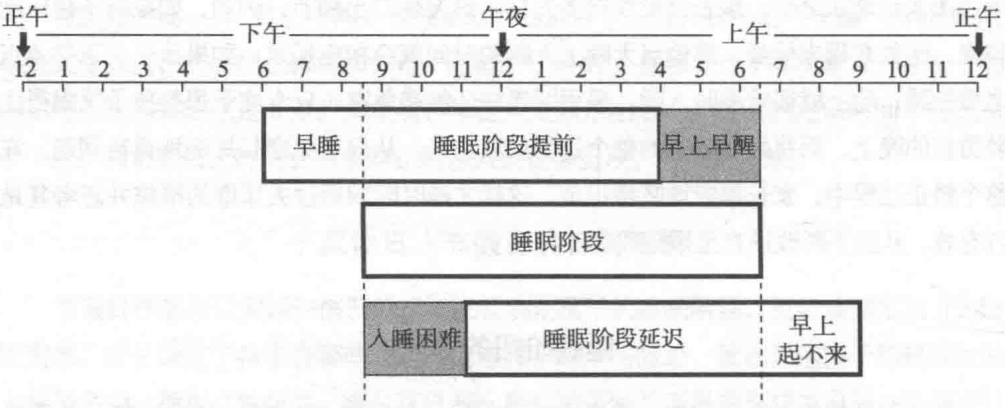


图 7—1　睡眠阶段改变

如果只解决早醒问题，随着矫正的深入，很多潜在问题就会纷纷浮现。首先，由于她的父母总是在她一醒来就给她喂食，她已经养成了习惯，到了那个时间就会感到饿，

如果我们想要矫正早醒问题，就要先着手矫正喂食问题。我们给维多利亚的父母灌输了一个理念，给孩子喂食的前提是她确实感到饿了，而不仅仅是一种习惯，所以一开始我们就明确了第一步要做的就是让维多利亚的早饭延迟。

其次，维多利亚在早晨的回笼觉也是问题的症结所在，如果我们只是解决早醒问题而对回笼觉不闻不问，就会事倍功半。这种多余的回笼觉会打乱她的作息，从而导致睡眠阶段整体提前。我们要做的第二件事就是将这个回笼觉延迟，让它与夜间睡眠独立开来，从而延迟她在上午小睡的时间。

我向维多利亚的父母解释，仅在一个晚上延迟她的入睡时间并不能达到重设生物钟的目的，而生物钟提前才是她雷打不动地在早晨 5 点就醒来的原因。睡眠阶段的改变要循序渐进。我让维多利亚的父母逐渐改变她的作息，从一日三餐、日间小睡到夜间入睡，统统往后延迟，每天比前一天延迟 15 分钟。只有这样，她的早睡问题才能改善。

我们的矫正计划实行得非常顺利。6 天之后，维多利亚的整个睡眠阶段往后延迟了一个半小时，她的睡眠阶段从晚上 8 点半开始，到第二天 6 点半结束，完全符合她父母的期望。通过矫正，维多利亚的回笼觉延迟到了上午 10 点，午睡则挪到了下午 2 点，她的三餐进食时间分别为：早饭 7 点，午饭 12 点，晚饭 6 点。

当然，并不是每次矫正都需要改变孩子的整个作息。如果孩子的三餐进食时间与日间小睡时间都没有明显提前，仅仅是起床时间过早，那家长可以单独调整入睡时间与起床时间。对仍旧需要在日间补充睡眠的儿童来说，在矫正过程中，应该保留平时的日间睡眠，但是要确保这些日间睡眠不会过长，至少不应该比平时所需的时间长：因为矫正的目的是让孩子更多地利用夜间时间补充睡眠，而不是白天时间。

要是矫正的效果不明显，家长可以继续加大延迟的力度。记住，每一次延迟都要循序渐进。在持续矫正的过程中，要确保孩子的三餐进食时间与回笼觉时间也相应延迟。要是通过矫正，孩子的起床时间比家长预期的要迟得多，那家长可以逐渐将其提前，直到完全符合预期为止。

在矫正过程中，可以利用光线对人的影响。晚上可以在房间里开灯，以延迟孩子入睡；早晨可以让房间保持黑暗，以防止孩子过早醒来。为此，家长可以在房间里挂上窗帘，给卧室里的灯装上罩子。根据我的经验，那些卧室在清晨就很明亮的孩子，比较容易早醒，要改变他们的睡眠阶段，就需要从减少光线开始。

睡眠阶段延迟

所谓的睡眠阶段延迟就是指孩子入睡与醒来的时间比家长预期的要晚，通常发生在猫头鹰型的宝宝身上。事实上，由于生物钟的作用和过多的人造光源干扰，每个人的睡眠阶段都在慢慢延迟。因此，睡眠阶段延迟在任何年龄段都是最为普遍的睡眠问题。

睡眠阶段延迟可能单独发生，也可能与其他睡眠问题一起出现，所以表现出来的状态比较复杂。下面我们来看几个案例，这些案例能够反映出睡眠阶段延迟问题的共性。

> 亚当是一个18个月大的男孩子，他有睡眠延迟问题。他的父母希望他能够在晚上7点半入睡，可是他从来没有遵守过。要是家长抱着他试图哄他入睡，他会非常抗拒，扭动着要挣脱家长的怀抱。从7点半开始，他的父母每隔半小时就会尝试哄他入睡，一直持续到10点。到了10点，他要么在家长怀中入睡，要么一个人在客厅里入睡。等他睡着，家长就会将他放到婴儿床上去。亚当每夜会醒来1~2次，哭闹不休，家长就会起来哄他入睡，如此反复。亚当的妈妈会在6点半起床去照顾亚当的兄弟姐妹，但是由于亚当晚上睡得太晚了，妈妈总是不忍心那么早叫醒他。（如果在8点前叫醒亚当，他就会有起床气。）8点起床后，亚当会马上吃早饭，下午1点吃午饭，然后在下午3点睡午觉。

亚当的父母每晚都轻轻地摇着他哄他入睡，这就导致了睡眠环境问题，这部分问题可以通过第3章介绍的循序渐进法加以矫正。但是，如果他的父母从7点半就开始使用循序渐进法，那亚当会在从7点半到10点这两个半小时内都哭闹不休。这就有点残忍了，更何况这两个半小时的哭闹根本无助于解决问题。

我建议亚当的父母将他的入睡时间设定为10点，跟他平时的入睡时间一致，先着手解决睡眠环境问题。同时，每天早晨都比前一天早15分钟叫醒他，逐渐让他的起床时间与兄弟姐妹一致，集中到6点半。他的午睡时间也要相应提前，从3点提前到1点半，也是每天提前15分钟，循序渐进。一旦他习惯了每晚10点上床睡觉，一安顿下来就能马上入睡，那就可以着手提前他的入睡时间了，也是每天提前15分钟。渐渐地，亚当的入睡时间提前到了8点半，早晨起床时间提前到了6点半，午睡时间提前到了1点半。

同时，他的睡眠环境问题也通过循序渐进法得到了矫正，他能自己按时入睡了，并且能一觉睡到天亮。对他这个年龄的孩子来说，10 小时的睡眠时间就足够了，亚当已经达到了这个要求，所以他的父母也就不需要再将他的入睡时间提前到 7 点半了。

解决儿童睡眠阶段延迟问题最简单的方法就是，首先让孩子的作息与当下的睡眠阶段相吻合，然后通过控制起床时间，循序渐进地提前整个睡眠阶段。关键在于：

- 早晨起床前与晚上入睡时，控制好室内光线；
- 矫正一开始就可以适当延迟入睡时间；
- 调整起床、日间睡眠与三餐进食时间；
- 逐渐提前入睡时间。

以下是一些具体的矫正方法：

- 确定孩子的睡眠问题类型。
- 在矫正早期，要确保孩子的作息与当下的睡眠阶段相吻合。
- 晚上避免室内太明亮，同时确保早晨室内光线充足。
- 接下来的步骤取决于孩子的具体情况：

  A. 矫正应该循序渐进，每天比前一天提前 15 分钟叫醒孩子，但是不要同时提前孩子的入睡时间。

  B. 如果是学龄儿童，需要每天在固定的时间起床去上学或去托儿所，那家长应该固定孩子的起床时间，然后着手调整孩子的整个睡眠阶段。

- 在矫正期间，可以保留孩子的日间小睡习惯，但是不要延长其日间睡眠时间。
- 与夜间睡眠一样，要是孩子的三餐与日间小睡时间都比家长期望的要晚，那么在矫正夜间睡眠的同时，也要矫正三餐与日间小睡时间。
- 要是除了睡眠阶段延迟之外，孩子还有其他睡眠问题，比如缺乏限制、睡眠环境问题等，家长可以一起矫正它们，也可以分开矫正。

引起儿童睡眠阶段延迟的原因多种多样，除了前几节介绍的生物钟原因与环境影响之外，还有很多其他因素会导致睡眠阶段延迟，比如生病、过于兴奋、外出旅行、黑夜恐惧等。只要是会导致儿童第二天赖床的原因都可以看作引发睡眠阶段延迟的原因。如

果前一天不晚睡，睡眠阶段就不会在第二天延迟；相反，如果前一天的晚睡导致了第二天赖床，就有可能引发接下来几天睡眠阶段的延迟。即使仅仅是在双休日晚睡晚起，也有可能引发睡眠阶段延迟问题。事实上，双休日晚睡晚起恰恰是大多数学龄儿童睡眠阶段延迟的主要原因。

青少年的睡眠阶段变化

| 睡眠阶段提前 |

青少年睡眠阶段提前问题极其罕见。在现实生活里，很少有哪个青少年会主动提前入睡时间并主动早起。有些青少年属于“云雀族”，他们的睡眠阶段相较于同龄人可能会显示出提前的迹象，他们不像同龄人那样熬到 11 点才睡，也不会赖床赖到 8 点过后再起来。但是，即使是“云雀族”的青少年也没有达到睡眠阶段提前的标准，他们的睡眠阶段仍旧在延迟。当然，从表面上来看，“云雀族”的青少年有着比同龄人更提前的作息，他们的起床时间更接近于睡眠阶段终止的时间，这也使得他们被剥夺的睡眠时间相对较少。

| 睡眠阶段延迟 |

青少年比较容易出现睡眠阶段延迟问题，而且其矫正难度要比儿童大得多。青少年在双休日常常熬夜，第二天睡到中午甚至更晚才起，渐渐地，他们的睡眠阶段就延迟了。青少年的睡眠时间被剥夺得非常厉害，尤其是在周一到周五，他们需要保持高度的注意力与清醒度，精力消耗非常大。

对家长来说，控制青少年的作息比控制儿童的作息要难得多，很多青少年即使心里明白规律作息的重要性也不愿意严格遵守。处于青春期的孩子很容易受到同龄人的影响，而这个年龄段的孩子通常都愿意将夜间时间花在看电视、玩电脑游戏、煲电话粥和听音乐上。生物钟原因加上这些后天的环境因素的影响，导致青少年的睡眠越来越不规律。

我们来看一个典型案例。

科纳是一个15岁的高一新生，多年来他都无法在晚上按时睡觉，也无法在早晨按时起床去上学，我见到他的时候是暑假，当时他的状况非常糟糕。等到秋天学校开学，尽管他在11点半就上床准备睡觉，但是直到凌晨三四点他才能睡着。在11点半到凌晨三四点之间，他会听收音机打发时间，偶尔也会起来吃夜宵。可想而知，科纳在早晨根本起不来。他的父母对他早晨赖床非常生气，有时候甚至会在叫他起床时动手打他。尽管如此，科纳还是能准时到校，偶尔有几次会迟到几分钟。周末晚上，科纳甚至会更晚入睡，他会看电视，直到凌晨三四点才上床准备睡觉。第二天整个上午他都在睡梦中度过，到了下午1点才会起来。

科纳在学校里表现平平，他对上学并不特别积极，也不会无故旷课，他想顺利地从学校毕业。他对自己晚上晚睡也很苦恼，尤其是只睡三个多小时就要起床去上学，这让他感觉身心疲惫，所以在早晨的几节课上他都会打瞌睡，即使勉强保持清醒也很难集中注意力。

科纳的睡眠阶段延迟得非常厉害，比我们在这一章前几节介绍的几个案例严重得多，他的睡眠阶段从凌晨3点半开始到中午12点半结束，整整比正常睡眠阶段延迟了5~6小时。

一开始，我给科纳的建议就是每天早起，戒除一切日间小睡，这与我们前几节介绍的方法基本一致，只是科纳的睡眠阶段实在是延迟得太严重了，矫正起来要复杂得多。一旦矫正开始，他所获得的睡眠时间就比实际所需要少得多，即使是周五与周六晚上，也无法获得足够的睡眠时间。他会感到非常疲倦，显得毫无生机，有时候会撑不下去。一旦他开始放弃，整个矫正就前功尽弃了。

因此，我为科纳提供了另一种方法——逆向法，这种方法对睡眠阶段严重延迟的情况非常有效。我让科纳反其道而行之，矫正开始后比平时睡得更晚，这样他的入睡时间就会顺着时钟逐渐推迟，直到推迟到与预期相符。一旦他的入睡时间达到了预期要求，我们就要求他每天早起，包括双休日，以便让他的睡眠阶段归位。

对科纳来说，这个方法比较容易实行，也比较有机会取得成功。在矫正过程中，无论他前一天多晚入睡，第二天都必须在6点半起床，双休日适当延迟到7点半。

无论我们采取哪种方法，前提都是科纳要学会自己控制入睡与起床时间。尤其是要确保自己每天按时起床。必要时，科纳的父母也会叫他起床，但他非常想躲回被窝里去，这样一来，争执就不可避免了。后来科纳自己去买了一个带收音机的闹钟，每天早晨科纳都在响亮的收音机声音里醒来。他还在房间另一头放了一个闹钟，一到起床时间就会一直响，直到他起来摁掉为止。

科纳最终选择了我给出的第二种方法，反其道而行之，顺着时钟一直迟延入睡时间，直到达到预期为止，具体见表 7—1。

表 7—1　　科纳睡眠阶段矫正方案

起初，科纳的睡眠阶段从凌晨 3 点半开始到中午 12 点半为止。

一周为限	入睡时间	起床时间
周六	早晨 7 点	下午 3 点
周日	上午 10 点	傍晚 6 点
周一	下午 1 点	晚上 9 点
周二	下午 4 点	午夜 12 点
周三	晚上 7 点	凌晨 3 点
周四	晚上 10 点	早晨 6 点
周五	晚上 11 点	早晨 6 点半

一周后，科纳的睡眠阶段从晚上 11 点开始到早晨 6 点半为止。

第一天，科纳要在早晨 7 点入睡，到下午 3 点起床；第二天，他要在上午 10 点入睡，在下午 6 点起床。以此类推。7 天之后，他的睡眠阶段就会调整到预期范围内，他所有的睡眠时间都会落在夜间。开始几天，多睡 1~2 小时是可以的，这会让他的睡眠阶段往后延迟得更多一点，从而加快矫正进度。但是到了矫正后期，他就必须在 6 点半之前起床了。矫正开始后，科纳同意如实记录整个过程，这样我跟他都能及时跟进。

矫正过程不可避免地会影响孩子的学业，可能导致 1~2 次缺课，但是在周五早晨开始矫正过程会将缺课的数量降到最低，我们对科纳就采取的这个方法。如果周五开始矫正过程，那接下来的周二或周三孩子很有可能是无法按时去上学的，但是一旦矫正结束，他们的出勤率就会比矫正前好得多。

当然，如果孩子的睡眠阶段延迟得并不是非常严重，整个延迟时间控制在 4 个小时之内，那应该优先采取第一种方法，通过循序渐进地提前入睡时间同时固定起床时间的

方法来矫正，在矫正过程中要确保包括双休日在内的每一天都按时起床，日间小睡要彻底戒除。很多睡眠阶段延迟得非常厉害的儿童也倾向于选择这个方法，因为即使不矫正他们也需要在周一到周五早起，而矫正只是增加了双休日的早起而已。

这种方法会在一定程度上导致孩子的睡眠被剥夺，需要孩子具有一定的自制力，家长无法越俎代庖。但是家长可以从旁协助，给孩子解释矫正的目的与具体方法。孩子的矫正意愿必须是出自真心，这样他才能坚持每天早起。如果这个方法不管用，家长可以尝试第二种方法，也就是我们对科纳实行的逆向法。

| 改变生物钟的其他方法 |

下面我会介绍一些行之有效的方法，帮助青少年调整生物钟。

方法一：在早晨让室内充满光线。我们在前面也介绍过光线对人体生物钟的作用，大量接触光线会提前生物钟，从而提前整个睡眠阶段。每天早晨早半个小时起床，待在充满光线的客厅里，保持睁眼状态，人很容易就清醒了。长期坚持下去，生物钟自然会提前，这个方法也是最安全、最有效的方法。（如果能在早晨待在阳光里就更理想了，可是在冬天青少年往往需要在日出前就起来去上学，此时就需要借助人造光源。在人造光源的环境里，光线应该适度，并不是越强越好。）

要让青少年每天少睡半小时早起是一件非常困难的事，所以巧妙地借助光线非常重要，如果在早晨保持室内黑暗，那无论多么努力都无济于事。

方法二：吃点褪黑激素。有些人会在下午或傍晚适当服用一点褪黑激素来辅助调整生物钟。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

褪黑激素水平是生物钟设定的一个直观反映，在晚上睡眠阶段开始后处于上升阶段，到了早晨则开始回落并降至最低。褪黑激素并不直接影响睡眠，但是它能让大脑以为睡眠阶段已经开始了，从而提前睡眠阶段的开始时间。

褪黑激素所发挥的作用与光线类似。研究显示，褪黑激素确实有助于青少年改善睡眠。为了避免每天使用药物，有些学者建议只在周日下午服用，以降低双休日晚睡晚起对整个睡眠阶段的影响。还有些研究建议将服用时间定在下午而不是晚上，以发挥最大

药效。尽管如此，服用褪黑激素仍旧应该谨慎，毕竟这是一种有多种副作用的药物。（动物实验表明，褪黑激素有可能对性功能产生副作用。）关于长期服用褪黑激素可能导致的后果，至今还没有明确定论。

方法三：睡前吃安眠药。由于安眠药无法改变生物钟的运行，所以服用安眠药的效果不如上述两个方法好，但是，在1~2周内，服用安眠药能让人在早晨更容易醒来。长期服用安眠药可能会导致人体对药物产生依赖，还有可能对人体造成伤害。在白天服用帮助保持清醒的药物同样有害。要解决睡眠问题，药物只能起到暂时的辅助作用，而无法起到根除问题的作用。如果需要药物辅助，应该在服用前咨询医生。

设置作息表

无论采用哪种矫正方法，最困难的都是在取得一定效果后坚持下去，不让问题反弹。在矫正中，很有可能只是将问题最小化，而不是根除它。假设一个青少年需要在早晨6点起床去上学，为了获得9小时的睡眠时间，他就必须在前一天晚上9点入睡。而在现实生活中，很少有青少年能在9点就乖乖上床睡觉。就算是一个乖学生，放学之后马上回家，然后吃饭、做作业，不看电视也不煲电话粥，忙完所有事准备睡觉也是10点之后了，有时甚至会拖到11点。但是，如果这个乖学生在就寝后很快就能入睡，那他获得的睡眠时间还是要比睡眠阶段延迟的孩子多得多。

对青少年来说，最理想的睡眠时间是9小时，尽管睡7小时比睡四五个小时要好得多，但是睡7小时相较于睡9小时仍然是处于睡眠不足状态。要是一个青少年每天都只睡7小时，那他就一直处于睡眠不足的状态，更不用说到了周末，他会比平日睡得更晚。为了补充睡眠，他会放任自己在双休日睡到很晚。这时家长就要出面干预，不能让他的睡眠阶段无限制地延迟下去，否则他的睡眠永远不会补足。就算是补充睡眠，也要有一个限度，一般来说，双休日早晨可以让孩子比平时晚起1小时左右，以防止恶性循环。

自愿延迟睡眠阶段

有些孩子本身就想将睡眠阶段往后挪，尽管他们不愿意承认这一点。家长要及时发现并重视这些问题，我们在前面介绍的所有应对之策都只有在发现问题之后才能发挥作用。从表面上看，自愿延迟睡眠阶段所呈现出来的特征与我们前面介绍的没有什么差别，只是对自愿延迟睡眠阶段的孩子来说，睡眠阶段延迟的时间更长。孩子会觉得无法

在早晨起来，父母也无法在早晨按时唤醒他们，所以他们的出勤率非常差，就算是去上学，也会迟到很久。事实上，这些孩子的睡眠本身并不存在任何问题，也具备按时起床的能力。只要不去上学，他们能在早晨为了其他事自然醒来。

我们来看一个案例。

> 安娜是一个14岁的女孩子，跟科纳一样，她的睡眠阶段也有着非常严重的延迟问题。但是，与科纳不同的是，她的父母在早晨根本无法唤醒她，她也不像科纳那样只是偶尔迟到，她几乎没有准时到校过，出勤率非常差。暑假的时候，她不像其他孩子那样晚睡晚起，她会比平时早上床睡觉，第二天也醒得比较早。（在暑假她凌晨1点入睡，第二天上午10点起床；在平时，她到了早晨5点才入睡，一直睡到中午12点才起床。）
>
> 安娜的学校允许她只上半天课，每天下午去报到，可是这反而让她的睡眠阶段延迟得更厉害了，她变得无法在下午3点前起床，入睡时间也延迟到了早晨7点。当我见到安娜的时候，她几乎缺课一年了。安娜的父母每天都绞尽脑汁叫她起床，可是等他们离开家去上班，她又会爬回床上去睡。
>
> 自从安娜上高中之后，她的问题就越来越严重，尽管她自己也想准时去学校上课，可还是缺课得非常严重。因为她的缘故，家里的氛围很紧张。家人都为此闷闷不乐，对她也非常不理解，而安娜自己也非常沮丧，她没有什么好朋友，讨厌去学校上学。早上起不来让她错过了很多学校的活动，也让她与同龄人疏远了，而与同龄人打成一片正是她最渴望的。安娜对她的父母和她自己说，她不是不想有一个正常的作息，她只是无法做到。安娜的话只有一部分是对的：她的睡眠阶段确实在往后延迟，但是安娜自己却对这种延迟听之任之。

我们在前几节介绍的方法对安娜来说都没用，因为从主观上来说，安娜采取的是不合作的态度。为了确认安娜对矫正所持的态度，我们给她制定了以逆向法为指导原则的矫正计划，可是安娜一点都不配合，并最终导致这个方法失败了。矫正开始前，她跟我们说她无法在凌晨5点前入睡，可是矫正开始后，她又告诉我们说她不能在5点后保持清醒。

像安娜这样的孩子其实根本没有什么睡眠问题，他们需要的只是更严格的限制而已。

那些不想去上学的孩子会千方百计地寻找不去上学的理由，而睡眠问题恰恰给他们提供了这样一个借口。如果无法改变他们的主观态度，再多的矫正也于事无补。安娜的真正问题在于她本身有点抑郁、有点孤僻不合群，自信心不足，最重要的是她不想去上学。如果允许她不去上学，而让她做自己喜欢做的事，那所谓的“睡眠问题”就迎刃而解了。

对安娜这样的孩子，我建议首先要给予心理评估和心理咨询。家庭环境也很重要，通常这样的问题或多或少会与家庭中存在的其他问题有关。在有些家庭里，反而是孩子要承担起照顾大人的责任，因为有些家长自身就有抑郁或孤僻等心理问题，这种家庭环境反而是在鼓励孩子养成一个延迟的睡眠阶段。由于在这样的家庭中，家长与孩子都在主观上排斥改变，所以一般来说我提出的建议都会被他们否决。

当然，并不是所有自愿延迟睡眠阶段的孩子都是因为抑郁或讨厌上学，也并不是自愿延迟睡眠阶段的孩子都有家庭问题，但是他们所有人都会利用所谓的“睡眠问题”来逃避某些事，尽管这种逃避要付出巨大的代价。这些孩子最需要的并不是矫正睡眠问题，而是要解决隐藏在表象之后的深层次问题。

自愿延迟睡眠阶段的问题处理起来比较复杂，情况持续越久，孩子缺课越严重，要扭转这种局面的难度就越大。但是，只要深层次问题被解决了，睡眠问题也就不攻自破了。对这些孩子来说，起床之后所做的事如果是他喜欢的事（例如不去上学而去度假），那他们自然就有了起床的动力。只要主观上有了改变，其他问题解决起来就相对容易了。

一开始，安娜和她的父母都非常抵制心理咨询。几个月之后，他们才勉强同意试一试，但是要让他们公开谈论家庭隐私还是有点困难。渐渐地，通过咨询，他们发现了很多以前忽视的问题。这些问题尽管无法立刻得到解决，但是家庭关系得到了改善。安娜还是无法与同龄人打成一片，但是她慢慢地试着去交朋友，心情也开朗了很多，与家人的关系也融洽了很多。尽管安娜还是熬夜，但是她的睡眠习惯比以前正常了许多。

第8章 第二类作息紊乱问题——其他常见作息问题

并不是所有的儿童作息紊乱问题都与睡眠阶段有关，本章我们要讨论三类其他常见的作息问题：规律作息前提下的其他睡眠问题、作息不规律或不持续导致的其他睡眠问题、跨越多个时区引发的睡眠问题。

规律作息前提下的其他睡眠问题

我们上一章讨论的都是不规律的作息引发的睡眠问题，但是即使是规律的作息也有可能引发睡眠问题。在作息规律的前提下出现的睡眠问题一般都有多个诱因，而一个诱因又有可能导致多种睡眠问题，接下来我们会着重分析。

在床上待得太久

很多家长根本不知道自己的孩子应该睡多久，他们所认为的孩子应该有的睡眠时间总是或多或少地与标准值有一定差距。有的多子女家庭为几个子女设定统一的作息，而不管每个孩子的个性化需求，也不管每个子女的白天小睡时间长度。他们对睡眠时间的判断主要来自亲戚朋友或者邻居的建议，似乎每个人给出的建议都是让孩子多睡一会儿。事实上，绝大多数建议都是毫无根据的。有时候家长会觉得孩子睡得太多了，可实际上孩子躺在床上的时间并不等于睡眠时间，他们躺在床上不哭不闹，却保持清醒，有时候会自己玩，有时候会胡思乱想，有时候仅仅是躺着四下张望而已。

绝大多数几个月大的婴儿每天所需的睡眠时间总数在 11～13 个小时之间。他们的夜间睡眠时间不会超过 11 个小时，如果白天小睡过几小时，那他们的夜间睡眠时间就会在 9～10 小时之间。等到了上学的年龄，儿童就会逐渐减少日间睡眠，直到完全戒除，他们的夜间睡眠时间在 9～11 小时之间。要是让孩子待在床上的时间超过他所需的睡眠时间，就会产生睡眠问题，比如睡眠阶段的改变等，这些问题可能单独产生，也可能跟其他睡眠问题一起产生。

假设有一个孩子每天最多只需要 10 小时的睡眠时间，如果强制他在床上待 12 个小时，就会引发睡眠问题。如果这个孩子的入睡时间定在晚上 7 点，强制他在床上一直待到早晨 7 点会发生什么呢？这个孩子可能会入睡困难、早醒、半夜醒来后无法再次入睡，这些状况可能单独出现，也可能一起出现。如果孩子年龄很小，还可能出现第 4 种状况：晚上睡满 12 小时，白天无法入睡。具体可以参考图 8—1。

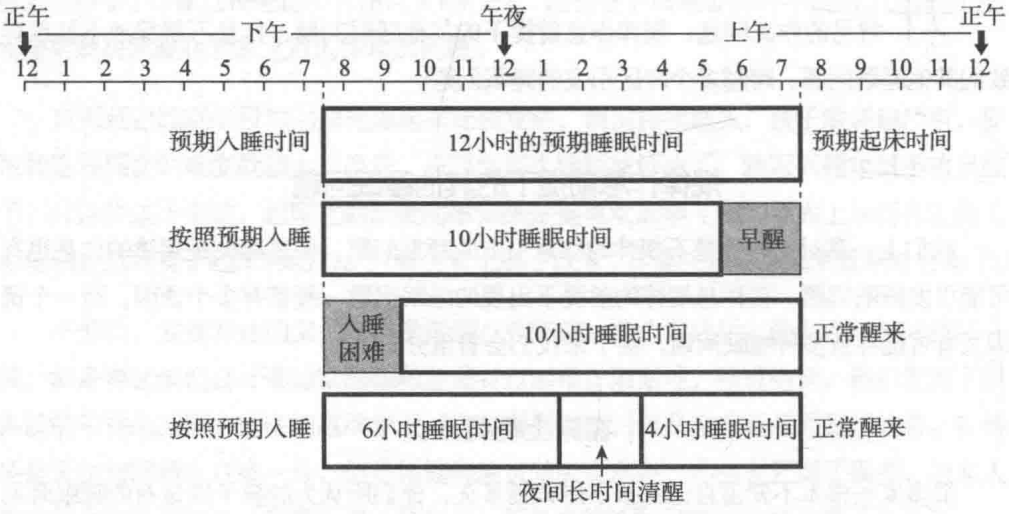


图 8—1　在床上待得太久可能引发的睡眠问题

解决这类问题最重要的就是要矫正睡眠阶段的起止时间。无论孩子的情况属于图 8—1 中的哪一种，他都已经获得了所需的全部睡眠时间。家长可以改变睡眠阶段的起止时间，但是无法改变其所需的睡眠时间总量。

➤ 入睡困难

假设孩子的上床时间是晚上 7 点，可是每次他都要折腾两个小时后才肯入睡，这样一来他的入睡时间被延迟到了 9 点。如果他的起床时间定在早晨 7 点，那他的整个睡眠阶段就是从晚上 9 点开始到早晨 7 点结束，一共 10 个小时。晚上 7 点到 9 点这两个小时刚好是他的睡眠禁区，在这个时间段，孩子很不容易入睡，具体可以参考第 11 章。除非孩子能按时起床，否则这个问题在很大程度上属于睡眠阶段延迟问题。

从 7 点到 9 点这两个小时内，不同的孩子会有不同的表现。孩子可能会哭闹以引起父母的关注，也可能安安静静地躺在黑暗中想东想西。家长在这两小时内可能会为了哄孩子而忙得焦头烂额，也可能根本不会注意到孩子其实是醒着的。

宝宝出现了上述任何一种症状，家长都可以通过延迟入睡时间来进行处理。孩子的入睡时间应该跟他睡眠阶段的开始时间吻合，只有这样才能确保快速入睡。如果家长希望晚上不再为了哄孩子入睡而忙得焦头烂额，能拥有一点自己的时间，那我建议家长们参考上一章介绍的方法，通过逐渐提前孩子早晨起床的时间来改变作息。

➤ 早晨早醒

假设有个孩子的入睡时间是晚上 7 点，入睡很快，不折腾也不哭闹，一觉睡到第二天早晨 5 点，然后就再也睡不着了，那这个孩子的睡眠阶段就是从晚上 7 点开始到早晨 5 点结束，一共 10 小时。如果他的家长将早晨起床时间定为 7 点，那从 5 点到 7 点这两个小时，他都会保持清醒，要让一个孩子睡满 12 个小时既不现实也不合理。这个孩子可能存在早醒的问题，但是仅仅拖延起床时间毫无益处。要达到这个目标，我建议面临类似问题的家长通过延迟孩子的入睡时间来延迟其起床时间。在总的睡眠时间不变的情况下，家长可以通过逐渐延迟入睡时间来延后整个睡眠阶段，从而让孩子的起床时间符合家长的预期。

➤ 夜间醒来后难以再次入睡

> 赛思是一个两岁的小男孩，他晚上 7 点上床睡觉，早晨 6 点半起床，每天午饭后，他会睡两小时午觉。他对自己睡觉一点都不排斥，也不需要人哄，每天都能准时上床睡觉、准时起床。但是每天半夜，凌晨 1 点左右，他都会醒来，然后开始大哭，一直要持续到 3 点。他的父母认为在他哭的时候去安抚他会娇惯他，所以任由他一直哭，只是偶尔进入他的房间以防

出现意外。于是每晚赛思都会在半夜哭 1.5~2 个小时，然后再次入睡。

即使他的父母一直严格坚持不去安抚他的原则，赛思的情况还是持续了好几个月而没有好转。最终父母妥协了，当赛思哭的时候，他们就把他抱到他们的床上，这样一来赛思就不哭了，他会让父母陪他玩，一直玩到他困了为止。每当他昏昏欲睡的时候，他就会要求父母将他抱回自己的小床上。妈妈把他抱回到他的小床上，然后给他讲故事、放音乐，陪他玩玩具，直到他睡着为止。只要有家长的陪伴，赛思就不会再哭，但是他也不会立刻再次入睡。每天晚上这样折腾两小时，赛思的睡眠质量当然好不到哪里去，受连累的妈妈也一样。

如果在床上待的时间超过了所需要的总的睡眠时间，就有可能导致儿童入睡困难与早醒，这两种情况我们分别在前两节介绍过了。本节我们要详细讨论由此引发的第三种情况——半夜醒来后难以再次入睡。在这种情况下，孩子的睡眠时间总量没变，却被分成了两个部分。通常，年龄较小的婴幼儿由于保留着日间小睡的习惯，比较容易出现这种情况。

如果你家宝宝也出现了这种情况，家长首先要明白一点，这不是一种病。这些孩子有一个共同点，即使家长在他们哭闹时给予安抚，也无法让他们立刻入睡。他们会变得兴奋，想要拉着家长一起玩，就像上文提到的赛思一样。他们所需要的不是安抚，而仅仅是家长的关注。如果家长此时陪他们一起玩或者像赛思的妈妈一样放上音乐让他自娱自乐，他们就会立刻停止哭闹了。从醒来到再次入睡，通常需要经过一个 30 分钟到 3 小时的完全清醒期。

从我接触的案例来看，如果孩子持续在半夜有长时间的清醒期，在清醒的时候不需要父母的安抚，而仅仅是自娱自乐，那十有八九是因为他待在床上的时间比他实际需要的睡眠时间长。家长在遇到这类问题时，很容易误入歧途，就像赛思的家长一开始做的那样，给孩子设定更为严格的限制，时不时起来去看看孩子是否好好躺在床上，或者对孩子的哭闹放任不管。这些错误的应对方法都有一个共同的前提，就是假设孩子所需的睡眠时间跟家长预期的一样。实际上，这个假设根本不成立，孩子根本不需要那么长的睡眠时间，如果硬要他们在床上待那么久，半夜长时间的醒来就是不可避免的。

我建议家长通过调整孩子的作息、增加孩子实际所需的睡眠时间来减少孩子夜间醒

来的时间。例如，家长给孩子设定的睡眠时间是 12 小时，可实际上他只睡了 10 小时，那家长就可以将孩子入睡与起床之间的时间设定为 10 小时。也就是说，可以让孩子推迟两小时上床睡觉，或者早两个小时起床，也可以在推迟 1 小时上床的同时提前一小时起床，以此类推。家长可以根据实际情况分配这多余的两小时，只要确保孩子入睡与起床之间的时间间隔为 10 小时即可。

如果孩子保留着日间小睡的习惯，在矫正期间，小睡时间应该和平时一样，因为矫正的目的是将睡眠集中到一起，而不是分散到白天。我认为，只有将过长的睡眠时间缩短，才有可能减少半夜醒来的时间。

我们回过头来看赛思的案例。赛思在夜间睡 11 个半小时，在白天睡两个小时，一整天下来要睡 13 个半小时。由于他在半夜清醒一个半小时到两个小时，所以事实上他每天的睡眠时间是 11 个半小时至 12 小时，这对他这个年龄段的孩子来说是很正常的。而赛思会半夜长时间醒来的原因就是他无法睡满 13 个半小时。所以我建议他的家长将他的就寝时间延迟了两小时，而起床时间与日间小睡时间保持不变，并且在半夜不再给他听音乐、不再陪他玩，几天之后，赛思的情况就彻底改善了。

绝大多数因为睡眠时间过长而导致半夜无法再次入睡的儿童都与赛思的表现差不多，当然也有少数孩子例外。他们会安安静静地躺在床上，非常享受独自在黑暗中待着的感觉，而他们的这种表现又会让父母误以为他们是处于睡眠状态的，这也是为什么有些父母会错误地认为自己的孩子可以按照自己的预期睡满 12 小时的原因。除此之外，还有一种孩子在夜间醒来后，既不像赛思那样能完全保持清醒，也不会安安静静地待在床上。他们虽然醒了，却仍旧处于昏昏欲睡中，于是他们就会躺在床上，一边打盹一边躁动不安地翻身、乱动，直到再次入睡为止。我觉得，无论在清醒期间孩子是安静的还是哭闹不休的，只要家长发现孩子有半夜长时间清醒的问题，就应该着手矫正。

| 所需睡眠时间过短 |

在我跟家长打交道的过程中，很多家长告诉我，他们的孩子“几乎不睡觉”，这些孩子要么晚上只睡几小时，要么白天不补充睡眠，要么两者兼有。这其实是一个误解。每个人所需的睡眠时间固然各异，但是差异不大，具体可以参考图 1—1。

如果一个儿童所需的睡眠时间真的比同龄人要短，那就意味着这个孩子像我们前面

讨论的那样，在床上的时间远远大于他实际所需的睡眠时间。可事实上，对绝大多数儿童来说，他们并不是真的拥有一个异于常人的睡眠时间长度，所需睡眠时间比同龄人短也绝对不是他们睡眠问题的根源。所以，在实践中，我通常会采用证伪法，即先假设这些孩子的睡眠长度与睡眠能力处于正常范围内，再通过深入细致的工作来检验这个假设，看看是否能证明假设错误。

通常，当我按照家长的表述将孩子的睡眠时间一点点地加到一起之后，我们就会发现，孩子其实已经获得了充足的睡眠，只是家长没有意识到而已。有的家长对“正常的睡眠时间长度”定义不明。还有的家长根本搞不清楚自己的孩子到底睡了多久，他们在晚上多次起来照顾哭闹的孩子，自己感觉到睡眠严重不足，就理所当然地认为孩子也跟他们一样，处于睡眠不足的状态。也有的家长对事实记忆不全，总是记住那些哭闹不休、异常折腾的晚上，对那些一觉睡到大天亮的晚上却视而不见。

睡眠时间缩短的原因多种多样，比如生活不规律、家长对孩子的控制力欠缺或不合理、缺乏限制、作息不固定、焦虑，等等。但是由人为因素造成的睡眠时间缩短并不意味着孩子天生就比同龄人睡得少。只要家长能重新制定规律的作息并增强对孩子的掌控，我相信问题就会迎刃而解。

到底睡多久才是正常的呢？这个问题没有唯一的答案。每个人所需的睡眠时间各异，但是，如果儿童获得了充足的睡眠，他的行为举止就会非常恰当，不会出现打瞌睡、昏昏欲睡的情况。一个睡眠充足的儿童能够自然醒来，或者在被家人或闹钟叫醒的时候很容易醒来。除了入睡前这段时间，他不会表现得困倦不堪。在白天，睡眠充足的孩子会表现得非常有精神，注意力集中，情绪稳定。

所谓所需睡眠时间比正常人少，是指在任何情况下都比同龄人睡得少。如果孩子能在他选定的环境中睡满正常的时间长度，那就不算是睡眠时间过短。同样，如果孩子在父母的安抚下能很快入睡，在父母的陪伴下能安睡到天亮，半夜醒来后能在父母的床上再次入睡，或者在车后座上能安稳入睡，那问题就不是出在睡眠时间长度上，而是出在睡眠环境和睡眠习惯上，出在缺乏限制和自律上。如果前一天晚上孩子睡得比平时多，第二天比平时更有精神、心态更好，那这个孩子也绝对不是天生所需睡眠时间过短。

要是你家宝宝真的是天生睡眠时间过短，那也不用担心，这并不是一种病，没有潜在的生理或心理问题，不需要通过药物来人为地延长他的睡眠时间，也不需要强迫他长

时间地待在床上。对家长来说，这样的宝宝非常考验人的耐心，因为他们比同龄人睡得晚、起得早，白天几乎不需要小睡。当然，如果孩子的睡眠时间是被人为缩短的，那就可以通过矫正加以改善，下面我们来介绍几种情况及其应对之策。

| 环境问题：噪音和人声 |

周围环境里的光线与噪音，是引发儿童早醒的重要原因之一。虽然可以人为控制室内的光线亮度，但是要隔绝从街上传来的各种噪音却不是那么容易的一件事。有些对声音比较敏感的孩子，一听到有人在室内走动，就会立刻醒来，再也睡不着了。对这样的孩子来说，早醒一两个小时是很常见的，他们被人为吵醒的时候，已经完成了绝大部分睡眠，驱使人体进入睡眠状态的激素不再像夜间那样占据主导地位，所以此时一旦醒来，就很难再次入睡了。

睡眠环境可以影响儿童的睡眠规律。如果卧室内很早就充满了明亮的光线，孩子的睡眠阶段就很有可能提前，日复一日，习惯成自然，孩子就会在黎明前自然醒来。孩子的睡眠阶段提前对家长来说也是一个不小的挑战，很多家长为了配合孩子的作息，不得不在早晨起床时蹑手蹑脚，甚至改变一些日常生活习惯。

接下来我将给出一些建议，以帮助为这类问题所苦的家长们。

- 首先，在卧室内装上窗帘，以阻隔光线进入房间，有些窗帘还具有很好的隔音效果，可以同时阻隔噪音，而且最好在睡觉时关上窗户。
- 其次，可以将对光线或声音敏感的孩子搬到比较安静的房间里去，也可以让他与睡眠质量比较好的兄弟姐妹换个房间睡。
- 另外，卧室内不要放会发出噪音的电器，比如电扇、加湿器等。一旦孩子习惯了在电器发出的噪音下入睡，再要他在安静的环境下入睡就几乎不可能了。

当然，家长也可以人为地延迟孩子的睡眠阶段。一旦将睡眠阶段延迟，孩子被噪音或光线影响的时间段就会在整个睡眠阶段中相应前移，也就是说，当噪音或光线影响孩子时，他还处于睡眠不足状态，会因为急需睡眠而忽视周围环境的影响。

其实，入睡时的噪音比早晨起床时的噪音更容易影响孩子的睡眠。要是在入睡时，周围都是大喊大叫的人声，孩子肯定无法入睡。最好的睡眠环境未必是完全寂静无声的，

如果有人在看电视，不需要把电视关掉，只需要将音量调小即可。但是，良好的睡眠环境应该是相对安静的，并且这种安静应该是比较持久的。孩子一旦被吵醒，他很可能醒好几个小时而睡不着。

有时候，在孩子快要入睡时，家长刚从外面回来，家长可能想陪陪孩子，孩子也很兴奋，完全从睡眠状态中清醒过来，这通常会导致孩子的入睡时间延迟好几个小时。要是家长总是在孩子入睡前后回家，孩子就会养成等家长回家后再睡的习惯，他的入睡时间就总是被延迟。要解决这类问题，最好的方法就是家长调整回家时间，在孩子还完全清醒时就回家或者在孩子完全睡着后再回家，以避开入睡这段时间，也可以将孩子的入睡阶段提前或延迟，以配合家长的习惯。

通常，半夜里出现的噪音不太会影响孩子的睡眠，但还是有例外情况存在。例如，有些孩子会在睡着后，被家长从一个地方挪到另一个地方，一般来说这也不是什么大问题，孩子会在挪动过程中保持睡眠状态或者在挪动之后快速再次入睡。但是，如果挪动之后孩子无法再次入睡，家长就需要考虑提前或者延迟挪动时间了。也可以调整孩子的睡眠阶段，以便让挪动过程发生在熟睡阶段，这样就不容易吵醒孩子了。

同样，如果孩子的睡眠阶段提前或延迟得非常厉害，家长的晚归或早起都有可能发生在孩子的浅眠阶段，而这个浅眠阶段又因为睡眠阶段的过分提前或延迟刚好处于孩子睡眠的中间段，在这个时间段被吵醒之后，孩子也有可能无法再次入睡。要是家里有这样的宝宝，家长应该在晚归或早起时尽量轻手轻脚。也可以通过调整孩子的作息让浅眠阶段与晚归或早起的时间错开，甚至可以在室内摆放一台电扇或类似的电器以发出持久稳定的声音来掩盖外界的噪音。

| 电视、电脑、电话引发的问题 |

很多孩子将睡觉与看卡通联系到一起，要是家长允许孩子在大清早起床后就看卡通，很多孩子会为了多看一分钟卡通而放弃最后一个睡眠周期提前起床。可是，一起床就看电视有弊无利。一旦孩子养成了提前起床看卡通的习惯，就很有可能导致睡眠不足。而且，为了看卡通而人为地提前起床，会混淆孩子对起床时间的认知，他们很有可能搞不清楚到底什么时间才是真正的起床时间，从而导致生物钟混乱、作息不规律。

因此，起床后的一两个小时内，家长不应该让孩子看卡通。在孩子的卧室里放置电

视机不仅不必要，还非常不明智。一旦卡通不再是影响孩子早起的主因，孩子就会自然而然地恢复到正常作息中去。

年龄稍大的孩子也有类似的问题，与婴幼儿不同的是，他们通常会在晚上熬夜看电视、通宵上网或煲电话粥。相较于早起，熬夜对人的伤害更大。看电视不像看书，晚上看书容易犯困，一犯困你就会放下书进入睡眠状态，可是看电视不是这样，即使已经困得睁不开眼了，你还是会被电视节目所吸引。睡意袭来是呈波状的，第一波睡意袭来的时候，如果硬撑着保持清醒，就至少需要等半个小时第二波睡意才会袭来，而半小时的时间足够电视上出现一个新的电视节目，吊足人的胃口让人硬撑下去。

看电视既不应该成为孩子起床后的第一件事，也不应该成为他入睡前的最后一件事。家长应该对孩子看电视这件事设定限制，特别要设定一个关电视的时间，玩电脑或打电话也是如此。相较于看电视，看书或听故事是比较不错的睡前活动。**我再强调一次：在孩子的卧室摆放电视机是非常非常不明智的一件事。**即使是年龄稍大的孩子也不应该单独在卧室内看电视，很多深夜节目是为成年人准备的，观看这类节目有可能让孩子产生沮丧、困惑或惊恐。要是家长疏于监督，情况可能会一发不可收拾。

除了工作日，在周末也应该严格控制孩子看电视的时间，不要让周末的晚上电视节目泛滥。要是有一个节目家长觉得非常适合给孩子看，而播出时间又非常晚，家长可以将节目录制下来，然后挑一个合适的时间陪孩子一起看。

作息不规律或不持续导致的其他睡眠问题

很多儿童的睡眠问题其实是由作息不规律引发的。他们有时很早入睡，有时又熬夜到很晚，所以他们醒来的时间也很不固定。这些孩子的三餐非常不固定，并且只有前一晚熬夜了，第二天白天才会乖乖午睡。

如果孩子的作息不规律，其日夜节律也将处于混乱状态。与常人不同，作息不规律的孩子体温会出现异常，在入睡时体温反而会上升，在起床时则呈现下降状态。他会在入睡时或两餐之间产生饥饿感，在饭点却什么也吃不下。他的生理机能也会出现一定程度的混乱，在该活跃的时候困倦不堪，在该入睡的时候精神奕奕。他的睡眠几乎没有可预见性，在该入睡的时候睡不着，在半夜却长时间醒着。

调整作息的唯一办法就是以24小时为周期重新建立一套作息模式。而每天在相对固定的时间让人体暴露在光线中就是对调整生物钟最直接的刺激，也是唯一的方法。午睡时间过晚会导致孩子晚睡，而晚睡又会额外增加他接收的人造光源散发出来的光线，这个额外增加的光线就会影响他生物钟的正常运作。相反，如果他在白天不午睡，从而过早上床睡觉，就会导致他在夜晚接受到的光线减少，从而将他的生物钟提前。同样，三餐不规律也会影响生物钟的运行，因为三餐不规律会导致饥饿感无法控制，在本应睡着的时候，有可能会因为感觉饥饿而保持清醒，从而在不适宜的时间接收到光线。

作息不连贯是本节讨论的另一个诱因。孩子的作息不连贯，家长就无法预知孩子的日常行为，不知道他什么时候要睡觉，什么时候会醒来。要是孩子有时在晚上9点入睡，有时在6点入睡，当有一天他在6点上床之后，他的生物钟就无法判断这到底是夜间入睡还是一次小睡，也无法判断接下来的睡眠需要持续10小时还是1小时。他的睡眠被分割成几个零碎的部分，任何一个部分都不足以维持10小时，而10小时的连续睡眠对儿童来说是必需的。而且，作息不规律的孩子在夜间醒来后很难再次入睡，他们会长时间保持清醒，这就导致次日他们的午睡时间会非常长。

詹姆斯是一个4岁的小男孩，他的睡眠问题变化无常，很难准确归类。他没有固定的就寝时间，入睡前的时间也过得一团糟。他可能在晚上7点到11点间的任何一个时间点入睡，而他入睡的时间点则取决于这一天是否进行了午睡及午睡的长度。有时候，他会乖乖地睡在自己的房间里，但是大多数情况下，他只要困了，随时随地都可以睡着。因此，很多时候，他都睡在客厅里，电视机开着，灯也亮着。

要是詹姆斯入睡得早，他会在一两个小时之后醒来，很难再次入睡，接下来的数个小时内都保持清醒状态。相反，如果入睡比较晚，他就会睡上9或10个小时，到第二天早晨四五点才完全清醒。如果詹姆斯早晨醒来得比较早，他会在白天延长午睡时间，午睡醒来后又会非常清醒，这种清醒状态会持续到夜里11点。第二天早晨，他仍旧会很早醒来，一整天都萎靡不振，呵欠连连，还会偶尔睡死，无论父母怎么叫都叫不醒。他在白天小睡的时间很不固定，从早晨9点到下午6点间的任何时间点都能入睡，每次持续的时间也很不确定，从半小时到4小时都有可能。

詹姆斯这种无规律的作息反映了其家庭环境的无序，这种无序来自詹姆斯一家的错

误观念，他们认为无规律的饮食与睡眠习惯是很正常的，甚至在他们的亲朋好友中，这种无序也屡见不鲜。詹姆斯这种无规律的作息在白天还勉强过得去，可到了夜间，就成了让父母头疼的问题了。只可惜，他的父母对引发这种无规律作息的根源熟视无睹。

当詹姆斯一家来向我求助时，我意识到，詹姆斯除了缺乏规律的作息外，还缺乏引导他持之以恒的外界干预。他的父母必须引导他建立适当的作息规律，并帮助他坚持下来。当然，除了有良好的就寝规律之外，要彻底解决詹姆斯的问题，还需要帮助他建立起良好的日间作息规律。问题的关键在于，由于缺乏适当的引导，詹姆斯的 24 小时作息变得杂乱无章。所幸的是，尽管问题的表象看起来很严重，解决这一类问题的方法还是比较简洁明了的。

| 矫正不规律作息 |

无论不规律作息是问题的根源所在，还是仅仅是整个睡眠问题的一部分原因，建立一套规律的作息并持之以恒都是解决这类睡眠问题的重要途径。

矫正开始后的几周内，为你家宝宝建立一套非常精确的作息，什么时候入睡、什么时候起床、什么时候吃饭，都要明确规定。一旦孩子适应了这套作息，家长就可以适当放宽时间限制。要记住，只要孩子的作息曾经混乱过，一旦家长放松警惕，坏作息就会卷土重来。

如果家长不确定孩子在夜间的睡眠时间到底是多少，可以先从能确定的最小值开始执行。宁可一开始让孩子睡得少一点，也不要一开始就设定过长的睡眠时间，因为增加孩子的睡眠时间比较容易执行，孩子也比较容易适应。要是你家宝宝还处于需要午睡的年纪，那家长可以参考本书第 2 章与第 12 章来调整孩子白天的睡眠时间。要是家长不是很确定孩子是否需要午睡，可以试着取消它；要是不确定孩子在白天是需要睡一次还是睡两次，可以从睡一次开始执行。一旦孩子的作息变得规律，家长就可以总结出是否应该延长孩子的睡眠时间，如果孩子确实需要更多的睡眠，家长可以逐渐延长他的夜间睡眠时间，也可以在白天安排小睡，或者延长原有的午睡时间。

在我的建议下，詹姆斯的父母为他设定了规律的白天作息，并规定了每天入睡与起床的时间。由于詹姆斯已经 4 岁了，我们没有在白天为他安排小睡时间。他的父母还为他安排好了入睡前的时间。我们还为他设定了固定的进餐时间，每到这个时间就开饭，

除了饭点之外，不在其他时间提供他点心。尽管这些安排与詹姆斯一家以往的生活习惯大不相同，但是，詹姆斯的父母在了解到这些安排的作用与好处后，都愿意尽力配合。

根据詹姆斯以往的习惯，如果白天不午睡，他总是在晚上 9 点入睡，因此，我们决定将 9 点定为他入睡的时间。矫正开始后，詹姆斯每晚都在 9 点入睡，睡前他的父母会给他讲一个故事或陪他玩一会儿游戏，第二天早晨，父母会在 6 点叫醒他，给他穿好衣服，安排他吃早饭。我们取消了他的日间小睡，如果白天他感到昏昏欲睡，他的父母就会立刻叫醒他，最多让他睡 10 分钟或 15 分钟。詹姆斯所需的睡眠时间肯定大于 9 小时，但是我更愿意在一开始让他少睡一些。一旦詹姆斯适应了新的作息，我们就会将他的入睡时间提前或将起床时间延后，每次提前或延迟 15 分钟，循序渐进，以确保他能及时入睡，第二天按时起床。

他的父母确保他每晚都睡在自己的房间里。要是詹姆斯半夜醒来，父母就会到他房间帮助他再次入睡，而不允许他起来玩游戏，防止他养成半夜醒来的习惯。

从矫正开始到睡眠变得正常，一般只需要一两周时间，事实也确实如此。一旦他的睡眠变得正常，醒来后再次入睡就变得非常容易了，而此时他也不再需要父母陪伴与帮助了。尽管如此，我还是让詹姆斯的父母等到他确实能自己再次入睡后再取消陪伴，事实上，詹姆斯做得很好，他严格按照作息时间表自己入睡。

前期矫正效果良好，詹姆斯的父母了解到了作息规律的重要性，他们对坚持整个矫正很有信心。与绝大多数父母一样，他们一旦看到孩子出现翻天覆地的变化，要再坚持下去就有了更大的动力，也变得容易得多。

在矫正刚开始的第一周里，詹姆斯对矫正非常抗拒，他的父母对他严格要求，适当鼓励，让他坚持了下来。很快，詹姆斯与父母都开始期待入睡前的共处时光了。到了第二周周末，詹姆斯就能准时入睡、起床，一夜好眠了。很快，我们发现詹姆斯实际需要的睡眠时间比我们设定的 9 小时要长，所以，他的父母开始逐渐调整他的作息，将他的入睡时间提前到 8 点半，起床时间延迟到 6 点半。

在矫正过程中，打断作息规律的事经常发生，因为父母还不是很理解持之以恒的重要性。有些时候，导致不规律的原因根植于深层次的家庭问题。当出现夫妻不和、生理或心理疾病、亲人过世、夫妻分居甚至离异时，家长敦促孩子维持规律作息的力度就会

减弱。如果出现这些情况，我建议家长去寻求心理咨询以解决问题。

跨时区旅行导致的睡眠问题

很多家长会担心，带着孩子做跨时区旅行会不会对孩子的作息产生影响。其实，只要认识到这样的旅行可能带来的后果并做好预防，就可以省去这些不必要的担心。

无论是儿童还是成年人，都无法迅速适应跨时区旅行所带来的时差感。然而，儿童对此的适应能力比成年人强，因为儿童自身的睡眠驱动力非常强，而年纪越小的孩子，这种驱动力就越强，甚至可以强到战胜人体的日夜节律。要是孩子在想睡觉的时候没有得到充足的睡眠，他就会在平时清醒的时间里睡着，将之补回来。

假设你带着孩子往西穿越三个时区，孩子的作息就会比平时“提前”三小时，如果家长非得让孩子根据新时区的时间入睡，而不是在第二天早晨比平时早三小时叫他起床，那孩子很可能就比平时晚起床三小时。相反，如果往东走，孩子的作息就会“延迟”，但是，如果你比平时早三小时叫醒他，根据新时区的时钟这也确实已经到了他起床的时间了，孩子很有可能在当天晚上提前入睡。无论往东还是往西穿越时区，就算第一天孩子的作息没有变化，往后几天总会显现出来。（一般来说，家长应该减少孩子日间小睡的时间，将这部分睡眠时间挪到晚上去。）

另外，跨时区旅行还可能因为白天活动、就餐及其他相关因素的改变而导致作息改变，而这些因素家长很少会注意到。跨时区旅行孩子作息规律变化及应对方法见表 8—1。

表 8—1　　跨时区旅行孩子作息规律变化及应对方法

往东穿越 1~3 个时区：

1. 让孩子根据新时区的时间入睡。如果孩子一时很难改变过来，可以分两三天逐渐适应。

2. 家长和孩子都有可能比平时早醒。在这种情况下，家长不应该对孩子的哭闹置之不理，因为造成他早醒来的原因仅仅是时区改变，毕竟家长自己也会因为时区改变而早醒。

3. 维持原本的日间小睡时间长度不变。孩子很可能会比平时“早”睡午觉，家长应该想方设法延迟他睡午觉的时间，所延迟的时间应该与他晚上入睡的时间相匹配。

4. 旅行动身前几天，可以考虑将孩子夜间与白天的入睡时间往后延迟一些。这样可以减少旅行开始后的适应时间，也可以防止孩子到了新时区后每天早晨都过早醒来。

5. 如果旅行时间很短，尤其是当旅行只跨过一两个时区，或者孩子平时就习惯晚睡晚起时，家长应该让孩子维持原有的作息规律。

续前表

往西穿越 1~3 个时区： 1. 开始一两天，孩子的入睡时间会比平时“晚”，不要强求孩子立即调整。 2. 根据新时区的时间叫醒孩子。如果孩子一时很难改变过来，可以分两三天逐渐适应。 3. 维持原本的日间小睡时间长度不变。孩子很可能会比平时“晚”睡午觉，家长应该想方设法提前他睡午觉的时间，所提前的时间应该与他晚上入睡的时间相匹配。 4. 如果旅行时间很短，家长应该让孩子维持原有的作息规律不变。
穿越 3 个以上的时区（例如在美国、欧洲与亚洲间旅行）： 1. 孩子比父母更能适应这种大跨度的旅行，没必要为此制定详细的计划。 2. 很难在孩子不想睡的时候强迫他入睡，但是，家长可以在孩子困倦时让他保持清醒。孩子会很快适应，将失去的睡眠时间补回来。 3. 对还需要日间小睡的幼儿来说，适应新时区要容易得多，因为幼儿在白天与晚上都进行睡眠，将整个睡眠分成了好几个段落。对这样的孩子，只需要对其作息规律进行微调即可。 4. 如果孩子已经不再需要日间小睡了，那就需要大规模调整作息了。只要家长在白天不让孩子睡着，或者尽可能减少日间睡眠时间，孩子就自然会延长夜间睡眠时间，循序渐进，将作息调整到新时区中来。

SOLVE
YOUR CHILD'S
SLEEP PROBLEMS

第三部分

养成规律的睡眠习惯

第9章 帮助孩子养成良好的睡眠习惯

由于家庭环境、文化背景的不同及种族差异，孩子们的入睡环境与睡眠习惯也截然不同。孩子们睡着时可能被裹在襁褓里，可能仅穿着内衣裤，也可能光着身子；他们可能独自睡在一间房里，可能与兄弟姐妹合住一间房，也可能全家人睡在一张床上。从睡姿来看，孩子们可能趴着睡，侧着睡，也可能仰着睡；从睡眠环境的亮度来看，可能伸手不见五指，可能有微弱的光，也可能灯火通明。从睡眠环境的嘈杂程度来看，可能是寂静无声的，也可能存在噪音，例如加湿器或空调运行发出的嗡嗡声，电视、收音机或屋外车辆传来的时断时续的声音，偶然出现的飞机轰鸣声、船舶汽笛声和其他小孩的哭闹声。

当然，我们应该明白，所谓的睡眠习惯也只是一个粗略的作息规律，毕竟没有哪一种习惯是能够被一丝不苟地执行的。

睡前相处

虽然我觉得家长与孩子睡前相处的模式有优劣之分，但是其中并没有绝对化的标准。只要那个相处模式能让家长与孩子都感觉幸福，能让孩子快速入睡、夜间少醒、第二天行为表现正常，这个模式就是有效的。当然，家长们应该牢记，有些模式确实更容易帮助孩子建立固定的作息规律，养成良好的睡眠习惯。

家长与孩子的睡前相处模式包括所有为了帮助孩子入睡而产生的活动，可以叫作睡

前例行程序（bedtime routine）。对婴儿来说，这个程序无非是换个尿片，然后抱着他轻轻摇晃直到他睡着。也有可能家长只是抱着孩子轻轻摇晃，等睡意袭来，就将孩子放到摇篮里或小床上，让他自己入睡。还有的情况下，孩子可能毫无睡意，家长在哄了一会儿之后就将他放到床上，让孩子自己入睡。

以上三种情况都可以算作睡前例行程序，在婴儿出生后的几个月里对睡眠的影响不大，因为婴儿出生后的头几个月，无论采取什么样的睡前例行程序，婴儿都不可能自己一觉睡到大天亮。但是，到了三个月左右，绝大多数足月的婴儿都具备了自己一觉睡到大天亮的能力，如果此时孩子在夜间还是反复醒来，家长就需要反思睡前相处模式是否恰当了。因为上述三种睡前例行程序都有可能阻碍孩子养成良好的睡眠习惯，久而久之，孩子在夜里醒来后，如果不加以外力干涉，就无法再次入睡。此时，家长就需要调整固有的睡前相处模式。

随着孩子渐渐长大，睡眠习惯会变得越来越重要。如果孩子感觉睡前相处的时间是愉快的，那他就会期待那段时间，而不会总是拖拉着不肯上床。家长们应该根据实际情况制定一个相对固定的模式，确保每一天都有足够的时间花在孩子身上。久而久之，孩子就会知道到哪个时间点他应该换睡衣、刷牙、上床了，他会主动去做这些事，也会习惯每天的睡前互动，知道这些活动的时间限度与尺度。

当然，整个睡前相处过程的最后一个环节应该留到床上，这样孩子自然而然就会在愉快的相处中上床睡觉。如果最后的环节发生在其他地方，孩子就会对那个地方恋恋不舍，不想上床睡觉了。家长们要注意，挠痒痒、躲猫猫、讲鬼故事这种活动不太适合放在睡前，孩子们会越来越兴奋，越来越不想睡，最好静下来跟孩子好好聊聊、玩一些不太激烈的游戏或者给他们念睡前故事。

家长要事先对睡前相处的时间做出限制，时间到了就要让孩子上床睡觉，一般情况下不要随意延长。时间快到的时候要适时提醒孩子，不要耳根太软，随便答应孩子延长时间的请求，这样孩子就会学会遵守规律。我们来看一个例子。

> 保罗是一个4岁的小男孩，他爸爸每天都很早起床去上班，直到吃晚饭时才回家。爸爸坚持每天陪保罗入睡，这是一天内他俩单独相处的时间，也是父子俩增进感情的好时机。每晚7点，爸爸会花25分钟陪他玩小汽车、搭积木，天气暖和的话，他们会去户外玩。到了7点25分，爸爸就带保罗

去洗澡，换睡衣，上床。然后给他读睡前故事，每晚读一章，快读完的时候，爸爸就会提醒他今天的故事快念完了。读完睡前故事，爸爸关掉照明灯，打开夜灯，保罗亲吻完爸爸之后，就抱着自己的玩具猴入睡了。

随着孩子慢慢长大，他们希望在睡前能跟家长互动，他们喜欢那种亲密、温暖、私密的相处。有的家长会在睡前跟孩子一起看电视，这其实不是一个好的相处模式。对孩子来说，这种相处缺乏直接的互动，也没有任何私密性可言。

我推荐家长在睡前和孩子讨论一下当天学校里发生的事、周末的计划、足球赛、舞蹈课、课后兴趣班、音乐课等孩子感兴趣的话题，也可以讨论一下孩子烦恼的事，这样他就不会将烦恼带上床了。当然家长应该审时度势，要避免在睡前讨论让孩子产生新的忧虑的事。孩子长大后，家长可以适当调整睡前相处模式，跟孩子一起出去散散步、去街角的店里吃冰激凌、玩跳棋、打打乒乓球，也可以和孩子一起做家庭作业。

孩子到了十一二岁的时候，会喜欢在睡前一个人待着：他可能会看看书、听听音乐，或者做一些自己喜欢的事。家长当然应该尊重孩子，但还是应该去道个晚安、随便闲聊几句。家长应该让孩子明白，尽管他长大了，爸爸妈妈还是像他小时候一样想跟他共处一段时光，并且随时可以帮他排忧解难。

仰卧能降低婴儿患猝死综合征的风险

婴儿的睡眠姿势与睡眠环境会影响其猝死的可能性，因此，这一节我们在探讨科学睡眠姿势的同时会不可避免地谈及婴儿猝死综合征（Sudden Infant Death Syndrome，简称 SIDS）。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

婴儿猝死综合征是最常见的引发婴儿死亡的病因，通常发生在一岁以下的婴儿身上。一旦出现即导致婴儿死亡，事后就算进行详细彻底的医学调查，也无法找出确切的致死原因。

90% 的猝死都发生在 6 个月以下的婴儿身上，其中 2~4 个月的年龄段会出现猝死高峰。尽管迄今为止医学界还没有找到导致猝死的确切原因，但是，特定的睡眠姿势与睡眠环境对猝死概率的影响却不容忽视。缺乏产前护理或产前护理不及时、早产、出生

时婴儿体重过轻、母亲在怀孕期间抽烟等都可能导致婴儿猝死的概率上升。特定种族与性别的猝死概率也会高于正常值，例如，非洲裔美国人与美洲土著的婴儿猝死率就比其他种族要高，而男宝宝的猝死率则要高于女宝宝。

从睡眠姿势来说，趴着睡会大大增加猝死的概率。所以除非医生特别嘱咐，家长都应该让孩子仰着睡。早在 1992 年，美国儿科学会（American Academy of Pediatrics）就建议家长们让孩子在睡觉时保持仰卧姿势。到了 1994 年，该学会连同其他社会组织一起，发起了“仰卧运动”，旨在让仰卧成为婴儿睡眠的必选姿势。此后，大多数家长都纠正了孩子的睡眠姿势，趴着睡的比例从 70% 下降到 20%，由此，婴儿猝死综合征的发生率也下降了 40%，一个小小的改变换回了巨大的成就。

睡眠环境也影响着婴儿猝死的概率。家长们要牢记，除了专门给宝宝睡的婴儿床之外，千万不要让宝宝睡在其他地方，尤其不要让他们睡在软软的东西上，比如软软的椅子或沙发、睡床、枕头、抱枕、被子、羊皮褥子。这些软软的东西会导致婴儿的脸夹在床褥与墙壁或床褥与床沿板之间，或者埋在垫子里，从而导致婴儿窒息死亡。

有些家庭会让婴儿与父母同床睡，如果双亲中的一方体重超重或者喝了酒、吃了药不容易被唤醒，那婴儿还有可能被压死。同一张床上睡的人越多，婴儿的睡眠空间就越小，被压死的可能性就越高。另外，睡在不该睡的地方、婴儿床放置的位置错误、睡在墙边或家具边、跟父母一起睡等都有可能增加猝死的风险。

在室内吸烟，尤其是在婴儿所在的房内吸烟，婴儿猝死的概率会增加一倍甚至两倍。家长们也要注意，睡觉时不要给孩子穿太多衣服，太热也会导致婴儿猝死。当然婴儿房内也要注意保持舒适的温度，如果婴儿衣服穿得适度、室内温度适宜，那就不需要给他们加盖毯子了。给婴儿穿得过多、盖得过多、室内温度过高有可能是导致猝死在冬季高发的原因之一。

一些研究表明，婴儿在睡眠中吸奶嘴会降低猝死风险，因此，美国儿科学会在 2005 年建议家长们在婴儿入睡时让他们吸上奶嘴。具体建议如下：

- 一周岁之前，家长应该在宝宝入睡时让他们吸上奶嘴，如果宝宝不愿意，也不应该强迫他们。（至于宝宝清醒时是否要吸奶嘴则视情况而定。）
- 一旦宝宝入睡，家长就不要再将奶嘴塞进他们嘴里了，研究没有发现宝宝入睡

后奶嘴掉出来的情况会降低奶嘴的防范功能。

- 奶嘴要经常清洗、经常更换，不要将奶嘴沾糖后再给宝宝使用。
- 对母乳喂养的宝宝来说，奶嘴使用时间应该在出生 1 个月之后，要确保宝宝完全熟悉母乳喂养后才能使用奶嘴。

婴儿出生后的 2~4 个月至关重要，过了这个时期，发生猝死的可能性就会大大降低。迄今为止，我们还不知道使用奶嘴到底能不能降低猝死风险，有可能使用奶嘴会避免婴儿误食被褥等床上用品里的棉花、羊毛等，从而降低窒息的概率。也有可能不过是婴儿在吸奶嘴时会意识到嘴里有异物，时不时清醒过来，从而降低猝死风险。如果真是如此，那奶嘴带来的猝死率的降低是以婴儿的劣质睡眠为代价的。

孩子应不应该跟父母同床睡

在儿童睡眠研究领域，孩子是否应该跟父母同床睡大概是最有争议的话题，持支持与反对态度的都大有人在，而且两个阵营都宣称对方阵营倡导的做法不仅会在心理上甚至会在生理上给孩子造成伤害。

我本人在过去 25 年里都从事儿童睡眠研究，与很多家庭一起应对孩子的睡眠问题。根据我的经验，儿童既不会因为独自入睡或与兄弟姐妹一起睡而变得没有安全感，也不会因为跟父母一起睡而变得缺乏独立性与自理能力。只要行之有效，家长们完全可以选择对孩子与自己来说最舒适的方式。

不论儿童睡在哪里，他们都能很快入睡，而且夜里睡得很香。一般来说，从熄灯开始到完全清醒这段时间，儿童有 98%~99% 的时间是处于熟睡中的，也就是说，夜里他们即使醒来也是非常短暂的，一夜醒来的总时间为 5~10 分钟。而且，即使是在短短的 10 分钟里，他们也处于昏昏欲睡的状态，根本不会关心外界环境，只是换个姿势或翻个身就继续睡了。因此，在夜里睡着后，儿童根本不会留意自己睡在什么样的环境里，也不会关心身边还有没有其他人。

我接触过的绝大多数家庭都选择让孩子单独睡。很多和孩子一起睡的家长并不是真心希望如此，而是迫于经济问题或空间狭小，不得不和孩子一起睡。也有一些家长之所以会和孩子一起睡，是因为孩子一离开家长就哭闹不止，只有一起睡才消停。有些家庭

则想出了一个两全其美的方法，他们在孩子出生后的头几个月里在卧室里放置一张专门给婴儿用的摇篮或小床，既可以就近照顾，又可以避免同床睡。当然我也接触过一些坚持和孩子一起睡的家庭，他们心甘情愿这样做，并从中获得了不少天伦之乐。

我建议家长在做出选择前先好好想一想，要确保所做出的选择是出于家长的真心，而不是基于其他因素。不管别的家长是否选择和孩子一起睡，家长都应该从自己的实际情况出发来做决定。一旦决定和孩子一起睡，就要考虑两个重要问题：何时分开睡、如何分开睡。有些家长在孩子很小的时候和他一起睡，以为孩子长大了自然而然就能分开睡了，结果到了孩子 5 岁、7 岁、10 岁甚至 12 岁都还没能分开睡，那时不仅家长尴尬，孩子更尴尬，所以到时候绝大多数孩子会在家长之前主动提出分房睡。

如果双亲中一方想和孩子一起睡，而另一方不乐意，就可能引发“家庭战争”。如果双亲都不愿意和孩子一起睡，可是迫于孩子的强烈要求而不得不这样做，久而久之，也会导致家庭关系紧张。在这两种情况下，如果双亲中的一方和孩子一起睡，另一方睡在另一个房间里，家长就会感觉孩子导致了夫妻分开。无论做出这种决定是基于对孩子的爱还是无奈，这种导致夫妻分开睡的方法都不利于家庭关系的维持。

家长在忙碌了一整天后，身心俱疲，已经没什么精力来应付孩子了，如果晚上还要和孩子一起睡，那简直是超负荷运作了。我接触过一些这样的家庭，家长们都表示，如果和孩子一起睡是唯一能让孩子消停的方法，他们还是会继续和孩子一起睡，但是不会考虑要第二个孩子了。

孩子和家长一起睡的小常识

| 孩子与家长一起睡的利与弊 |

孩子与家长一起睡是一件有利有弊的事。

有利的地方在于：

- 无论孩子是睡着的还是清醒的，一起睡能让家长持续不断地给予孩子照顾。这种亲密感是孩子最喜欢的，有些家长也乐在其中。
- 一旦夜里孩子出现什么状况，家长都能第一时间给予关照。

- 家长在夜里不用起床就能应对孩子的哭闹。
- 家长与孩子能拥有更多相处的时间。
- 如果孩子的睡眠质量比较差，一起睡能让孩子与家长都睡得好。

弊端在于：

- 有可能增加婴儿猝死的风险。
- 如果孩子夜里躁动不安，家长就睡不好。
- 如果孩子导致夫妻分房睡，则可能导致家庭不和睦。
- 孩子与家长的睡眠周期不重合。
- 家长每晚的入睡时间会大大延迟，个人生活几乎全被孩子占据，即使有紧急情况要外出，也无法请保姆看管孩子。
- 一起睡可能引发的睡眠问题会比一般的睡眠问题更难矫正。
- 家长几乎没有隐私可言。

正如上文所分析的，孩子和家长一起睡可能引发更严重的睡眠问题，所以，在此问题上需要做更深入的研究。

在西方社会，很多人会将熟睡的宝宝放在大大的软垫子或枕头上，而不是放在专门的婴儿床上，这样做其实会大大增加婴儿猝死的风险，也会提高孩子窒息死亡的概率。

有观点认为，孩子与家长一起睡会减少猝死的风险，其依据就是一起睡时无论是家长还是孩子都会自动或被迫醒来，这个次数比分开睡要多很多。相关研究结果却刚好相反，起码在西方社会是这样。当然，这些研究关注的大多是婴儿的意外死亡，而不是严格意义上的猝死综合征。

猝死的概率与同床共寝的人数、寝具的选择、床与墙壁或家具的距离、家长自身的状况有关，而且，不同国家婴儿猝死的概率不同，即使两个同样有着家长与孩子一起睡的传统的国家，也会出现截然不同的婴儿猝死概率。猝死率并不单纯取决于孩子是否和家长同床，还和环境、社会、经济因素有关，如家长的吸烟习惯、母亲怀孕期间及产后的护理情况等。

和孩子一起睡的家长一定要做好心理准备，婴儿在夜里是非常容易躁动不安的，就算他们正常醒来，也会出现踢蹬、翻滚、呻吟、四肢乱挥等动作，睡下去时好好的，早晨醒来可能脚就在枕头上了。孩子不管怎么折腾都能睡得很好，可是家长就不行了。

考虑到婴儿在睡觉时非常容易躁动不安，有些家长就想出轮班的方法：一个家长陪着孩子睡，另一个去另一间房睡，第二天交换，这样至少有一个家长能睡个好觉。这其实挺伤夫妻感情的，如果出现这种情况，我建议夫妻双方都认真思考以下两个问题：

- **夫妻双方是否都希望睡在一起？如果是，那就不要轮班。**
- **夫妻双方是否有一方或双方都想分房睡？如果是，那就不要抱怨是孩子导致了夫妻分开，而要去寻找其中真正的原因。**

儿童与成年人的睡眠周期是无法同步的，因为成年人的睡眠周期更长一些。睡在同一张床上的家长与孩子会相互影响，只要有一个人在夜里醒了，其他人也会跟着醒来，同床的人越多，醒来的可能性与次数就越多。由于成年人比儿童更容易醒来，再次入睡也要困难得多，所以睡在一起时，家长的睡眠质量要比孩子差。

有些孩子不仅要求睡在家长的床上，还要家长陪着一起入睡。这意味着家长的入睡时间完全被孩子控制，如果孩子 7 点就要上床睡觉，家长就只能跟着睡。有的家长会在孩子入睡后偷偷溜出房间，去做自己的事，我个人认为这不是一个明智的方法。无论如何，家长无法在孩子清醒时离开片刻，就算在他熟睡后偷偷离开，也要确保能在他醒来之前回来，否则，孩子可能会哭闹不止，根本不可能自己再次入睡。

家长和孩子一起睡还会增加矫正睡眠习惯与规律的难度。举例来说，如果家长希望自己 9 个月大的宝宝改掉时不时要人哄的睡眠习惯，或者希望自己 18 个月大的宝宝不在睡觉时乱揪大人的头发、乱打大人的脸，分开睡其实就能让这些问题迎刃而解。

最后，还有个很尴尬的问题，就是一起睡会妨碍家长过正常的夫妻生活。有的家长会等孩子睡着后，再偷偷地、安静地“办事”，我觉得这个习惯不好，因为孩子随时都有可能醒来，一旦发现父母在做一件他不懂的事，他会产生误解与困惑。

对于与孩子一起睡的家长们来说，这一节讨论的很多问题都有可能发生。这些问题的根源都是同一个：孩子在睡眠过程中很有可能躁动不安、不时醒来。解决办法也很简

单，就是“分床不分房”。当然，只要方法得宜，即使孩子和家长睡在一张床上也能纠正孩子的不良习惯。我们在下文会继续谈论这个问题。

何时应该分床睡

关于何时应该让孩子与家长分开睡这个问题，各种说法莫衷一是。有人认为应该在孩子 6 个月大的时候就分开睡，再迟一点孩子就会因为分开睡而产生焦虑；有人认为应该等到孩子满周岁再考虑分开睡；还有人认为应该等到孩子完全断奶后再分开睡；有的儿童护理专家甚至建议等孩子满 3 岁后再分开睡。我觉得选择权在家长，只是当家长决定要跟孩子一起睡的时候，就应该计划好何时、以何种方法与孩子分开睡。除非经济条件或房子面积不允许，否则，家长应该在孩子满 3 岁前就让他一个人睡。

分开睡的时间越早，执行起来就越容易。6 个月左右时分开睡，孩子不会有太大反应；到了 1 周岁，孩子已经习惯和父母一起睡了，如果此时分开，他的适应性就不如 6 个月时那么好；到了 3 周岁孩子就会拒绝自己一个人睡，要想说服他就难得多了。如果孩子到了学龄前还是跟家长一起睡，他会觉很尴尬甚至羞愧，因为同龄伙伴们都已经自己睡了，只有他不是。**家长们要记住：孩子越大，纠正他们的睡眠习惯就越难。**因为随着孩子慢慢长大，家长想要违反他们的意愿硬着来的难度越来越大。

有的专家建议在分开睡之前留一段缓冲期，先“分床不分房”，再“分床又分房”。如果孩子没有太大的反应，这个方法倒也可以一试，但如果孩子抵制情绪强烈（比如他会偷偷地爬到大人的床上去），那这个方法实施起来就很难了。即使家长能做到“分床不分房”，要真的实现“分床又分房”，也还需要很多的努力。

比较可行的方法是，家长与孩子都睡到孩子的卧室里，孩子睡自己的床，家长再铺一张床或者席地而睡。久而久之，孩子会逐渐习惯睡在自己的房间、自己的床上，此时再让他自己睡就容易多了。这种方法比缓冲期法更容易实施，家长等孩子入睡后可以试着离开，一开始离开的时间短一些，然后逐渐延长，最后帮助孩子养成自己入睡的习惯。当然，进度取决于孩子的具体情况。孩子的性格与年龄是比较关键的决定因素，包括孩子的敏感度、沟通能力、遵守规则的程度和积极性。家长不要急于求成，让孩子一夜之间适应一个人睡是不现实的。

双胞胎和多胞胎家庭怎么办

现在多胞胎的现象越来越常见了，大概 300 个新生儿中就会出现一对同卵双胞胎，异卵双胞胎的发生概率则比同卵双胞胎高三倍（这个数据因国家、种族不同而不同）。

多胞胎的家长会认为，多胞胎孩子的睡眠问题与一般孩子不同，需要区别对待。事实上，多胞胎孩子的睡眠问题与一般孩子并无本质差异，问题出现时的表现也大同小异。即使双胞胎们在白天形影不离，到了晚上睡觉时，也无法保持这样高度的同步。睡觉是每个人需要独自应对的事。话又说回来，毕竟养一个孩子和养几个孩子还是有差别的，所以，有些具体的情况还是需要额外注意。

照顾多胞胎要比照顾一个孩子难得多，有些问题不得不提前考虑好。如果家里除了双胞胎之外，还有其他的孩子，并且年龄相差不大，那么照顾这些孩子所要付出的精力根本无法单纯用孩子的数量累加。照顾一对双胞胎所要付出的精力，远远多于单独照顾两个孩子所要付出的精力。多胞胎意味着几个孩子的年龄一样，他们的基本需求也一样，家长可能需要在同一时间给几个孩子喂食、换尿布、换衣服，还需要同时对他们进行学前教育。即使有人帮忙，完成这些任务也会让家长筋疲力尽。

即使家里还有很多空着的房间，家长们仍然喜欢将双胞胎放在一个房间里照顾，有些家庭甚至让双胞胎共用一张婴儿床。家长们希望双胞胎能同时入睡、同时起床、同时睡午觉、同时进食，而对于年龄相仿的非双胞胎子女，他们却没有这样的期望。可以说，很多双胞胎的睡眠问题都与这些不合理的期望有关。

事实上，过了出生后最初的几个星期后，让双胞胎睡在同一张婴儿床里有弊无利。家长们要明白，尽管双胞胎看起来时时刻刻都腻在一起，可他们是完全独立的两个个体。他们坐在同一辆车上，却坐在两个不同的位子上；他们一起吃饭，却坐在各自的高脚椅上。到了夜里，也没有理由要求他们完全一致。让双胞胎一起睡危害很大，首先，从此以后，双胞胎里的任何一个都离不开另外一个了，除非两个人一起睡，否则他们根本无法独自入睡；其次，两个人里只要有个人动了，另外一个就有可能被吵醒。

一般来说，同卵双胞胎的作息规律大同小异，睡眠习惯也很相像，但还是有所差异，他们不可能每天都分秒不差地一起入睡、一起醒来；异卵双胞胎的作息规律则呈现出更明显的差异。

无论是独生子女、双胞胎还是多胞胎，每一个孩子都是独一无二的，他们会有自己独特的能力与需求，家长应该关注孩子的独特性，因人而异地照顾他们。在双胞胎中，某一个孩子可能天生就比另一个睡得少，也可能比另一个更早戒掉夜间哺乳；某一个孩子可能会在晚上醒来后安安静静地自己玩，另一个可能一醒来就吵闹不休。

总而言之，“分床不分房”的双胞胎或多胞胎可能会面临一些睡眠问题，这些问题与同样“分床不分房”的兄弟姐妹所遇到的问题类似，家长们可以用类似的方法来解决。例如，如果双胞胎中的某一个孩子每晚要睡 10 小时，另一个只需要睡 9 小时，那么睡 10 小时的孩子就总是被睡 9 小时的孩子吵醒。解决这个问题的方法跟解决非双胞胎兄弟姐妹间作息不重合问题的方法一模一样：

- **方法一，让只睡 9 小时的孩子延迟一个小时上床睡觉，也就是说，即使是双胞胎也不需要同时入睡。**
- **方法二，让他们同时入睡，但是在早醒的孩子吵醒另一个孩子之前，家长就要把早醒的孩子抱出去，这意味着他们可以拥有不同的起床时间。**
- **方法三，缩短早醒的孩子的午睡时间，让他在晚上多睡一会儿，尽可能接近另一个孩子的夜间睡眠周期，但是这样的话，他们的午睡周期就不重合了。**

如果双胞胎中的某一个孩子睡得很安稳，另一个却在夜间频繁醒来，那家长最好让他们分开睡，至少要暂时分开。这样家长就能集中精力应对那个频繁醒来的孩子，在矫正这个孩子醒来的问题的同时，确保另一个孩子不受打扰。综合考虑婴儿床在房间里的位置与睡眠问题的具体表现形式，有时需要将有睡眠问题的孩子搬出去，有时又需要将睡眠质量较好的那个孩子搬出去，这得具体情况具体分析。如果两个孩子都有睡眠问题，那将他们安置在不同的房间有助于问题的解决，等问题解决后再让他们一起睡。

家长一开始可以在维持他们同房睡的前提下试着矫正问题，如果行不通，再将他们分开。有时候，双胞胎离开彼此就折腾不起来了，分开睡之后所有的问题就都迎刃而解了。如果双胞胎中有一个孩子比较喜欢折腾，家长就先哄这个孩子入睡，等他消停之后再将另一个孩子抱进来。在矫正孩子们的睡眠问题时，分床不分房或者分床又分房都是很常用的方法，等问题解决之后，家长会发现孩子们养成了不同的作息规律与睡眠习惯。

养育双胞胎或多胞胎确实任重道远，但是，不能因为这样就忽视孩子们的不同需求。

家长要尽量做到不“一刀切”，试着“具体情况具体分析”。

为孩子挑选他最喜欢的玩具

等孩子大一点之后就可以试着让他一个人睡了，如果他在一开始不习惯，家长可以给他一个“替代物”作为过渡，可以是一个动物玩偶、一个洋娃娃或者他特别喜欢的小毯子。即使家长和孩子睡在一张床上，也可以在床上放这样一个“替代物”，久而久之，孩子就会逐渐习惯由“替代物”而不是家长陪着睡了。

那个陪孩子入睡的玩偶或小毯子就放在孩子触手可及的地方。玩偶不像家长，它们不会在孩子睡熟的时候偷偷溜走，也不会因为早起而吵醒孩子，所以它们能带给孩子安全感，让他感觉周围的一切都处于可控状态。此外，它能将孩子的依赖性从家长身上转移出去，让家长脱身。

通常来说，孩子在婴儿时期尤其是12~18个月大时就已经拥有自己最喜欢的东西了，这种钟爱会持续数年。如果你家宝宝还没有特别喜欢的东西，家长不妨为他挑选一个。当然，喜不喜欢最终还是孩子说了算，家长不可能强行塞给孩子一个他不喜欢的东西。最重要的是，家长自己不能成为孩子最喜欢、最依赖的“玩具”。如果家长和孩子睡在一起，哄他入睡，还无条件地满足他的任何要求，那孩子根本不会考虑挑选一个中意的玩具，因为他不需要。

对那些有“替代物”的孩子，家长应该在孩子入睡时把“替代物”放在孩子身边，然后跟往常一样，给他讲睡前故事，哄他入睡。如果孩子有特别中意的小毯子，给他盖上。这些小小的“替代物”会发挥巨大的作用，让你们的夜晚变得安宁而轻松。

帮助孩子养成良好的作息习惯

新生儿的睡眠是极其不规律的。绝大多数孩子在出生后两周内呈现出一种婴儿式的睡眠规律，他们总是小睡，有时睡的时间长，有时仅仅是打个盹儿，不分白天黑夜，睡去又醒来。也有个别婴儿一出生就有良好的睡眠规律，即使因为哺乳而醒来，也会立刻再次睡去，但这是例外，绝对不是常态。所以，当婴儿不规律的睡眠搞得家长身心俱疲时，家长也不要绝望，也许转瞬之间，孩子就会呈现出另一种完美的作息规律了。

还有些婴儿会呈现出昼夜颠倒的睡眠规律，这当然也是暂时的，不用担心。其实，婴儿呈现出正常的睡眠规律才叫人吃惊呢，毕竟他们才刚出生没多久，没有那么多时间来养成良好的睡眠规律，也没有学会分辨白天和黑夜。婴儿这种昼夜颠倒的睡眠规律不足为奇，这反而是他们开始养成良好睡眠规律的前兆。绝大多数孩子都能随着岁数的增加自己矫正这种颠倒的睡眠规律，如果他们无法自力解决，家长可以插手帮忙。

家长干预或不干预，孩子都会随着年龄的增长而慢慢养成 24 小时的睡眠节律，但是，家长的适当干预有利于睡眠节律的养成。家长在干预时应该充分考虑孩子的生活作息、日常习惯、学习能力、生理与心理需求等，尽量避免打乱孩子的日常生活。

婴儿的进食规律对其睡眠规律的养成也有很重要的影响。过去，儿科医生会要求家长从孩子一出生就坚持实行一种精确的 4 小时进食法，现在已经极少有儿科医生这样建议了，相反，他们会建议家长根据孩子的需求进行喂食。通常，婴儿需要每隔 2~6 小时喂食一次，但是，除非你家宝宝是早产儿，进食困难或者生长迟缓，否则，婴儿的进食时间应该灵活一点。

家长在掌握喂食规律时应该注意两点：

- **第一，并不是每一次孩子哭闹都需要给他喂食，只需稍微留心就能分辨出孩子哭闹的意思。**
- **第二，喂食应该有一定的限度。**

新生儿每天都需要喂食两次以上，但喂食次数也不能过多。足月出生的健康婴儿是不需要每小时都喂食一次的，就算他每隔一小时就哭着要喝奶，家长也不需要次次都满足他。每小时都喂奶对家长来说是过分折腾的一件事，对哺乳的母亲来说更是痛苦不堪。对婴儿来说，这是不必要的，并且会打断他们养成良好的睡眠规律。

家长应该明白，帮助孩子养成良好的睡眠规律也是对孩子的一种爱，这个过程也许会让孩子哭闹得更厉害，但是时间久了，家长就会想出其他办法来应对哭闹，而不是孩子一哭就喂奶。比如，婴儿开始哭闹，如果家长抱着他到处走动，轻轻摇着他，拍拍他，即使不喂奶，孩子也会停止哭闹。类似的小窍门还有很多，家长可以自己摸索以备不时之需。

举例来说，如果家长希望孩子养成每隔 4 小时进食一次的习惯，那家长可以逐渐延

长喂食的间隔时间，每天比前一天延长 15 分钟，直到孩子习惯每隔 4 小时进食一次为止。当然，这个规律应该在孩子出生后 3 个月内养成。

同时，家长也可以着手调整婴儿的睡眠规律。例如，如果孩子在白天睡 6 小时，晚上清醒，而这种睡眠规律在婴儿出生后的几周内持续出现，那家长可以逐渐提前叫醒孩子，慢慢缩短孩子白天睡觉的时间，让孩子认识到白天的睡眠只是小睡而已，应该将长时间的睡眠移到晚上。当然，这种调整需要留心观察孩子的需求，循序渐进。

3 个月大的婴儿对外界刺激已经有自主意识了，他们会自己判断白天和黑夜、安静和嘈杂。4 个月左右，他们会将长时间的睡眠放到晚上，通常可以持续 5~9 小时，白天小睡 3~4 次，白天清醒的时间越来越规律。这时，家长就可以开始帮助孩子建立良好的睡眠规律了。只有孩子的睡眠规律了，家长才能睡得好，才能在孩子清醒的时候更加全身心地照顾他们。

家长应该仔细观察孩子的日常生活，比如，他什么时候醒来、什么时候活跃、什么时候需要进食、什么时候入睡，从而更好地把握孩子的需求，在他想玩耍的时候陪他玩，在他饿的时候喂他，在他困的时候哄他入睡。当然，孩子的吃喝拉撒睡不可能精确到某时某分某秒，但是，到了大概的时间，家长就能行动起来，时间一长，孩子就自然养成习惯了，24 小时的作息节律也就养成了。

婴儿 3 个月大时，如果已经养成了 24 小时作息节律，家长就要帮助他养成更为规律的生活习惯。如果家长自己有着良好的作息，耳濡目染，孩子也会逐渐养成这样的作息。相反，如果家长率性而为，任由孩子进食、玩耍、洗澡、作息等三天两头地变化，孩子的生活也会毫无规律可言。我们在第 2 章里说过，如果没有固定的生活作息，人的本能是遵照 25 小时的作息节律生活的，孩子也是如此。所以，如果家长不坚持让孩子养成良好的作息规律，孩子的生活将会一团糟。

我曾跟很多家庭一起应对儿童的睡眠障碍问题，其中最普遍的一种情况就是这些有睡眠障碍的儿童都遵循一个异于常人的睡眠规律，他们的睡眠周期并不是正常人的 24 小时，而是 25 小时或 26 小时。而家长就只好配合孩子的睡眠周期，睡得越来越晚，或者早晨起得越来越早。有时候，这些孩子的睡眠时间随着周期运转，刚好停留在白天，他们的生理周期就变得日夜颠倒了。这些孩子其实没什么大问题，在特定的时间让他们身处明亮的环境里，他们的生理节律就会改变。

家长要努力帮助孩子巩固良好的睡眠规律，无论是在婴儿期、幼儿期还是成人以后，良好的睡眠规律都应该保持。事实上，如果不考虑年龄差异，我们所有人最好的生理节律都应该建立在规律的睡眠之上。研究显示，不规律的睡眠会严重影响成年人的情绪状态，让人变得烦躁，甚至会影响其按时入睡的能力。儿童亦然。

我建议家长不要让两三岁的孩子自己决定什么时候入睡，因为这个年龄段的孩子会一直消耗体力，直到困得睁不开眼才会去睡。长此以往，孩子的睡眠规律就会被破坏，变得毫无规律，断断续续。例如，他会今天早睡明天晚睡，今天午睡明天不午睡，午睡出现的时间也毫不固定，甚至，他的进食时间也变得毫无规律，早晨 7 点开始到 10 点为止的任何一个时间点都可以变成他的早餐时间，而午餐与晚餐时间也变得无法估计，家长最终会被搞得一头雾水。睡眠不规律容易引发严重的睡眠问题，甚至会导致行为异常，而这些其实在一开始就可以通过矫正睡眠规律来加以控制。

我认为，家长在孩子出生后三个月内就应该帮助其建立起良好的睡眠规律。婴幼儿不具备自控能力，家长应该为他们制定作息时间表，然后坚持不懈地遵守。当然，这个作息时间表也不用太死板，应该有一定的灵活性。例如，有的孩子天生就比其他孩子贪睡，有的孩子天生就比其他孩子更有适应能力，家长应该根据孩子的实际情况，慢慢摸索出最佳方案，然后坚持执行。

良好的睡眠规律对治疗睡眠障碍有很重要的作用。所以，如果看这本书的家长正着手解决孩子的睡眠障碍，可以先试着为孩子制定一个合理的睡眠规律，然后坚持几周，看看成效如何，再根据具体情况调整方案。

建立良好的睡眠规律，也并非一劳永逸，有很多情况会破坏其运转，孩子出牙、生病、全家去旅行、家长吵架等都会影响孩子的睡眠。如果家长不加干涉，这些破坏睡眠规律的情况就会持续下去，有时甚至会持续几个月。遇到这样的情况，家长就要为孩子重建睡眠规律，帮他改掉坏习惯，安抚他的情绪，然后更严格地执行新规律。

第10章 如何给孩子设定限制

很多孩子会向父母要求“给我拿杯水”、“再给我讲一个故事吧”或者“再亲我一下”，这样的要求往往会没完没了，一旦家长开始满足，就会逐渐毁掉整个晚上。只有当孩子的需求得到满足，他才会乖乖地待在床上，慢慢睡去。这就是缺乏限制的表现。其实导致缺乏限制的原因、其具体表现及矫正方法与其他睡眠问题非常类似，只不过缺乏限制更容易发生在年龄较大的孩子身上，发生的时间通常在孩子入睡前，而不是睡眠阶段转换的间隙。

谁说了算

孩子都是鬼灵精，只有当要求有可能实现时，他们才会提出要求，否则不会浪费精力去争取。他们可能会提出一大堆要求，但是会集中精力“攻关”最有可能实现的那几个。他们提出的要求类似于演员谢幕前观众发出的“叫幕声”，一次次重复，而这些要求无非是要喝水、再讲一个故事、再给一个晚安吻，或者：

“再给我挠挠背。”

“我想（再）上一次厕所。”

“再给我唱首歌吧。”

“我想跟爸爸道晚安。”

“我想跟你聊聊。”

约束孩子的行为是家长的职责，要明白在家里家长才是“老大”。我接触过很多案例，都没有担当起约束孩子的职责，孩子成了家里的老大。有家长告诉我，他也知道不应该在入睡前再给孩子喝第二瓶奶了，可是孩子要求他这样做。也有家长告诉我，他们给孩子设定的关电视睡觉的时间是晚上 9 点，可是“孩子坚持要再看一个节目”。还有家长告诉我，家里是妈妈在掌控孩子的作息，孩子根本不买爸爸的账。以上几个例子形象地说明，家长的控制权很重要。

> 有一个叫梅根的小女孩，4 岁，平时非常乖，可是一到晚上，她的卧室就跟太空航行地面指挥中心一样忙碌。她会要求父母给她端水喝，如果拿水来的是爸爸，她就会说“我要妈妈”。等妈妈按照要求端着水进来了，她又会说“用错杯子了”。等妈妈再次拿水进来，她又说“水太少了，不够满”，等等。为了满足她的要求，父母只好楼上楼下满屋子跑。

梅根的情况就是典型的缺乏控制，她代替父母成了家里的“老大”，然后全家人都没得睡。

对家长来说，学会给孩子设定限制是很重要的一件事。当涉及人身安全时，家长就会毫不犹豫地出面约束孩子的行为。如果看到孩子在玩通电的插座，父母就会立刻出面制止。对于这种制止，父母心安理得，不会觉得剥夺了孩子的自由。相反，如果孩子要求在睡前喝杯水，家长就不会那么心安理得地拒绝了。对孩子来说，这两种情况没有本质的差别，都是：“我想要做这件事，我能做吗？”如果约束孩子的行为有一个好的理由，父母就不会感到内疚，也不必担心因此破坏亲子关系，可一旦这种理由不能提高到保护孩子人身安全的高度，家长就会开始纠结了。

家长要注意，在约束孩子的行为时，不能一天一个样，也不能根据自己当下的心情来做决定，夫妻双方要意见一致。不要过分严厉，也不要过分放任，应该寻找一个宽严合适的“度”，然后始终如一地坚持下去。

给孩子设定限制的困难何在

设定限制的困难很多，不一而足。有的是因为家长缺乏正确的认识，没有认真考虑过适宜的限制对孩子是有好处的；有的是因为家长使用的方法错误，没法持之以恒。孩子固有的作息规律可能会阻碍家长干涉孩子的行为，对于改变孩子的作息，家长可能会

觉得内疚，这种内疚感让家长自己都没法坚持下去。孩子的抵抗会让父母感觉不安，慢慢地家长也不再坚持了。最终，这种妥协会改变家长的控制力，让家长既无法显示出关怀，又无法约束孩子的行为。下面我们一项项来看。

1. 了解设定限制的重要性，掌握设定限制的技巧。有些孩子每晚都跑到父母房里，对着一个家长又踢又打，直到这个家长挪去隔壁房间，将位置让给孩子为止；有些孩子在入睡前会随心所欲地吃吃喝喝，或者没有节制地看电视，或者非要父母答应买一样他想要的东西。家长要是无法拒绝孩子的不合理要求，同时又觉得要做点什么来改变这种状况，那我建议家长学一点设定限制的小技巧。我会在本章的后面几节详细讲解几个小技巧，家长可以参考。但是，家长首先要充分认识到设定限制的重要性，认识到心理因素在其中的作用。

2. 设定合理的作息规律。如果孩子只有缺乏约束这一个问题，那一旦家长为其设定一些限制，孩子就应该能够很快入睡了。但是，如果孩子的就寝时间定得过早，还没犯困就要求他入睡，那不管父母如何严厉，他都无法入睡。其实，就寝时间不对会让孩子在夜间更容易醒来。家长应该为孩子设置合理的就寝时间。

3. 不要有莫名的内疚感。设定限制是比较难的。家长通常都希望将自己对孩子的关心与爱非常清晰地传达给孩子，所以要让父母忽视孩子的哭闹与请求，实在是有点困难，父母会纠结于孩子对他们的看法会不会因此改变。如果孩子天生是聋哑人、患有心脏病、正在接受化疗，或者家长经常要出差、身兼两职而没有时间陪孩子，那要家长严厉起来就有点强人所难了。

我要告诉家长的是，没有哪件事是不需要付出就能有收获的。在上述那些特殊情况下，家长不需要一次性矫正孩子的行为，可以制定一个合理的方案，分步实行。例如，可以先禁止孩子多看一集电视节目，成功之后再禁止孩子多喝一杯饮料，以此类推，直到他不再任性要求为止。

4. 不要忽视继发性获益（Secondary Gain）。如果设定限制失败或者向孩子的任性妥协有利于父母，那这种获益就是所谓的“继发性获益”，它会导致父母怠于改变孩子的不良习惯。例如，家长可能会对整夜反复哄孩子睡觉感到厌烦，但是在孩子入睡时搂着他，却是大多数父母享受天伦之乐的方式之一。也有复杂一点的情况，有的夫妻只要聚在一起就免不了吵架，孩子在半夜频繁醒来反而阻止了他们时刻会爆发的“内战”。

我认为，无论对家长来说这种获益有多少，都不应该让孩子承担起维护家庭关系的重任，这对孩子来说是不公平的。

5. 考虑家庭困难因素。如果家长想为孩子的夜间睡眠设定某些限制，在白天时，孩子就应该得到很好的照顾，这两者是相辅相成的。如果白天孩子没有得到很好的照顾，例如家庭经济困难，或者某一个家长没有劳动能力、酗酒、嗑药、患重病等，到了晚上他就会想方设法地吸引家长的注意，希望家长给予他充足的关爱。在这种情况下，要设定限制是非常困难的。对父母来说，他们根本不知道要如何在家庭有困难的情况下着手矫正孩子的睡眠问题。在这种情况下，我建议家长寻求专业人士的帮助。

多种问题交织出现

本章一开始我就提出，很多睡眠问题会与设定限制问题纠缠在一起，相互作用。如果同时具有睡眠环境问题与设定限制问题，那基本矫正方法是不变的；如果同时具有夜惊与设定限制问题，或者同时具有作息混乱与设定限制问题，矫正方法就截然不同了。

如果孩子在入睡时既不惊恐也不焦虑，虽然夜间醒来数次，但每次都能自己入睡，一夜不哭闹，或者孩子在夜间最多醒来一两次，家长就可以得出结论，孩子的问题出在睡前这一环节，而不是入睡后。在这两种情况下，孩子都在同样的环境中入睡，又在同样的环境中醒来与再次入睡，所以根源也不在睡眠环境上。如果家长对这些情况听之任之，渐渐地，孩子就会在夜间越来越频繁地醒来。

有的孩子会要求家长在他入睡时留在房内或者陪着他入睡，有的孩子甚至会拉着父母的手，这样他不用睁开眼就能知道爸爸妈妈还在不在。如果家长每晚都要这样哄孩子入睡，当孩子在夜间醒来后，也要重复这些步骤，时间长了，家长就会习惯睡在孩子房间里了。这样我们就面临两个问题：睡眠习惯问题与睡眠环境问题。这两个问题的矫正方案完全一致。

如果孩子和家长一起睡，就有可能发生上述两个问题交织出现的情况，孩子可能会坚持睡在父母中间，将父母逼到床沿。如果在这种情况下，孩子还需要依靠奶瓶或奶嘴才能入睡，那就是三个问题交织了：睡眠环境问题、睡眠习惯问题以及夜间进食问题。在这三个问题中，应该优先矫正夜间进食问题。如果孩子在就寝后，会在床上清醒一个多小时，然后才能入睡，那很可能他的入睡时间过早了，也可能是早晨起得太晚了，此时，

应该优先矫正孩子的作息，然后再进一步对孩子的睡眠习惯设定限制。

给孩子设定限制的方法

设定限制问题和睡眠环境问题之间的区别很不明显，通常两者的矫正方案也非常相似，有时甚至完全一致。

我们在第 9 章介绍过，孩子应该有一个健康的作息规律。孩子的夜间睡眠应该全部发生在孩子自己的卧室里，并且睡眠时间适宜。对于婴幼儿，睡前相处的时间应该控制在 5~15 分钟；对于学龄儿童，可以适当延长。千万不要无限制地延长睡前时间，这容易给孩子造成一种无休无止的错觉。家长可以在某些时间适当提醒孩子（例如，可以提醒孩子说“接下来讲最后一个故事”），然后坚持自己的事先设定。如果家长随便向孩子妥协，多讲一个故事，这种妥协就会永无止境了。

家长可以将睡前相处的主动权掌握在自己手里，例如，如果家长希望在孩子睡前让他喝点水、亲亲他或者抱抱他，那家长完全可以主动去做。一旦家长掌握主动权，这些举动就会变成睡前相处的例行动作，而不是家长向孩子妥协的产物。

对于睡在婴儿床里的婴儿，可以按照循序渐进法等待一段时间后再回应孩子的哭闹。如果孩子年纪尚小，不能自己走出房间，当他跟父母一起睡时，家长可以在矫正时主动离开，实施循序渐进法。家长也可以不离开房间，就坐在椅子上看着孩子。

如果孩子已经能够自己离开卧室了，或者能够偷偷溜进父母的房间了，情况就更棘手一点。家长要牢记，无论孩子哭得多凶、嚷得多厉害、态度有多强硬，父母都要比他更加坚定。一旦孩子掌握主动权，他就会得寸进尺。所以，当孩子发现父母不再踏入他的房间，他就可能自己走出来寻找父母，此时，家长要果断地关上房门。如果家长只是在孩子的房间门口设置了障碍物，孩子又能翻过这些障碍物的话，家长就要设置“双保险”，逐渐增加障碍物的难度，直到孩子爬不过去为止。

家长要尽量坚持事先设定的规则，态度要像不让孩子玩火时那样坚决。只有当家长成功地解决孩子制造的麻烦之后，孩子才会明白要听父母的，并且不再挑战父母的权威。

家长在设定限制时要注意有效性。有些孩子无论房门开着还是关着，都不会跑出房间，面对这种孩子，家长根本用不着关门。有些孩子就算家长关上门，还是会费尽心思

地想要跑出房间，面对这种孩子，家长就需要对其设定限制了。

| 限制孩子的活动范围：概述 |

为了限制孩子的活动范围，有时家长需要给孩子设置障碍物。可以在楼梯口或过道里装一道低矮的栅栏，用以区隔夜间孩子的活动区域，以确保孩子相对安全。当然，家长最好在此基础上告诫孩子要乖乖地待在自己的房间里，然后在孩子的卧室门口装上栅栏。千万不要让孩子卧室的门开着而锁上家长卧室的门，因为如此一来，孩子除了不能去家长卧室，可以去家里任何地方，他就变成家里的“老大”了。

在孩子的卧室门口装上栅栏之后，孩子可以自由地在房间内活动，但是却无法走出去。不要让孩子从栅栏的间隙看到家长站在门的另一边，否则他就不会乖乖地回到床上去了，而是会守在栅栏里面。要是孩子从栅栏的间隙看到父母在做他也想参与的事，比如看电视，他就更不会主动回到床上去了。家长可以在睡前关上自己卧室的门与客厅的门，只要让孩子与家长隔开就行。

一般来说，栅栏对 4 岁以下的孩子比较有用，如果孩子已经有足够的活动能力了，家长就不要装栅栏了，因为栅栏比较容易被攀爬，孩子可能会忍不住爬上去。可以选择尼龙料子的纱门，也可以装比较高的竖条的栅栏，这样的门攀爬起来比较有难度。

在孩子的卧室门口装一道栅栏，比关上家长卧室的门要管用得多。绝大多数孩子都喜欢在睡觉时开着房门，这样会让他们感觉与家里的其他部位连成一体，而不是被隔绝在一个角落里。孩子也会坚持父母的房门不能关死，这样他就不会感到与父母隔绝了。同样，能听到家人的走动声会让孩子感觉安心。

栅栏应该是一种工具，限制孩子在夜间待在卧室里，确保他的安全。关上栅栏应该成为睡前相处的重要环节之一，当父母进入孩子的房间给他讲睡前故事或唱摇篮曲时，家长要随手关上栅栏。如果家长只是在离开房间或者生气的时候关上栅栏，孩子就会将关栅栏与不好的情绪联系在一起。当睡前相处结束时，家长离开后要及时关上栅栏。记住，家长离开后要远离孩子的视线，不要让孩子透过栅栏的间隙看到家长的身影。

进一步说，家长可以采用表 3—1 给出的循序渐进法来逐步矫正。如果孩子哭闹不休，家长可以逐步增加开门的等待时间，最好不要频繁地进入孩子的卧室。有两大原因可以说明为什么家长不应该频繁地进入孩子的卧室：

- 第一，如果孩子一哭闹家长就进入房间，那对孩子来说，哭闹反而成了一种满足自己需求的工具，这不利于矫正的进行。
- 第二，一旦家长进入房间，孩子就会黏到父母身上，父母就不得不拉开他，将他关在房间里，这对家长和孩子来说都有点残忍。

所以最好是等孩子睡熟后再进入房间探视，然后在必要的时候重复这种探视。

| 限制孩子的活动范围：设置栅栏 |

家长如果要在孩子的门口设置障碍物，首先要确保所设置的障碍物能够发挥实效。例如，如果家长在孩子卧室门口装了一道栅栏，就要确保栅栏边上没有椅子或凳子之类能让孩子顺着栅栏爬到外面去的物体。其次，要确保障碍物的设置持久有效，而不是一时的心血来潮。不能因为孩子哭闹得比较厉害就妥协或拖拉。

孩子的卧室应该像有围栏的婴儿床一样安全，窗户应该关好，不要放置有尖角的家具。如果孩子生性活泼好动，家长就要再仔细一点。对这样的孩子，由父母来掌握控制权显得尤为重要。如果孩子推翻柜子、打翻台灯、乱扔玩具，家长最好将这些东西统统挪到房间外去，而且一旦挪出去，除非孩子完全养成良好的睡眠习惯，否则就不能将这些东西搬进房内。最极端的情况就是，整个矫正过程在一间空房子内进行，除了睡觉的软垫子之外，房间内空无一物。

对于新手家长来说，这一章谈及的某些技巧显得有些不近人情了。但是，家长们要明白，一个无人管束的孩子并不幸福。在孩子卧室门口设置一道栅栏有利于家长在矫正过程中保持冷静，试想一下，如果连家长都失去理智而变得暴怒了，孩子还怎么完成矫正呢？最好的矫正方法应该是家长站在栅栏的外面，透过栅栏间隙与孩子在温暖的、充满鼓励的、能掌控的氛围中好好谈谈，而不是任由孩子拳打脚踢、哭闹不止。

从某种程度上来说，矫正过程的开端越是困难重重，设定限制就越是容易。毕竟，一开始就已经糟糕透了，往后再怎么糟糕也糟糕不到哪里去了。反而是那些琐碎的、无关痛痒的要求最难让人拒绝，例如，孩子会要求父母每天帮他盖两次被子，满足这样的要求花几秒钟就够了，但是家长在帮孩子盖完被子之后可能会失眠。所以就算是为自己着想，家长也要对这样的要求采取一点措施。在采取措施前，家长要明白，在这种情况下，孩子通常会有一定的反弹，如果反弹得比较厉害，家长就要停下来仔细考虑是否

要继续矫正以及矫正的时间是否恰当。

一旦矫正取得实效，家长就会掌握控制权，睡前的相处也不会像以前那样紧张，当家长帮孩子换睡衣准备就寝时，孩子不会再一溜烟逃走了。家长和孩子都会体会到睡觉是一天中的特殊时刻，孩子会感觉放松，不会再因为犯错而触怒家长。孩子卧室门口的那道栅栏就是家长掌握控制权的象征，一开始排斥栅栏的孩子会在矫正之后主动提醒家长关上栅栏，因为这道栅栏除了将孩子的活动范围固定在卧室里以外，更控制了他的情绪。这道栅栏变成了家长的延伸，帮助父母履行职责：保护自己的孩子。

如果矫正取得效果之后的几天或几周内，孩子要求父母在离开时不要关上栅栏，家长可以试试看。孩子也许已经可以自觉地待在卧室里乖乖睡觉。当然也有孩子抵制不住诱惑，家长应该根据孩子的矫正情况判断是否要关上栅栏。

| 限制孩子的活动范围：装一扇门 |

对年纪稍大的孩子来说，一道栅栏显然已经不能阻挡他了，一般来说，4~6 岁的孩子能轻松应对栅栏，此时家长要考虑在孩子的卧室门口装一扇门。装上门之后，一旦孩子在夜间从卧室里跑出来了，家长要及时把孩子抱回房，然后关上门，每次关门的时间都应该比上一次久一点。一般来说，第一次关门的时间以 15 秒为宜（参见表 10—1），然后逐渐增加。如果家长觉得自己和孩子都可以忍受更久的关门时间，则可以直接从表 10—1 的第 3 行及以下开始执行。

只有当孩子离开房间的时候，才需要关门，每次关门都应该有特定的时间限制。孩子会在逐渐增加的关门时间里了解到，正是由于自己偷跑出房间才会导致被关在房间里，关门的时间会随着次数的增加而逐渐增加，而自己对这种增加没有决定权，只能执行。有些孩子会马上回到床上睡觉，以此希望不关门，千万不要答应，一旦门开着，孩子就还是会偷偷溜出去。

在特殊情况下，家长可以从外面将门反锁。千万不要在反锁之后一走了之，而应该站在门外等一会儿。家长可以在门外对孩子说几句话，让孩子知道家长的存在，但不要隔着门跟孩子聊起来，也不要回答孩子提出的任何问题。一旦开始与孩子交流，控制权就又会回到孩子手中，这是绝对不允许的。

时间到了就要打开门。家长可以在开门后跟孩子谈谈，让他明白在睡觉时间他只能待在房内，要是他非要出去，你就会采取措施延长关门的时间。就算孩子乖乖地待在房内没有出去，家长也不要随便满足孩子的其他要求，以便矫正其他睡眠问题。

如果孩子需要去厕所，家长还是应该让他去。但是，如果孩子去厕所只是一个托词，进了厕所之后什么都没干，那家长就应该拒绝孩子去厕所的请求。

如果孩子乖乖待在房内，却大声呼唤父母，家长可以采取循序渐进法加以矫正。如果孩子走出房间，则采取表 10—1 所给出的方法。

表 10—1　　帮助孩子养成待在卧室里的习惯

如果孩子不乖乖待在卧室内，家长每次关门的时间长度					
		如果孩子不厌其烦地从房间里溜出来			
第几日	第一次关门时间（分钟）	第二次关门时间（分钟）	第三次关门时间（分钟）	第四次关门时间（分钟）	第五次及以后各次关门时间（分钟）
1	1/4	1/2	1	2	3
2	1/2	1	2	3	5
3	1	2	3	5	7
4	2	3	5	7	10
5	3	5	7	10	12
6	5	7	10	12	15
7	7	10	12	15	20

1．这张表格反映的是在孩子入睡前或半夜醒来后想要离开卧室的时候家长应该实行的关门时间长度。

2．即使孩子在关门后很快就上床了，家长也要按照表中所列的时间关门。

3．到了开门的时间，家长可以跟孩子间断地说几句话，给他一些鼓励，然后离开。如果孩子再次跑出卧室，家长要及时将他抱回去，然后按照表 10—1 给出的时间再次关门。

4．一旦达到了当夜最大关门时间值，家长应该以最大值为标准，继续一次次地关门，直到孩子乖乖到床上睡觉为止。

5．孩子半夜醒来后偷溜出房间，家长可以从表 10—1 给出的最小值开始执行，直到达到最大值为止。

6．孩子每次夜间醒来偷溜出房间都可以根据表 10—1 给出的时间来关门，直到早晨

五六点为止。如果孩子在这个时间点醒来，家长就不需要再让孩子睡了，可以直接让孩子准备起床。

7．如果孩子醒来后躺在床上大哭大闹而不肯起床，家长可以参考表3—1给出的循序渐进法加以解决。

8．家长在矫正过程中要认真细致，每天都要记录孩子的睡眠情况，可以使用图3—1给出的登记表，以便更好地掌握孩子矫正的进度。

9．记住，关门的目的不是制造恐惧感或者惩罚孩子。为了让孩子安心，家长可以隔着门对孩子说说话，千万不要忽然提高音量，也不要威胁恐吓孩子。让孩子明白，除非他乖乖待在床上，否则关门是不可避免的。

10．为了确保矫正取得效果，孩子一溜出房间，家长就要将他抱回去。家长可以在自己卧室门口装个铃铛或放几个易拉罐，也可以在门口放把椅子，或者在孩子的必经之路上设置一道栅栏，使其发出的声音唤醒家长。

11．通常到了第3天或第4天，孩子的情况就会有所改善，如果到了第7天仍毫无进展，那么家长可以在接下来的矫正中适当延长关门的时间。

12．白天小睡时也可以用这个方法。

13．开始几天会比较困难，家长可以让孩子比平常就寝时间晚一点入睡。只要家长明确自己的职责，并持之以恒，情况就能很快得到改善。

孩子和家长一起睡怎么办

当孩子与家长一起睡时，就无法使用前文介绍的关门法了，家长可以另辟蹊径，对孩子的行为设定限制。例如，孩子要是总是延长看电视的时间，家长可以拔掉电视插头，或者干脆将电视机挪到卧室外面去。要是孩子晚上会偷偷溜出卧室，家长可以在门口设置栅栏，或者干脆锁上门。

要是孩子晚上频繁地骚扰家长，想要家长满足他的要求，家长可以从床上起来，坐到卧室内的椅子上去，每一次起来后到再次睡到床上的时间间隔可以逐渐延长。要是孩子跟着家长一起坐到椅子上，或者家长觉得自己无法做到和孩子同处一室却不满足他的要求，那家长可以在孩子提出无理要求时离开卧室，离开的时间也可以参考表3—1。在离开房间时，家长要确保门口的栅栏已被关上。

对单亲家庭来说，一旦家长离开卧室，孩子就处于无人监管的状态了；处于婴儿期的孩子，由于年龄实在太小，片刻也无法离开家长。在这两种情况下，家长可以先让孩子搬出卧室，在有人陪伴的前提下进行矫正，直到孩子改掉坏习惯，再让孩子搬回到家长的卧室里来。

| 巧用激励机制 |

对那些比较自律但是会出于习惯提出不合理要求的孩子，可以在矫正过程中引进激励机制，通过肯定孩子的某些正确行为来帮助矫正。对有些孩子，仅仅使用激励的方法就足够了；对另一些孩子，则可能需要限制与激励双管齐下，在孩子遵守限制之后给予某种奖励。

如果孩子已经三岁了，家长完全可以跟孩子进行沟通，一起协商着制定一套奖励方法。例如，家长问孩子是否愿意晚点起床，孩子肯定会非常乐意，然后家长就可以提出条件，要晚起床就必须一整夜都待在自己的房间内，不哭不闹，不提出无理要求。孩子答应后，家长可以问问孩子，是否需要家长在他入睡时守在门外或待在隔壁房间。

在孩子同意跟家长一起建立一个激励机制之后，家长可以跟孩子一起设计一张积分表，对不同的行为给予不同的积分，这能大大激发孩子的积极性。例如，乖乖待在自己卧室的床上，积 2 分；醒来后呼唤家长但是不离开卧室，积 1 分。对晚上的表现，可以分为 4 个档次：一整夜都独自度过，不呼唤父母，积 3 分；呼唤父母，但是不离开房间，积 2 分；有一次从房间里跑出来，积 1 分；跑出房间 2 次或 2 次以上，不积分。

如果问题出在就寝时，家长可以将奖励的重点放在就寝这一时间段。例如，乖乖入睡，积 3 分；呼唤父母一次，积 2 分；呼唤父母 2 次，积 1 分；呼唤父母 2 次以上，不积分。然后再设置 1~2 分的加分，如果夜里表现良好，就给予加分。

对三岁左右的孩子来说，积分本身就是一种激励。大一点的孩子则需要家长每周清算积分，然后根据得分多少给予实物奖励。学龄儿童也会接受实物奖励，奖品应该是价格不高的小东西，因为奖品本身就是一种象征，而不是家长对孩子的贿赂，而价格不高的小东西非常适合每周发一次。在设计奖励方法时，家长要记住一点，如果孩子需要等待很长时间才能获得奖励，他们就会对整个过程失去兴趣。（稍微大一点的孩子更愿意几周领一次奖品，将几个星期的积分攒起来，换一个价格更高的奖品。）

如果需要，家长可以在开始时放宽奖励条件，对一些“过得去”的行为也给予奖励，以此来调动孩子的积极性。不要设置过高的门槛，尽量不要把那些孩子办不到或很难办到的事设置成奖励的条件，一旦孩子意识到即使自己努力也很难甚至不可能得到奖励，他就会停止尝试。

要是仅仅采用激励机制无法根除孩子的坏习惯，家长可以加入一些限制，比如使用栅栏或门。一旦孩子开始接受激励机制，设定限制就会容易很多。他会把心思放在如何做得更好以获得积分、换取奖品上，一旦成功，就会产生自豪感，从而进入良性循环。如果激励机制运行良好，家长可以一直使用，直到孩子失去兴趣为止。一般来说，还没等孩子失去兴趣，矫正就已经完成了。当然也有极个别的情况刚好相反，此时家长就需要回到设定限制这条老路上来了。

| 延迟就寝时间 |

矫正应该在孩子犯困并准备入睡时进行，如果孩子在上床时根本不困，那就失去了矫正的意义。记住，孩子在入睡之前的那段时间是非常清醒的，如果他在入睡前总是从房间里跑出来，说自己不困，那很有可能他是真的不困。此时，即使家长陪着他睡，他也睡不着，非要等上一个小时才肯睡。

无论家长是消极地设定限制还是积极地进行激励，都要记住一点，不要让孩子比平时早睡。一般来说，最理想的入睡时间应该比平常延迟 30 分钟到一小时，就算延迟之后入睡时间接近晚上 10 点或 12 点也不要紧。如果孩子每晚入睡的时间都不固定，那家长最好从最晚的那个入睡时间入手。除非孩子早晨起床太晚或午睡时间太长，否则，在矫正过程中，最好不要改变原有的作息时间。

这样做的目的就是确保孩子在就寝时处于昏昏欲睡的状态，从而减少反弹，降低矫正难度。一旦孩子进入固有的睡眠阶段（从第一次昏昏欲睡开始到第二天清晨清醒为止），他就会越来越困，越来越没有抵抗力。延迟就寝时间是父母矫正孩子睡眠问题的“利器”，家长应该善用之。但是，如果在矫正阶段，家长发现需要在早晨反复唤醒孩子，这其实是孩子没有睡够的表现，此时家长就应该适当提前入睡时间了。

有些父母发现，只要延迟入睡时间，孩子入睡就会变得非常容易。如果真是这样，那家长可以放心，孩子的夜间睡眠问题也会因为延迟入睡时间而迎刃而解的。孩子

在半夜醒来后，总是会重复入睡时的状态。如果孩子在就寝时迟迟不肯入睡，总是走出自己的房间，那几乎可以肯定，他在半夜醒来后也会这样做。但是，如果孩子入睡非常顺利，那他在半夜醒来后也会乖乖再次入睡。

即使在延迟入睡时间之后，睡眠问题依旧存在，那延迟入睡时间也能使睡眠问题得到一定程度的缓解：孩子会觉得在非常困的时候比较容易完成激励机制规定的那些事，他的反弹也会因此而缓和，持续时间也不会太长。

允许孩子晚一点入睡并不意味着允许孩子做一些不合理的事。在适当的时间，家长应该果断关掉电视与电脑，根据孩子的年龄选择是陪孩子一起玩、给他讲故事还是和他聊聊天。一旦孩子习惯了新的睡眠模式，家长就可以着手调整孩子的作息了。

| 几个孩子合用一个房间时怎么办 |

如果需要矫正的孩子与他的兄弟姐妹合用一个房间，那在房间门口设置栅栏或门就有点困难了。要是另一个孩子年纪比较大，他就能在必要时自己打开房门（比如去房间外面上厕所）。可要是孩子还比较小，没办法自己开门，家长就可以告诉他在需要走出房间时呼唤家长，家长会帮助他开门出去上厕所或帮他穿衣起床。这样的方法可以一直沿用，直到需要矫正的孩子完成矫正为止。

如果进行矫正的孩子为了抵制矫正而故意大吵大闹，吵醒他的兄弟姐妹，家长应该多关注被吵醒的那个孩子，可以适当安抚他，直到“噪音”消失为止。必要时可以让孩子们分开睡，直到被矫正的孩子不再那么激烈地抵制为止。如此一来，制造噪音的孩子就会明白，正是由于他大吵大闹，家长才让他独自一人待在房间里，这会反过来促使他停止抵抗，逐渐适应新的睡眠习惯。在矫正时，千万不要因为顾及其他孩子而放弃，否则只会向孩子传达一个错误的信息，让他以为大哭大闹是有用的。

有时，兄弟姐妹的存在会削弱矫正的效果。例如，姐姐可能会自作主张帮矫正中的弟弟打开门，让他睡到自己床上，或干脆睡到弟弟床上去。如果出现类似情况，家长应该坚决制止。可以好好跟孩子谈谈，让他明白正在进行的矫正是为了他的兄弟姐妹好，告诉他矫正的原因与过程，最后告诉孩子，他能提供给兄弟姐妹的最大帮助就是不要干预矫正过程。一般来说，交谈的效果会比较明显。但是，如果孩子继续干预，则可能意味着也需要对这个孩子设定某些限制。可以暂时将孩子们分到不同房间，让其中一个跟

父母一起睡，也可以一个家长看管一个孩子，花几天时间让孩子们适应新的睡眠习惯。

给孩子设定限制的实例分析

我们先来看伊莎贝拉的案例。

> 伊莎贝拉是一个5岁的小女孩，她没有什么大的睡眠障碍，小的睡眠问题却一直很多。她在晚上8点准时上床睡觉，入睡时总是很折腾。她每隔10分钟就会大声呼唤父母，等父母走进她的房间，她就会要求他们给她盖盖被子，吻吻她。对这些小要求，父母通常都予以满足。有时她会要求父母陪她一起睡，父母就会果断拒绝。如果父母没有及时回应她的呼唤，她就会自己从房间里跑出来，站在外面大声呼唤。如果此时父母还是没有反应，她就会直接跑去找父母。这整个过程会重复5次左右，直到她睡着，从她就寝开始到睡着大概需要一个小时的时间。
>
> 有些夜晚伊莎贝拉会表现得很沮丧，尤其是当父母对她的呼唤反应得不够及时的时候，她会延迟入睡时间，一直折腾到9点半或10点才肯入睡。当她半夜醒来，她又会大声呼唤父母，然后对赶来的父母提出一些小要求，拍拍她、吻吻她之类的。如果父母睡得太熟，没有听到她的呼唤，她就会悄悄地走到他们的卧室，站在父母床前，直到父母中有一人醒来发现为止。如此重复三次左右，父母筋疲力尽了，伊莎贝拉才肯好好睡觉。

鉴于大多数情况下，伊莎贝拉都是在9点入睡的，我们可以推断出父母设定的8点就寝对她来说太早了。因为伊莎贝拉早晨总是在7点之后才起床，所以如果晚上9点入睡的话，她的睡眠时间也已经达到了10小时。就寝时间过早引发了伊莎贝拉频繁呼唤父母的行为，时间一长，这种行为就变成了习惯，在就寝及半夜醒来时都会反复发作。

我给伊莎贝拉一家开出的“药方”非常简单：将伊莎贝拉的就寝时间延迟到9点。然后我帮伊莎贝拉一家设计了一张表格，用来记录她的睡眠情况，从实行的第一晚开始，伊莎贝拉就表现得非常好。当我再次见到她时，她兴高采烈地要把那张表格上的良好记录展示给我看。伊莎贝拉已经不需要更大强度的矫正了。

迈克尔是一个两岁半的小男孩，他在晚上8点半入睡，他表现得对这个入睡时间非常适应。4个月前，他的父母将他从婴儿床挪到小床上去睡，从那时起，他就养成了让人非常头疼的睡眠习惯。

通常，妈妈会在睡前给他讲一个故事，可是迈克尔总是希望故事越多越好，他不想让妈妈离开自己的房间。一旦妈妈试图离开，他就会从床上跳起来，跟着她一起走出房间。无奈之下，妈妈只好每晚都坐在他床上给他讲故事，直到他睡着为止。要是迈克尔迟迟不肯入睡，讲故事就变成了一件苦差事。有时妈妈以为他已经睡着了，就停下来准备离开，迈克尔就会马上睁开眼睛，大叫着“再讲一个”。

通常，妈妈在努力了45分钟之后就会不顾迈克尔的反对离开房间。迈克尔会躺在床上大声地叫妈妈，然后爬起来，走出房间去找她。有时妈妈会妥协，有时她就干脆让他站在一边，等她手里的活做完后再陪他回房间。有时讲故事讲得实在太晚了，妈妈就会跟迈克尔一起睡在小床上。要是妈妈比他先入睡，迈克尔就会摇醒她，要她再讲一个故事或者给他挠挠背，这两种方法都能让他知道妈妈就在身边，从而安然入睡。夜里醒来后，他也会大声呼唤，妈妈很快就会赶来，跟他躺在一起，陪着他，给他挠背，安抚他入睡。这一待就会待到第二天早晨。

迈克尔的问题就是典型的混合型问题，是睡眠环境问题与缺乏限制问题的综合体，同时也存在作息不合理的可能性。要彻底矫正迈克尔的行为需要坚持不懈地对他的行为设定限制，我建议他的家长将他的就寝时间延迟到9点半，以更符合他的真实入睡时间，然后将他的起床时间提前到7点。矫正开始前，在他的卧室门口装一道栅栏，然后建立固定的睡前相处模式，在睡前相处时，栅栏始终保持关着的状态。他妈妈仍旧会给他讲一个故事，但是选的故事更加简短，并且讲完后就离开房间，随手将栅栏关上。

一开始，迈克尔会大声呼唤，也会跑到栅栏边去张望。他妈妈则按照表3—1给出的方法回应他。矫正开始后的第一个晚上，迈克尔睡在了地板上，他妈妈后来进去把他抱到了小床上。到了第三个晚上，迈克尔就不再大声呼唤了，而是独自安睡了一整晚。一周后，我们将他的就寝时间调整到了9点，到了第三周，我们就恢复他原来的就寝时间，让他在8点半入睡。

第11章 作息规律与生理节律

大多数情况下，婴幼儿睡眠问题主要集中在入睡时间、觉醒形态及日常作息三个方面，在现实生活中，这些问题表现为作息非常不规律、作息规律却不恰当或入睡时间有问题。如果孩子白天行为不规律，那么夜间睡眠也有可能是混乱的。例如，白天小睡或进食时间不恰当，会导致孩子早晨过早醒来，或者夜间迟迟不肯睡去。孩子长期在不恰当的时间入睡，就会养成习惯。

很多睡眠问题可以通过调整潜在的睡眠规律来进行矫正。我在做日常咨询的时候，通常会问家长几个问题：孩子什么时候上床、什么时候真正入睡、什么时候醒来以及白天睡眠情况如何。同时我也会向家长了解孩子夜间醒来的次数与持续时间、早晨是自己醒来还是需要家长唤醒、周末或节假日作息规律是否发生变化、不同的家长照顾时是否会出现不同的作息规律、改变入睡环境后作息规律是否发生了变化等等。了解这些情况是进一步诊断的基础，因为它们可以直接反映出人体的日夜节律。

对人来说，不借助药物来校准生物钟的方法只有一个——借助光。光线进入眼睛之后，会刺激视网膜，这一刺激通过神经系统传递给脑丘下部的细胞，从而发出校准的指令。如果生物钟当下的设定与外界环境通过刺激给予人体的标准值不符，生物钟就会自行开始校准。这就是为什么人体能适应所在地的时间、能在跨越时区后及时进行调整的原因。光线对人体的作用在不同的情况下会有所差异：正午时分，光线对人体的影响不大，日落后与清晨的光线对人体的影响要大得多，这些时刻出现的光线会让人以为白天

变长，从而引发生物钟进行校准。

户外活动、进食、小睡等行为只能通过改变人体接触光线的时间长短来间接影响人体的生物钟设定。如果你比平日晚睡一点，或者比平时早起很多，那么接触光线的时间就比平时要多。同样，在夜间进食也就不可避免地增加了接触光线的时间。

除生物钟因素外，良好、规律、合理的作息得益于平时的习惯养成。例如，我们都会在固定的饭点出现饥饿感，如果人为地将进食时间延迟，久而久之，到了平时进食的时间我们就不会感觉饥饿，到了新的饭点才会出现饥饿感。睡眠也是一样，可以人为改变入睡或起床时间，甚至可以改变白天小睡与夜间睡眠的关系。

时差综合征是生物钟混乱的另一种表现。当人体穿过时区进入新时间系统里时，生物钟还停留在原来的时间系统里。如果坚持执行新的时间系统，终有一天生物钟会校准到与新时间系统一致，但是此时人体的行为却不如过去那样规律了。有些人的工作是轮班制，常常需要在还清醒的时候就强迫自己入睡，在昏昏欲睡的时候强迫自己清醒，这样就会产生类似时差综合征的后遗症。如果长期从事这样的工作，人体的睡眠规律就会完全被打破，其后果就是在家时永远睡不着，而工作时又永远睡不醒。

日夜节律与睡眠禁区

如果整晚不睡，人在夜间的清醒程度变化可以用一个 U 形来表示：从越来越困到昏昏欲睡，再逐渐清醒，直到早晨完全清醒。正常的睡眠阶段与此稍有不同：在浅眠阶段会出现一个觉醒程度的高峰值，半夜觉醒程度会大大降低（见图 11—1）。这就解释了为什么人容易在凌晨 3 点左右而不是入睡后一小时或觉醒前一小时起来上厕所。

白天的情况与此类似。人在白天的清醒程度变化并不能简单地用 U 形来表示，也不是从早到晚直线下降，而是呈现出与夜间相反的特征，在中午前后会出现一个低谷值，对应于夜间出现的高峰值：在起床后人会进入觉醒状态，随着时间的推移，会慢慢觉得倦怠，到了下午 3 点左右，则会经历一个低谷值。那些有午睡习惯的孩子通常都在这个时间点进行午睡，如果不睡就会感觉崩溃。成年人也可以在这个时候睡上一小时。即使那些没有午睡习惯的人也会发现，过了这个时间点，人会比较清醒。如果总是熬夜到很晚，这个清醒程度的低谷值会延迟到晚饭后才出现。

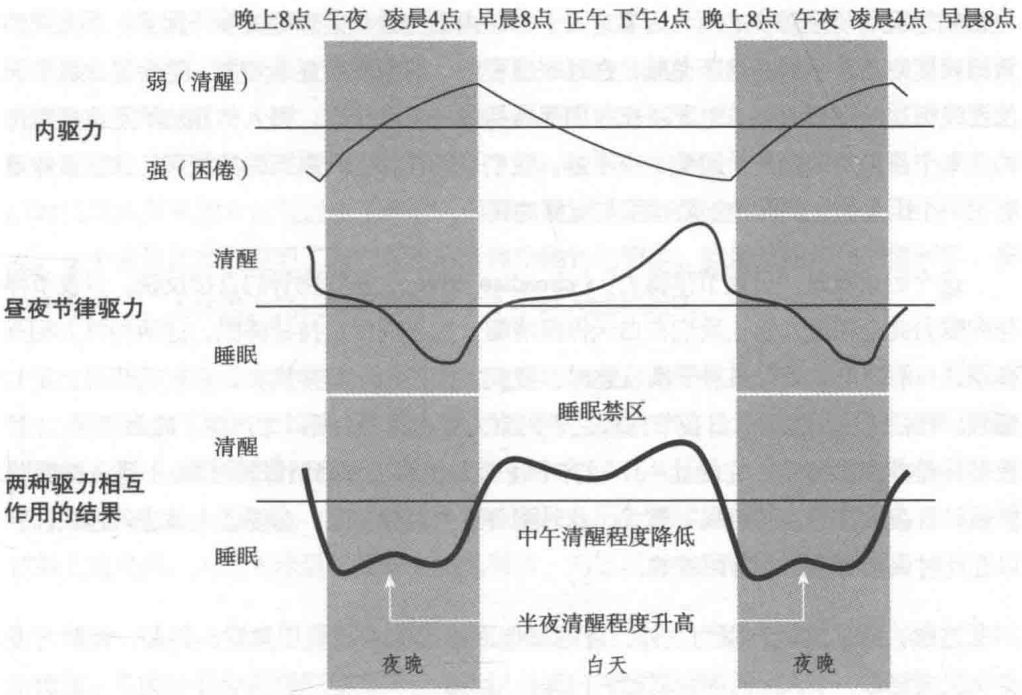


图 11—1　一昼夜出现的睡眠与清醒状态转换——两种驱力的作用

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

入睡前几小时的夜晚时间是睡眠禁区，在这个时间段，要想入睡是非常困难的。在这个时间段里，人会异常清醒，异常警觉，注意力非常集中。睡眠禁区对研究与矫正儿童睡眠问题至关重要。

其实每个家长都见识过孩子在睡眠禁区的表现，只是在那些当下他们没有意识到那些表现所代表的含义。有些家长会很奇怪，明明孩子在下午或晚饭前后表现得非常想睡觉，但是等家长做好让他们上床就寝的准备时，他们却又无缘无故地变得异常清醒了。这就是睡眠禁区在作怪：一天之中，最长的觉醒期出现在白天终了之时而不是早晨起床后，也就是说，这个觉醒期出现在睡眠期之前，而不是睡眠期之后。这就是为什么有的孩子明明昏昏欲睡了，却又突然精神百倍的原因。甚至对那些每天需要进行三次小睡的婴儿来说，傍晚的那次小睡也是其中最短暂的，并且是最容易被彻底戒除的。

这是为什么呢？究其根源，可以归结到所谓的“内驱力”（homeostatic drive），这

是影响睡眠与阶段转换的两大因素之一。如果内驱力是决定睡眠的唯一因素，那人类的清醒程度应该从早到晚逐渐递减，在睡眠过程中，清醒程度逐渐增加。这会导致我们无法在晚饭前后保持清醒，也无法在夜间保持持续的睡眠状态。而人体显然不是这样运作的，举个最简单的例子，即使一夜不睡，我们也能在第二天白天保持清醒，这就意味着有另一个因素也在同时控制着睡眠与觉醒的转换。

这个因素就是“日夜节律驱力”（circadian drive），是生物钟的直接反映。日夜节律与内驱力完全相反，它让我们在白天保持清醒，在夜间保持持续睡眠。这两种驱力相互作用，只有当它们处于某种平衡状态时，我们才能在白天精神奕奕，在夜间获得充足的睡眠。在白天快结束时，日夜节律较之于内驱力更占优势，所以才产生了睡眠禁区。（日夜节律是非常强势的，它能让一个通宵不睡的人在第二天仍旧保持清醒。）进入睡眠阶段后，日夜节律进入“睡眠”模式，此时两种驱力目标一致，都要让人体进入睡眠，所以在此时保持清醒是非常困难的。

当然，除了这两种驱力之外，还有其他因素影响着睡眠与觉醒。例如，年龄与发育状况决定着一个人所需的睡眠时间与保持清醒的时间。总是熬夜会让你欠下一屁股的“睡眠债”，从而导致内驱力增强，在白天感觉困倦。睡午觉则刚刚相反，会让人在晚上睡不着。

服用药物也会影响睡眠，镇静剂或感冒药会让人昏昏欲睡，咖啡因或其他刺激类药物会让人睡不着。疾病也会产生类似的影响：发烧会让人困倦，而疼痛则会让人保持清醒。心理因素与认知因素也影响着睡眠：抑郁有时会让人想睡觉，这点儿童表现得更明显，而焦虑会让人难以入睡。

设定生物钟：确定自身的时间系统

我们在前文提到过光线与生物钟的关系，光线能通过生物钟设定和调整睡眠阶段。在入睡时，如果处于明亮的环境中会延迟睡眠阶段，从而导致入睡迟，起床也迟。而在清晨如果人体处于明亮的环境当中，就会产生截然相反的作用，明亮的光线会让人提前醒来，从而提前夜晚的入睡时间。

例如，假设某人的睡眠时间从晚上 9 点一直持续到第二天早晨 6 点，如果让这个人

每天晚上从 9 点开始对着一排非常刺眼的灯管坐到半夜，然后上床睡觉，睡觉时戴上一个眼罩，直到第二天上午 9 点再起床，摘下眼罩。按照这个方法，这个人每晚暴露在灯光中的时间增加了 3 小时，第二天早晨处于黑暗中的时间也增加了 3 小时。坚持几天之后会发现，这个人的睡眠阶段整体延迟了 3 小时左右。如果继续坚持下去，这个人的入睡时间就从原来的 9 点延迟到了半夜，早晨自然醒来的时间也由原来的 6 点延迟到了 9 点。这个例子其实就说明了跨时区之后人体生物钟的调整，就像从纽约飞到洛杉矶，横跨 3 个时区，人体因为光线的原因延迟了 3 小时入睡和起床。

实际上，人体的生物钟每天都在做出这样的调整，只是这些调整非常细微。我们在前文中提到过，人体的生物钟通常比 24 小时的周期慢一点，如果放任其自然发挥作用，生物钟运行一个周期的时间就是 24 小时又 10 分钟。在实际生活中，人的生物钟更接近于以 25 小时为一个周期，究其原因，主要是因为社会发展，人类在日落后越来越多地依赖人造光源。人造光源虽然没有太阳光强烈，却足以对生物钟产生影响。

同时，人类不再像祖先那样睡在室外，而是睡在室内，导致早晨光线无法及时影响人体的生物钟。这就导致了这样一种趋势：无形中我们都趋向于比前一天晚睡一小时，迟起床一小时。这在假期或周末就表现得很明显，我们都会偏向于比工作日晚睡晚起，到了假日最后一天的晚上或周日晚上，我们就会觉得很难像工作日那样按时入睡，而接下来的周一或工作日早晨又很难按时起床。

为什么我们不放任以 25 小时为周期的生物钟自然发挥作用，每天改变我们的作息呢？因为现代的生活模式让我们不得不每天准时起床，等到起床后接触到光线，我们的生物钟就被人为提前了，这种提前刚好可以阻挡每天改变的趋势。正是如此，我们的作息才有规律可循。但是，一旦我们可以随心所欲地决定入睡时间，或者身处假期和周末，我们的生物钟就会发挥作用，让我们的作息时间每天延迟一小时，这种动态的延迟是导致某些睡眠问题的根源。

个人差异：你是云雀还是猫头鹰

任何关于作息的讨论都不可能忽视个人差异这一重要因素。就拿睡眠禁区来说，它对有些人的影响非常强烈，对有些人则影响甚微。个人差异取决于个人对白天与黑夜的偏向，由此可以将人分为两类：云雀型和猫头鹰型。

猫头鹰型的人在夜晚精力特别旺盛，他们喜欢熬夜，夜晚是他们一天中最愉快的时间段。在夜里，猫头鹰型的人会特别警觉，思维运转得更快，学习起来更有效率，甚至玩起来也会更过瘾。熬夜对他们来说是家常便饭，但是早晨对他们来说就有点难熬了，一夜不睡之后要让他们再保持清醒是很痛苦也很困难的，就像让他们从一个深不见底的黑洞里慢慢往上爬一样。所以猫头鹰型的人很讨厌早起，他们会尽可能地避免在早晨工作和学习。猫头鹰型的人很容易将整个睡眠阶段延迟。

云雀型的人不擅长熬夜，一旦夜幕降临，他们就会感觉自己正慢慢滑入一个无底的黑洞，所以云雀型的人不喜欢夜生活，即使要在夜间活动，也会将时间尽量提前。到了早晨，他们能毫不费力地起床，心情舒畅，精力充沛，干劲十足。对云雀型的人来说，早晨是一天中最愉快的时间段，而晚饭后睡觉前的时间则是比较难熬的。与猫头鹰型的人相反，云雀型的人很容易将整个睡眠阶段提前。

这个分类只是一个大概划分，大多数人都不是绝对属于哪一个类型的，但是每个人都会有一个相对的倾向，只是有些人的倾向较之于其他人更强烈而已。尽管这种倾向是一个人的内在倾向，不会轻易随着时间的推移而更改，也不能轻易被教化，但是如果客观环境要求，猫头鹰型的人也能提前入睡，云雀型的人也能延迟就寝，当然这种变化会让人非常不舒服。

在现实生活中，云雀型的人和猫头鹰型的人会显示出生理上的差异，例如，在凌晨猫头鹰型的人会经历一个体温的最低点，这个最低点比云雀型的人要低很多。

即使是儿童，也有倾向差异，也可以分为猫头鹰型儿童和云雀型儿童。一个猫头鹰型的婴幼儿在晚上精力会特别旺盛，对周围发生的任何事都很感兴趣，很轻易就能熬夜不睡。这样的孩子如果没有一个合理的就寝时间，或者没有一个强有力的强制就寝措施，他的整个睡眠阶段就会延迟或者出现无规律的混乱。要在早晨叫醒这样一个孩子，简直是家长的噩梦。

而云雀型的宝宝则刚好相反，他会很早就寝，如果家长没有在就寝时间安顿好他，他会自己拿着小枕头或者小玩具爬到小床上去睡。一旦入睡，他就与周围环境彻底隔绝，无论发生什么事都没法引起他的兴趣。对这样的孩子来说，睡觉不是问题，问题是他每天会很早醒来。

社会化剥夺了我们的睡眠

在现代社会，我们长期处于睡眠被剥夺的状态，我们的睡眠阶段实际上被延迟了。从成年开始，到退休为止，极少数人能随心所欲地享受睡眠。扪心自问，有多少人是一觉睡到自然醒的？有多少人能不用闹钟自动醒来？如果不是非熬夜不可，有人会无缘无故硬撑着不睡吗？在假期或双休日，有多少人睡懒觉？

现代人被剥夺睡眠的原因是复杂多样的，处理起来也是千头万绪。首先，在日落后入睡前的这段时间，我们的周围充斥着无数人造光源。尽管早晨的太阳光能调整人的生物钟，但是这种调整也不是百分之百有效的。如果我们总是处于睡眠被剥夺的状态，晚上熬夜，早晨很早起来，太阳光导致的生物钟校准反而会加剧睡眠阶段的延迟。

其次，我们身处的这个花花世界日夜不停歇。以前那种夜深之后电视就只剩下测试信号的日子已经一去不复返了，现在的电视节目充斥着我们的生活，其目标受众不仅涵盖了成年人，也涵盖了青少年，这些节目从早到晚几乎不会出现空白。很多青少年宁可少睡一会儿，也要看完喜欢的电视节目。在我们的生活里，网络、电脑游戏、电话都可以 24 小时连轴转。而且，这种昼夜不停的生活模式已经蔓延到了生活的每个角落，已经出现了 24 小时营业的饭馆、电影院、酒吧和商场。

此外，对很多人来说，睡觉不是最优的选择，当他们有第二个选择时，睡觉永远是排在后面的那个。很多人错误地认为，剥夺睡眠时间来学习、工作、开车是无害的。可是，已经有无数的实验反复证明，缺乏睡眠对人体来说有弊无利。大家都明白酒驾的危险性，可是很少有人明白在缺乏睡眠的状态下开车所存在的危险性与酒驾差不多。

新闻里经常报道说有年轻人因为缺乏睡眠而在开车时出了车祸，丧了命。由缺乏睡眠引发的交通事故致死率远远高于其他因素引发的交通事故致死率。在美国，每年有超过 100 000 起交通事故和 1 500 起交通事故致人死亡案件是由司机缺乏睡眠引起的。绝大多数单一车辆的交通事故不是由酒驾引起的，而是由司机缺乏睡眠导致的。这些交通事故的司机有一半是十几岁的男孩或青年男子。而且，酒精可以增强缺乏睡眠引发的交通事故的破坏性。对一个 17 岁的司机来说，如果他前一天只睡了 5 小时，那只需要一罐啤酒就有可能让他出交通事故。

在美国，成年人是缺乏睡眠最严重的群体，他们的作息常常出现问题。除去文化因

素不予考虑，仅仅从客观上来看，成年人的睡眠比儿童要浅得多，其对人体的修复功能也要弱得多。因此，即使在最好的状态下，一个十几岁的青少年也比儿童容易犯困。而青少年一边由于缺乏睡眠而犯困，一边却常常熬夜不睡，他们甚至发明了“补眠法”，就是在上午或午后小睡一会儿或者在节假日睡懒觉。最后，有研究显示，成年人天生有一种潜在的延迟睡眠阶段的倾向：比起儿童，成年人睡得更晚也起得更晚。

总而言之，在工作日，成年人总是睡得晚起得早，睡眠被剥夺得非常严重。到了周末，他们会延迟就寝时间，第二天睡到很晚，以此来弥补被剥夺的睡眠。这就导致了睡眠阶段的延迟，到了第二个礼拜，他们就会比上一个礼拜睡得更晚，早晨更起不来，睡眠时间也就被剥夺得更加厉害。到了周末，他们又会比上一个周末睡得更迟，起得更迟，如此恶性循环，工作日与周末的作息就会越来越不协调。有些青少年会在上学时熬到凌晨 1 点才睡，第二天一早仍旧 6 点起床去上学，睡眠时间只有 5 小时。到了周末，他们会从凌晨两三点开始一直睡到下午，睡 10~14 小时。这样一来，周末所获得的睡眠时间往往是工作日单日的几倍之多。

如果一个学生的自然醒时间是中午，那他只有在周末才能睡到自然醒，在周一到周五，他都处于睡眠严重不足状态，在他上课时，身体机能都处于睡眠状态。他的注意力会无法集中，学习能力、思维能力与接收知识的能力都会大大削弱。在美国，学生们早晨 6 点起床，晚上却没有提前入睡，这导致他们的睡眠严重不足。要解决这个问题，最乐观的方法就是学校延迟上课时间。也有很多研究结果支持这一方法，认为这对孩子来说是有利无弊的。但是，尽管延迟上课时间是个好办法，但是这也只能解决部分问题，而无法解决根本性的问题。

造成睡眠不足的原因非常复杂，没有哪种方法能一劳永逸地解决这个问题。我觉得我们要从教育入手，让人们深刻认识到睡眠的重要性，适当调整自己的作息。对青少年来说，一丝不苟地遵循某个作息规律是很困难的，但是，起码家长应该帮助其建立规律的作息，让他认识到缺乏睡眠可能造成的伤害，只有这样才能将问题最小化。

不同的睡眠问题影响不同的睡眠阶段

我们所谓的睡眠规律问题有两层含义：第一层含义是指某种具体的症状，比如早晨早醒；第二层含义是指某种潜在的生理问题，比如睡眠阶段的动态转变。各种睡眠规律

问题背后的共同原因如下。

入睡困难：

- 睡眠环境不对（详见第 3 章）；
- 缺乏限制（详见第 10 章）；
- 焦虑（详见第 5 章）；
- 腹绞痛（详见第 6 章）；
- 睡眠阶段延迟（详见第 7 章）；
- 待在床上的时间过长（详见第 8 章）；
- 必需睡眠时间过短（详见第 8 章）；
- 午睡时间太迟（详见第 12 章）；
- 白天睡太多，晚上睡不着（详见第 8、12 章）；
- 睡眠不规律（详见第 8 章）；
- 噪音太多、干扰太多（详见第 8 章）；
- 晚上看电视，导致孩子宁愿牺牲睡眠时间（详见第 10、11 章）。

夜间频繁醒来：

- 睡眠环境不对（详见第 3 章）；
- 夜间频繁哺乳（详见第 4 章）；
- 设定限制出现问题（详见第 10 章）；
- 焦虑（详见第 5 章）；
- 乱吃药（详见第 6、17 章）；
- 夜惊、睡眠觉醒障碍、夜游、做噩梦、尿床（详见第 13、14、15 章）；
- 待在床上的时间过长（详见第 8 章）；
- 必需睡眠时间过短（详见第 8 章）；
- 白天睡太多，晚上睡不着（详见第 8、12 章）；
- 睡眠不规律（详见第 8 章）；

- 噪音太多、干扰太多（详见第 8 章）；
- 晚上看电视（详见第 10、11 章）。

早晨早醒：

- 睡眠阶段提前（详见第 7 章）；
- 待在床上的时间过长（详见第 8 章）；
- 晚饭吃太早，导致早晨很早就饿了（详见第 4、7 章）；
- 上午安排小睡（详见第 7、12 章）；
- 白天睡太多，晚上睡不着（详见第 8、12 章）；
- 睡眠不规律（详见第 8 章）；
- 必需睡眠时间过短（详见第 11 章）；
- 早晨噪音比较大、干扰比较多、光线比较强（详见第 8 章）；
- 早晨起来看电视，导致孩子宁愿牺牲睡眠（详见第 8 章）。

不想午睡：

- 晚上睡太多（详见第 12 章）；
- 必需睡眠时间过短（详见第 8 章）；
- 午睡或白天小睡安排得过多（详见第 12 章）；
- 午睡断断续续持续很长时间（详见第 12 章）；
- 被噪音或外来刺激吵醒（详见第 12 章）；
- 睡眠环境不对（详见第 3 章）。

几乎所有的孩子都需要日间睡眠。当人们说自己的孩子“从来不在白天睡觉时”，其实是指他们家的宝宝日间小睡时入睡困难、持续时间很短或者没有规律，也有可能是他们家宝宝日间小睡的姿势或状态与普通孩子不一样，仅此而已。正常的婴幼儿不可能真的像家长讲的那样“从来不在白天睡觉”，只是有些孩子睡眠持续时间很短很不连贯，给了家长这样的错觉。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

新生儿的睡眠与觉醒以 24 小时为周期不规则地分布。到了三四个月，睡眠就变得越来越有规律，绝大多数睡眠发生在夜间，白天则会出现规律的几次小睡。一周岁之后，绝大多数婴幼儿会将日间小睡减少到每天一次。

一般来说，减少日间小睡的次数并不是单纯地将其中某次小睡戒除，而是彻底改变整个日间睡眠习惯。例如，原本在上午 10 点与下午两点分别进行一次日间小睡，在减少之后，很有可能将日间小睡调整到午饭之后。即使减少了一次小睡，整个睡眠时间可能并未因此减少，孩子可能通过延长仅剩的那次小睡来弥补次数上的减少，也有可能通过延长夜间睡眠来弥补日间睡眠的不足。仅剩那次日间小睡也会随着时间的推移而最终消失。绝大多数孩子在 3~4 岁时会完全戒掉日间睡眠，但是也有的孩子会在两岁前后就完全戒掉，还有的孩子直到去上幼儿园都还保持着日间小睡的习惯。

每个孩子的日间小睡习惯与趋向都截然不同。有的孩子喜欢日间小睡，会非常积极主动地进入睡眠状态，也有的孩子不喜欢安安静静地小睡，而宁愿将时间花在嬉戏打闹上。有的孩子漏掉一两次日间小睡问题不大，不会影响他的情绪或日常行为表现；但是有的孩子一旦漏掉一次日间小睡，接下来的一整天都会表现得不正常，他们在夜间会提前上床睡觉，如果日间小睡延迟了，就会影响他们的夜间入睡时间。还有极少数的孩子对日间小睡非常敏感，一旦日间小睡出现问题，他们的整个作息就会被打乱。

同样，每个孩子对日间小睡的环境与地点的接受程度也不一样。有的孩子适应性特别好，既可以在婴儿床里睡，也可以在床上睡，还能在车上或家长的背上睡。相反，有的孩子对睡眠地点与环境非常挑剔，只有在特定的条件下才能入睡。例如，有的孩子经常在车上小睡，换个地方他可能就睡不着了。

在日间睡眠阶段发生的睡眠问题比夜间出现的睡眠问题更棘手，因为在夜间，随着时间的推移，孩子会变得越来越困，最终即使家长不干预，孩子也能进入睡眠状态。然而，在白天，睡意在袭来后，并不会越来越浓，经过一定的时间，就会慢慢消减，直至完全清醒。孩子在白天打盹时，人体的日夜节律系统就会唤醒他，然后进入“睡眠禁区”，从而让人体保持完全清醒。

日间睡眠的长度及时间点

很多日间睡眠问题背后的原因都集中在作息安排及睡眠长度上，在面对问题时，千万不要孤立地看待日间睡眠，而要将其看作整个睡眠的一部分，要看到小睡之间、日间睡眠与夜间睡眠之间相互作用、相互影响的内在联系。其实，孩子们对睡眠阶段的调整具备一定的适应能力，在不改变睡眠总量的前提下，家长可以根据实际需要合理调整睡眠发生的时间与持续的长度。

“隐藏的”日间睡眠

婴幼儿的睡眠会以 24 小时为周期分为几个长短不一的部分，每个孩子对睡眠时间的划分是非常不同的，甚至有些孩子夜间睡眠与日间睡眠的界限非常模糊。如何划分各个睡眠阶段，关系到矫正方案的制定，也关系到矫正的具体方法。我们来看一个例子。

一个5个月大的小男孩每天晚上6点准时入睡，早晨7点半起床，白天有两次日间小睡。对他这个年纪的孩子来说，每天两次日间睡眠似乎少了点，而晚上睡满13个半小时则有点太长了。而且他在晚上入睡后通常会在一个半小时后哭闹着醒来，父母需要花一个小时才能哄他再次入睡。整个晚上，他会再次醒来1~2次，每次都需要人哄才能再次入睡。到了早晨5点半，他会醒来一个小时左右，然后在6点半左右再次入睡，直到7点半完全醒来为止。在上午10点左右，他会有一次短暂的小睡，下午2点，他会午睡一会儿。

解决这个小男孩的睡眠问题可以有两种分析方法。

方法一：导致这个小男孩睡眠问题的原因是睡眠时间太长，他在夜间的13个半小时的睡眠时间并不是完整的，而是被多次醒来打断的，而13个半小时的睡眠无论对哪个孩子来说都太多了。

方法二：导致他睡眠问题的原因是日间小睡次数过多。如果我们将他的夜间睡眠看作是由几个部分组成的，那从8点半开始到5点半为止，除掉首尾两次长时间醒来的时间，他的整个夜间睡眠时间是9个小时，而他在两次长时间醒来后的小睡并不是夜间睡眠的一部分，而是独立于夜间睡眠的日间小睡，所以加上他在上午10点与下午2点的两次小睡，他的日间小睡一共有4次，即晚上6点至7点半、早晨6点半至7点半、上午10点、下午2点。按照这种分析方法，这个小男孩并不是夜间睡眠时间过长，而是小睡次数过多，由此导致夜间入睡困难和早醒。

方法二比方法一更简洁明了，也更容易着手处理。

因此，如果你家宝宝也像这个小男孩一样，在入睡后与醒来前有长时间醒来与再次入睡的情况，那么，这些被分离出来的睡眠时间可以被视为独立的日间睡眠时间，而不是夜间睡眠的一部分。要解决这类问题，可以对这两个日间睡眠时间进行调整，将入睡前的小睡稍微提前，或者将清晨那次小睡延后。

晚上或白天睡太多

通常白天不肯睡的孩子，夜间睡眠情况会非常好，可以睡满11个小时甚至更长时间。这种类型的孩子白天不肯睡觉，即使勉强睡着了，也会在半小时之内醒来。一般婴

幼儿的夜间睡眠时间维持在9个半小时左右，日间睡眠则维持在两小时左右，而这些每天不肯睡的孩子的夜间睡眠时间则要长得多，日间睡眠则被挤压到几乎没有。但是，由于这些孩子的夜间睡眠质量实在是太高了，所以即使白天一点都不睡，也不会感到困倦。

如果宝宝的睡眠问题仅仅是日间小睡时间太短，那家长完全不必担心。然而，要是因为缺乏日间睡眠而导致孩子日间行为异常，或者孩子过短的日间睡眠给家长带来了不便，抑或孩子对日间睡眠产生了抗拒，家长就要注意了。可以减少孩子的夜间睡眠时间。减少幅度维持在30分钟至一小时，最多减少两小时，确保睡眠时间总量维持在9小时以上。可以一次性削减，也可以循序渐进逐渐削减；可以延迟入睡时间，也可以提前起床时间，还可以双管齐下。记住，减少夜间睡眠的目的不在于减少睡眠总量，而在于将部分夜间睡眠挪到白天去。

要是孩子白天睡太多，家长就会开始担心是不是出了什么问题。家长通常会认为，孩子是因为晚上睡不好才在白天睡这么久，但事实刚好相反：**正是由于孩子在白天睡太多，才导致他在晚上睡不着。**有的家长跟我说，他们的婴儿晚上只睡六七个小时，白天却可以睡4~6个小时。我们来计算一下，即使这个孩子白天只睡4个小时，他的睡眠总量也达到了10或11个小时。要是他白天睡满6个小时，那他在晚上能睡满7个小时家长就应该偷笑了。

这样的作息显然是不合理的。一般来说，婴幼儿的日间睡眠时间没有这么长，一次通常不会超过两小时，绝大多数孩子的日间睡眠总量都不会超过3~4小时，尤其是在三四个月大的时候。

要解决这类问题，可以从减少日间睡眠时间着手。如果你家宝宝的日间睡眠次数跟他的年龄不相符，比如10个月大的宝宝每天还需要3次日间小睡，或者18个月大的宝宝还需要2次日间小睡，那么家长应该适当地帮助孩子减少日间小睡的次数，具体的方法可以参考本章后几节。如果你家宝宝的日间睡眠次数合理，但是睡眠时间过长，那么家长应该帮助孩子逐渐减少每次睡眠的持续时间，例如，每一天都比前一天减少15~30分钟，将原本4个小时的午睡减少到两小时左右。如果孩子的小睡超过两次，那可以用同样的方法逐渐减少每次小睡的持续时间，直到每次小睡都维持在两小时左右，甚至一个半小时左右为止。除了固定的时间外，不要让孩子在其他时间睡着，以便巩固新的睡眠习惯。

在矫正期间，家长应该减少或避免在白天带孩子出行。要是孩子在白天是由家长之外的人看管，家长要事先告诉看护人新的睡眠规则。

白天晚上都睡很少或白天晚上都睡很多

有些婴幼儿比一般孩子睡得少，他们只需要 8~9 小时的夜间睡眠，不需要日间睡眠进行补充。记住，这样的孩子是少数中的少数。如果你家宝宝确实属于这种极罕见的类型，那家长不需要削减孩子的夜间睡眠以延长日间睡眠时间，家长要做的就是接受孩子的现状。另一方面，如果孩子在暂停日间睡眠之后，白天行为异常、易怒或有其他不适，家长应该适当削减孩子的夜间睡眠时间，及时恢复日间睡眠，直到孩子完全不需要日间睡眠也能在白天保持行为举止得宜为止。

有的孩子晚上要睡 10~11 个小时，白天还要睡 3 个多小时，这种孩子的夜间睡眠已经非常充足，不需要再通过削减夜间睡眠来弥补日间睡眠了。这种孩子很有可能是天生如此。但是，如果过了出生后的头几个月之后，孩子还是需要过长的睡眠，每天的睡眠时间总量维持在 15 个小时左右，那家长就需要带孩子去看医生了。某些神经性问题或代谢障碍可能引发婴幼儿不正常的嗜睡，具体可以参考本书第 18 章相关内容。

记住，有些嗜睡的表象具有一定的欺骗性。即使孩子在卧室内安安静静地待了 11~13 个小时，也并不意味着他每分每秒都是睡着的。通常，这样的孩子会在夜里数次醒来，每次清醒一个小时左右，实际上他们的睡眠总量非常合理。当孩子的日间睡眠被削减，或者夜间待在床上的时间被缩短，夜间长时间醒来的问题就迎刃而解了。

日间睡眠短而多

过长的日间睡眠会导致夜间睡眠时间被挤压，然而，无论孩子日间睡眠总量是否适宜，日间睡眠问题还是会出现。即使每次日间小睡的时间很短，只要次数够多，就仍旧能影响夜间睡眠。

而且，如果孩子在白天睡太多，在几次小睡之间的清醒阶段就会受到影响：清醒时间过短导致接下来的日间小睡无法持久，而日间睡眠无法持久又会反过来导致清醒时间过短。最终，孩子的日间睡眠变得异常短暂、频繁、不连贯。我们来看两个案例。

案例一：一个20个月大的孩子，每天需要两次日间小睡，一次在早晨10点，另一次在下午2点，每次持续20~45分钟，每次小睡前都会有一个30分钟左右的哭闹。在午睡之后的6个小时内，他应该是完全保持清醒的，到了晚上睡觉时应该比较容易入睡。

案例二：一个30个月大的孩子每天要午睡一次，但是在白天要打盹数次，每次10分钟左右。

上述假设的两种情况，其实都是日间睡眠时间点与睡眠长度不适宜，可以通过减少日间睡眠次数、调整睡眠时间点、合理控制睡眠长度来加以解决。

在案例一中，早晨的那次小睡可以取消，下午那次小睡的时间可以适当提前1~2小时，到午饭之后。或者取消下午那次小睡，将上午的小睡逐渐延后，每天延后半小时，直到延后至午饭之后为止。无论采用哪种方法，两次小睡都被缩减到了一次，而持续时间也被大大延长了。调整后，这个孩子将会更容易入睡，睡眠质量也会大大提高。

在案例二中，可以保留每天一次的午睡，去掉那些打盹儿。而避免孩子总是打盹最简单的方法就是在一两周内不要让孩子坐车或玩得太疯。如果必须坐车，那就将车程安排在每次午睡之后，这样即使孩子打盹儿了，也可以视为午睡的延长。只要孩子不再频繁地打盹，他的入睡情况就会变好，睡眠质量也会提高。

| 白天睡太早或白天睡太迟 |

如果上午有一次小睡，可能会导致孩子早晨早醒，这种情况下的日间睡眠其实充当了夜间睡眠的最后一个环节，这个环节独立于其他睡眠环节，对起床与进食都会产生深刻的影响。即使上午的小睡时间适当延迟，而这次小睡是全天唯一一次日间睡眠，也有可能产生睡眠问题。因为在上午的小睡之后，一直到夜间就寝为止，孩子需要保持相当长时间的清醒状态而不打瞌睡，这对婴幼儿来说着实有点困难。

要解决这类问题其实非常简单，只要逐渐延迟上午小睡的时间即可。如果必要的话，还可以将孩子的早饭时间延迟，从而延迟孩子产生饥饿感的时间，以配合延迟之后的小睡时间。对一天小睡两次的孩子来说，可以将第一次小睡挪到10点之后；对一天小睡一次的孩子来说，可以将小睡挪到午后。

要是孩子每天在傍晚4~6点进行午睡，那他的就寝时间可能会延迟到晚上10~11点。在不改变午睡习惯的前提下，要想提前孩子的就寝时间，简直是不可能完成的任务。绝大多数家长都明白这个道理，所以他们都会选择提前午睡时间或缩短午睡持续的时间。如果家长希望大幅度提前午睡时间，从4点提前到1点或2点，那么最好循序渐进地提前。每次提前10~15分钟，直到符合预期为止，同时相应提前夜间入睡的时间。

过早取消日间睡眠与过度疲劳导致的睡眠问题

由于过多的日间小睡会导致孩子夜间入睡困难或过早醒来，家长可能会认为减少或者干脆取消日间睡眠就能解决问题，可事实上，情况远不是这么简单。单纯地让一个孩子感到困倦并不能提高他的睡眠质量。由缺乏睡眠而导致的孩子过度疲劳会导致其行为异常、情绪失控，他会变得过度活跃和易怒。在这种情况下，孩子会对睡眠产生抗拒，在应该睡觉的时候还硬撑着，他们在床上的时间反而很难放松。即使他们睡着了，也很容易醒来。相较于普通孩子，他们更容易产生夜惊与睡眠觉醒障碍。

> 加布里埃拉是一个两岁半的小女孩，每晚要折腾到10点才去睡。她的父母告诉我，以前她在傍晚时会睡几个小时，他们以为这就是导致她晚睡的原因，所以他们取消了她的这次小睡，以期将她的入睡时间提前到晚上8点。可是，新的问题又出现了。加布里埃拉在傍晚仍旧会犯困，父母要费尽心思地让她保持清醒。如果傍晚的时候她刚好坐在车上，那就肯定会睡着，而且一旦睡着就很难被叫醒。她的新作息很难贯彻执行。每天的晚餐时间都是加布里埃拉一家最难熬的时间，由于睡眠不足，加布里埃拉变得非常易怒。可是晚饭之后，到了她就寝的时间，她又变得非常有精神了，要让她在8点前睡觉简直是不可能的。

加布里埃拉的问题并不是睡得太多，而是睡眠不足：她所有的表现都可以归结为过度疲倦。她仍旧需要午睡，只不过午睡时间需要进行调整。我们恢复了她的午睡，将其调整为90分钟，然后逐渐提前她的午睡时间与夜间入睡时间。调整之后，她每天午睡一个半小时，晚上8点半上床睡觉。她的睡眠时间总量变得更合理了，睡眠时间点也变得更适宜了，由此她的易怒表现不见了，每晚入睡也变得非常容易。

从上述案例可以看出，过早取消孩子的日间小睡很有可能导致一系列睡眠问题。一般来说，等孩子自己感觉到困才打发他去睡觉，那肯定是太晚了，这会导致孩子白天行

为异常，也会导致他第二天早晨起不来。婴儿的就寝时间通常比他们产生睡意的时间要早。家长可以逐渐提前孩子的入睡时间。另外，睡前的亲子互动也很重要，愉悦的睡前时光会大大提高孩子的睡眠质量。

| 日间睡眠被打断 |

日间睡眠被打断的原因多种多样：哥哥姐姐放学归来，制造出噪音；孩子在保姆家里睡着了，然后被家长抱回家去；孩子在车上睡着了，车一停下来就醒了。

有些造成日间睡眠被打断的原因很容易避免。例如，哥哥姐姐放学归来后，可以在外面玩一会儿或在客厅看看电视，等弟弟妹妹睡醒了再开始活动。小睡可以适当提前，以防止被意外出现的因素打断，从而导致睡眠不足；也可以适当延迟，等可能打断睡眠的事项过去之后再开始小睡。或者，家长可以将孩子的夜间睡眠时间削减 30~60 分钟，这样他在白天小睡的意愿就更强烈了，轻微的响动不太会打断他的睡眠。

饥饿感也是打断睡眠的重要原因之一。在饭点前让孩子睡着是非常不明智的，因为他很快就会因为饥饿而醒来，应该在饭后安排孩子午睡。吃完饭之后的小睡通常比饭前的小睡持续时间更长。

| 日间睡眠的变化 |

如果孩子的日间睡眠缺乏规律，即使他的整个日常作息相对固定，其日间睡眠的开始时间与持续时间也会每日不同。家长可以用图 12—1 来记录孩子的日间睡眠情况，坚持几周后，就能大致掌握孩子日间睡眠的走向。

例如，通过记录家长可能会发现，原本在上午 10 点出现的小睡被慢慢地分成了两个部分，而这两个部分间的时间间隔逐日延长。最终，前一个部分可能提前到早晨，成为夜间睡眠的一个环节，从而导致孩子晚起。后一个部分则可能会延迟到午后，从而导致午睡提前，午睡持续时间延长。又如，家长可能会发现，夜间睡眠的最后一个环节逐渐脱离开来，发展成早晨的一次日间小睡；几天后，这个小睡逐渐延迟到午后，成为午睡的一部分；最终，这个小睡与夜间睡眠再次合并，成为夜间睡眠的起始环节，从而导致孩子就寝时间提前。也有可能在日间睡眠发生变化的前提下，孩子的入睡时间与起床时间变化甚微或根本不发生改变。

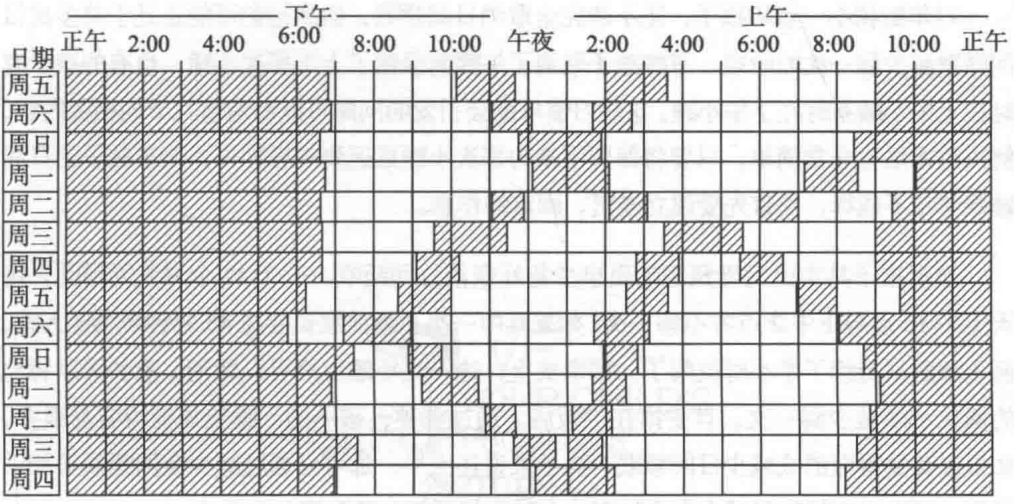


图 12—1　日间睡眠变化

尽管日间睡眠变化的原理非常复杂，但是要应对这类问题还是比较简单的：家长只要确保孩子的日间睡眠规律即可。**记住，人体生物钟只有在规律而可预期的前提下才能正常运作，若是放任生物钟自行运作，结果就会一团糟。**

取消日间睡眠的困难所在：过渡阶段产生的问题

三岁左右的幼儿处于逐渐取消日间睡眠的过程中，他们的日间睡眠变得不太规律，有几天会需要日间小睡，有几天则完全不需要。这种过渡过程本身不是问题，但是处于此过程中的幼儿可能会遇到一些继发性问题。即使是在不需要小睡的那几天，他也可能没有做好彻底取消日间睡眠的准备，他可能并没有完全将日间睡眠挪到夜间去。到了午后，他可能会显得行为异常。遇到适合小睡的环境，他还是会选择日间小睡，例如，在车后座上，或者在幼儿园里当其他孩子都安安静静地躺着的时候，他可能会迫于环境或同龄人的压力而乖乖入睡。而一旦他重新开始小睡，就寝时间就会延迟，要比他正常的入睡时间晚好几个小时。

通常，这样的过渡阶段会持续数周。一旦过渡阶段结束，经过数周的巩固之后，过渡阶段出现的那些睡眠问题就会迎刃而解了。调整之后，尽管到了平时小睡的时间，孩子还是会出现困倦的迹象，但是他已经不再需要靠睡眠来缓解了，相反，他会选择坐在沙发上看看电视来打发这一个小时。

对年龄稍小一点的孩子，还不能完全取消日间睡眠，但是他们可能正处于将多次日间睡眠减少到一次的阶段。有些孩子取消了午睡而保留了上午那次小睡，也有的孩子有时在上午小睡有时在下午小睡。这些习惯可能会引发的问题可以参考前几节的相关内容，解决的方法也非常简单，只要将保留下来的那次小睡延迟到午后即可，如果孩子的日间睡眠非常不规律，则首先要建立连贯、固定的作息。

很多孩子其实比父母预想的更早准备好取消日间睡眠。一个 11 个月大的婴儿，每天上午 10 点与下午 2 点各小睡一次，如果其中一次小睡前家长要花 45 分钟来哄他入睡，而入睡后只持续了半小时就醒了，那事实上，这一次小睡完全可以取消。家长可以将他的两次小睡减少到一次，且安排在午饭后。通过调整，孩子的入睡应该变得容易很多。如果家长觉得取消或减少日间睡眠对孩子来说还太早，那可以通过减少夜间睡眠来加以调整，可以将夜间睡眠减少半小时至一小时，将这部分睡眠挪到白天去。

孩子在家或在托儿所小睡

一般来说，孩子每周需要在托儿所里进行 3~5 次日间睡眠，剩下的日子则在家里进行。有的孩子在托儿所睡得好好的，回到家里就不肯睡了。当然，只有当孩子的行为因为缺乏日间睡眠而出现异常时，这才算得上是一个问题。

通常，这样的孩子都在三岁左右，处于完全取消日间睡眠的年龄段中。对这样的孩子来说，与其每天的日间睡眠时间不固定，不如完全将其取消。如果不允许他彻底取消日间睡眠，那就会出现上文介绍的过渡阶段睡眠问题的升级版，需要花费大量时间加以解决。我建议家长不要硬性规定孩子在家也必须像在托儿所一样进行日间小睡，而是用一段安静的独处时间来代替，在这段时间里孩子可以看书、听音乐、看电视或安安静静地玩。这样一来，孩子可以在比较放松的环境里做想做的事。由于不需要刻意抵制日间睡眠，有些时候即使大人不硬性规定，孩子困了也会主动去小睡一会儿。

有些孩子在晚上睡觉时会乖乖地去自己的房间，但是在白天小睡时却不喜欢睡在自己的卧室里。在这种情况下，只要孩子选择的睡觉地点是适宜的、合理的，比如在客厅里边听故事或边看电视边睡，而不是睡在引擎发动着的汽车里，那家长不妨满足他的要求。如果硬是要求他去自己的房间睡，可能会让孩子对卧室产生厌恶，从而影响夜间睡眠。总之，如果方法合理、适宜，家长不妨接受最为行之有效的那一个。

SOLVE
YOUR CHILD'S
SLEEP PROBLEMS

第四部分

非正常睡眠

第13章 非正常觉醒
——说梦话、梦游、觉醒障碍、夜惊

非正常觉醒通常发生在第一或第二个睡眠周期的末期，发生在入睡后1~4小时的区间里。导致非正常觉醒的原因通常是人体从非快速眼动期非正常醒来，绝大多数比较激烈、持久的症状发生在从第四阶段觉醒的过程中，而相对缓和的症状也有可能发生在从第二阶段醒来的过程里。对婴幼儿来说，第二阶段也属于睡眠程度较深的阶段。我们先来看几个案例。

玛希是一个4岁的小女孩，她每晚入睡后都会呻吟、喃喃自语，在床上翻来覆去两小时左右才会睡着。所幸醒来后她都能再次独自入睡。

丽莎是一个18个月大的小女孩，每晚入睡后不久，她都会哭着醒来，在床上翻来覆去睡不着。

克里斯托弗从6岁开始就出现了梦游的症状。他在梦游时非常安静、非常镇定，脸上毫无表情。到了8岁，他会突然从睡梦中醒来，坐在床上大声尖叫，似乎看到了什么可怕的东西。

大卫是一个17岁的小伙子，入睡后2~3小时他会突然从床上跳下来，惊慌地四处乱跑，程度非常激烈，常常不小心就伤到自己。

上述案例的表象各有不同。但是，从根本上来说，他们都具有同样的症结：出现症

状的时候都处于从睡眠到觉醒的过渡阶段，都经历了一个少梦的非快速眼动期睡眠阶段，无法从睡眠中彻底醒来。这种非正常觉醒的特征及意义会因个体的年龄、生理状况、行为习惯、心理素质不同而不同。

家长们在遇到这些现象时通常会将它们归结为做了噩梦。事实上，非正常觉醒不仅与做梦无关，也不同于孩子在完全清醒的状态下为了引起父母的注意而故意做出的行为。非正常觉醒的孩子根本不是处于完全觉醒状态，无法意识到自己当下的行为。有些家长在面对非正常觉醒的孩子时非常严格，但是对一个连自己的行为都无法意识到的孩子，设定再严格的限制也是毫无作用的。

综上所述，本章所涉及的症结与应对之道不同于其他睡眠问题，与个人习惯、睡眠环境、设定限制或克服恐惧无关。当然，也有部分非正常觉醒的原因与一般睡眠问题类似或者重合，在孩子完全清醒的状态下引发其睡眠问题的原因有可能与非正常觉醒状态下引发睡眠问题的原因相似。在应对这样的问题时，可以借鉴前几章提出的方法。

非正常觉醒现象

儿童出现非正常觉醒的现象非常常见，一直到五六岁都还有可能出现，所以很多家长认为，出现这种现象只是孩子睡眠系统生长完善的一个过程而已。几乎所有的儿童都会经历不同程度的非正常觉醒，只是到底多久经历一次很难说清，因为每个人的表现都迥然不同，尤其是对婴幼儿来说，要识别出来非常困难。

一般来说，非正常觉醒阶段的结束都比较突然，有时症状也可能持续稍长时间。在有的案例中，在进入持续、平稳的睡眠之前，非正常觉醒会分为前后相连且各自独立的几个部分，每次持续几分钟。

像玛希那样的案例其实是非常和缓的，她仅仅是喃喃自语一番，翻几个身就又睡去。有时她也会抬起头来，磨牙，甚至短暂地坐起来四下张望，表情非常困惑。绝大多数说梦话都发生在从非快速眼动期醒来的和缓的非正常觉醒中，而不是发生在多梦期。

较为激烈的非正常觉醒（见表 13—1）可能会伴随梦游现象：孩子在床上到处爬，好像在找什么东西，也有可能从床上下来，安静地在房内走动，但是对四周的环境没有任何意识。他喃喃自语，有时从楼上走到楼下，甚至会离开家到外面去。

表 13—1　　儿童非正常觉醒现象排行榜（按激烈程度排序）

1. 第四阶段正常终止：小幅度的身体挪动，有时会睁眼、喃喃自语或咀嚼
2. 说梦话
3. 安静地坐在床上，四下张望，脸上毫无表情
4. 安静的梦游：好像在寻找什么东西，可能会朝父母或光源走去，行为表现非常像是饿了或者要去上厕所
5. 较为激烈的梦游：不知所措，上蹿下跳，满脸愤怒；想要到屋外去，像是在逃避什么东西
6. 觉醒障碍：伴随着手脚乱挥、呻吟、尖叫、乱蹬乱踢，也可能会表现得非常怪异，像是“中邪了”
7. 夜惊：恐慌地大声尖叫，从床上跳下来，满屋子乱跑，好像在逃避什么东西，很可能伤害到自己

注：幼儿常见的觉醒障碍问题其实不能被排在这个排行榜中，因为觉醒障碍本身就有很多种，根据激烈程度、持续时间、对外刺激的反应不同可以自成一体。

要是孩子看上去非常平静，那他会对简单的问句做出一两个字的回应，比如家长问他“没事吧”，他就会回答。如果此时家长要求他回到自己的卧室去，他也可能会听从，也可能会允许家长带他回房。一旦回到床上，年龄较小的孩子会立刻进入到睡眠中去，中间根本不会醒来。年龄较大的孩子或青少年则会出现短暂的清醒。

要是年龄稍大的孩子还有非常明显的非正常觉醒问题，他很可能会从床上起来，在屋子里乱跑。他可能会靠着墙壁，像盲人那样顺着墙根走，从房间里出去。有时他会显得很不高兴，看起来既困惑又不知所措，还有点惊慌，他会大声发出警告，比如：“别！千万不要！停下来！”但是他的这种表现又不像是受到了惊吓。有这种梦游症状的孩子一般不会回应家长的呼唤，也不会回答任何问题。他认不出家长，排斥家长的碰触。处于梦游状态的孩子是很难被唤醒的，通常是 5~20 分钟，最多不超过 40 分钟，他自己就会平静下来，短暂醒来，能自己回到床上或允许家长抱他回房。对于梦游，他几乎不会记得任何细节。

婴幼儿一般不会发生这种比较激烈的梦游，但是他们其他的非正常觉醒现象有可能比梦游更激烈，更奇怪，更吓人。有的孩子可能一开始会呻吟，然后哭闹或啜泣，再变成尖叫。之后，他的眼睛会睁开，在床上手脚乱挥，心跳加快。这样的症状可能会持续 40 分钟甚至一小时，激烈程度超出家长的想象。很多家长说，这样的孩子很像是“中邪了”，因为症状出现时，孩子的面部表情非常怪异，身体的反应也非常激烈，对家长提供的帮助产生抗拒。

症状发作后期，孩子会逐渐平静下来，他们会舒展身体，重新躺好，也会要求父母

给他挠挠背。如果此时孩子醒来，他会变得非常平静，主动要求再次入睡，并且只要家长不阻碍，他很快就能再次入睡。对症状发作的情况，他会彻底忘记，无论是当下还是第二天醒来后，都不会有任何记忆。

幼儿与学龄儿童有时会在夜间出现暴怒现象。孩子会表现得非常愤怒，在房间里跑来跑去。他好像有什么诉求要表达，可是连他自己都不知道到底要表达什么，例如，他会向父母要一样东西，当父母拿给他时，他又会扔得远远的。这种现象会持续10~45分钟，然后逐渐平静下来。

最激烈的非正常觉醒当属“夜惊”了，这种现象并不常见，多见于青少年与年龄稍大的儿童身上。夜惊的出现通常没有任何预兆。孩子会突然发出一声撕心裂肺的尖叫，然后从床上坐起来，他会大量出汗，心跳加速，看上去非常惊恐。有时他会大叫“它要来抓我了”、“放开我”、“停下”，有时又会重复叫着“不要！不要”。夜惊通常持续1~5分钟，不会伴有肢体挣扎，随后，孩子会立刻进入睡眠。如果孩子在夜惊结束时醒来，他对刚刚发生的事一点记忆都没有，但是他会说自己有一个模糊的记忆，但是表达不清楚到底记住了什么。

最最激烈的夜惊现象是非常罕见的，有这种症状的孩子会从床上跳下来，满屋子乱跑，好像在逃避什么人或什么东西的追逐。他看上去极度恐慌，在乱跑过程中可能会撞到家具或人、打破台灯或窗户，很有可能摔倒或伤到自己。这种现象一般持续不到1分钟，然后孩子可能会出现几分钟的混乱或困惑。

要是将非正常觉醒现象摊开来看，我们就能看到孩子在经历这些现象时身体的内在运转了。**出现非正常觉醒时，觉醒系统会竭力让身体醒来，而睡眠系统却不要失去控制权。两个系统同时作用于人体，从而导致孩子处于半睡半醒状态，同时具有清醒与觉醒两种特征。**

其实同时出现两种特征并不奇怪，我们可以来看一个类似的情况：假设你刚睡下一小时就被吵醒，突然从睡梦中“醒来”，心跳加快。开始的几秒钟，你的大脑肯定是混乱的，无法仔细思考到底发生了什么，也无法对下一步所要做出的措施做出判断。这混沌的几秒钟就有点像非正常觉醒的儿童所经历到的过程。但是，处于混沌阶段比非正常觉醒更接近于完全清醒。处于混沌状态时，人会感到惊慌失措，行为会变得滑稽可笑，但是不会出现异常，第二天早晨醒来，对昨晚的经历会记忆深刻。

非正常觉醒发生的原因：睡眠与觉醒的平衡

当非正常觉醒发生后，儿童脸上会出现不知所措或不安的神情，这很容易让人联想到在那个当下，孩子肯定想到了某些可怕的事。我认为，导致非正常觉醒的原因是生理性的，而不是在出现非正常觉醒前或在此过程中出现了什么可怕的想法。正是人体的生理变化导致了非正常觉醒的出现，从而引发了一系列生理表现：心跳加快、血压升高、眼睛鼓起，有时还会伴有尖叫。这些表现都是由神经系统的深层次活动引发的，而不是由于大脑出现了奇怪的情绪或想法。

这就可以解释为什么在某些较为和缓的非正常觉醒中，儿童根本不会表现出受到惊吓的症状。这也可以解释，为什么非正常觉醒通常出现在第一或第二个睡眠周期的末期；为什么儿童会对经历过的一切毫无记忆，等他从非正常觉醒中彻底醒来，不会表现出一丝惊恐或不安，各项身体机能都恢复到正常水平。

我们在第 11 章提到过，褪黑激素与昼夜节律控制着人体的睡眠与觉醒。而褪黑激素与昼夜节律除了可以被其他生理因素增强、减弱、调节外，还会受到外界环境与心理因素的影响。搞清楚这些因素间的相互影响就能进一步明白非正常觉醒出现的原因。

睡眠系统与觉醒系统决定了在从深度睡眠醒来的当下，人的外在表现。当然，这跟从什么样的睡眠中醒来也有关系，从深度睡眠或浅眠中醒来，从快速眼动期或非快速眼动期醒来，都是不一样的。驱动睡眠的驱动力与驱动觉醒的驱动力间的相互角力也会影响人在出现非正常觉醒时的表现，这取决于在醒来的当下孩子到底有多困、驱动其彻底醒来的驱动力到底有多强，以及他自己到底有多想醒来。

当睡眠驱动力与觉醒驱动力处于平衡状态时，人在晚上会睡得很好，睡眠周期的转换会非常顺遂，早晨很容易醒来，一整天都精神奕奕。夜晚开始时，人体处于深度睡眠（第四阶段），睡眠驱动力大于觉醒驱动力，所以人很难被吵醒。越接近早晨，睡眠驱动力越弱，觉醒驱动力逐渐增强，人就容易醒来。当两者间的平衡被打破，就会出现混乱，人可能在该睡的时候睡不着，在该醒的时候醒不过来。这都是因为失去平衡后，两种驱动力在该强的时候变弱，在该弱的时候变强，导致人在该处于深度睡眠的时候睡得很浅，在浅眠期却又睡得很熟。这就导致了非正常觉醒的出现：**两种驱动力同时强烈地作用于人体。**

影响睡眠驱动力与觉醒驱动力的因素

生长发育

儿童天生就能睡熟，这大概是儿童容易出现非正常觉醒的原因之一。儿童在第四阶段的睡眠比青少年和成年人要深。因此，当人体内部的生理机能在睡眠周期结束时企图唤醒大脑，儿童天生的强大睡眠驱动力就会阻止这种唤醒行为，这就导致了儿童比成年人更容易出现非正常觉醒。此外，过度疲倦也可能导致儿童出现非正常觉醒。

感官刺激

噪音、光线及其他感官刺激容易导致觉醒驱动力增强，它们会向大脑传达一个信号，告诉大脑周围环境可能发生了某种变化。要是发出信号时正好是第四阶段中期或末期，就会增强觉醒驱动力的作用，从而导致非正常觉醒的发生。实验表明，在儿童入睡后一小时左右，发出巨大的噪音会引发敏感的儿童出现夜惊。在家里，外界刺激要比在实验室环境里和缓得多，但是同样也能引发类似的反应：孩子可能会在听到人的走动声后从床上坐起来，大声尖叫，家长在其睡眠周期末期给他盖被子也会惊醒他。如果在第四阶段的末期将睡眠中的儿童抱起来，让他站在地上，即使是从来不梦游的儿童，也有可能出现梦游的症状。

作息不规律

睡眠驱动力与觉醒驱动力在很大程度上受到人体生理节律的控制。当我们去旅行时，跨时区可能会引发生物钟紊乱：在特定的时间内，生理节律不再同时上升或下降，两种驱动力相互影响、相互作用。因此，人体接收到了来自不同生理系统的不同指令，有些命令人体进入睡眠，有些则命令人体进入觉醒状态。

要是儿童作息不规律，就会出现类似的状况。对婴幼儿来说，作息不规律的影响力会更大。每天的入睡时间与起床时间都不固定，日间小睡发生的时间也是随机的，这就会导致儿童的生理节律处于混乱状态。在该睡觉的时候，人体却接收到觉醒的指令，而在该保持清醒的时候，却又接到睡眠的指令，这就很容易引发非正常觉醒。

生病和服药

生病和服药对睡眠与觉醒的影响是非常复杂的。一方面，很多疾病与药物的副作用会导致睡眠驱动力增强；另一方面，有些药物的副作用能导致人体保持清醒。有些疾病

或睡眠障碍也是如此，它们会直接或间接地（通过引发疼痛或不适）促使人体保持清醒。例如，患病的儿童可能会在半夜因为喉咙痛或口干舌燥而醒来。这种非正常出现的清醒会打断儿童的睡眠，而大量失去原本应有的睡眠会导致儿童的睡眠驱动力大大增强。所以，很多孩子只在生病或服药时才会出现非正常觉醒。

➤ 遗传因素

有些经常出现非正常觉醒的儿童会有家族病史。我们至今无法得知到底是何种遗传特质导致了这类问题的出现，有可能是这些儿童的家庭成员天生就比其他人睡得熟，也有可能是他们具有比一般人更强的遗传性觉醒驱动力。遗传因素不仅可以用来解释为什么只有部分儿童会在心里惦记着某些事，而在夜里梦游、说梦话、尖叫，还能够决定儿童非正常觉醒的程度。

少数儿童的非正常觉醒会连续出现，即使处理掉所有导致其非正常觉醒的认知因素，情况也不会好转。这些儿童的非快速眼动期被数次小规模的非正常觉醒打断，他们的睡眠天生就不稳定，而我们至今无法确定到底是哪些因素导致了这种不稳定。当然，尽管他们的非正常觉醒无法用行为矫正法进行治疗，但是，通常他们对药物治疗的反应还是比较好的。

| 心里惦记某件事与非正常觉醒 |

晚上睡觉时心里总惦记着某件事无益于睡眠，这会导致儿童的觉醒驱动力大大增强，从而引发非正常觉醒。

假设有个孩子，只有当他爸爸坐在房间里陪他时他才能睡着。在入睡时，他会反复确认爸爸是否还在那里，因此不能快速入睡。到了半夜，他会再次醒来看爸爸还在不在，一旦发现爸爸不在房间里了，他就会去父母的房间找他，然后在父母床上度过这天晚上剩余的时间。对这个孩子来说，他之所以能够在半夜毫不费力地换房间睡，就是因为在那个当下他是完全清醒的。

我们再来假设，这个孩子在某一晚试图重复这个行为，时间就在他入睡后两小时左右，第一个睡眠周期刚刚结束。由于之前每一晚他都会在半夜跑到父母房间去，所以这个行为对他来说已经是非常熟悉的了。在那个当下，他的习惯要求他醒来，然后换房间睡，但是此时第一个睡眠周期刚刚结束，睡眠驱动力的影响还非常强，想要睡觉的意愿

比他平时换房间的时候强烈得多。于是，睡眠驱动力与觉醒驱动力就同时作用于他，发生激烈的角力，从而引发了一次非正常觉醒。

孩子当下的行为如何取决于他从多深的睡眠中醒来。如果他没有彻底醒来，按照习惯，他还是会走去父母的房间，但是更像是一次梦游。很难说他此时是清醒的还是处于睡眠中，当然这种区分意义不大，因为在这种情况下，睡眠与觉醒都一起发挥着非常积极的作用。如果此时他更倾向于睡眠，那他可能会出现哭闹、挣扎的症状，也可能会出现梦游，脸上的表情非常不安或困惑，走路时也走错方向。在这种情况下，孩子的睡眠意图太强烈了，以至于他根本无法意识到自己起来是为了什么事。如果他心里不惦记着换房间这件事，他就能顺利过渡到下一个睡眠周期而不醒来。

孩子在睡觉时到底惦记着什么事，因人因年纪而不同，会受寝具、家长的反应、近期出现的重要事件与当下关心的事所影响。学龄儿童与婴幼儿所惦记的事总是不一样的，一个 8 岁大的孩子可能会担心自己尿床，所以他每晚在固定的时间强迫自己醒来，去上厕所。一个 10 岁大的孩子可能会担心他的父母在半夜里吵架，所以他会在半夜醒来留神听听看父母是否在吵架。有的孩子可能常常在客厅睡着，然后父母将他抱到卧室里，所以他可能会隔一段时间醒来，看看周围的环境是否已经改变。

一旦养成夜里醒来的习惯，无论导致其醒来的原因是否存在，也不管当下是否能够彻底醒来，孩子总是会在固定的时间试图做习惯做的事。有的孩子可能总是在睡着后被家长抱到卧室里，即使家长不再这样做了，他还是会在夜里醒来，试图从自己的房间走到家长的房间去，这种行为在很大程度上带有自动的意味。也就是说，即使惦记的那件事已经消失了，孩子还是会按照习惯行动，只是在行动时，他没有彻底清醒，不记得他根本不需要再有所行动了。

年纪稍大的孩子所惦记的事就更不一样了，他们会试图在夜间控制自己的意愿与想法。在白天，处于绝对清醒的状态下，我们能很好地控制自己的情绪与想法，将不开心的事藏起来；当我们处于睡眠中、昏昏欲睡时或做白日梦时，这种控制力就减弱了。当人从深度睡眠中醒来时，对自己的思想与行为的控制力就大大减弱了。如果在此时强迫自己重新控制好思想与行为，就有可能产生激烈的挣扎，特别是对儿童来说，这种挣扎很有可能引发非正常觉醒。

焦虑与担忧也是引发夜间醒来的原因。要是在入睡前为了某事焦虑很久，夜间就很

容易醒来，然后继续焦虑。同样，儿童要是在入睡前为了某事焦虑很久，在入睡时竭力摆脱这种感觉，睡着后，他又会试图醒来以重新控制这种负面情绪。而一旦这种觉醒发生在深度睡眠期，就有可能引发非正常觉醒。

评估非正常觉醒的状态：何时叫醒孩子比较恰当

要搞清楚非正常觉醒的严重性如何，从而决定何时采取措施叫醒处于非正常觉醒状态的孩子，家长首先需要搞清楚以下几件事：

- 孩子的年龄；
- 发作的频率、持续时间的长短、发作时的激烈程度；
- 在多大程度上影响到了包括家长自己在内的其他家庭成员的睡眠；
- 会引起多大的社会后果（例如在野营或外宿时会出现什么后果）；
- 是否可能导致孩子受伤；
- 是否存在可以辨认的诱因（如过度疲劳或进入了一个新学期）；
- 是否存在自加压力的现象；
- 是否有外在的心理压力。

婴幼儿的非正常觉醒通常到五六岁时就会自行消失，不需要进行特别的治疗。通常，影响婴幼儿睡眠的原因为晚上睡觉时总挂念着某件事、原本规律的作息变得不规律或过度疲劳等，应对这些诱因的方法都是非常简洁明了的。而导致青少年出现非正常觉醒的诱因通常是心理性的或情绪性的。心理或情绪因素引发的非正常觉醒也是可以被治愈的，但是如果放任不管，它们就会一直存在，不会像婴儿期那样自行消失。

轻微而短暂的非正常觉醒可以忽略，即使是频繁出现也无需进行矫正。激烈程度适中的非正常觉醒只要是偶尔出现，不论持续的时间长短，都可以忽略不管。但是如果频繁出现，就需要认真对待，至少应该考虑相应的矫正方案。对于比较激烈的非正常觉醒，即使偶尔出现，也应该做好应对的准备。如果年龄稍大的孩子因为非正常觉醒问题感到尴尬，特别是在参加社会活动（比如外宿或野营之类）时感到不好意思，家长就应该及时作出恰当的应对。

内科或神经方面的问题可能会交织在一起，成为影响儿童非正常觉醒的原因。例如，胃灼热或耳部疾病可能会成为非正常觉醒的诱因，有些疾病的症状可能会与非正常觉醒的症状类似，从而被搞混。如果孩子的症状与本章介绍的非常不同，家长就应该提高警惕，从病理学角度寻找根源。例如：

- 孩子的非正常觉醒发生在清晨前后而不是入睡后；
- 每次的症状都一模一样；
- 孩子在症状出现前就已经彻底醒了，醒来后知道刚刚经历了不愉快的事；
- 孩子能够在非正常觉醒之后清楚地记得发生了什么；
- 在症状出现时，孩子表现出对称的姿势（如左臂伸展，头往左边转）；
- 孩子的身体在睡梦中突然动一下，然后不时重复这一动作。

家长要明白，绝大多数健康且正常的婴儿也会偶尔出现不同程度的非正常觉醒。我们至今不知道到底有多少孩子出现过梦游、夜惊或其他症状，但是可以肯定的是，至少15%的儿童曾出现过一次说梦话，而其他非正常觉醒发生的覆盖面可能比这个数字还要大。当然，这些非正常觉醒很少是频繁出现的，其激烈程度也不高，即便如此，也还是有孩子会偶尔出现夜惊，在夜里疯了似的乱跑，表情非常惊恐。

评估孩子非正常觉醒严重性的最好方法是评估孩子在白天的表现。如果孩子有情绪上的问题，还伴有梦游或夜惊症状，那么最好带他去进行心理治疗。当然，家长应该理解，再好的心理治疗也不会立竿见影，例如，千万不要用孩子梦游的距离长短来判断治疗是否有效果。

在评估孩子的心理状态时，不要过分考虑孩子在说梦话或出现其他非正常觉醒问题时说的话。在非正常觉醒中，孩子很可能会说“不要！不要”，这类反应是大脑较低层次的部位做出的一种自动回复，并不是在清醒状态下控制人语言的部位发出的。不要让这些自动回复干扰你的判断，它们既不能反映孩子的潜意识，也不能反映孩子内心的恐惧或欲望。

如何解决孩子的非正常觉醒问题

在开始治疗前，家长首先要了解导致孩子出现非正常觉醒的因素是什么，然后将这

些因素的作用最小化，直至消除。如果成功做到这一步，孩子的症状就会消失或缓解。即使症状仍旧存在，这一步也为接下来的治疗打好了基础。以下提供的方法家长可以根据孩子的具体情况进行选择。

| 总体建议 |

1. 确保孩子睡眠充足　如同我们在前面所说，过度困倦的孩子更容易出现非正常觉醒问题，因为这些孩子在第一或第二个睡眠周期结束时想要继续睡眠的需求大大增加。在儿童 6 岁之前，有可能解决其非正常觉醒的最好方法就是让他们拥有充足的睡眠。对 4 岁或 3 岁半以下的婴幼儿来说，应该坚持规律的日间小睡习惯。

2. 作息规律　家长应该确保孩子的入睡时间与日间小睡都持续、固定而规律。这会让孩子的生命节律非常稳定，运作平稳、协调，从而导致孩子的第一和第二个睡眠周期运行良好，在深度与较浅睡眠的转换中，平稳过渡。

3. 减少夜间活动　在睡眠周期转换时，孩子不应该因为心里挂念着某事而想着醒来，不应该被某种动静吵醒（比如有人摇着他、挠他的背或给他喂食），不应该为寻找某种东西（父母或奶嘴）或确认周围环境是否如旧而醒来。孩子不应该起床换房间睡、换床睡、走动或看看父母是否在身边。本书第3~5章和第10章介绍的方法可以用来缓解这些症状。

4. 在夜间快乐轻松地入睡　当我们在夜间醒来时，我们会试着去辨认是否还处于睡觉时间。要是孩子在夜间被其他事物占据了注意力，无法做到心无旁骛，就会勉强自己保持清醒去记挂某些事。因此，夜间时光应该是快乐的、无负担的。不能让孩子在入睡时还因为担心第二天的考试而睡不着，也不能让他因为害怕在入睡后被家长挪回到自己床上而不想入睡。就寝时，孩子应该具有越来越强的入睡欲望，而保持清醒的欲望则应该越来越弱。

5. 巧设入睡时间，让孩子快速入睡　合理设置入睡时间对孩子来说也非常重要。要是在入睡前，孩子有太多时间保持清醒，就有可能胡思乱想，等到入睡后，这些活跃的思想就可能导致他出现非正常觉醒，所以不要过早让孩子上床等待入睡。合理的入睡时间应该既能确保孩子第二天能够按时起床，又能让孩子在就寝后很快入睡。

6. 确保孩子在睡眠中处于安全状态　梦游的孩子通常不会意识到自己正在梦游。对于这样的孩子，家长就要确保走廊和楼梯上设有可能绊倒孩子的障碍物。要是孩子年龄

非常小，可以在楼梯的最顶端、门廊或卧室门口安装栅栏，限制孩子的活动范围。要是孩子睡在高低床上，要让会梦游的孩子睡在下铺。如果孩子在梦游中试图离开家到外面去，家长可以用铁链将门锁住，把锁安置在孩子够不到的地方。必要时，可以在孩子的卧室门口装上铃铛，当孩子离开卧室时，家长就能知道。

| 其他方法 |

1. 放松疗法 对7岁及7岁以上的儿童来说，放松疗法具有一定的效果。在做好就寝准备后，可以让孩子躺在床上，一个部位一个部位地分批放松自己的身体。放松时将注意力集中到放松的感觉上，而不要集中在行为上，这能减少孩子保持清醒的欲望。很多发生非正常觉醒的儿童都会在半睡半醒间试图搞明白自己在入睡前到底做了什么，而放松疗法可以让孩子直接进入睡眠，省去了中间纠结思考的过程。

2. 心理治疗 正如我们在前文讨论过的，是否要进行心理治疗需要评估孩子在日间的表现，即使是频繁出现非正常觉醒的儿童，也并不意味着需要进行心理治疗。记住，进行心理治疗是为了确定和治疗某种特定的心理问题，而不是为了确定和治疗某一类非正常觉醒问题。通过心理治疗可以帮助孩子掌握应对不同情绪的方法，从而帮助其在入睡时不因为挂念某事或被某种情绪困扰而无法放松。

3. 药物治疗 学龄儿童与青少年的非正常觉醒问题可以通过服药来加以解决，且效果不错，可是用在年龄稍小的幼儿身上，效果就不甚明显了。在入睡时给孩子喂一点氯硝西泮（又称“百忧解”，效果有点类似于安定片），通常效果会很好。但是，药物治疗是治标不治本的，可以消除非正常觉醒的症状，却无法消除其深层次的症结。

| 当非正常觉醒出现时，家长应该怎么办 |

1. 让非正常觉醒按照其固有流程进行下去 当孩子出现非正常觉醒时，家长最好远观，等孩子自己停下来，当症状消失后，帮助孩子重新入睡。如果家长“采取行动”，可能会让情况变得更糟，甚至有可能延长非正常觉醒持续的时间。因为在那个当下，孩子根本无法辨认出眼前的人是谁，他们极有可能将家长的行为解读为某种威胁或攻击。当孩子挣扎不休、将父母推开甚至乱踢乱打时，家长的“作为”只会让孩子更不受控制。基本上没有什么外界刺激能将处于非正常觉醒状态中的儿童唤醒。

2. 保持冷静：控制好自己的担忧与好奇　家长不要反应过度，克制住想要唤醒孩子的冲动。当孩子从非正常觉醒状态中清醒过来后，不要问他刚刚发生了什么，因为孩子根本不会对刚刚经历的非正常觉醒有任何记忆。家长此时只要让孩子继续睡觉就好了。

非正常觉醒案例回顾

这一节我们回过头去看本章开始时介绍的几个案例，通过分析成因与症状，给出具体的矫正方案。

> 玛希是一个4岁的小女孩，她在睡觉时会说梦话，入睡后不久就不安地翻来覆去。其实，玛希没有什么大问题，可是她的父母却对她无法安静睡觉感到忧心忡忡，他们想要知道怎样才能让自己的女儿安静睡觉。

我告诉玛希的父母，她的情况是正常的，属于睡眠阶段转换过程中的正常表现，她父母在听到我的解释后大大松了口气。就玛希的情况来说，不需要家长做任何矫正，她本身就处于正常范围之内。

> 丽莎是一个一岁半的小女孩，入睡时要吸着奶嘴，她能自己睡在婴儿床上，并且入睡速度非常快。但是在入睡几小时后，她就会哭闹着醒来，手脚乱挥。她看上去非常不舒服，有点沮丧，但不是处于惊恐之中。她的爸爸或妈妈会在她哭闹时抱着她、哄着她，但她仍旧抗拒得非常厉害，弓起背，对家长又踢又踹。她的父母试图唤醒她、跟她交流，摇着她，强迫她站起来走路。父母偶尔会对她非常严格，也会通过大声呼唤来唤醒她。
>
> 丽莎每次折腾的时间都在10分钟到半小时之间，等非正常觉醒结束，她会开始安静下来，四肢舒展，打哈欠。而她的父母则会发现，直到此时她才真正醒来。非正常状态终止后，丽莎会拿起自己的奶嘴，重新回到睡眠状态中，直到第二天早晨再醒来。这期间她会出现数次喃喃自语，家长只需要起来照看一下即可。

我向丽莎的父母解释说，其实丽莎并没有在夜间醒来，也没有受到惊吓或感觉痛苦。我让他们密切关注她的情况，但是不要随意干涉，除非丽莎完全醒来，自己提出要求。

等她停止哭闹，家长就能帮助她重新躺好，帮她盖上被子，但是没必要让她保持完全觉醒的状态，也没必要拿掉她嘴里的奶嘴。一段时间后，她的家长就能够在不干涉的前提下密切关注她的情况，并且不再感到内疚。此外，我建议丽莎的父母不再让她使用奶嘴，因为半夜自己换奶嘴的过程有可能导致她出现非正常觉醒。经过三个晚上的矫正，丽莎已经能够做到在入睡时不依赖奶嘴了。

矫正开始后，丽莎的父母发现了两个立竿见影的效果：一是她的非正常觉醒状态持续的时间缩短了，二是在非正常觉醒状态终止后，不需要父母唤醒她，丽莎就能自己再次入睡。到了矫正的第二周，情况大大改善，所剩不多的几次非正常觉醒都非常和缓，只出现过少数几次挣扎的情况，到了后来，父母已经不再需要进入她的房间去照看她了。

克里斯托弗是一个8岁的小男孩，过去两年都被非正常觉醒所困扰。他的睡眠问题出现在父亲去世后的第二个月，他跟着妈妈搬到了一个邻居家里。从那以后，他每周要梦游2~3次，梦游时非常平静，几乎不发出什么声音。他既不会哭闹，也不喃喃自语，没有任何激烈的迹象。他妈妈说他在梦游时，脸上表情“很怪异”，当她试图跟他交流时，他也不会积极回应。通常，他的漫游像是漫无目的的，但有时候又像是在寻找什么东西。

尽管在梦游时他无法辨认出自己的妈妈，但却允许妈妈引导他先去上个厕所，再回到床上。有两次他尿在了自己房间里，一次尿在废纸篓里，一次尿在衣柜里。还有两次他梦游时走出了家门，邻居见到后将他领了回来。这种症状持续了一年之久，没有任何改善。期间他的妈妈被紧急叫到医院去为病人动手术，一忙就是两个星期，她回来后不久就跟别人结婚了，然后他们全家搬到了新家里。

此后不久，他的妈妈就再次怀孕了。在同母异父的妹妹出生前，克里斯托弗的非正常觉醒情况恶化了，一夜要出现数次，且症状与以前非常不一样。从那以后，他会在入睡后一小时左右突然从床上坐起来，然后大哭，表现得非常惊恐。当妈妈安抚他时，他也不再回应。当其他人碰触他时，他会抵抗，在整个过程中他会一直断断续续地喃喃自语。几分钟后，他会自己平静下来，然后躺平，很快再次入睡。这种情况每隔一小时就会重复一次，重复两次之后，他会起来在房间里走动，出现梦游，比以前更激烈。

他的妈妈和继父无法理解为什么他会这样，而由于他们的睡眠被克里斯托弗的非正常觉醒搞得断断续续的，他们对他非常不满、充满愤怒。

据我所知，克里斯托弗以前是一个快乐而安静的小男孩。通过深入了解，我发现他已经过世的父亲与继父都酗酒，他经历的两个家庭都存在着家庭暴力问题。他对身边的人不满，但是又不敢表达这种情绪。他又对无法控制身边的环境感到害怕，而且他觉得自己的父母也无法控制他们身边的环境。他将大量的精力花在了自我控制上，他担心一旦自己失控，父母就会变得更加愤怒，然后增加对他的惩罚。

我建议克里斯托弗和他妈妈都去进行心理咨询。同时，我向他的妈妈和继父详细解释了非正常觉醒的原理，要求他们不要将怒气撒在孩子身上。为了不让他在梦游时离开家里，我建议在大门上加上锁，安置在他够不到的高处。

由于克里斯托弗在梦游时会出现伤害自己的现象，而一时半会儿他的妈妈与继父又无法提供实质性的帮助，所以我给他开了点药，帮助他控制非正常觉醒，至少在他的心理咨询取得进展之前，持续地让他服用药物。我让他在入睡时吃非常小剂量的百忧解，他的非正常觉醒基本上可以完全消失。在心理咨询中，我给他创造出一个安全又可靠的谈话环境，鼓励他表达出内心的恐惧与担忧。而他的妈妈通过心理咨询学到了如何用一种富有同情心的、不带道德评判的方法来应对他的非正常觉醒问题。渐渐的，他变得更放松了，担忧也变少了，又慢慢变得快乐起来。

6个月后，克里斯托弗和他妈妈都取得了很大的进展，家里的氛围也变得更融洽了，因此我逐渐让他停止服药。有个别晚上，他仍旧会出现非正常觉醒，但是相较于之前程度更轻了。他的梦游不再激烈，而且绝大多数情况下不再出现真正的梦游，而只是从床上坐起来，平和地说几句梦话。通过矫正，克里斯托弗出现非正常觉醒的频率大大降低，一夜最多出现一次，而他的妈妈也学会了如何正确应对他的非正常觉醒问题，而不再总是怒气冲冲的。接下来的几个月里，情况持续好转，到他9岁时，非正常觉醒出现的频率已经变得非常低，只是偶尔出现而已。

大卫是一个17岁的小伙子，我认识他已经有8年了，他的双亲在离异后又都再婚了。在父母离异前，大卫就有说梦话的习惯。到了12岁，他的爸爸再婚了，他的非正常觉醒变得更激烈了。他会突然从床上跳起来，然

后大喊大叫，这种情况每个月都要发生一次，每次都出现在午夜前后。他妈妈赶来后总是发现他站在卧室里，有着明显的不安，用他妈妈的话说，看上去“像是有什么不幸要降临到他身上了”。实际上，他没有受到惊吓，尽管有时他会用哭腔喃喃自语说“我马上要抓到他了”之类的话。

大卫15岁的时候，他妈妈也再婚了，他的非正常觉醒变得更加激烈。原本的大喊大叫变成了撕心裂肺的喊叫，他会从床上跳下来，敲打家具，满房间乱跑，看着像是在躲避什么东西的追逐。在出现这些症状时，他确实处于惊恐中。有时他会伤害到自己，身上常有小伤口或淤青，有一次他打坏了玻璃窗，割到了手。当非正常觉醒出现时，让他靠近开着的窗户是非常危险的，因为他的房间在二楼，很有可能发生意外。每当症状消失时，他就会彻底醒来，然后尴尬地发现身边围满了家人，盯着他看。

大卫的父母说他是非常“有控制欲”的，他想“将事物掌握在自己手中”，“过分要求控制权”。在学校里时，他没有尽全力学好。我发现他很好相处，也很善于和人合作，但是看上去总有点压抑。他是很容易交谈的人，事实上，他能清楚地表达出很多自己的感受，虽然其中有一些他还无法完全理解，特别是涉及悲伤和愤怒的感受。

尽管大卫的非正常觉醒出现的频率不高，危险性却很大，我总担心他会伤害到自己。我给他开了药，帮助他消除非正常觉醒，但是这也只是治标不治本的方法。我们都希望他能在不借助药物的前提下，安静又安全地入睡。即使不关心他的睡眠情况，他因为睡眠不好而导致的轻度抑郁、异常的愤怒情绪及学业上的不投入也需要家长花大力气进行矫正。因此，我建议大卫进行心理治疗。

大卫和他的父母接受了我的建议，效果很好。不久当我再次见到他的时候，他已经变得比以前更开朗、更优秀了。几个月后，我跟大卫一家商量停止对大卫的药物治疗。由于他的非正常觉醒具有人身危害的潜在可能性，所以我在减少药量时不是立刻停止，而是逐渐减少剂量，并且仔细观察他的反应。等到他大学毕业时，他已经完全不用吃药了，不过我还是仔细询问他的父母，他的室友是否提及过大卫会出现非正常觉醒，万一真的复发，给予药物治疗还是很必要的。

儿童非正常觉醒的主要类型及解决方法见表13—2。

表 13—2　　儿童非正常觉醒的主要类型及解决方法

行为表现	出现时的年龄	应对方法	建议
觉醒障碍、长时间哭闹、啜泣、呻吟，脸上表情怪异	6个月至6岁，偶尔会出现在年龄较大的孩子身上	• 确保孩子不受伤。 • 让整个过程自然进行，家长可以远观，不要干涉。只有当孩子能够认出家长并且期望被拥抱时再抱住他。不要在症状出现时摇晃他或试图用激烈的方式唤醒他。 • 等症状消失、孩子平静下来后再帮助他重新入睡。不要唤醒孩子，也不要问他是否记得刚刚发生了什么，第二天早晨也不要发问，不要让孩子觉得自己很怪异。	• 确保孩子睡眠充足。 • 不要轻易取消日间睡眠。 • 确保孩子作息规律且固定。 • 必要时延迟入睡时间，以便让孩子快速入睡。 • 减少睡前活动。 • 减少让孩子挂心的事。
安静的梦游	孩子学会走或爬之后的任何年龄段	• 用镇定平和的语气跟孩子交谈，引导其回到床上去。 • 如果孩子对家长的碰触不抵抗，家长可以牵着他回到床上去，除非孩子要求，否则不需要绕路去厕所。 • 当孩子在症状消失后醒来时，会感觉尴尬，家长应避免做出负面评价，更不能嘲笑孩子。不要让孩子感觉自己很怪，要用平常心对待梦游这件事。	• 确保孩子睡眠充足，作息规律。 • 确保睡眠环境安全，必要时可以在卧室门口装上铃铛，也可以在大门上加锁。要是孩子试图离开房间，可以在门口安装栅栏以便及时唤醒家长，并限制其活动范围。尽量睡在下铺。 • 必要时延迟入睡时间，取消不合理的睡前活动，减少让孩子挂心的事。
较为激烈的梦游	年龄稍大的儿童及青少年	• 当症状比较激烈时，尽量不要试图阻止，否则有可能延长发作时间且增加发作强度。 • 当孩子平静下来后，参考安静梦游时的做法加以应对。	• 与处理安静梦游时一样。 • 如果发作频率高、危险性大或家长确实很担心，可以去咨询医生。孩子可能需要药物治疗或心理咨询。

续前表

夜惊(尖叫、看上去惊恐不安、有时会乱跑)	年龄较大的儿童及青少年	• 不要唤醒孩子，让他发作完，然后帮助他重新入睡。孩子醒来后，不要发问，也不要让他感觉尴尬。 • 出现自我伤害或危及其他人的状况时，家长要进行干预。但是要小心谨慎，不要伤害到孩子，也不要伤到自己，语气要镇定，避免直接的身体接触，可以间接排除可能发生伤害的因素。	• 与应对激烈梦游时一样。 • 确保房间内、门窗都处于安全状态。 • 要是孩子会乱跑，睡在一楼或地下室会更安全一些。

所谓噩梦，其实是梦的一种，只不过与普通的梦相比，噩梦显得更可怕，它将人从睡梦中惊醒，带给人巨大的恐惧。与普通的梦一样，噩梦也发生在快速眼动期。婴儿的梦是未发展完全的，他们将大量时间花在快速眼动睡眠中。在这一阶段，他们的眼睛快速转动，脸上会出现些许微笑。

一岁左右的孩子做的梦是非常简单的，通常梦的内容就是重建或重复经历最近遇到过的可怕的事。尽管一岁的孩子还不能准确描述梦的内容，但是通过他的只言片语我们还是能明白梦的内容与他最近经历的一次验血、车祸或被蜜蜂蛰有关。这个年龄的孩子还不明白梦与现实的区别，因此，当他从梦中醒来后，他也不会清楚地意识到梦已经结束了。他会继续感到害怕，就好像梦里那些可怕的事物仍旧会存在于现实中一样。

两岁孩子的梦就比较具有象征性了，他的梦中会出现怪物或野兽，这通常代表着他内心的欲望与恐惧。到了两岁，孩子就能明白梦是什么了，但是还不能准确理解梦与现实的区别。他可能会觉得梦里的那头怪物“还待在房间里”。

孩子越大，梦就越复杂，其分辨梦与现实的能力也越强。到了 5 岁左右，孩子从梦中醒来后，立刻就能明白刚刚做了梦，而现在已经进入现实当中了。但是，从噩梦中醒来后，这种能力又会相对减弱。到了 7 岁，其分辨能力更强了，即使做了噩梦也能自己面对。但是，即使是年龄更大一点的孩子，也无法摆脱噩梦带来的恐惧感。就像一个孩

子跟他母亲说的那样："妈妈，我知道我不过是做了个梦而已，但是这个梦太真实了！"

影响儿童噩梦内容的因素通常有：其生理与心理发展情况、最近所经历的情绪冲突以及特别让他害怕或恐惧的事。做噩梦时所产生的焦虑也会使恐惧感增加，从而导致孩子在清醒后仍旧处于惊恐中，久而久之，就会影响孩子入睡或再次入睡的能力。

婴幼儿都害怕与家长分开。当孩子第一天去托儿所回来后，可能会做噩梦，家长让孩子独自在家然后外出办事或就医也有可能导致孩子做噩梦，甚至在逛商场时家长与孩子走散了也有可能导致孩子做噩梦。随着孩子慢慢长大，他将更多的担心放在家长可能会不爱他这件事上，例如，他可能会担心家长的爱被弟弟妹妹夺走了。到了三岁左右，孩子开始养成规范的如厕习惯，夜间睡觉时，他可能会陷入纠结中，一方面他的本能让他尿床，另一方面，他又想取悦家长或害怕家长的责骂而起来上厕所。如果此时他做梦的话，梦的内容很可能就会反映出这种焦虑感。

3~6岁的儿童会经历性意识与暴力意识的觉醒。他可能会喜欢触碰自己的生殖器，也可能会对刚出生的弟弟妹妹非常不友好，会想打他。可是他又会对自己这些冲动感到害怕，尤其是当他觉得家长不会帮助他克服这些冲动或者会因为这些冲动而惩罚他的时候，恐惧感就会更深。如果家长没有告诉孩子这些冲动是正常的，没有给他示范过规范的日常行为，更没有帮助他控制或克服这些不恰当或有伤害的冲动，那他的这些冲动就可能变成噩梦里的"怪物"。这个年龄段的孩子非常敏感，如果在家里看到了暴力行为或听到了大声争执，他也会受到影响。他会觉得家长也无法控制自己的行为，从而担心家长无法在他需要时提供帮助。

这个年龄段的孩子会想要替代家长中的一方，如果允许这种焦虑感自由释放出来，对孩子的刺激会更大。

> 丹尼尔是一个5岁的小男孩，他总是会在晚上溜到父母的卧室里，要求爸爸去其他房间睡。要是爸爸不同意，他就会拳打脚踢。通常爸爸总是顺着他，毕竟去另一个房间的话还能睡一会儿，如果坚持留在卧室里则会片刻不得安宁。但是对丹尼尔来说，他对爸爸的要求反而会让他感到害怕，睡眠质量总是不高，总会梦到自己遇见了怪物。

这个年龄段的孩子对死亡也似懂非懂，他们会担心一旦睡着了，就再也醒不过来了。

亚历山大是一个6岁的小男孩，他的睡眠一直非常好，直到他听到自己叔叔的死讯，情况就急转直下了。叔叔去世后，大人总是告诉他不要担心，因为叔叔看上去“就像是睡着了一样”，而事实上，亚历山大非常清楚叔叔在睡眠中去世了。从此以后，他就将睡眠与死亡联系到了一起，这就导致了他总是做噩梦。

让孩子感到恐惧或担忧的任何事都可能引发噩梦。

劳伦是一个5岁的小姑娘，自从三个星期前看了一部恐怖片之后就一直做噩梦，晚上怎么也睡不好，她父母就带她来找我。这部恐怖片肯定是儿童不宜的，看了之后，她就会在凌晨三点醒来，哭闹着呼唤父母。当父母走进她的卧室时，总是会发现她醒着，非常警惕，浑身发抖，显然是处于惊恐状态。她做梦的内容并不是一成不变的，却或多或少地与那部恐怖片有关。父母在进入她的卧室后总是停留一小会儿就离开，也不允许她到他们的床上去睡，因为他们不想纵容她发展出坏习惯。可是这种得不到帮助的情况只会让她的恐惧感越来越深，不久后她就对上床就寝产生了抵抗心理，一旦父母进入她的房间，她就会想方设法地留他们多陪陪自己。

7~11岁的孩子做噩梦的概率就更小了，大概一个月也不到一次。等到进入青春期，青少年就会面临新的压力，随之而来的是新的焦虑感。等孩子长大成人，无论是生理、心理还是认知上都已经成人化了，他就进入每天都要面临压力困扰的阶段了。这个时期的噩梦出现得更加频繁，但是由于青少年不再像儿童那样频繁地与家庭成员沟通交流，也不会像小时候那样一做噩梦就叫醒父母，所以到底做噩梦的概率如何也不得而知了。

孩子做噩梦时，家长应该怎么办

要是你家宝宝做噩梦的频率非常低，几个月才有一次，那家长大可以忽略不管。对于两岁以下的婴幼儿，不需要费心去解释“这只是一个梦而已”。此时家长要做的就是抱住他，好好安抚一番。对两岁左右的孩子来说，他需要家长用平缓且坚定的语气来安抚他，要是家长能满怀同情地耐心听他描述所做的噩梦，他也会感觉非常受用。要是孩子已经三四岁了，家长还是应该安抚他，除此之外还需要向他说明，他所经历的只是梦

而已，并不是现实。

在面对刚从噩梦中醒来的孩子时，家长要明白孩子此刻最需要的是支持与安全感。要是孩子在醒来后不愿意独自入睡，家长可以陪孩子待一会儿。家长给孩子的支持应该是平静的、让人信服的，要让孩子相信，家长可以掌控局面，可以确保他的安全。此时不宜过于严苛，当孩子处于极度恐惧中时，千万不要留他一个人在房内。

当然，家长也不需要为了安抚孩子而满足他的每一个要求。例如，不要按照孩子的要求将家里所有的灯都打开，不要当着他的面去检查床底下和柜子里有没有东西，不要依着孩子重新摆放家具，也不要锁上窗户。因为这样做与其说是为了保护孩子，不如说是加深了孩子的推测：怪物就在屋子的某一个角落里。家长应该用理性的方法让孩子知道一切尽在掌控中，没有什么能伤害他。

要是孩子做噩梦的概率比较高，比如一个月有好几次，那我建议家长在白天跟孩子一起努力，找出让孩子担忧的症结，然后帮助他缓解焦虑。例如，有的一岁左右的婴儿无法离开家长身边片刻，家长可以通过玩躲猫猫的游戏来缓解这种情况，让孩子习惯家长消失在视线里又重新出现。有些两岁左右的幼儿在养成如厕习惯的过程中总是做噩梦，即使他的如厕习惯已经非常好了，也还是会在夜里做噩梦。家长可以先将培养如厕习惯这件事放一放，跟孩子玩玩画手指画。

应对 3~6 岁的儿童，家长可以直接跟孩子谈谈让他感到恐惧的事。家长要对孩子接触到的书籍、电影与电视节目做一个大概的了解，避免让他接触到与年龄不符的内容，因为这些内容很可能引发孩子的异常反应。即使孩子看起来并不害怕看到的电影或电视，但是这些内容还是会刺激他，从而增加睡眠时的焦虑感。

无论对什么年龄段的孩子，家长都应该允许其表达出自己的感觉，但是要教会他掌握好度，避免做出道德评价。不要让孩子觉得有暴力或性的欲望是一件羞愧的事，相反，家长要进行合理引导，帮助孩子正确认识这些事，更多地进行沟通而不是责骂。对年龄稍大的孩子来说，开诚布公的谈话会让他们更愿意表达自己的感觉，从而将那些难以启齿的事说出来，比如家长离异、性或毒品。我们来回顾一下前面提到过的几个案例。

丹尼尔，当我跟他父母谈了之后，他们明白了应该是家长而不是孩子决定晚上谁该睡在哪里。其实，丹尼尔的爸爸每次顺着他的要求从卧室里出去，都会增加丹尼尔的不

安全感。通过谈话，丹尼尔的父母决定从此以后即使丹尼尔撒泼哭闹也不再顺着他了。他们回去实践后发现，丹尼尔反而睡得更好了。不久之后，他做噩梦的现象也消失了。

亚历山大在叔叔去世后就频繁地做噩梦，通过咨询，他的父母鼓励他打开心扉，谈一谈对死亡及葬礼的看法。他们纠正了亚历山大的几个错误观念，给他读了专门为儿童准备的讲死亡问题的书，渐渐的，他的症状就好转了。

劳伦在看了不该看的恐怖片之后就时常做噩梦，这些噩梦看上去也没有什么更深层次的焦虑。但是由于她晚上实在是太害怕一个人待在房间里了，所以我建议她的父母暂时睡在她的房间里，直到她的恐惧感与噩梦都消失为止。同时，我建议他们在白天与劳伦谈谈那部恐怖片，帮助她缓解恐惧。劳伦对这个方法反应良好，不到两周，她就能安然就寝了，做噩梦的情况也消失了。两周后，她就答应自己一个人睡，前提条件是一旦她做噩梦，爸爸或妈妈就要回到她房间里陪她度过剩下的时间。接下来的一周，她不只做了一次噩梦，每一次她的妈妈都会依照约定过去陪她。渐渐地，她的症状也消失了。

要是导致孩子产生恐惧的是某种他看到或听到但不理解的事物，家长应该帮助孩子进行认知，并帮助他缓解压力。但要是导致压力的原因是更深层次的，仅仅给予感情上的支持是远远不够的，那就应该求助于专业的心理治疗。

做噩梦与非正常觉醒

在着手处理孩子做噩梦的问题前，家长应该确定问题出在噩梦上。当孩子在夜里哭闹着醒来，显得非常恐惧，或者从床上坐起来，看上去非常不安时，家长通常会认为孩子是做了噩梦。但是，这些情况也可能代表着孩子经历了一次夜惊、非正常觉醒或短暂而激烈的梦游。夜惊与做噩梦是最容易被搞混的两种情况。

做噩梦是指在快速眼动期做了非常可怕的梦，随后会出现完全觉醒。而夜惊则是一种非正常觉醒，发作时人处于半睡半醒间，通常发生在无梦或少梦的深度睡眠期。尽管从概念上来看，两者很容易分辨，但是在实践中，界限却没有这么明显，特别是对儿童来说。关于夜惊与做噩梦的区别，家长可以参考表 14—1。噩梦通常出现在快速眼动期，一般是在夜晚接近尾声时，而非正常觉醒则发生在入睡后几小时的非快速眼动期，一般是在深度睡眠期。

表 14—1　　做噩梦与夜惊等的对比

	做噩梦	夜惊、觉醒障碍、比较激烈的梦游
概念	可怕的梦魇。在快速眼动期出现，经历后即进入完全觉醒状态	从无梦期（第四阶段，非快速眼动期）醒来后出现的非正常觉醒
家长何时得知孩子做了噩梦或出现了夜惊	噩梦结束后，孩子会哭闹或呼唤父母。在做噩梦时，家长无法得知	在处于非正常觉醒期间孩子会受到惊吓或大叫。当孩子彻底从非正常觉醒中醒来后，他反而会很平静
出现时间	做梦非常频繁的后半夜	入睡后 1~4 小时，处于无梦的深度睡眠中
孩子行为表现如何	通常会彻底觉醒，小一点的孩子会哭闹，即使在噩梦结束后，所有的孩子都会表现出恐惧	不会完全觉醒，对外界刺激反应不明显。通常孩子会坐起来，手脚乱挥或乱跑，表情怪异，眼睛鼓起，心跳加快，大量出汗。会表现出大哭、尖叫、喃喃自语，会有明显的恐惧、愤怒、不安等情绪，这些症状在完全觉醒后会彻底消失
对外界唤醒如何反应	会醒来，对父母在身边感到安心，也允许家长安抚他，会对家长产生依赖	不会醒来，也不允许家长安抚，会推开家长，比先前哭闹挣扎得更厉害
多久会再次入睡	取决于噩梦的惊恐程度、孩子的年龄及家长的安抚程度。要是孩子感觉极度恐惧，再次入睡的时间会被大大推迟	通常能很快再次入睡，一般不会超过 45 分钟
醒来后孩子是否能描述梦境	可以，只要孩子年龄足够大	不能，根本不记得做过梦或有过挣扎与哭闹

经历过噩梦之后，年龄稍大的孩子通常可以描述出梦的内容，到第二天早晨起床时，也仍旧记得。但是经历非正常觉醒的孩子通常说自己没有做梦。当孩子从噩梦中醒来，年龄稍小的孩子会哭闹，年龄稍大的孩子则会呼唤父母。当家长出现时，孩子能立刻认出他们，并主动要求家长抱抱他、安抚他。而处于非正常觉醒状态的儿童并未完全觉醒，他可能会哭闹，也有可能处于一种混乱的状态，他会说话、喃喃自语、大哭。他无法认出家长，也不允许家长对他进行安抚。要是孩子在非正常觉醒后期醒来，他根本不会记得刚刚发生的一切，甚至根本不记得刚刚做了一个梦。

被噩梦吓醒的儿童，即使完全清醒后，也会觉得恐惧。通常，在做噩梦醒来后，他会对再次一个人入睡产生抗拒，甚至在接下来的几天内，他都会对上床睡觉心有余悸。而经历过非正常觉醒的儿童在醒来后则会表现得比较放松，没有任何恐惧或行为激烈的迹象，很快就能再次入睡。

对有些孩子来说，“我做了一个噩梦”的含义是“我很害怕”。对这些孩子，只要他看上去处于恐惧中，家长就应该给予安抚。

尿床，又称夜间遗尿症，是一种非常普遍又非常让家长和孩子难堪的儿童睡眠问题。有关尿床的记载自古就有，且广泛分布于所有国家。尽管在不同社会或同一社会的不同群体中，有关尿床的统计数据不一，但是，大概 15% 年龄在 5 岁左右的孩子、5% 年龄在 10 岁左右的孩子及 1%~2% 的青少年每月会至少尿床一次。而在尿床的孩子中，有 2/3 是男孩。

尿床的原因

导致尿床的原因非常多，遗传因素、生长发育情况、膀胱容量、夜间起夜的意识、睡眠深度、药物影响、对食物的敏感性、情绪因素、环境因素及童年早期的影响等，都有可能导致尿床。但是对特定的个体来说，很难说哪个因素是导致其尿床的主要原因。

1. 遗传因素 从某种程度上说，遗传因素可能是导致尿床最主要的单一性因素了。那些父母小时候有过尿床经历的孩子比其他孩子更容易产生尿床问题。普通儿童尿床的概率是 15%，但是，对那些父亲或母亲小时候有过尿床经历的儿童来说，这个比例就会上升到 50%，如果双亲都有尿床经历则会上升到 75%。

2. 生长发育情况 这是指儿童控制自己排尿的能力，其神经系统逐渐完善，直到对膀胱具有一定的控制能力。婴儿不会意识到自己的膀胱被尿液充满，需要排尿。一岁到一岁半左右，幼儿就能意识到了，当他出现尿意时就会停止玩耍，脑中出现一个意

识：需要排尿了。如果此时他已经接受了上厕所训练，他就会自己跑到卫生间去上厕所。到了三四岁，儿童就能根据自己的意愿控制排尿行为了，他能在膀胱还不满时就提前排尿，也能进行适当的憋尿。

绝大多数孩子在四岁左右就会停止尿床，当然这个年龄因人而异。在两岁到四岁半之间，孩子的膀胱逐渐生长，使得他在夜间憋尿的能力逐渐增强。有些孩子甚至在一周岁之前就不再尿床了。到了两岁半，50% 的幼儿会停止尿床行为，到了三岁，75% 的幼儿不再尿床。“生长迟缓”最经常被用来解释五岁以上儿童尿床的原因。

3. 膀胱容量过小 在夜间尿床的孩子比普通孩子上厕所的频率更高，但是每次的排泄量更少。这似乎暗示着这些孩子的膀胱容量过小，但是通过医学检查就能发现，这些孩子的膀胱其实非常正常。之所以会产生这样的现象，主要是因为这些孩子的膀胱收缩间隔过短，导致他们在膀胱充满前就感觉到了排尿感的假象。而且，这种收缩可能是非常强烈的，到了夜间，就出现了尿床现象。关于这一点，我们在稍后的章节会详细讨论。

4. 起夜的意识 尿床的孩子可能没有将膀胱充满后的收缩感与觉醒联系起来。我们在前面的内容中提到过，对人来说比较重要的刺激比相对不重要的刺激更容易唤醒一个人。人在睡着时也能分辨出出现何种刺激必须醒来，出现何种刺激不需要醒来，儿童也是如此。如果孩子不具备这种分辨能力，就无法将排尿感与觉醒联系起来，也无法暂时憋尿等到醒来后再去上厕所，从而导致尿床。

5. 睡眠深度 研究显示，孩子在做梦期间不会发生尿床现象。要是孩子说梦见水打湿了他的衣裤，这并不代表其尿床就是由梦境造成的，应该是先出现了尿床现象，然后感觉到了床单与睡衣裤都尿湿了，这种湿答答的感觉刺激大脑产生了有关水的梦。

尿床一般都发生在整个睡眠过程前 1/3 时间内，处于从非快速眼动期短暂醒来的过程中，这就意味着，尿床发生在从深度睡眠醒来的半睡半醒间。此外，尿床也可能发生在从相对较浅的非快速眼动期醒来的过程中。尿床的孩子在非快速眼动期膀胱收缩的频率比在快速眼动期要高得多，这种收缩有可能引发了非正常觉醒，在不同的时间段里，又引发了尿床。

6. 环境因素与儿童早期经历 儿童早期的经历可能会影响其是否尿床，例如，研究显示，生活在家庭收入较低或家庭压力较大的家庭的孩子比中产阶层家庭的孩子更容易

出现尿床现象。在孩子三岁左右，压力对其的影响最大，因为此时孩子刚刚开始接受如厕训练。如果如厕训练是伴有惩罚性的，那孩子尿床的可能性反而更大。

尿床的解决之道

家长和孩子都应该明白，通过矫正，孩子完全可以减少尿床的次数，很多孩子还能彻底摆脱尿床的困扰。但是，在开始矫正前，家长要明白矫正的过程需要足够的耐心、坚持与通力合作。因此，在矫正开始前家长要与孩子充分沟通，向他解释矫正计划的目的、重点与流程，并听取他的反馈。我为家长提供了几张图片，以便于家长向孩子解释泌尿系统的工作原理，家长可以参考图 15—1。

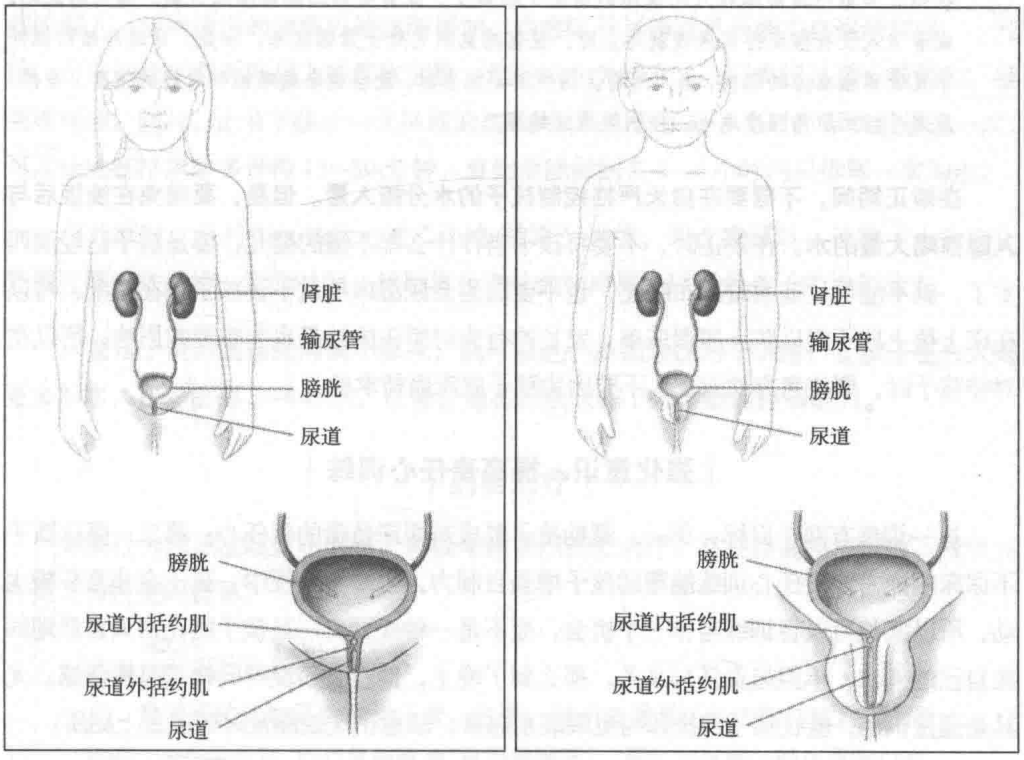


图 15—1　儿童泌尿系统

在向孩子解释时，可以根据孩子的具体情况，选择合适的语言，便于孩子理解。

肾脏：人体非常重要的器官，用以过滤人体血液中不需要的化学物质，这些过滤之后

的液体就变成了尿液。

输尿管：连接肾脏与膀胱的柔软管道，尿液顺着它进入膀胱。

膀胱：人体储存尿液的器官。其实是由一种特别的肌肉构成的，当膀胱充满时，就会开始收缩，让人产生尿意，从而排出尿液。

尿道内括约肌（第一道屏障）：其实质也是一种肌肉，用以控制尿液从膀胱排出。绝大多数时候，尿道内括约肌处于关闭状态，以确保尿液留存在人体内。当人需要排尿时，尿道内括约肌就开始松弛，并自动张开。然而，当膀胱被完全充满时，它就会剧烈收缩，试图排空膀胱，人就会产生强烈的排尿欲望。

尿道外括约肌（第二道屏障）：与第一道屏障不同，第二道屏障通常处于松弛与张开的状态。当第一道屏障在人不情愿的情况下松弛了，就需要第二道屏障来控制。当人憋尿时，或者当人没有彻底排完尿液就终止时，就能感觉到它处于紧绷状态。但是，尿道外括约肌并不是非常强有力的肌肉，当人急需上厕所而不能去时，就会越来越难控制尿液的排出。当然，尿道外括约肌的强度越大，控制能力就越强。

在矫正期间，不需要在白天严格控制孩子的水分摄入量。但是，要避免在晚饭后与入睡前喝大量的水。在矫正时，不要将孩子当作什么都不懂的婴儿，要是孩子已经满四岁了，就不能再让他裹着尿布睡觉，也不要因为会尿湿床单就不让孩子睡在床上，可以在床上垫上尿不湿以防止尿湿床单。家长的行为对矫正的效果也有重要的影响，所以在对待孩子时，要注意方式方法，不要因为孩子尿床而苛求他。

| 强化意识、提高责任心训练 |

这一训练有两个目标：第一，帮助孩子养成对尿床负责的责任心；第二，强化孩子不尿床的能力。责任心训练能帮助孩子增强自制力，在矫正过程中，孩子会非常积极主动，所以家长可以将训练当作一个机会，而不是一种处罚。一旦孩子能在白天自然地回应自己的需求，承担起责任与义务，那么到了晚上，他也会表现得同样具有责任感。尤其是通过训练，能让孩子将排尿与觉醒联系起来，尿意出现就能及时醒来去上厕所。

首先，家长要让孩子承担更多的责任，比如打扫、整理或喂狗。最重要的是要让孩子承担尿床后的部分善后工作，孩子应该自己换掉尿湿的睡衣裤，7 岁左右的孩子就应该自己换尿湿的床单并负责清洗。（记住，这些工作并不属于对孩子的惩罚，避免让孩子承担全部的工作，给他们额外的奖励，让他们在承担工作之余得到肯定。）这些工作

能够帮助孩子培养责任感，如果他们无法胜任全部的工作，家长可以帮忙，这样孩子就会对家长产生感激，亲子关系也会变得更好。

其次，建立一套奖励机制，记录下孩子不尿床的日子，然后进行奖励。家长可以结合日历本做一个积分表，实践证明，这样的方法效果很好，特别是对 10 岁左右的儿童来说。要是哪一天孩子没有尿床，就在那个日期下画上五角星，等五角星积累到一定的数量，就对孩子进行奖励。

| 膀胱承受力训练及“开始-结束”训练 |

这两种训练的目的在于让孩子尽可能多地憋尿，锻炼其控制能力。每天在固定的时刻让孩子憋一次尿，以出现不适为限。然后让孩子排尿，记录下排出的容量。随着训练的深入，每次排出的容量应该逐渐增加，这意味着其膀胱承受能力在逐渐增强。一开始，可以记录下两天内最大的那次容量，然后以此为标准，一旦有超过这一数值的，就更换标准。同时，记录下孩子一天排尿的次数：如果孩子每 3~4 小时排尿次数超过一次，可以让他在排尿前多等待 15~30 分钟，直到他能做到在 3~4 小时内只排尿一次为止。

与此同时，坚持每天执行一次“开始-结束”训练，即在排尿时，让孩子人为中止排尿过程，并保持一定的时间，然后再允许其继续排尿，以锻炼孩子的控制能力。

只要孩子能做到连续两周不尿床，就可以进一步拓展这两个训练：让孩子在白天喝更多的水，在睡前喝 2~4 杯水，以便让他在睡眠状态下继续锻炼控制能力。

| 药物治疗 |

如果行为矫正法收效不明显，可以考虑使用药物治疗。在使用药物治疗前，应该先咨询儿科医生的意见。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

最常用的药物是去氨加压素。这是一种人造激素，与人体自然产生的激素后叶加压素类似，因此又被称为“抗利尿激素”。后叶加压素一般在夜间分泌，帮助人体从尿液中过滤水分补充到血流中。经过过滤的尿液变少、变浓，从而降低夜间尿床的概率。

有证据表明，有些尿床的儿童在夜间分泌的后叶加压素比正常儿童要少，但是，他们的激素水平是否比正常值要低还不得而知。夜间服用去氨加压素能降低尿床的概率，但是，对6岁以下的儿童不推荐使用。当出现特殊情况，如需要外宿、旅行或野营时，可以借助去氨加压素。当然，对年龄稍大、频繁出现尿床且其他矫正方法都无效的孩子来说，也可以每晚服用。家长要明白，药物本身是不可能消除致病的根源的，所以当药物停用时，尿床现象又会出现。

想要根除尿床是很困难的，持续的尿床现象会让人感觉束手无策。尽管本章介绍的方法无法保证一定会根治成功，但是，只要方法得宜，大多数孩子的症状是可以减轻的，部分孩子甚至能根除。尿床算是较为和缓的睡眠问题，但是也会严重干扰到睡眠。家长应该对尿床有一个较深的了解，然后对孩子的需求要合理回应。主动与孩子合作，帮助孩子减少因为尿床而备受折磨的时间，提升其自尊心，亲子关系会因此变得更融洽，孩子的社交生活也会变得更好。这样一来，治疗尿床的目的反而更容易达成。

第16章 怪异而有节律的动作

有些儿童在夜间会表现出有节律的怪异行为，比如前后摇晃身体、转动脑袋，或者反复拿脑袋去撞击墙壁等硬物。这些行为会让家长感到奇怪与担忧，特别是当家长无法明白出现这些行为的原因与其背后的含义时，家长的忧虑就会更深。

> 贾森是一个两岁的健康宝宝，平时行为举止正常。在他7个月大时，父母发现每天入睡前，他都要前后摇晃身体5分钟左右。不久之后，这种行为发展为用头去撞婴儿床的围栏，每晚重复，一直持续到现在。通常，他会在20分钟内停止这种行为，有时候会延长到一小时左右。更糟糕的是，他渐渐出现在半夜醒来后撞头的行为，每夜1~2次，每次持续45分钟左右。
>
> 他的这种行为常常会导致婴儿床移位，对睡在里面的宝宝来说，这是非常危险的。父母在婴儿床四周加上软垫，可是即便如此，贾森还是能找到更硬的地方继续撞头，或者干脆将垫子推开。父母只好在地板上铺上软垫与铺盖，让他睡在上面，可是他仍旧会爬到墙边，然后撞头。

通常，这样的行为出现在夜间，也可能出现在孩子早晨醒来后，还有的孩子会在日间睡眠前或夜间醒来后再次入睡前出现这样的行为。当然有些孩子仅仅在半夜醒来后才会出现这样的行为，他们其实是处于浅眠阶段或昏昏欲睡中，一旦进入较深的睡眠，这些行为就会停止。在清晨出现这些行为的孩子，则会在完全清醒后停止动作。

虽然看上去很怪，可是这些有节律的行为却是儿童成长过程中的一部分。绝大多数婴幼儿在日间会出现有节律的前俯后仰，一般持续几分钟，通常发生在他们坐着时，周围环境中充满音乐。少数儿童会出现其他有节律的动作，比如撞头或摇晃脑袋，通常出现在夜间睡眠中或白天小睡时。男孩子出现撞头的概率是女孩子的三倍，但是身体的有节律动作出现的概率却基本上保持着男女一致。

有些孩子在有节律地执行动作时，会发出同样有节律的声音，通常这些声音是响亮而连续的，声音的强度与音准和其动作完全吻合，可以参考图 16—1。

图 16—1　有节律的动作和声音完全吻合

家长应该何时干预怪异而有节律的行为

出现有节律的行为并不意味着孩子有潜在的心理问题或神经性疾病，一般情况下，这种行为在孩子 18 个月大时出现，到了三四岁就会自动消失。绝大多数出现有节律行为的孩子身心都非常健康，家庭氛围也很融洽。不过，身体存在缺陷的儿童比正常儿童更容易出现此类行为，特别是精神状况异常、双眼失明或有自闭症倾向的儿童。

只有当儿童到了 4 岁以后仍旧反复出现此类行为时，家长才需要采取措施。记住，即使是在年龄稍大的儿童身上，只要行为持续时间不长、强度不大，比如出现了轻微的摇头晃脑或者重复几次撞击枕头的行为，家长也不需要过分担忧。有可能孩子仅仅是将这样的行为与入睡联系起来了，使其成为了入睡前的习惯动作而已。除去年龄因素，家长应该关注此类行为的持续时间与强度，如果持续时间超过 10 或 15 分钟，且在夜里反复出现，家长就应该注意。留心观察，仔细判断，然后采取措施。

怪异而有节律的行为出现的根源

本章介绍的大部分有节律行为都属于儿童成长过程中的一部分，除了正常生长这个因素之外，还有其他因素会导致这些行为的出现。

1. 正常生长过程的组成部分　婴幼儿会用自己的方法来找乐子，他们天生就会对有节律的外界刺激产生反应，这就是为什么婴幼儿喜欢听摇篮曲、喜欢被人抱着轻轻晃动的原因。节律感能让儿童感觉到愉悦和舒适，就像成年人会跟着音乐打拍子一样。婴儿通过有节律地吮吸奶嘴、手指和母亲的乳头来获得快感，稍微长大一点，他们就会从有节律的晃动中找到类似的快感。在儿童的成长过程中，等他们发展出新的思考、倾听、行为模式时，就会逐渐改掉这些行为。

这些有节律的行为出现得非常早，通常在婴儿一岁之前就已经出现了。婴儿一般在6个月左右就有可能出现身体有节律的行为，到了9个月时，就会有节律地撞头和转动脑袋。此类行为持续时间短则数周，长则数月，通常在出现后一年半之内就会彻底消失。孩子满4岁之后，就很少出现这种行为了。

2. 作息不合理　尽管作息不合理不会单独引发有节律的怪异行为，但是特定的作息问题会延长行为发作的时间，增加其强度。调整作息是矫正有节律行为的关键。

有节律的怪异行为通常发生在儿童清醒时、昏昏欲睡时及睡眠阶段转换时的浅度睡眠期，一旦进入深度睡眠，发生的概率就大大降低。所以，如果在就寝后入睡前出现了大块的时间富余，就会增加孩子在这一时间段出现撞头或摇头晃脑的可能性。

3. 习惯　让人感觉心情放松的习惯会将我们从日常的遐思或焦虑中解救出来，这些习惯既强势又具有自发性，成年人和儿童一样，都会在日常生活中展现出这样的习惯：在思考或谈话中，不由自主地抖脚、做鬼脸或保持交叉双腿的坐姿。当大脑意识到身体在重复这些行为时，会发出阻止指令，但是，注意力一转移，这些行为就会重新出现。同时，这些行为越是被反复执行，其自发性就越强，要改掉也就越难。如果有节律的行为发生在入睡时，孩子就有可能将这种行为与睡眠联系起来，而一旦将入睡与有节律的行为联系到一起，他就会将这种习惯延续到半夜醒来时。最终，这种有节律的行为发展成为一种自发性的习惯，从孩子入睡开始直到进入浅眠阶段为止，一直持续出现。

4. 情感需求　有的时候，儿童出现有节律的行为是对焦虑感的一种反应。即使这种

行为无法根除焦虑，也有助于缓解担忧与不安。而有些孩子之所以会出现有节律的行为，是为了引起父母的关注。要是家长在这种行为出现时不加以限制，就会放任其成为一种恶习。

5. 神经系统发育缺陷 神经系统发育迟缓的儿童会表现出自闭、智力发育迟缓等倾向，这些儿童通常会从有节律的行为中获得某种自我刺激的快感。他们与正常的婴幼儿一样，由于生理、知觉及认知能力受到限制而阻碍其通过其他途径分散注意力或获得宽慰，导致其出现节律性行为的原因与正常的婴幼儿出现这些行为的原因类似。然而，正常儿童不会因为重复这些节律性的行为而弄疼或弄伤自己，有些生理有缺陷的儿童会由于其节律性的行为而出现自残，并从中获得某种快感。对这些儿童，就需要通过外力阻碍或禁止其自残行为。

6. 家族遗传 在有些家族里，有节律的行为不是个别的，而是普遍出现在几代人身上，这种现象比较罕见。由遗传因素导致的有节律行为通常持续时间较短，强度也不大，这些儿童的作息也比较规律，其节律性行为甚至会随着时间的推移而逐渐变得和缓。

7. 先天性睡眠障碍 通常有节律的行为不会从浅眠阶段延续到深度睡眠阶段，但是，在个别情况下，有些儿童的有节律行为就发生在深度睡眠阶段。这些儿童会在各种环境下反复做出有节律的行为，比如在父母的床上、在祖父母或朋友家里，或者在家里和保姆待在一起时。当症状出现时，即使父母进入他们的卧室，孩子也无法意识到，也无法对父母的问话产生回应，这是因为孩子还处于深度睡眠中，没有醒来。

怪异而有节律的行为的解决方法

家长对孩子出现节律性行为的原因与表现有了一定的了解之后，就可以据此决定解决方法了。方法有很多，我们会在下文一一介绍。

1. 调整睡眠规律 解决儿童睡眠习惯问题的最好方法应该是适当调整其夜间作息规律，让其在夜里始终处于困倦状态而无法长时间醒来。如果调整得宜，不适宜的行为会立刻大幅减少，孩子即使在夜间醒来也不会再次重复有节律的行为。久而久之，孩子就会习惯新的作息，即使在不那么困倦的时候也不需要依赖有节律的行为入睡。

2. 应对孩子的情绪问题 学龄儿童出现强有力而又持久的有节律行为可能暗示其出

现了情绪问题，此时就需要家长介入。家长对孩子合理的要求应该予以满足，但是不能允许其通过有节律的行为来获取家长的关注，否则就有可能强化这种行为。在白天多花点时间陪陪孩子，让他感觉到你非常享受与他在一起的时间。设定一个从容的睡前互动模式，主动给予孩子关心，而不要等孩子通过有节律的行为来吸引家长的关注。家长也可以在孩子就寝后待在隔壁房间，不时进入孩子的卧室去看看他，直到他睡着为止。

3. 直接进行行为矫正　有的婴幼儿会躺在婴儿床上不停摇晃，让婴儿床跟着摇晃起来，甚至可能导致婴儿床挪动，家长可以在地板上铺上被褥，让孩子睡在地板上。要是孩子的有节律行为不是摇晃而是撞头，这种方法就不管用了，因为即使将被褥铺在卧室中央，孩子还是会在入睡前爬到墙角对着墙撞自己的头。

家长也可以通过奖励的方法来鼓励孩子放弃有节律的行为，可以为其设定一个目标，达到目标后就给予一定的奖励。为了使激励机制发挥最大的作用，家长可以在实施激励机制的同时延迟孩子的入睡时间，并缩短其总的睡眠时间。

白天，可以让孩子荡秋千或坐木马，以此满足其对节律刺激的需求，也可以让他听听韵律感较强的音乐或玩摇摇椅。如果孩子能在白天得到足够的刺激，其夜间对有节律行为的需求就会降低。

4. 防范措施与药物治疗　有自闭倾向及精神异常的儿童，尤其是有严重精神障碍的儿童，会一直保持有节律的行为，极有可能伤害到自己。家长可以给这样的孩子戴上头盔，或者进行适当的束缚，也可以在床的四周铺上软垫子。对这些孩子也可以像对正常孩子那样，通过减少其睡眠时间来减少有节律行为的出现。必要时可以给以药物治疗。

尽管贾森只有两岁，他的撞头行为可能会在将来的一年左右自行停止，但是由于其行为持续时间过长、强度过大、频率过快，我们决定对其进行干涉。贾森每晚 7 点上床睡觉，第二天早晨 7 点起床，白天有一次 2 小时的小睡，这样一来，他 24 小时内的睡眠时间达到了 14 小时，比同龄人多 2~3 小时。因此，我建议将其入睡时间调整到晚上 9 点，早晨起床时间提前到 6 点，日间小睡时间缩减到 90 分钟。

作息调整后，他的撞头行为大幅减少，变成在入睡时会出现 10 分钟，半夜醒来时可能会重复 1~2 次，每次不超过 10 分钟。几周后，持续时间变得更短，强度也变得较为和缓，我们又逐渐将其睡眠时间增加到 10 小时，从晚上 8 点半到第二天早晨 6 点半，

同时将其日间小睡时间挪后 2 小时。这样一来，他在床上的富余时间就全部被取消了，而撞头行为也变得更加短暂，出现间隔也更长了，贾森的情况大大好转。

有节律的行为并不像初看时那样怪异，导致其出现的原因通常能够确定，而其出现并不意味着儿童有着内在的心理问题。大多数情况下，采取适宜的方法，这些行为是可以被大幅减少甚至戒除的。

大多数家长都不重视孩子在睡觉时打鼾，但是，打鼾可能意味着孩子在睡眠中出现了严重的呼吸问题，有可能是阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的征兆，需要进行治疗。即使没有出现阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，打鼾也会影响孩子夜间呼吸的顺畅性，干扰其睡眠，从而影响其白天的行为举止与学习能力。

睡眠呼吸暂停综合征是怎么回事

内科医学界关注睡眠呼吸暂停综合征由来已久，但直到20世纪70年代，睡眠问题实验室的出现才让世人明白此类综合征的普遍性。尽管此类综合征的目标人群一般是中年男子与绝经后的妇女，但是也有不少儿童受此困扰。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

所谓“呼吸暂停”是指暂时停止呼吸行为。当患有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的儿童处于睡眠状态时，其上呼吸道会反复收缩或关闭，通常每8~10秒钟出现一次。当出现这种症状时，无论怎样用力呼吸，都无法让空气进入呼吸道。

在睡眠呼吸暂停过程中，如果呼吸道中还留有空气，就会引发打鼾。当呼吸道中的空气比较少时，鼾声显得轻微而短促；当呼吸道中的空气较多时，则会出现响亮而连续的鼾声；当气流平稳通过时，鼾声就又会变得轻微和缓。要是气流暂时完全堵住了呼吸

道，就不会出现一点声音了，因为此时人体暂时停止了呼吸。当气流减小时，血液中的氧气含量也随之降低，8~10 秒钟之后，人就会慢慢醒来，调整舌头与喉咙的状态，以便空气进入呼吸道，逐渐恢复成顺畅的呼吸。

导致睡眠呼吸暂停的阻塞通常出现在喉咙的后部，舌根背部。这个部位的肌肉相对松弛，一旦垮下来，舌头就会往后阻挡住气流的进入。图 17—1 是人体上呼吸道的剖析图，其原理有点类似于吸管。“吸管”完好无损，人就能顺畅呼吸，但是，如果在“吸管”中间折几下，“吸管”就会变得不那么僵硬。如果此时呼吸太急太快，就有可能让“吸管”上最脆弱的部分失灵。如果此时捏住“吸管”的另一头，就会导致“吸管”失灵，并出现阻塞现象。这就是儿童在睡眠呼吸暂停时经历的情况，呼吸道被增大的扁桃体或淋巴组织阻塞。为了获得更多的空气，儿童会拼命呼吸，喉咙后部较为松弛的区域就容易出现阻塞。

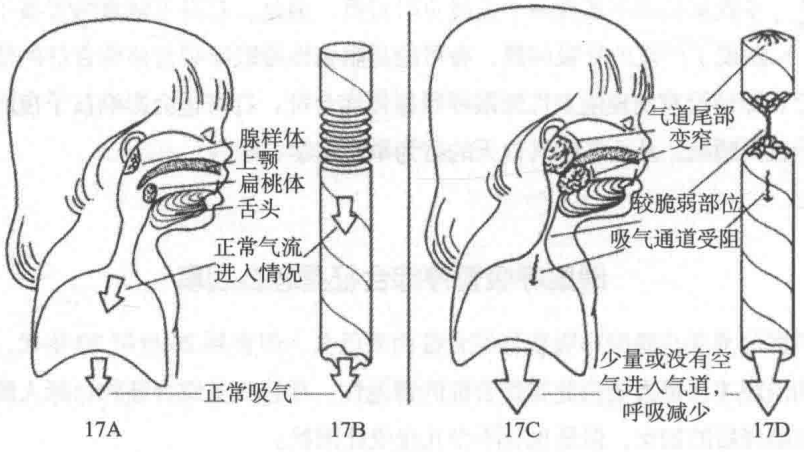


图 17—1　阻塞性睡眠呼吸暂停综合征

17A 显示的是正常情况下的呼吸行为，图中所示的是正常大小的扁桃体和腺样体，吸气时只要稍稍用力就可完成，就像用一根通畅的吸管吸气一样（17B）。

在 17C 中，增大的扁桃体及腺样体使呼吸道变窄，呼吸时需要非常用力才能让空气进入狭窄的气道。而吸气又会导致扁桃体与腺样体下面的脆弱部分闭合，从而导致气流无法进入气道，就像用一根一头封闭且中间扭曲的吸管吸气一样（17D），这就是阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的产生原理。

与成年人不同，儿童的睡眠呼吸暂停并不是出现了呼吸道被完全阻塞的情况，也就

是说，此时儿童仍旧可以呼吸，只是比较费力而已。他必须拼命呼吸才能让空气进入呼吸道，虽然这种努力能够满足人体对于空气的需求，但是，过分用力地呼吸会干扰睡眠。呼吸困难程度因人而异，即使对同一个儿童来说，在夜间的不同时间段，其呼吸困难程度也是不同的。

最容易出现睡眠呼吸暂停的姿势是仰卧，因为此时舌头往后，容易阻塞呼吸道。最容易引发睡眠呼吸暂停的时间段是快速眼动期，因为此时头部与脸部肌肉处于极度放松的状态。相反，要是侧睡或处于非快速眼动期，呼吸就会顺畅很多。入睡后 3~4 小时的深度非快速眼动期是呼吸最顺畅的阶段，而后半夜则是呼吸较为困难的阶段，因为此时会出现持续时间较长、较为激烈的梦。

什么导致了阻塞

只要上呼吸道受阻变窄或喉咙内组织出现不正常的松弛就有可能导致睡眠呼吸暂停。很多患有睡眠呼吸暂停的成年人都有一个又短又粗的脖子，他们体重超标，喉咙里有大量柔软松弛的脂肪组织，从而使得气道变窄。与成年人类似，肥胖也是导致儿童出现睡眠呼吸暂停的主因之一，而肌肉力量较弱或有肌肉控制缺陷的儿童（比如患有肌肉萎缩症、肌肉痉挛、肌紧张减退等疾病）出现睡眠呼吸暂停的概率也会大大增加。

鼻部异常，比如鼻中隔偏曲和鼻息肉也有可能导致阻塞，但其导致阻塞的可能性较小。鼻部过敏导致的阻塞有可能引发打鼾现象，但不会引发严重的睡眠呼吸暂停。患有唐氏综合征的儿童也有可能出现睡眠呼吸暂停，这些儿童的舌头过于肥大，而鼻部通道则较小。由于长年流鼻涕，其扁桃体大面积受到慢性感染，加上神经系统异常，无法控制舌头与喉咙的肌肉，所以这些儿童出现睡眠呼吸暂停的可能性很高。

| 扁桃体增大及腺样体肥大 |

对绝大多数患儿来说，扁桃体增大或腺样体肥大是导致其出现睡眠呼吸暂停的主要原因。扁桃体是粉色的扁卵圆形团块，在口腔后根部，舌头上方，附着在两侧喉咙内壁上。扁桃体受到感染时会变得肿大，等感染消失后，通常会缩回到原来的尺寸，但有时会一直保持肿大状态。

不借助专业设备是很难看到腺样体的，它附着在喉咙的后部，口腔的顶端，看上去

与扁桃体差不多。腺样体肥大会阻塞正常的气流通过鼻部进入人体，而迫使人改用嘴巴呼吸，这会导致儿童说话时带有鼻音，鼻子的负担就会加重。

由扁桃体或腺样体肥大导致呼吸困难的儿童在睡眠中会打鼾，而且可能持续数年之久，随着时间的推移，打鼾的情况有可能恶化，也有可能一直维持在某一个水平上。在少数情况下，打鼾会引发一次突如其来的扁桃体炎。由于冬天感冒频发，这个季节呼吸困难的程度会加重。

> 格蕾丝是一个三岁的小女孩，她是典型的呼吸困难患者。在白天，她精神很好，也非常开朗。她有午睡的习惯，可有时候即使睡了午觉，她也会表现得很疲倦。她的行为举止良好，与其他孩子的相处也非常融洽。在她三个月大的时候，她开始出现打鼾现象，并逐渐恶化。
>
> 现在她几乎每晚都要打鼾，声音非常响，能把整座房子的人吵醒。在睡眠中，格蕾丝看上去呼吸困难，她的嘴巴总是张开，有时候她的胸腔往里凹进去，而不是像正常呼吸时那样往外凸出。她的父母发现，有时候她的胸部虽然在起伏，却没有气流吸进吐出，每当这时他们就会唤醒她，让她重新正常呼吸。格蕾丝在被唤醒后会颤抖，当空气进入她的肺时，她会发出奇怪的声音。当她感冒时，情况就更糟了。

为了搞清楚在睡眠状态下，格蕾丝到底经历了什么，我们让她在实验室里睡了一晚。我们整晚都在检测她的睡眠阶段及气流进出身体的情况，记录下胸腔与腹部随着呼吸的进行而出现的起伏运动。我们使用传感器检测设备检测出她的血氧含量及肺部二氧化碳的含量，结果发现格蕾丝的情况比大多数患有睡眠呼吸暂停的儿童要严重得多。

在夜间，格蕾丝要经历350次完全或部分阻塞导致的呼吸异常，每次持续8~55秒钟，这个数字非常惊人，绝大多数正常儿童根本连一次都不会有。她1/4的睡眠时间花在了经历呼吸困难上。在前半夜，她睡得很好，尤其是在深度睡眠的非快速眼动期，她的呼吸顺畅，打鼾也很轻微。但是在其余时间里，她的呼吸就出现受阻现象，她必须要挣扎着才能呼吸，睡眠质量一落千丈。在经历呼吸受阻时，她的血氧浓度明显下降。在快速眼动期，格蕾丝全身放松，喉咙的肌肉也处于松弛状态，呼吸受阻就会随之出现。

格蕾丝这样呼吸困难真是让人心疼。尽管她的睡眠频繁被呼吸困难打断，但是她在

白天并没有表现得很疲劳，也没有出现易怒现象。我告诉格蕾丝的父母，他们的担心是合理的，但是只要努力，格蕾丝的情况就会好转，这让她的父母安心不少。

肥　胖

体重严重超标的儿童更容易出现睡眠呼吸暂停。绝大多数内科医生对匹克威克综合征都不陌生，这种综合征是指儿童既有严重的体重超标问题又非常嗜睡。这个名词来自于查尔斯·狄更斯的《匹克威克外传》，里面有一个角色乔就是如此。书上描述乔是一个“肥胖、红脸的男孩”，看上去总是“处于一种昏昏欲睡状态”。

> 贾斯丁今年12岁，有两个问题一直困扰着他：第一，他的体重超过了82千克，非常肥胖；第二，即使晚上睡得很好，他在白天还是很容易犯困。他总是会在上课时睡着，在家里做作业时也会趴在桌边睡着，因此，他五年级留了一次级。他的家长与老师都认为他这样容易犯困是因为他太懒了，所以总是生他气。

当他们一家到我这里来时，根本没有提及他打鼾的问题，他的父母只是对他总是犯困感到担忧。在交谈中，我了解到，贾斯丁已经有好几年在睡觉时打鼾了，这说明他的问题比格蕾丝更加严重。他每晚要经历600次呼吸困难，每次持续20~70秒钟。他在睡眠中处于缺氧状态，血氧浓度在阻塞消失后也不一定会恢复到正常水平。与格蕾丝不同，贾斯丁根本没有深度睡眠，也很少有规律顺畅的呼吸。这就是为什么他在白天总是犯困的原因了。

睡眠呼吸暂停的治疗方法

对绝大多数儿童来说，扁桃体与腺样体肥大是导致睡眠呼吸暂停的主因，在这种情况下，我们建议患儿进行扁桃体与腺样体肥大组织的切除手术。例如，格蕾丝的扁桃体与腺样体过于肥大，尽管她没有出现耳部或喉咙的感染，我们依然认为她需要进行切除。手术后，她的情况明显好转，夜间呼吸变得轻松安静多了，睡眠质量也大大提高。

如果孩子像贾斯丁那样过于肥胖，治疗方案中还应该增设减肥计划，这有助于睡眠呼吸暂停自行痊愈。除此之外，可以进行药物治疗。例如，贾斯丁的扁桃体过于肥大，在切除后，他的睡眠情况有了很大改善，呼吸也顺畅多了，但距离正常标准还有很大差

距。接下来6个月，贾斯丁执行了严格的减肥计划，足足减了36千克。现在，他很少会在夜间出现气道阻塞了，睡眠变得连贯，睡眠质量也大大提高。

如果引发儿童睡眠呼吸暂停的原因是口腔或面部异常，则需要对其进行矫正手术。例如，孩子的下巴往里缩进得很厉害，可以通过手术进行调整。做手术是件大事，尽管可以预见会对患儿的情况有所改善，但是无法确保能够完全治愈。如果引发儿童睡眠呼吸暂停的原因是咽后瓣成形术的后遗症，则可以通过手术移除或削薄咽瓣，让空气有足够的空间通过。

另外，可以考虑使用持续正压通气呼吸机（CPAP），如图17—2所示。在夜间睡眠时，让儿童戴上一个面罩，覆盖口鼻。面罩通过一根管子与电泵连接，在夜间持续将空气送入孩子的鼻部通道，只要其压力大于孩子吸气时的压力（具体数值由专业机构设定），气管就会始终处于开放状态，从而让孩子自由呼吸。面罩的材质与尺寸多种多样，以让人感觉舒服为宜，即使对婴幼儿也有专门的面罩提供。面罩可以连接到加湿器上，以防止空气变得干燥。

图17—2　持续正压通气呼吸机的使用

对某些患有睡眠呼吸暂停的儿童来说，最好的治疗方法就是每夜使用持续正压通气呼吸机。睡觉时，儿童戴上一个特制面罩，持续正压通气呼吸机就会将空气通过一定的压力送到鼻部，以防止阻塞产生，确保儿童夜间呼吸顺畅。

此外，咽形成术也是治疗睡眠呼吸暂停的方法之一，包括通过手术使喉咙肌肉变得紧致或通过激光治疗减少其松弛性。这两种方法对成年人来说，通常是组合使用的，但

是用在儿童身上效果不佳，可能是因为儿童的喉咙肌肉不像成年人那样松弛。对成年人来说，可以通过多种方法调整口腔、舌头或下颚的位置，但是由于畸齿矫正学及安全上的考量，这些方法都不适用于儿童。同时，药物治疗亦不适用于儿童。

所幸，绝大多数儿童的睡眠呼吸暂停都可以通过移除扁桃体或腺样体、减肥来加以解决，少数案例需要进行口腔或整形治疗。同时，由于 CPAP 的普遍使用，很少案例需要采取气管造口术。扁桃体移除术及腺样体切除术是两种相对简单的手术，在治疗过程中也使用得比较多，即使对情况不甚严重的儿童也可以采用。

有关睡眠呼吸暂停的注意事项

患有睡眠呼吸暂停的儿童睡眠质量不高，其学习能力、注意力、行为控制能力都会受到影响。家长通常容易忽视孩子白天表现出来的症状，从而错过治疗期。睡眠不足会导致儿童出现多种行为问题，比如极度活跃、易怒、注意力难以集中、健忘、懒散等。患有睡眠呼吸暂停的儿童也会出现其他睡眠问题，比如遗尿、夜惊、做噩梦、梦游等。在个别睡眠呼吸暂停非常严重的案例中，心电图显示儿童心脏活动过度，偶尔会出现血压升高的现象。体重超标的儿童还会出现成年人才有的各种睡眠呼吸暂停症状。

睡眠呼吸暂停可能会变得非常严重，需要内科医生的专业诊断与治疗。成年人的睡眠呼吸暂停如果不及时进行治疗，可能会引发严重的心脏疾病，偶尔会因为血氧浓度偏低而导致心律不齐，从而引发致死危险，也有可能会在开车时出现呼吸暂停而导致交通事故。所幸儿童的心脏比成年人更有活力，而且儿童也不会开车，所以睡眠呼吸暂停导致儿童死亡的概率比较低。但是尽管如此，也不是没有致死的可能性，当儿童服用镇静剂时就可能由于药物作用降低其呼吸的自发性，从而出现致死危险。

关于如何判断儿童是否患有睡眠呼吸暂停综合征，可参见表 17—1。

表 17—1　　如何判断儿童是否患有睡眠呼吸暂停综合征

主要症状
• 打鼾
——响亮、刺耳、短促、带着鼻音
——通常整座房子都能听到（如果需要站在孩子床边才能听到，就表示症状轻微）
——几乎每夜出现（并不是偶尔出现，也不是只有在感冒时才出现）
——通常在后半夜出现
——仰卧时出现

续前表

• 呼吸困难 ——需要非常用力或挣扎着才能呼吸 ——嘴巴通常是张开的 ——当吸气时，胸部不是凸出而是凹进的 ——睡眠躁动不安 ——反复出现阻塞：呼吸困难并伴有非正常觉醒现象，呼吸时有响亮的鼻音，会出现打鼾、喘气或呼吸粗重等现象 ——出现完全阻塞：出现剧烈的呼吸行为（胸部和腹部起伏明显），但是气流却被完全阻塞，无法进入气管
儿童常见的相关征兆 • 扁桃体或腺样体肥大，经常出现喉咙或耳部的感染，体重超标，下颚、嘴巴或喉咙异常 • 白天较少出现明显的困倦迹象，但是会出现易怒、注意力无法集中、学校表现不佳等问题 • 出现其他睡眠问题：遗尿、夜惊或觉醒障碍
其他症状（常见于成年人而较少见于儿童） • 白天昏昏欲睡 • 早晨头痛 • 出现“自发性行为”（在没有完全清醒的情况下完成日间的例行活动） • 心血管问题（高血压和心电图异常）
睡眠研究实验室环境下的发现 • 反复出现呼吸阻塞 • 血氧浓度偏低（总是） • 二氧化碳浓度偏高（经常） • 睡眠被干扰（程度有所不同） • 心脏节律异常（儿童身上不常见）

嗜睡症并不是一种普遍性的疾病，但也不算疑难杂症。在美国，每2 000个儿童中就有一个儿童患有嗜睡症，患儿中有一半会出现多发性硬化症，有很多甚至会出现囊肿性纤维化。性别对发病的影响不大，男女发病的概率均等。

> 布伦丹在到我这里求助前已经经历了两年固定午睡的日子，他在每天下午要睡40分钟到一小时。他总是在吃完晚饭后就上床睡觉了，从晚上7点开始，睡到第二天早晨6点半。布伦丹已经10岁了，他的作息不符合这个年龄段的标准。有时候在学校里，他也会忍不住打瞌睡，每次睡10~15分钟，当然大多数情况下，他能撑到放学回家再睡。我第一次见到他时，他在读四年级，面临着一大堆社会问题与学业上的问题。他的老师对他的情况也很关注，建议他父母带他去找专业人士咨询。

布伦丹患有嗜睡症，其主要症状就是昏昏欲睡。患有这类病症的儿童最终会出现其他症状：在白天会突然身体不适，可能会出现暂时性的身体瘫痪，偶尔会在入睡或行走时出现幻觉（分别被称为睡眠性麻痹及临睡幻觉）。

嗜睡症通常发作于青少年时期，但是也有例外，布伦丹就是其中之一。在确诊并接受治疗之前，布伦丹已经遭受嗜睡症困扰数年之久了。绝大多数嗜睡症患者需要10年甚至更长时间才能被确诊，这并不是因为病情复杂，而是因为嗜睡症的征兆与特征很容易被忽视或误解。

当然，并不是所有容易犯困的儿童都患有嗜睡症。嗜睡有可能是其他睡眠问题的表现，也有可能是抑郁的征兆。一般人很容易将嗜睡与“懒散”或“呆滞”联系起来，这种错误的想法就连内科医生也会有。其实嗜睡是一种很严重的疾病，需要认真对待。

嗜睡症对孩子的影响及症状

患有嗜睡症、出现特发性嗜睡症或患有睡眠呼吸暂停是导致睡眠异常的三大主因。嗜睡症通常出现在青少年或年轻人身上，大概 50% 的嗜睡症患者在 16 岁左右开始出现症状，而嗜睡的症状一旦出现，就再也不会消失了。如果症状出现在儿童期，在进入青少年时期后就会恶化。在怀孕期间，嗜睡情况会发生暂时的变化，有可能变好也有可能恶化。而且，在经过青少年时期后，嗜睡的症状就会稳定下来，持续数年。而嗜睡症的症状复杂多样，其程度与频率都会因人而异。

嗜睡症通常会与癫痫症搞混。事实上，这是两种截然不同的疾病，尽管有时两者都表现出某种程度的癫痫症状。对患有嗜睡症的人来说，其睡眠系统在白天无法正常工作，在夜间也总是出错。尽管快速眼动期与非快速眼动期都会受到嗜睡症的影响，但是通常是快速眼动期会在错误的时间出现，从而导致症状的出现。

| 嗜睡症导致睡眠中断 |

撇开误解，其实绝大多数嗜睡症患者得的都不是真正的“特发性”嗜睡症，因为其 24 小时内的睡眠时间是正常的或接近正常的，并且他们会出现深度睡眠。通常，他们的夜间睡眠会被多次短暂的清醒所打断，就像他们在白天的清醒期总是被日间小睡打断一样。对他们来说，与其说睡眠是集中在夜间的，不如说是分散在 24 小时之内的。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

患有嗜睡症的儿童通常很早就寝，有些甚至在放学回来后就直接睡了，睡眠时间长达 11~16 小时。与成年人不同，嗜睡症患儿的睡眠质量较高。

我们在上文提及过，嗜睡症的另一个主要特征是快速眼动期在入睡后不久就会出现，或者在入睡后 10 分钟就会出现。除嗜睡症之外，只有极少数的情况才会导致快速眼动期提前出现，这些情况包括：服用了减少快速眼动期睡眠的药物、早晨睡回笼觉、经历多时区旅行后出现时差感、睡眠不规律及总是熬夜。

由于嗜睡症并不会导致每次睡眠都从快速眼动期开始，所以仅仅观测一次日间睡眠或夜间睡眠是无法确诊的。可以通过 MSLT 测试，反复检测日间睡眠，如果在测试中，孩子只需要几分钟就能入睡，且在至少两次日间睡眠中都在入睡后迅速进入快速眼动期，就可以断定孩子患有嗜睡症。

| 嗜睡症的主要症状 |

昏昏欲睡与猝倒是嗜睡症的两大特征，如果同时具备这两个特征，那十有八九是得了嗜睡症。

➤ 昏昏欲睡

患有嗜睡症的儿童总是表现得昏昏欲睡。如果周围环境中没有特殊的刺激让其保持清醒，他们会很快进入睡眠状态。他们会时不时地感到困倦，这种困倦可能来得非常迅速，此时，如果让他们站起来活动活动或给予一定的刺激，就可以击退睡意。

其实嗜睡症患儿并不像传说的那样会毫无预警地突然睡着。正常人偶尔会觉得睡意袭来时势不可当，而嗜睡症患者每天都在经历无法抗拒的困倦，他们想要进入睡眠状态的意愿比一般人强烈得多。每个患者感受到的情况都是不同的，只有一点是类似的，那就是睡意随时可能出现。当睡意袭来后，嗜睡症患者只有通过身体的活动才可能保持清醒。就算勉强保持了清醒，他们也会觉得头昏脑涨，注意力大幅下降。

➤ 猝　倒

猝倒是指由于出现强烈的情绪反应，身体肌肉突然失去张力，甚至出现短暂的瘫痪。这种症状让人非常不安，也非常危险。大笑和生气是典型的引发猝倒的因素，除此之外，任何强烈的情绪波动都可能导致猝倒的出现。

SOLVE YOUR CHILD'S SLEEP PROBLEMS **知识补给站**

猝倒出现的频率、强度及持续时间因人而异。有的孩子的猝倒非常轻微，比如膝盖弯曲、下颚下垂或者抬不起头来，也有的孩子会忽然摔到地上，全身肌肉瘫痪。绝大多数的猝倒只会持续几秒钟，少数会持续数分钟。持续几分钟的猝倒最终会发展为睡眠。

严重而又频繁出现的猝倒如果不经治疗，会严重损害人体健康。要是肌肉失去张力的程度较重，即使是偶尔出现的猝倒也会非常危险。尽管猝倒不太会造成严重的损伤，

但是突如其来的猝倒可能会让人失手打破装满热水的杯子，或者从楼梯上滚下去。在室外危险更多：骑车的儿童可能摔倒在马路上，成年人则可能遭遇车祸。

除某些表面特征类似之外，猝倒和癫痫是完全不同的两种病症。当患者处于某种特殊的情况下时，比如受到惊吓或性兴奋，旁观者可能会认为其表现出来的症状是患者自己想象出来的或“歇斯底里”的，可事实上这些症状是真实存在的。猝倒时出现的肌肉无力与一般人处于快速眼动期时身体类似瘫痪的情况非常相似。身体系统控制快速眼动期瘫痪状态的部分会在白天突然启动，而不是在夜晚的快速眼动期启动。

嗜睡症的其他症状

除了上述两种症状之外，嗜睡症患者还会表现出两种症状，即睡眠性瘫痪与入睡幻觉。这两种症状不能作为确诊的依据，因为并不是所有的患者都会出现这两种症状，而且没有嗜睡症的人也有可能出现这两种症状。

➤ 睡眠性瘫痪

人在出现睡眠性瘫痪时，意识是清醒的，却无法动弹。睡眠性瘫痪出现在入睡时或清醒与睡眠的转换间隙，与快速眼动期身体类似瘫痪的情况相似。绝大多数睡眠性瘫痪只持续几分钟，可能是自发结束的，也可能是由于诸如触碰或声音等外界刺激而终止的。通常，一个月内只会出现几次睡眠性瘫痪，也有极个别案例每晚都会出现。

睡眠性瘫痪可能出现于嗜睡症发展、恶化的任一阶段。2/3 的嗜睡症患者都偶尔经历过睡眠性瘫痪，大概一半的患者会反复发作，1/4 的患者第一次出现该症状的时间是 16 岁。睡眠性瘫痪出现时会让儿童感到恐慌，尤其是第一次出现时。

➤ 入睡幻觉

嗜睡症患儿在入睡时可能会出现幻觉，他可能会听到或看到某些幻象，看上去非常逼真，这就是所谓的入睡幻觉。孩子看到的幻象也许只是一些移动的色块，听到的声音也许是毫无含义的噪音，但是一般来说，所出现的幻觉都不会那么粗糙。

孩子会将看到的幻象处理成他相信或好奇的东西，也可能会认为自己听到了音乐或人声。他会认为自己看到了强盗、怪异的彩色动物或让人害怕的怪物，通常这些幻觉包含着闯入和威胁的内容。孩子是否能意识到自己看到的是幻觉而不是真实的事物，取决

于其年龄大小与睡眠程度的深浅。还有一种幻觉是觉得自己在做某件事，比如逃跑或躲避攻击。如果在睡眠性瘫痪中同时出现了入睡幻觉，孩子会感到非常害怕。

出现入睡幻觉的原因可能是从觉醒进入睡眠状态的转换阶段出了问题。在正常情况下，这种转换会导致人直接进入非快速眼动期，而嗜睡症患者的阶段转换则直接导致其进入快速眼动期，他们会觉得在进入完全的睡眠状态前就已经开始做梦了。不仅如此，此时出现的梦境还非常强烈。嗜睡症患者是否能意识到所看到的都是幻觉取决于其处于转换阶段的哪一位置。

面对入睡幻觉，最好的解决方法不是与幻觉抗衡，而是任由睡眠占领大脑与身体。这样做可能无法让噩梦停止，但意识会渐渐消失，也就意识不到噩梦的存在了。

| 早期诊断的重要性 |

90% 的患者出现的第一个症状都是昏昏欲睡。有时候，症状会在儿童遭遇重大事件时突然出现。例如，受到感情创伤可能会让儿童出现昏睡症状。第一次诊断是非常重要的，而很多医生会将第一次出现嗜睡症症状误诊为心理疾病，而且在此后相当长一段时间内，这种误诊都得不到纠正。另一方面，当孩子出现昏睡症状时，无论是家长还是孩子自己都可能认为是缺乏睡眠或者学业加重导致这一问题的。

无论出现的第一个症状是昏昏欲睡还是猝倒，由误诊与延误治疗引起的后果是很严重的。在被误诊的前提下，孩子的学业与自尊都会受到损害。大概有 1/3 的嗜睡症患者在小学或高中就受到了嗜睡症的困扰。随着年龄的增长，嗜睡症会进一步影响孩子的深造，甚至会左右其以后的事业发展。对年龄稍大的孩子来说，嗜睡症还会影响其社交生活。人们会认为嗜睡症的儿童是生性懒散或者有心理问题，所以会采用心理学的方法来进行治疗，可是这种治疗通常会以失败告终，因为根本没有对症下药。越早确诊，对孩子来说就越有利。

嗜睡症产生的原因

迄今为止，学界已经发现了一种以前未知的神经递质（化学突触传递中担当信使的特定化学物质），被称为下丘泌素，位于外侧下丘脑，该区域是大脑控制身体特定基本机能的区域，其所控制的基本机能包括食欲。在狗与老鼠的实验中，缺乏下丘泌素都会

影响嗜睡症的出现。尽管嗜睡症患者没有表现出这一现象，但是大多数患者都缺乏下丘泌素，而且有证据显示，这些患者也缺乏制造下丘泌素的神经细胞。

在少数家庭，嗜睡症确实具有遗传性，出现在几代人之间。然而，这些家庭出现的嗜睡症都是非典型的，其出现时间通常较早，症状较为轻微。有证据表明，这些家庭都存在着基因缺陷，且不同家庭的缺陷不尽相同。**某些增加患有嗜睡症概率的特质是具有遗传性的，但这些特质还不足以起到决定性的作用。**

| 其他导致嗜睡的原因 |

如果家长觉得孩子确实出现了嗜睡现象，就要自问两个问题：

- 孩子是否获得了充足的睡眠?
- 孩子的睡眠质量如何?

首先，考虑孩子的睡眠时间是否充足。家长可以连续几周记录下孩子的睡眠情况，特别要关注周末与节假日的情况，看看在不需要起来上学的时候，孩子能睡多久。例如，有的孩子在周一到周五总是表现得睡不够，即使晚上睡了 9 个小时，白天还是很容易犯困，到了周末他在睡满 11 个小时后能自然醒来，一整天都精神很好，那 9 个小时的睡眠时间对他来说就是太少了。

其次，搞清楚孩子的睡眠质量如何。如果孩子在睡眠中躁动不安、总是醒来、睡眠断断续续或每晚打鼾而且鼾声响亮，伴有喘气或呼吸困难等现象，那我们就可以说他的睡眠质量不高，缺乏足够的深度睡眠。

很多药物会导致白天困倦，比如治疗过敏的抗组胺剂及治疗癫痫的药物都有可能让人在服用后产生睡意。很多疾病本身也会让人觉得疲倦。单核细胞增多症、肝炎及任何能导致发烧的疾病都会让人产生疲倦感，但是，这种疲倦不可能持续数月之久：当高烧退去，或者在病毒感染痊愈后的几周内，困倦就应该随之消失。

患有贫血或甲状腺机能减退等慢性疾病的儿童也很容易感觉疲劳，而高血糖和低血糖不会导致严重的嗜睡。像癌症这样特别严重的疾病很容易击垮儿童，从某种程度上说，也会引起儿童嗜睡。

嗜睡症的治疗方法

通常我们会给予嗜睡症患者药物治疗，帮助其调整作息及日间睡眠，从而获得充足的睡眠。

| 昏睡的治疗 |

昏睡症状可以通过药物与调整作息来进行治疗。在午饭后或其他时间进行规律而短暂的午睡有助于患儿保持清醒，减少药物的使用量。对上小学的儿童来说，这种方法可以帮助其在不彻底打乱基本作息的前提下，克服昏睡带来的影响，孩子可以在医务室等地方进行小睡。

有些药物只要使用合理就可以让孩子在学校期间保持清醒，也能让他们去参加课外活动或专心做作业。利他能和安非他命等兴奋剂对大多数患儿都有效果。莫达非尼是一种新药，副作用较小。服用莫达非尼的患者不会在药物效果减退时感到反差巨大，只要用量合理也不会出现耳鸣，而且也没有出现滥用的风险。另一种治疗昏睡的药物是羟丁酸钠。研究表明，它对于提高夜间睡眠质量、减少日间昏睡症状非常有效。

一旦昏睡状况得到有效控制，患儿的情况就会出现很大改善。无论是学业、社交活动，还是在家里的表现都会有很大进步。在布伦丹的案例中，我们通过增加其放学后的小睡，且坚持让其服用利他林，使得他的日间昏睡有了很大改善。通过治疗，他的自我感觉变得更好了，学业上也取得了很大进步。后来我将他的治疗药物调整为莫达非尼，治疗效果也非常好。他在夜里长时间醒着的情况基本上消失了，在晚饭后，他会去做作业或者与家人一起消磨时间。

| 猝倒、入睡幻觉和睡眠性瘫痪的治疗 |

应对猝倒、入睡幻觉和睡眠性瘫痪可以采用治疗抑郁症的药物，即选择性 5- 羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）。羟丁酸钠虽然不是抗抑郁类的药物，但是在夜间服用有助于减少猝倒的出现，其具有改善睡眠、减少快速眼动期异常的作用。

如果入睡幻觉与睡眠性瘫痪的程度比较轻微且只是偶尔出现，可以放任不管。这些症状并不具有危险性，一旦孩子明白这些症状出现的原理，就会试着去接受。如果患儿的猝倒症状也比较轻微且偶尔出现，那治疗也可以推迟进行。但是，如果猝倒具有危险

性，让患儿感到尴尬或者害怕，那治疗就无法避免了。

现在有一大批治疗嗜睡症的新药正在研发，其中有些药物模拟了缺乏下丘脑泌素时的治疗方法。我希望这些研究不仅能有效地治疗嗜睡症，还能治疗导致嗜睡症的病源。

如何应对相对简单的病因

有的孩子出现轻微的嗜睡是由于其缺乏足够的睡眠，家长可以根据本书其他章节提供的方法帮助孩子增加睡眠。

有的孩子出现嗜睡是由于其比一般孩子需要更长时间的睡眠，家长应该配合孩子的需要，对日常生活做出一些必要的调整。如果一个青少年每天需要睡满 11 个小时，而早晨需要在 6 点半就起床，这就意味着前一天晚上他需要在 7 点半就上床睡觉。为此，家长需要做出一些妥协。比如允许孩子在周一到周五早点上床睡觉（比如 9 点或 9 点半就寝），双休日可以允许孩子睡个懒觉，也可以安排孩子进行日间小睡来弥补夜间睡眠的不足。

尽管这个方法并不是最理想的，但实行起来效果不错，也能起到逐渐改善作息的作用。假设孩子以前是 11 点半才上床休息，提前到 9 点半就多出来两小时的睡眠时间了，不要小看这两小时，它会让情况发生巨大的改变。

还有的孩子出现嗜睡是由于受到疾病困扰或者是由药物的副作用所致，家长可以向孩子的主治医师咨询相关的问题，跟他一起找出解决方法，比如更换药物或改变剂量都有可能改善嗜睡的情况。

如果你家宝宝的嗜睡找不到确切原因，也无法归类到上述任何一种致病因素中去，那我建议家长带着孩子去睡眠问题治疗中心做一个全面检查。

一切为了您的阅读价值

★ 您知道自己为阅读付出的最大成本是什么吗?
★ 您是否常常在读过一本书后，才发现不是自己要看的那一本?
★ 您是否常常发现很多书都是一时冲动买下，至今一字未读?
★ 您是否常常感慨书的价格太贵，两百多页，值四十多元钱吗?

阅读的最大成本

读者在选购图书的时候，往往把成本支出的焦点放在书价上，其实不然。

时间才是读者付出的最大阅读成本。

阅读的时间成本=选择花费的时间+阅读花费的时间+误读浪费的时间

选择合适的图书类别

目前市场上的**图书来源**可以分为**两大类，五小类：**

1. 引进图书：引进图书来源于国外出版公司，多从其他语种翻译成中文出版，反映国际发展现状，但与中国的实际结合较弱，其中包括三小类：

a）教科书：理论性较强，体系完整，但多为学科的基础知识，适合初入门的、需要系统了解一门学问的读者。

b）专业书：理论性、专业性均较强，需要读者拥有比较深厚的专业背景，阅读的目的是加深对一门学问的理解和认识。

c）大众书：理论性、专业性均不强，但普及性较强，贴近现实，实用可操作，适合一门学问的普通爱好者或实际操作者。

2. 本土图书：本土图书来源于中国的作者，反映中国的发展现状，与中国的实际结合较强，但国际视野和领先性与引进版相比较弱，其中包括两小类，可通过封面的作者署名来辨别：

a）“著”作：大多为作者亲笔写就，请读者认真阅读“作者简介”，并上网查询、验证其真实程度，一旦发现优秀的适合自己的作者，可以在今后的阅读生活中，多加留意并了解。

b）“编著”图书：汇编了大量图书中的内容，拼凑的痕迹较明显，建议读者仔细分辨，谨慎购买。

阅读的收益

阅读图书最大的收益，来自于获取知识后，**应用于**自己的**工作和生活**，获得品质的**改善和提升**，油然而生无限的**满足感**。

我们出版的所有图书，封底和书脊都有“湛庐文化”的标志

湛庐文化
CheersPublishing

并归于两个品牌

财富汇　　心视界

找“小红帽”

为了便于读者在浩如烟海的书架陈列中清楚地找到我们，我们在每本图书的书脊上部 47mm 处，全部用红色标记，称为——小红帽。同时，“小红帽”上标注“湛庐文化”字样，小红帽下方标注所属图书品牌名称。

湛庐文化主力打造两个品牌：**财富汇**，致力于为商界人士提供国内外优秀的经济管理类图书；**心视界**，旨在通过心理学大师、心灵导师的专业指导为读者提供改善生活和心境的通路。

用轻型纸

您现在正在阅读的这本书所使用的是轻型纸，有白度低、质感好、韧性好、油墨吸收度高等特点。

关注阅读体验

我们目前所使用的字体、字号和行距，是在经过大量调查研究的基础上确定的，符合读者阅读感受。每页设计的字数可以在阅读疲劳周期的低谷到来之前，使读者稍作停顿，减轻读者的阅读疲劳，舒适的阅读感觉油然而生。

所有的一切都为了给您更好的阅读体验，代表着我们“十年磨一剑”的专注精神。我们希望湛庐能够成为您事业与生活中的伙伴，帮助您成就事业，拥有更为美好的生活。

湛庐文化
Cheers Publishing

湛庐文化2008-2011年获奖书目

《牛奶可乐经济学》

国家图书馆“第四届文津奖”十本获奖图书之一，唯一获奖的商业类图书。
搜狐、《第一财经日报》2008年十本最佳商业图书。
用经济学的眼光看待生活和工作，体验作为“经济学家”的美妙之处。

《大而不倒》

《金融时报》·高盛2010年度最佳商业图书入选作品。
美国《外交政策》杂志评选的全球思想家正在阅读的20本书之一。
蓝狮子·新浪2010年度十大最佳商业图书，《智囊悦读》2010年度十大最具价值经管图书。
一部金融界的《2012》，一部丹·布朗式的鸿篇巨制。

《金融之王》

《金融时报》·高盛2010年度最佳商业图书。
蓝狮子2011年度十大最佳商业图书，《第一财经日报》2011年度十大金融投资书籍。
权威透视国际金融界大佬在大萧条中的群像著作。
一部优美的人物传记，一部独特视角的经济金融史。

《富可敌国》

蓝狮子·《第一财经日报》2011年度最佳金融商业图书。
《第一财经日报》2011年度十大金融投资书籍。
源自300个小时的真实访谈，一部权威的对冲基金史。

《认知盈余》

2011年度和讯华文财经图书大奖。
看“互联网革命最伟大的思考者”克莱·舍基如何开启无组织的时间力量。
看自由时间如何成就“有闲”世界，如何引领“有闲”经济与“有闲”商业的未来。

《微力无边》

2011年度和讯华文财经图书大奖“最佳装帧设计奖”。
中国最早的社会化媒体营销研究者杜子建首部作品。
一部微博前传，半部营销后传。

《神话的力量》

《心理月刊》2011年度最佳图书奖。
在诸神与英雄的世界中发现自我，当代神话学大师约瑟夫·坎贝尔毕生精髓之作。

《facebook效应》

《金融时报》·高盛2010年度最佳商业图书入选作品。
蓝狮子·新浪2010年度十大最佳商业图书，《新智囊》2011年度最具价值十大经管图书。
首度公开facebook非凡创业的26个细节，马克·扎克伯格及40多位核心高管倾情讲述。

《真实的幸福》

《职场》2010年度最具阅读价值的10本职场书籍。
积极心理学之父马丁·塞利格曼扛鼎之作，哈佛最吸引人、最受欢迎的幸福课。

《绕着大毛球飞行》

蓝狮子·《职场》2011年度最佳职场图书。
畅销13年的职场创意手册，贺曼贺卡公司创意总监倾情之作。

延伸阅读

《赖克林儿童情绪手册》

◎ 亚马逊教养类榜首图书，畅销 10 年。
◎ 父母资源网络基金会创始人赖克林女士育儿经典。
◎ 40 个一定会发生的问题，467 条育儿妙计，让你轻轻松松搞定让人又爱又恼的 2~5 岁小鬼。

《希腊三部曲 I：追逐阳光之岛》（更新版）

◎ “希腊三部曲”的开篇之作，也是“保育顽童”杰拉尔德·达雷尔的诚恳之作。
◎ 带你走进纯真、童稚的动植物世界。
◎ 本书不仅被拍成电视剧，还是英国高中毕业语文考试用书。

《希腊三部曲 II：桃金娘森林宝藏》（更新版）

◎ “希腊三部曲”中笔锋最诚恳、成熟的一部。
◎ 为挥别童年与受战争污染前的世外桃源所谱写的柔情哀歌，对纯真年代的无限缅怀，对今日“失乐园”发出的一声浩叹。

《希腊三部曲 III：众神的花园》（更新版）

◎ “希腊三部曲”的结局之作，将达雷尔的童年岁月在奇特而令人难忘的盛宴画上句点。
◎ “希腊三部曲”中唯一透彻揭示作者心境的一部，锋利地划破上流社会浮华表面的虚伪面容。

《让孩子的大脑自由》

◎ 《纽约时报》畅销书《让大脑自由》作者最新力作。
◎ 《父母世界 Parents》执行主编朱正欧智慧推荐。
◎ 大脑科学家教你如何养育出聪明、幸福、有教养的好宝贝。

《教养大震撼》

◎ 关于孩子，你知道的太多都是错的！
◎ 轰动美国教育界，家长圈最热门的话题。
◎ 观念之差，决定孩子不一样的未来。

《简单的教养》

◎ 最简单的教养，正是最好的教养；最容易忽略的规则，正是最重要的规则。
◎ 全球最大的唱片公司环球音乐集团创意总监的养育智慧。
◎ 为孩子的人生尽早埋下幸福、智慧的种子。
◎ 新手父母最容易忽略的养育规则。

Solve Your Child's Sleep Problems by Richard Ferber, M. D.

Original English language edition Copyright ©1985, 2006 by Richard Ferber, M. D.

Simplified Chinese characters edition arranged with SIMON&SCHUSTER INC. through BIG APPLE TUTTLE-MORI AGENCY, LABUAN, MALAYSIA.

Chinese translation Copyright © 2012 by Cheers Publishing Company.

All rights reserved.

本书中文简体字版由 SIMON&SCHUSTER INC. 通过 BIG APPLE TUTTLE-MORI AGENCY,LABUAN,MALAYSIA 授权在中华人民共和国境内独家出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有，侵权必究。

献给被孩子的睡眠问题折磨得筋疲力尽的父母们

孩子半夜反复哭闹折腾得你精疲力竭？
孩子晚上不想睡早上醒不来令你束手无策？
孩子上课昏昏欲睡成绩一落千丈让你焦头烂额？
孩子夜惊、梦游、做噩梦、尿床使你备感心力交瘁？

风靡全美的法伯睡眠法，让宝宝安睡，父母安心。

郑先子
新浪育儿频道副主编

当你想要试着做一个好妈妈时，建议你从读一本科学养育的书开始。坚持读完一本，你会发现，我们想当然以为的小事情都有非常专业的研究背景。《法伯睡眠宝典》让我们了解到的不只是宝宝的睡眠问题，还有更多、更成熟的养育理念。

朱正欧
《父母世界Parents》执行主编

睡觉是再自然不过的事情，很少有人会大费周章地研究它，但是，几乎所有的父母都会问：我的孩子算不算睡眠质量差？他到底睡够了没有？他为什么不爱睡觉？怎样才能让他好好睡觉？无论孩子是黑白颠倒、睡不踏实、入睡困难还是半夜惊醒，父母们都深受困扰。感谢法伯，这位声名赫赫的儿童睡眠专家，将历时30年的研究整理成书，让我们真正地了解睡眠，并有效地解决孩子的睡眠问题。

湛庐文化
Cheers Publishing

上架指导：育儿

ISBN 978-7-213-05238-5

9 787213 052385

定价：39.90元

[General Information]
书名=法伯睡眠宝典　如何顺利解决孩子的睡眠问题
作者=（美）理查德?法伯著
页数=205
SS号=14144546
DX号=
出版日期=2013.01
出版社=浙江人民出版社